

中医基础课程笔记图解

- 运用形象直观图表 深度解析教材内容 ·
- 归纳整理繁杂知识 便于记忆理解掌握 ·

【刘喜平 主编 李沛清 林洁 副主编】

FANGJIXUE
BILITUE

方剂学

笔记图解



化学工业出版社
生物·医药出版分社

课程学习的必备参考 考前准备的应试宝典 教学实践的良好借鉴

中医基础课程笔记图解

- 中医基础理论笔记图解 •
- 中医诊断学笔记图解 •
- 中药学笔记图解 •
- 方剂学笔记图解 •
- 中医内科学笔记图解 •
- 伤寒论笔记图解 •
- 金匱要略笔记图解 •
- 黄帝内经笔记图解 •
- 温病学笔记图解 •
- 针灸学笔记图解 •

ISBN 978-7-122-03725-1



9 787122 037251 >

定价：19.80元

销售分类建议：中医学/方剂学

中医基础课程笔记图解

运用形象直观图表 深度解析教材内容
归纳整理繁杂知识 便于记忆理解掌握

【刘喜平 主编 李沛清 林洁 副主编】

FANGJIXUE
BILITUIJIE

方剂学 笔记图



化学工业出版社
生物·医药出版分社
·北京·

本书根据现行高等中医药院校《方剂学》教材，结合作者多年的教学经验并汲取学界同行的研究心得，将教材中的重点内容按照证、法、方、药贯通一体的方剂临床应用思维模式设计成了简洁的图表，进行形象展示与阐释，特别是对难点、疑点内容作了必要的浓缩提炼，可使初学者更好更快地掌握和记忆《方剂学》的基本理论与基本知识，从而为方剂的深刻理解和灵活应用奠定基础。

本书可作为《方剂学》教学参考材料，便于教师授课；亦可作为学习《方剂学》的入门读物，便于学生学习；也可作为中医师资格、晋升职称的考试参考材料。

图书在版编目 (CIP) 数据

方剂学笔记图解/刘喜平主编. —北京: 化学工业出版社, 2008. 11
(中医基础课程笔记图解)
ISBN 978-7-122-03725-1

I. 方… II. 刘… III. 方剂学—图解 IV. R289-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 142514 号

责任编辑: 李少华 陈燕杰
责任校对: 徐贞珍

文字编辑: 王新辉
装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 生物·医药出版分社
(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 三河市延风印装厂

720mm×1000mm 1/16 印张 12 字数 263 千字 2009 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80 元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 刘喜平

副主编 李沛清 林洁

编写人员 (按姓名笔画排序)

刘喜平	安耀荣	李 娟	李文彬
李沛清	吴红彦	张 艳	林 洁

前言

《方剂学》是研究并阐明治法和方剂的理论及其临床运用的一门学科，是中医学的主要基础学科之一，是中医基础学科与中医临床学科的桥梁和纽带，是中医理、法、方、药体系中的重要环节，还是申请中医师资格、晋升职称的必考科目。因此，学好《方剂学》，掌握一定数量的、行之有效的方剂，有十分重要的意义。

本书是以新世纪全国高等中医药院校规划教材《方剂学》为蓝本，并在总结作者多年来教学经验的基础上，汲取学界同行的研究心得，紧扣教学大纲编写而成。全书对教材中的主要内容进行了形象、直观的归纳分析，力争用最简洁的图表形式将方剂学的主要内容进行形象展示。全书在强调方剂学重点、难点、疑点的同时，着力突出证、法、方、药贯通一体的方剂临床应用思维模式，从而为深刻理解和正确灵活应用方剂奠定基础。

本书可作为《方剂学》教学参考材料，便于教师授课；亦可作为学习《方剂学》的入门读物，便于学生学习。全书按规划教材体例编写，由绪言、上篇、下篇三部分组成，绪言主要介绍方剂学的基本概念，上篇总论主要介绍方剂学的发展简史、方剂与治法，以及方剂的分类、组成和配伍、剂型、服法的基本知识；下篇各论部分以法统方，将方剂分为解表、泻下、和解、清热、温里、补益等 19 类方剂，共收录正方 170 多首，每首方剂按组成、主治、功用、方歌、表解、配伍特点、难点提示、应用要点、使用注意等编写。

此书是笔者多年来学习、研究、传授《方剂学》的心得体会，因学识所限，管窥之见，难识全貌，难尽人意之处肯定有之，恳请读者、专家予以批评指正，以便今后修改提高。

编者

2008 年 5 月

目 录

绪言

上篇 总论

第一章 方剂学发展简史	2	第四章 方剂的组成与变化	6
第二章 方剂与治法	3	第一节 方剂配伍的目的	6
第一节 治法概述	3	第二节 方剂的基本结构	6
第二节 方剂与治法的关系	3	第三节 方剂的变化形式	6
第三节 常用治法	3	第五章 剂型	7
第三章 方剂的分类	5	第六章 方剂的服法	8

下篇 各论

第一章 解表剂	9	大黄附子汤	26
第一节 辛温解表	10	温脾汤	26
麻黄汤	10	第三节 润下	27
桂枝汤	11	麻子仁丸	27
九味羌活汤	12	济川煎	28
小青龙汤	13	第四节 逐水	29
止嗽散	13	十枣汤	29
第二节 辛凉解表	14	第三章 和解剂	30
银翘散	14	第一节 和解少阳	30
桑菊饮	15	小柴胡汤	30
麻黄杏仁甘草石膏汤	16	大柴胡汤	31
柴葛解肌汤	17	蒿芩清胆汤	32
升麻葛根汤	18	第二节 调和肝脾	33
第三节 扶正解表	19	四逆散	33
败毒散	19	逍遥散	34
参苏饮	20	痛泻要方	34
麻黄细辛附子汤	21	第三节 调和肠胃	35
加减葶苈汤	21	半夏泻心汤	35
第二章 泻下剂	23	第四章 清热剂	37
第一节 寒下	23	第一节 清气分热	38
大承气汤	23	白虎汤	38
大黄牡丹汤	25	竹叶石膏汤	39
第二节 温下	26	第二节 清营凉血	39

清营汤	39	补中益气汤	67
犀角地黄汤	40	参苓白术散	68
第三节 清热解毒	41	生脉散	69
普济消毒饮	41	玉屏风散	70
黄连解毒汤	42	完带汤	71
凉膈散	43	第二节 补血	72
仙方活命饮	43	四物汤	72
第四节 清脏腑热	44	当归补血汤	72
导赤散	44	归脾汤	73
龙胆泻肝汤	45	第三节 气血双补	74
左金丸	46	炙甘草汤	74
苇茎汤	46	八珍汤	75
泻白散	47	第四节 补阴	76
玉女煎	47	六味地黄丸	76
清胃散	48	左归丸	77
葛根黄芩黄连汤	49	大补阴丸	78
芍药汤	49	一贯煎	78
白头翁汤	50	第五节 补阳	79
第五节 清虚热	51	肾气丸	80
青蒿鳖甲汤	51	右归丸	80
清骨散	52	第六节 阴阳并补	81
当归六黄汤	53	地黄饮子	81
第五章 祛暑剂	54	龟鹿二仙胶	82
清络饮	54	第八章 固涩剂	84
香薷散	55	第一节 固表止汗	84
六一散	55	牡蛎散	85
桂苓甘露饮	56	第二节 敛肺止咳	85
清暑益气汤	56	九仙散	85
第六章 温里剂	58	第三节 涩肠固脱	86
第一节 温中祛寒	58	真人养脏汤	86
理中丸	58	四神丸	87
小建中汤	59	第四节 涩精止遗	87
吴茱萸汤	60	金锁固精丸	87
第二节 回阳救逆	61	桑螵蛸散	88
四逆汤	61	第五节 固崩止带	88
回阳救急汤	62	固冲汤	89
第三节 温经散寒	63	固经丸	89
当归四逆汤	63	易黄汤	90
阳和汤	64	第九章 安神剂	91
第七章 补益剂	66	第一节 重镇安神	91
第一节 补气	66	朱砂安神丸	91
四君子汤	67	第二节 滋养安神	92

酸枣仁汤	92	川芎茶调散	123
天王补心丹	93	大秦艽汤	124
第十章 开窍剂	95	小活络丹	125
第一节 凉开	95	牵正散	125
安宫牛黄丸	95	玉真散	126
紫雪	96	消风散	127
至宝丹	97	第二节 平息内风	128
第二节 温开	98	羚角钩藤汤	128
苏合香丸(吃力伽丸)	98	镇肝熄风汤	129
第十一章 理气剂	100	天麻钩藤饮	130
第一节 行气	100	大定风珠	130
越鞠丸	101	第十四章 治燥剂	132
枳实薤白桂枝汤	101	第一节 轻宣外燥	132
半夏厚朴汤	102	杏苏散	133
金铃子散	103	桑杏汤	134
厚朴温中汤	103	清燥救肺汤	135
天台乌药散	104	第二节 滋阴润燥	136
暖肝煎	104	增液汤	136
第二节 降气	105	麦门冬汤	137
苏子降气汤	105	益胃汤	138
定喘汤	106	养阴清肺汤	139
旋覆代赭汤	107	百合固金汤	139
橘皮竹茹汤	108	第十五章 祛湿剂	141
第十二章 理血剂	109	第一节 燥湿和胃	142
第一节 活血祛瘀	110	平胃散	142
桃核承气汤	110	藿香正气散	142
血府逐瘀汤	111	第二节 清热祛湿	144
补阳还五汤	112	茵陈蒿汤	144
复元活血汤	113	八正散	144
温经汤	114	三仁汤	146
生化汤	114	甘露消毒丹	147
失笑散	115	连朴饮	147
桂枝茯苓丸	116	二妙散	148
鳖甲煎丸	116	当归拈痛汤(拈痛汤)	149
第二节 止血	117	第三节 利水渗湿	149
十灰散	118	五苓散	150
咳血方	118	猪苓汤	150
小蓟饮子	119	防己黄芪汤	151
槐花散	120	五皮散	152
黄土汤	120	第四节 温化水湿	153
第十三章 治风剂	122	真武汤	153
第一节 疏散外风	123	苓桂术甘汤	154

实脾散	155	苓甘五味姜辛汤	165
葶藶分清散（葶藶分清饮）	156	三子养亲汤	166
第五节 祛风胜湿	157	第五节 化痰息风	166
羌活胜湿汤	157	半夏白术天麻汤	166
独活寄生汤	157	定痛丸	167
第十六章 祛痰剂	159	第十七章 消食剂	169
第一节 燥湿化痰	160	第一节 消食化滞	169
二陈汤	160	保和丸	169
温胆汤	160	枳实导滞丸	170
茯苓丸	161	第二节 健脾消食	171
第二节 清热化痰	162	健脾丸	171
小陷胸汤	162	枳实消痞丸（失笑丸）	172
清气化痰丸	163	葛花解酲汤	173
滚痰丸	163	第十八章 驱虫剂	174
第三节 润燥化痰	164	乌梅丸	174
贝母瓜蒌散	164	第十九章 涌吐剂	176
第四节 温化寒痰	165	瓜蒂散	176

参考文献	178
------------	-----

索引	179 tgtk
----------	----------

绪 言

一、方剂的概念

方剂是在辨证审因、确定治法之后，选择合适的药物，酌定用量，按照组方结构的要求，妥善配伍而成的。

二、方剂学的概念

方剂学是研究并阐明治法和方剂理论及其临床运用的一门学科，是中医学的主要基础学科之一。

三、方剂学在中医学中的地位

方剂学研究的内容是以中医基础理论、中医诊断学、中药学等前期基础学科的内容为基础。方剂学是中医基础学科与中医临床学科的桥梁和纽带，是中医理、法、方、药体系中的重要环节。

四、方剂学的任务

通过一定数量常用方剂的讲授，引导学生掌握组方原理和配伍方法，培养学生分析、运用方剂以及临证组方的能力，并为学习中医临床课程奠定方剂学基础。

上篇 总论

第一章 方剂学发展简史

七部重要的方剂学著作及其价值

书 名	年 代	作 者	主 要 价 值
《五十二病方》	汉以前		我国现存最早的一部方书
《黄帝内经》	先秦		初步奠定了方剂的理论基础
《伤寒杂病论》	东汉	张仲景	融理、法、方、药为一体,被后人称为“方书之祖”
《太平惠民和剂局方》	宋朝		我国历史上第一部由政府编制的成药药典
《伤寒明理药方论》	金元	成无己	开方论之先河
《医方考》	明朝	吴昆	第一部方论专著
《普济方》	明朝	朱橚	我国历史载方最多的古方书,载方 61739 首

第二章 方剂与治法

第一节 治法概述

【概念】

治法是在辨清证候，审明病因、病机之后，有针对性采取的治疗法则。

【特点】

- 多层次 { 治疗大法：具有一定的概括性、针对某类病机共性所确立的治法，如常用“八法”
具体治法：针对具体证候所确立的治疗方法，如每首方剂的具体功用即为该方的具体治法
- 多体系 { 脏腑治法体系：如宣肺止咳、滋水涵木等
六经治法体系：如和解少阳、泻下阳阴热结
卫气营血治法体系：如清气分热、透热转气、清营凉血
三焦治法体系：如宣上、畅中、渗下及分消三焦等

第二节 方剂与治法的关系

从祖国医学的形成和发展来看，治法是在积累了相当医疗经验的基础上总结而来，是后于方药形成的一种理论。

当治法已经由经验总结上升为理论之后，就成为遣药组方和运用成方的指导原则。法随证立，方从法出，方以药成。

第三节 常用治法

【八法的概念】 历代医家创造了相当多的治法，其中清代程钟龄的《医学心悟》将其概括为八法。《医学心悟》中说：“论病之源，以内伤、外感四字括之。论病之情，则以寒热、虚实、表里、阴阳八字统之。而论治病之方，则又以汗、和、下、消、吐、清、温、补八法尽之。”

【八法的内容】

1. 汗法

汗法是通过发汗解表、宣肺散邪的方法，使在表的六淫之邪随汗而解的一种治法。

作用：汗法不仅能发汗，凡能祛邪于外、透邪于表、使气血通畅、营卫调和，皆是汗法的作用。

适应证：治疗外感六淫之邪的表证，麻疹初起、疹点隐隐不透，水肿病腰以上肿甚，疮疡初起而有寒热表证者。

分类：由于邪气有兼夹，体质有强弱，“阳加于阴谓之汗”，故汗法有辛温、辛凉。

2. 吐法

吐法是通过呕吐，使停留于咽喉、胸膈、胃脘等部位的痰涎、宿食或毒物从口排出

的一种治法。

适应证：咽喉痰涎壅阻，顽痰停滞胸膈，宿食留滞胃脘，或误食毒物尚在胃中。

注意：此是祛邪外出的一种治法，易损胃气，凡体虚气弱、妇人新产、孕妇均应慎用。但刺激咽喉、胃脘，引起呕吐易损正气，且较痛苦。

3. 下法

下法是通过荡涤肠胃、泻下大便或积水，使停留于肠胃的宿食、燥屎、实热、冷积、瘀血、痰结、水饮等从下而出以解除疾病的一种治法。

适应证：燥屎内结，冷积不化，瘀血内停，宿食不消，结痰停饮及虫积等。

分类：由于积滞有寒热，正气有盛衰，邪气有夹杂，故下法有寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施之别。

4. 和法

和法是通过和解或调和的作用，以达到消除病邪为目的的一种治法。所谓和解者，是指和解表里之意，专用于治疗半表半里证候。

适应证：疟疾，肝脾不和，肠胃不和，伤寒邪在少阳，气血不和，营卫不和。

分类：常用的有和解少阳，开达膜原，调和肝脾，疏肝和胃，调和寒热，表里双解等。

5. 温法

温法是通过温中、祛寒、回阳、通络，使寒邪去、阳气复、经络通、血脉和的一种治疗方法。

适应证：适用于脏腑的沉寒痼冷，寒饮内停，寒湿不化，阳气衰微等。

分类：由于寒邪所在部位不同，寒邪与阳虚的程度不同，因而温法中又有温中散寒、温暖肝肾、回阳救逆之区分。其他尚有温肺化痰、温胃降逆、温肾纳气、温中行气、温血活血、温阳止血、温里解表等。

6. 清法

清法是通过清除火热之邪，使在里之热邪得以解除的一种治疗方法。

适应证：火热证、热毒证及虚热证等里热证。

分类：由于里热证有热在气分、热入营血、气血俱热及热在某一脏腑之分，因而清法中又有清气分热、清营凉血、气血两清、清热解毒及清脏腑热之别。

7. 消法

消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水以及驱虫的方法，使气、血、痰、食、水、虫等所结成的有形之邪渐消缓散的一种治法。

适应证：适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化及痞积、虫积等。

8. 补法

补法是通过补养的方法，使人体脏腑或气血阴阳之间的失调重归于平衡。

适应证：适应于各种虚证，主要有气虚、血虚、阴虚、阳虚及脏腑虚弱证。

分类：补气、补血、气血双补、补阴、补阳、阴阳双补。

注意：补法虽可间接收到祛邪的效果，但一般是在无外邪时使用，以避免“闭门留寇”之弊。

第三章 方剂的分类

七方分类 { 内容：源于《素问·至真要大论》，金·成无己正式提出“七方”名称。《伤寒明理药方论》说：“制方之用，大、小、缓、急、奇、偶、复”
特点：是以病邪的轻重、病位的上下、病势的缓急、病体的强弱作为制方的依据，并非为方剂的分类而设

病证分类 { 内容：按病证名称分类。亦包括脏腑病证或以病因等分类的方法。首推《五十二病方》、《伤寒杂病论》
特点：最早使用的方剂分类方法，便于临床以病索方

祖方分类 { 内容：选取重要医籍的部分基础方剂，冠以祖方，用以归纳其他方剂，首推《祖剂》
特点：对归纳病机、治法共性的类方研究具有较好的作用，但不能推本溯源，始末不清

治法分类 { 内容：亦称功能分类，即以方剂的
功效来分类归纳方剂 { 十剂：宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿
八阵：补、和、攻、散、寒、热、固、因
八法：汗、吐、下、和、温、清、消、补
特点：是早期功用分类基础上逐渐发展成熟的

综合分类 { 内容：既能体现以法统方，又能结合方剂功用和证治病因，并照顾到治有专科。分别为补养、发表、涌吐、攻里、表里、和解、理气、理血、祛风、祛寒、清暑、利湿、润燥、泻火、除痰、消导、收涩、杀虫、明目、痛疡、经产及救急良方，共22类
特点：概念清楚，提纲挈领，切合临床，照顾面广，被多数医家推崇

第四章 方剂的组成与变化

第一节 方剂配伍的目的

方剂的配伍	配伍的概念	“配”即组织、搭配；“伍”即队伍、序列
		运用药物的组合过程，称之为“配伍”
	目的	增效与减毒
	作用	- 增强药力 - 产生协同作用 - 控制多功用单味中药的发挥方向 - 扩大治疗范围，适应复杂病情

第二节 方剂的基本结构

方剂的基本结构	君药	针对主病或主证起主要治疗作用的药物
	臣药	辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物
		针对中药兼病或兼证起主要治疗作用的药物
	佐药	佐助药 { 配合君、臣药以加强治疗作用 直接治疗次要兼证
		佐制药 { 消除或减弱君、臣药的毒性 制约君、臣药的烈性
		反佐药：与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用之药，以防止药病相格拒
	使药	- 引经药：引诸药直达病所之药 - 调和药：调和方中诸药作用之药

第三节 方剂的变化形式

方剂的变化形式	药味加减的变化	前提：主病、主证、基本病机及君药不变
		形式：加减方中次要药物（臣、佐、使药）
		影响：主病、主证、基本病机与原方基本相符，但适应了兼证变化的需要
	药量加减的变化	前提：组成方剂的药味不变
		形式：增加或减少组成方剂的剂量
	剂型更换的变化	影响 { 改变功用的强弱。如四逆汤与通脉四逆汤 改变功用和主治。如桂枝汤与桂枝加桂汤、桂枝加芍药汤
		前提：组成方剂的药味及其配伍用量比例不变
		形式：更换服用剂型
		影响 { 改变功用的快慢与峻缓，适应病情轻重、病势缓急的需要 有时也能改变方剂的功用和主治。如桂枝茯苓丸改为汤剂，名为催生汤

第五章 剂型

- | | | |
|-----------|---|--|
| 汤剂 | { | <p>制备：将药物饮片加水或酒浸泡后，再煎煮一定时间，去渣取汁，制成的液体剂型</p> <p>运用 {
 内服（主要形式）
 外用洗浴、熏蒸、含漱</p> <p>优点 {
 内服吸收快，疗效迅速
 便于灵活加减
 能全面照顾到不同病人或各种病证的特殊性</p> <p>缺点 {
 服用量大
 储存、携带不方便
 成分不稳定（某些药的有效成分不易煎出或易于挥发散失）</p> |
| 散剂 | { | <p>制备：将药物研成均匀混合的干燥粉末</p> <p>运用 {
 内服（调散）：煎（煮）散和细末口服（以温开水或酒、米汤、药汁冲服）
 外用散：敷于疮面或患病部位，如点眼、吹喉、塞鼻、吹耳等</p> <p>优点 {
 制作简便，吸收较快
 节省药材，不宜变质，便于服用携带</p> <p>缺点：口感较差，不便增减</p> |
| 丸剂 | { | <p>制备：将药物研成粉末或药材提取物，加适宜的黏合剂而制成球形的固体剂型</p> <p>运用：内服</p> <p>优点 {
 吸收较慢，药效持久，适合久服缓治
 节省药材，便于服用、保存及携带
 宜于药力峻猛、有较剧毒性及芳香类易挥发药物的应用</p> <p>缺点：不便于加减变化</p> |

第六章 方剂的服法

一、服药时间

服药时间	饭前服（空腹服）	{	病在胸膈以下者
			滋补类方剂
			和胃制酸类方剂
	饭后服	{	病在胸膈以上者
			对胃肠有刺激的方剂
			消食剂、缓下剂
	定时服	{	治疟药宜发作前 2 小时服
安神剂宜睡前服			
慢性病证			
不定时服：急证、重病可不拘时间服用			

二、服药方法

服药次数	汤剂一般 1 日 1 剂，每剂分 2~3 次服
	特殊病证汤剂可 1 日 2~3 剂，分数次服
	膏、丹、丸、散、酒之类，每日服 2~3 次

服药冷热	汤剂大多宜温服
	解表剂宜热服
	热证用凉药宜冷服，寒证用热药宜热服

服药注意	昏迷而吞咽困难者，宜鼻饲
	峻烈性或毒性药，宜从少量开始，逐渐加量

下篇 各论

第一章 解表剂

一、定义

凡以解表药为主组成，具有发汗、解肌、透疹等作用，可以解除表证的方剂，统称解表剂。属“八法”中的“汗法”。

二、立法依据

《阴阳应象大论》：“其在皮者，汗而发之。”“因其轻而扬之”。即用汗法，用轻轻辛散的药物，给邪找出路。只是手段，而非目的。

三、适应范围

(1) 表证 这是本类方剂的主要治疗证。所谓表证，是指外感六淫之邪侵犯人体肌表而出现的证候。症见恶寒发热、头痛、身痛、脉浮等。

(2) 麻疹、疮疡、水肿、疟疾、痢疾等初起 此类病证初起大都可见到恶寒、发热、头痛、身疼、苔白或黄、脉浮等表证，当此之时，都可以用解表剂助麻疹病毒外透肌表或促使疮疡消散或发汗解表、宣通肺气，使在表之邪随汗而解。

四、分类与配伍规律

解表剂	{	辛温解表剂——风寒表证——常以辛温解表药为主，配伍宣降肺气药
		辛凉解表剂——风热表证——常以辛凉解表药为主，配伍清热解毒药
		扶正解表剂——体虚表证——常以解表药为主，配伍补益药

五、使用注意

(1) 明确辨证 病邪由表入里，则不宜使用。如麻疹已透、虚性水肿、疮疡已溃、吐泻伤津等均不宜使用。

(2) 辨明兼证 表里同病，表邪未尽，又见里证，一般是先解表，后治里，表里俱重，则表里双解。

(3) 善于调护 温服或饮热水或温覆取汗，以助药力，邪随汗出。标准（度）：“遍身淅淅微似有汗”，不可大汗，以免伤正。

(4) 药后忌口 忌生冷、油腻（生寒生湿）。寒湿易凝滞收敛邪气（恋邪），有“闭门留寇”之弊。

(5) 不宜久煎 解表剂多用辛散轻扬之品，不宜久煎，否则药性耗散，作用

减弱。

第一节 辛温解表

辛温解表剂，主治外感风寒表证。外感风寒之邪侵袭人体，肌肤毛窍闭塞，肺气不宜，卫气不得外达，营气为寒邪束缚涩而不畅。症见恶寒发热，头项强痛，肢体酸痛，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧或浮缓等。临床常以辛温解表药如麻黄、桂枝、荆芥、防风、苏叶等为主组成方剂。代表方剂：麻黄汤、桂枝汤、九味羌活汤、小青龙汤、止嗽散、香薷散等。

• 麻黄汤（《伤寒论》）•

【组成】麻黄去节，三两（9g） 桂枝二两（6g） 甘草炙，一两（3g） 杏仁七十个，去皮尖（6g）

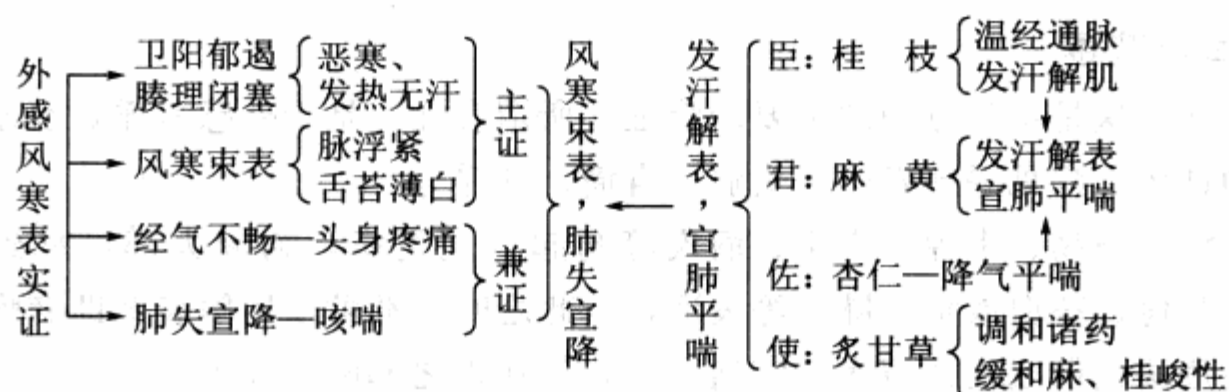
【功用】发汗解表，宣肺平喘。

【主治】外感风寒表实证。恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

【方歌】麻黄汤治太阳寒，麻桂杏草四味联，

表实无汗头身疼，脉紧气喘更恶寒。

【表解】



【配伍特点】

① 发卫气之闭以开腠理，透营分之邪以畅营阴。

② 宣降相因，止咳平喘。

【应用要点】本方为治疗外感风寒表实证的基础方。临床以恶寒发热，无汗而喘，脉浮紧为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、流行性感冒，以及急性支气管炎、支气管哮喘属风寒表实证者。

【使用注意】

① 因本方为辛温发汗之峻剂，故《伤寒论》对“疮家”、“淋家”、“衄家”、“亡血家”，以及外感表虚自汗、血虚而脉兼“尺中迟”、误下而见“身重心悸”等，虽有表寒证，亦皆禁用。纵观历代医家对此方开列的禁忌，大体有以下几点：阳虚禁汗；平素有寒，脾胃阳虚禁汗；汗家禁汗；疮家禁汗；亡血家禁汗；衄家禁汗；淋家禁汗；阴虚禁汗；营血虚禁汗。

② 只可暂用，不可久服。一服汗出，余勿尽剂。

• 桂枝汤 (《伤寒论》) •

【组成】桂枝三两 (9g) 芍药三两 (9g) 甘草炙, 二两 (6g) 生姜切, 三两 (9g) 大枣十二枚, 擘 (3枚)

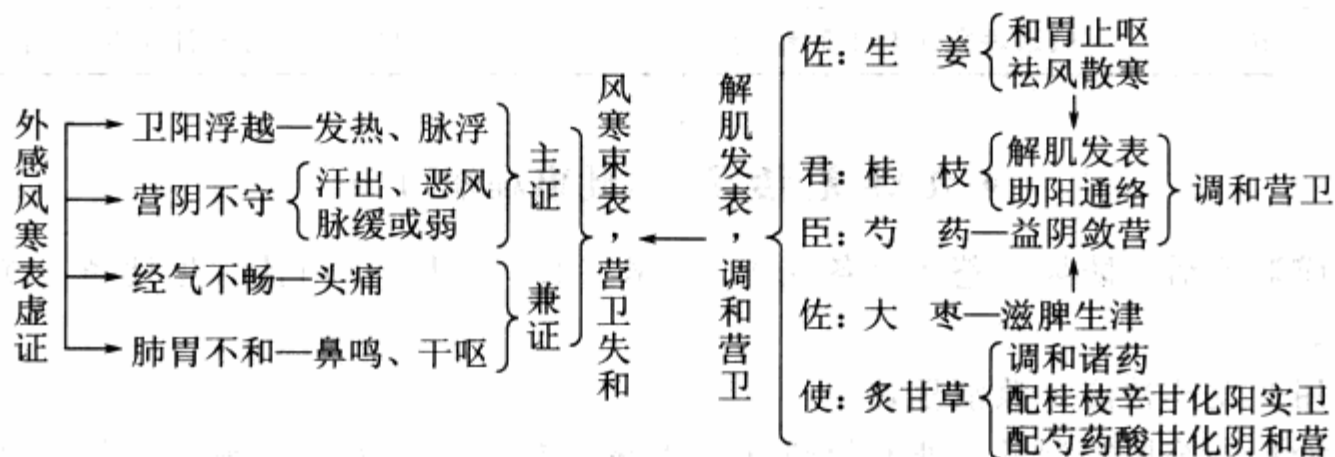
【功用】解肌发表, 调和营卫。

【主治】外感风寒表虚证。头痛发热, 汗出恶风, 鼻鸣干呕, 苔白不渴, 脉浮缓或浮弱者。

【方歌】桂枝汤用桂芍草, 佐用生姜和大枣,

啜粥温服取微汗, 调和营卫解肌表。

【表解】



【配伍特点】

- ① 散中有补, 散中有收。
- ② 阴阳并调, 邪正兼顾。

【难点提示】

(1) 桂枝芍药等量相配 方中桂枝与芍药的比例为 1:1, 目的在于散与收、邪与正的平衡, 使营卫达到“调和”(原方桂枝、芍药、生姜均等量)。

(2) 解肌发表 本方治法虽体现汗法, 但不可表述为发汗解表。解肌者强调病位深, 发表者强调正气虚, 而这正是桂枝汤证不同于麻黄汤证的关键所在, 故不可发汗解表。

(3) 卫强营弱与调和营卫 《伤寒论》言本方病机为“卫强营弱”。所以卫强者, 一则卫阳浮盛, 二则肌表邪气亢盛。所以卫强者, 实为卫阳不足, 营阴虚弱。桂枝汤可解肌发表祛邪, 又能助卫阳, 养营阴, 以调和营卫。

【应用要点】本方为治疗外感风寒表虚证的基础方, 也是调和营卫或调和阴阳的代表方剂。以发热, 恶风, 汗出, 脉浮缓为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、流行性感冒、原因不明的低热, 或多形红斑、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬季皮炎、冻疮及妊娠呕吐、产后病后低热等病, 属阴阳营卫不和者。

【使用注意】

- ① 伤寒表实证禁服桂枝汤。
- ② 注意服法: 微火煮取; 啜热稀粥 (意在养胃气、资汗源、助药力而鼓邪外出);

获效停药，不效继进；温覆取汗；药后忌口。

【类方比较】

麻黄汤与桂枝汤比较表

方名		麻黄汤	桂枝汤
组成	同	桂枝、甘草	
	异	麻黄、杏仁	芍药、生姜、大枣
功用	同	散寒解表	
	异	辛温发汗，宣肺平喘	解肌发表，调和营卫
主治	同	风寒表证，恶寒发热，舌苔薄白，脉浮	
	异	风寒表实证无汗而喘，脉浮紧	风寒表虚证有汗无喘，脉浮缓

• 九味羌活汤（《此事难知》） •

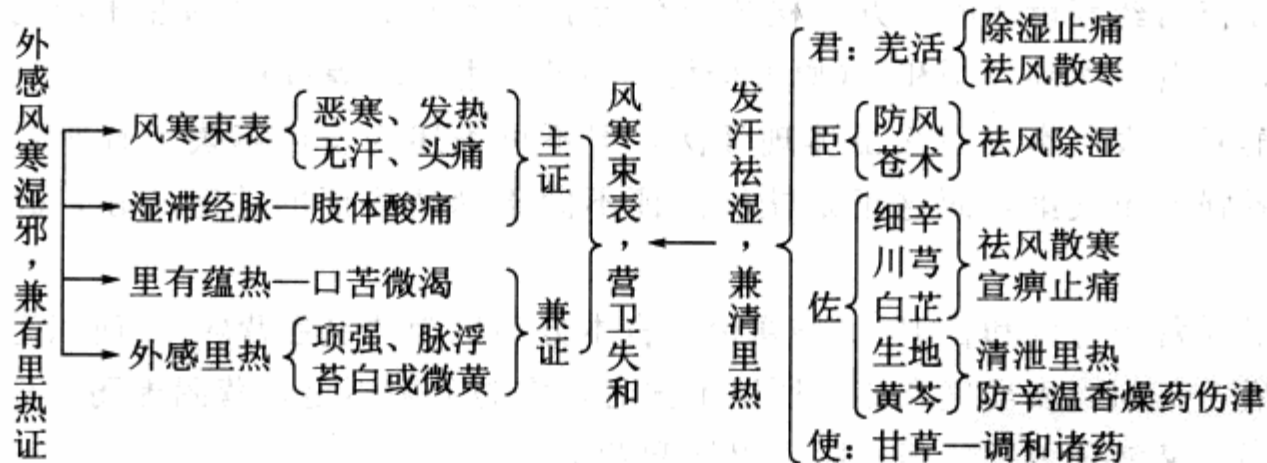
【组成】羌活 防风 苍术（各 6g） 细辛（2g） 川芎 白芷 生地黄 黄芩 甘草各（3g）

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

【主治】外感风寒湿邪，兼有里热证。恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。

【方歌】九味羌活用防风，细辛苍芷与川芎，
黄芩生地同甘草，分经论治宜变通。

【表解】



【配伍特点】

① 升散药与清热药结合。

② 体现了分经论治的思想。

【应用要点】本方为治四时感冒风寒湿邪，表实无汗而兼里热的常用方，也是体现分经论治思想的代表方。以恶寒发热，寒多热少，头痛无汗，肢体酸楚疼痛，口苦微渴为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、急性肌炎、风湿性关节炎、偏头痛等病属风寒湿兼有里热者。

【使用注意】本方偏辛温燥烈，阴虚内热及风热表证者不宜使用。

• 小青龙汤（《伤寒论》）•

【组成】麻黄去节，三两（9g） 芍药三两（9g） 细辛三两（6g） 干姜三两（6g） 甘草三两，炙（6g） 桂枝去皮，三两（9g） 半夏半升，洗（9g） 五味子半升（6g）

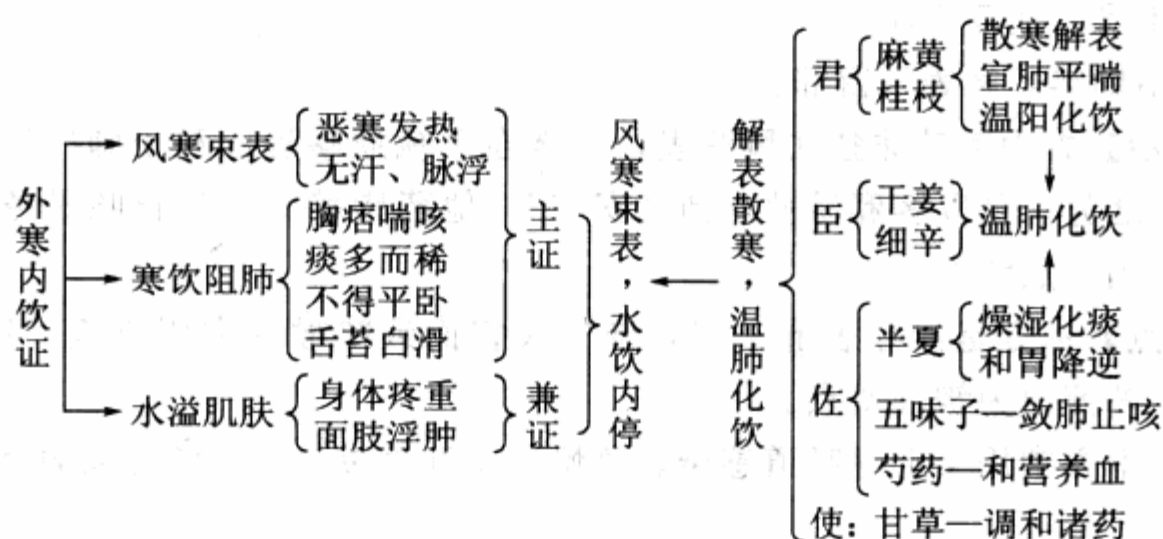
【功用】解表散寒，温肺化饮。

【主治】外寒内饮证。恶寒发热，无汗，胸痞喘咳，痰多而稀，或痰饮喘咳，不得平卧，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮者。

【方歌】小青龙汤用麻黄，桂芍辛味与干姜，

半夏炙草同剂量，表寒里饮病为殃。

【表解】



【配伍特点】

① 散中有收，散不伤正。

② 开中有合，合不留邪。

【应用要点】本方是治疗外感风寒，水饮内停咳喘证的常用方剂。以恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎的急性发作、支气管哮喘、老年性肺气肿等病属外寒内饮证者。

【使用注意】因本方偏于温散发散，易伤正气，故应注意以下几点。

① 阴虚干咳无痰，或痰热，苔黄，口渴，脉数者禁用。

② 慢性咳喘，上实下虚者，不宜久服。

③ 药量不宜过大，服药时间不宜过长。

• 止嗽散（《医学心悟》）•

【组成】桔梗炒 荆芥 紫菀蒸 百部蒸 白前蒸，各二斤（各9g） 甘草炒，十二两（3g） 陈皮去白，一斤（6g）

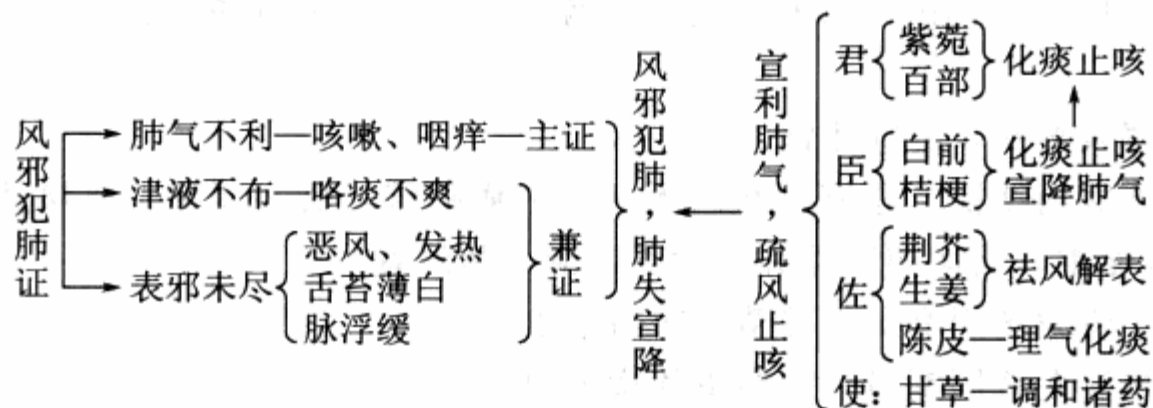
【功用】宣利肺气，疏风止咳。

【主治】风邪犯肺证。咳嗽咽痒，咯痰不爽，或微有恶风发热，舌苔薄白，脉

浮缓。

【方歌】 止嗽散内用桔梗，紫菀荆芥百部陈，
白前甘草共为末，姜汤调服止嗽频。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温而不燥，润而不膩。
- ② 散寒不助热，解表不留邪。

【难点提示】 方中荆芥非独祛风解表，关键在于疏通腠理以利于肺气通利，使全方有“启门驱贼之势。是以客邪易散，肺气安宁”。他药皆赖此，唯止咳是务，必收效甚微，故为本方画龙点睛之笔。

【应用要点】 本方是治疗表邪未尽，肺气失宣而致咳嗽的常用方剂。以咳嗽咽痒，微恶风发热，苔薄白为辨证要点。

现代临床本方常用于上呼吸道感染、急慢性支气管炎、百日咳等属表邪未尽，肺气失宣者。

【使用注意】

- ① 阴虚咳嗽或肺热咳嗽者，不宜使用。
- ② 荆芥穗、淡豆豉的用量要轻。
- ③ 不宜久煎。

第二节 辛凉解表

辛凉解表剂具有疏散风热的作用，适用于外感风热或温病初起的表证，症见发热、头痛、有汗、微恶风寒、口渴、咽痛、咳嗽、舌苔薄白或兼微黄、脉浮数等。常以辛凉解表药如薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花、葛根等为主组成方剂。以银翘散、桑菊饮、麻黄杏仁甘草石膏汤、柴葛解肌汤、升麻葛根汤为代表方剂。

• 银翘散（《温病条辨》）•

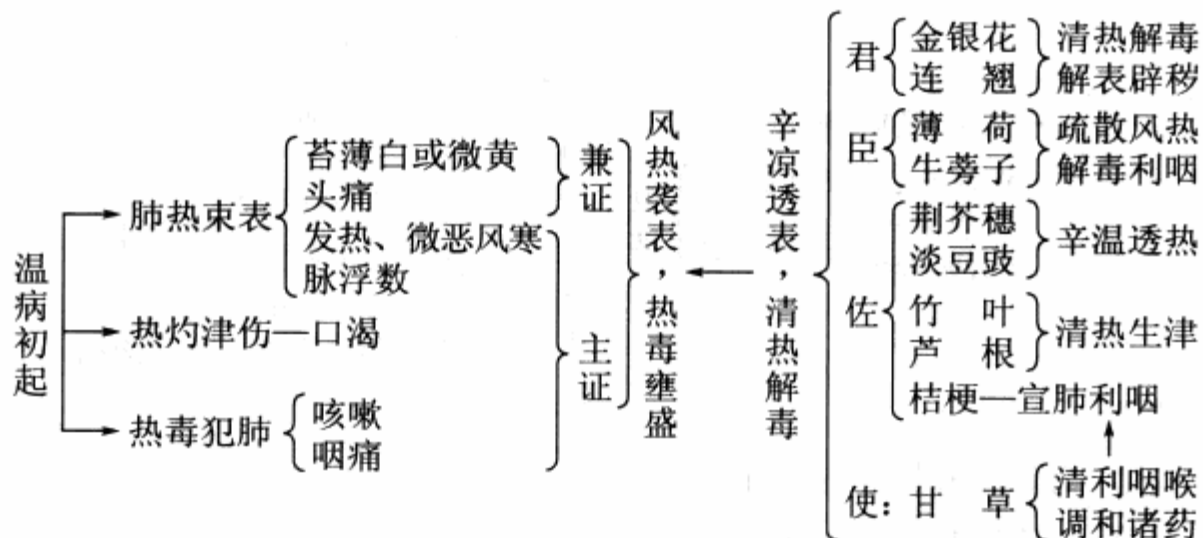
【组成】 连翘 银花各一两（各 15g） 苦桔梗 薄荷 牛蒡子各六钱（各 6g） 竹叶 荆芥穗各四钱（各 4g） 生甘草 淡豆豉各五钱（各 5g）

【功用】 辛凉透表，清热解毒。

【主治】 温病初起。发热，无汗或有汗不畅，微恶风寒，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。

【方歌】 银翘散主上焦病，竹叶荆牛豉薄荷，
甘桔芦根凉解法，清疏风热煮无过。

【表解】



【配伍特点】

- ① 凉温并用。辛凉之中少佐辛温之品，既有利于透邪外出，又不违辛凉之旨。
- ② 清疏兼顾。疏散外邪与清热解毒同用，既外散风热、透邪解表，又兼清热毒、芳香辟秽。

【难点提示】

① 制性存用。方中配伍辛温之荆芥穗和淡豆豉，意在制性存用，即通过方中寒凉药物制约二者之温热，而存其宣透之用。淡豆豉依其炮制不同，性能不同，而《温病条辨》吴氏在本方中所用为辛温的淡豆豉。故方中用辛温的荆芥穗和淡豆豉的目的有二：一为宣郁透邪。外感风热，本身常兼腠理闭塞。二为防方中寒凉药物遏阻留邪。

② 为何要清热解毒。方中以清热解毒为主的金银花、连翘为君药，意在防止截断邪气，热毒传变。

【应用要点】 本方为“辛凉平剂（《温病条辨》）”，为治疗风热表证的常用方。临床以发热，微恶风寒，咽痛，口渴，脉浮数为辨证要点。

现代临床常用于流行性感、急性扁桃体炎、麻疹初起，以及乙型脑炎、流行性脑膜炎、腮腺炎等初起属卫分风热证候者。

【使用注意】

① 宜用煮散，不宜久煎。方中多为芳香轻宣之品，故原方用“煮散”剂型，可取速效，并根据病情决定服药次数，体现吴氏“治上焦如羽，非轻莫举”的用药原则，至今对于辛凉解表方剂的法有普遍的临床意义。即“上杵为散，每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服。勿过煮，肺药取轻清，过煮则味厚而入中焦矣”。

② 对于外感风寒及湿热病初起则当禁用。

• 桑菊饮（《温病条辨》）•

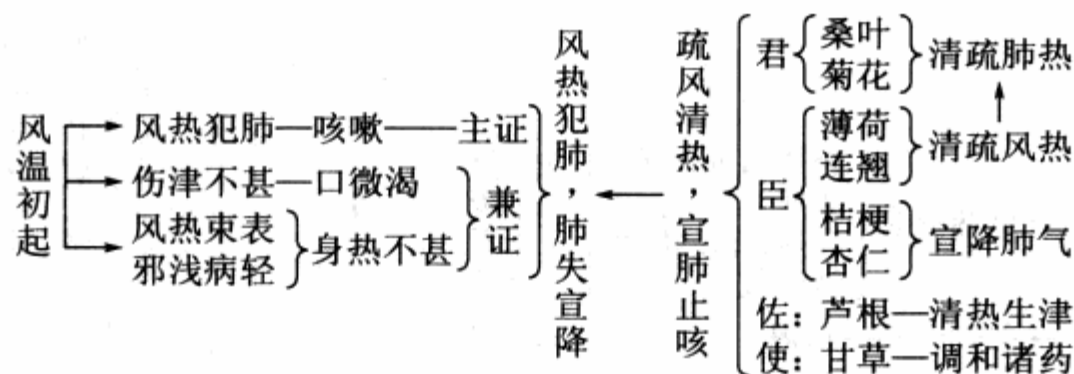
【组成】 桑叶二钱五分（7.5g）菊花一钱（3g）连翘一钱五分（5g）杏仁 桔梗 苇根各二钱（各 6g）薄荷八分（2.5g）生甘草八分（2.5g）

【功用】 疏风清热，宣肺止咳。

【主治】 风温初起。但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数。

【方歌】桑菊饮中桔杏翘，芦根甘草薄荷饶，
清疏肺卫轻宣剂，风温咳嗽服之消。

【表解】



【配伍特点】

- ① 轻清宣散，疏散风热以清头目。
- ② 辛苦宣降，理气肃肺以止咳嗽。

【应用要点】本方为“辛凉轻剂（《温病条辨》）”，为治疗风热咳嗽轻证的常用方剂。以咳嗽，发热不甚，微渴，脉浮数为辨证要点。

现代临床本方常用于流行性感冒、急性支气管炎、急性扁桃体炎、上呼吸道感染等属风热犯肺之轻证者。

【使用注意】

- ① 肺热甚者，加味运用。
- ② 风寒咳嗽，不宜使用。
- ③ 药味清轻，不宜久煎。

【类方比较】

银翘散与桑菊饮比较表

方名		银翘散	桑菊饮
组成	同	连翘、芦根、薄荷、桔梗、甘草	
	异	金银花、竹叶、牛蒡子、荆芥、淡豆豉	桑叶、杏仁、菊花
功用	同	疏风解表，清热解毒，止咳利咽	
	异	解表、清热力强（辛凉平剂）	宣肺止咳力大（辛凉轻剂）
主治	同	风热表证，症见发热口渴，咳嗽，脉浮数	
	异	温病初起，表热重证 发热咽痛，无汗恶寒，舌红脉浮数	风温初起，表热轻证但咳，余症不显

• 麻黄杏仁甘草石膏汤（《伤寒论》） •

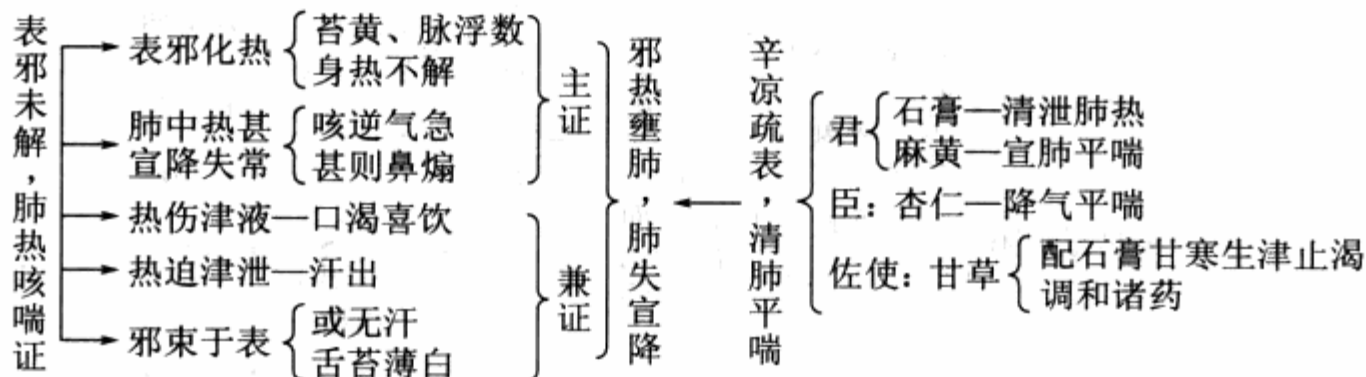
【组成】麻黄四两，去节（9g） 杏仁五十个，去皮尖（9g） 甘草二两，炙（6g） 石膏半斤，碎、绵裹（18g）

【功用】辛凉疏表，清肺平喘。

【主治】表邪未解，肺热咳喘证。身热不解，咳逆气急鼻煽，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉浮而数者。

【方歌】伤寒麻杏甘石汤，汗出而喘法度良，
辛凉宣泄能清肺，定喘除热效力彰。

【表解】



【配伍特点】

- ① 疏表与清肺并用，以清为主。
- ② 宣肺与降气结合，以宣为主。

【难点提示】

(1) 麻黄与石膏的配伍 麻黄配伍石膏，取其制性存用之意。以石膏之寒凉制约麻黄温热之性，而存其宣透之用，目的在于宣肺泻热，即“火郁发之”。二者宣肺不助热，清肺不留邪，全方仍不失为辛凉之剂。

(2) 石膏与麻黄的比例 原方石膏用量倍于麻黄，为 2 : 1（石膏半斤：麻黄四两），在临床应用时一般可作如下调整。

① 有汗，无大热者（邪热壅肺），为 5 : 1，或加清热药（如黄芩、知母等），突出清。

② 无汗，有大热者（邪热闭肺），为 3 : 1，或加辛凉之品（如桑叶、薄荷等），突出散。

【应用要点】本方为辛凉重剂，为治疗表邪未解、肺热咳喘证的基础方。临床以发热，喘急，苔薄黄为辨证要点。

现代临床常用于治疗流行性感、急性气管炎、支气管哮喘、各种肺炎属肺热炽盛者。

【使用注意】风寒咳喘，痰热壅盛者，非本方所宜。

• 柴葛解肌汤（《伤寒六书》）•

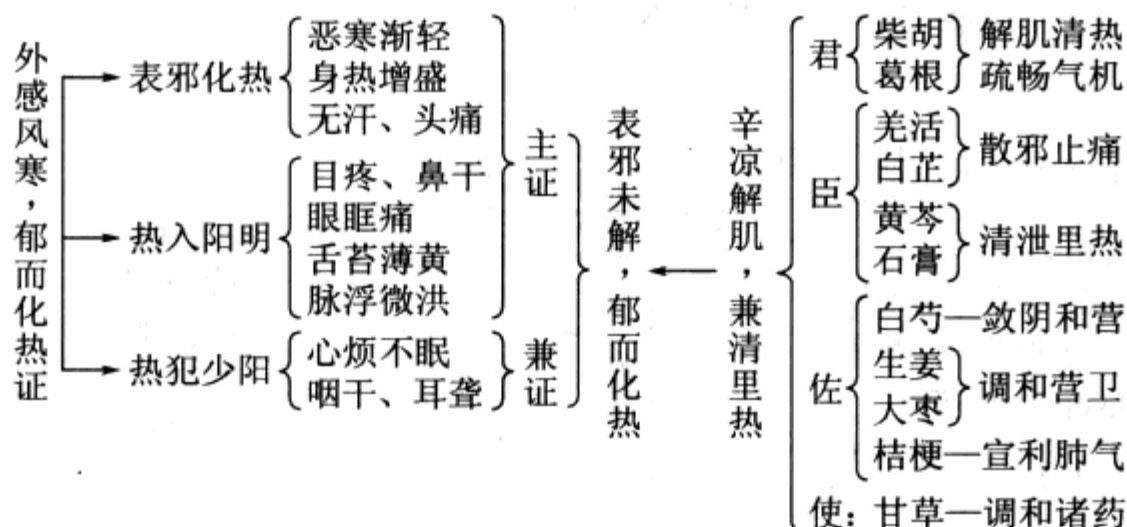
【组成】柴胡 黄芩 芍药（各 6g） 干葛（9g） 甘草 羌活 白芷 桔梗（各 3g）

【功用】解肌清热。

【主治】外感风寒，郁而化热证。恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。

【方歌】 陶氏柴葛解肌汤，邪在三阳热势张，
芩芍桔甘羌活芷，石膏大枣与生姜。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温清并用，以清泄里热为主。
- ② 表里同治，以辛凉解肌为主。

【应用要点】 本方是治疗表寒未解，入里化热，初犯阳明或三阳合病的常用方剂。以发热重，恶寒轻，头痛，眼眶痛，鼻干，脉浮微洪为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、流行性感冒等属外感风寒，邪郁化热证候者。

【使用注意】

- ① 表邪未入里者，不宜使用，恐引邪入里。
- ② 若里热而见阳明腑实（便秘、腹痛）者，不宜使用。

• 升麻葛根汤（《太平惠民和剂局方》）•

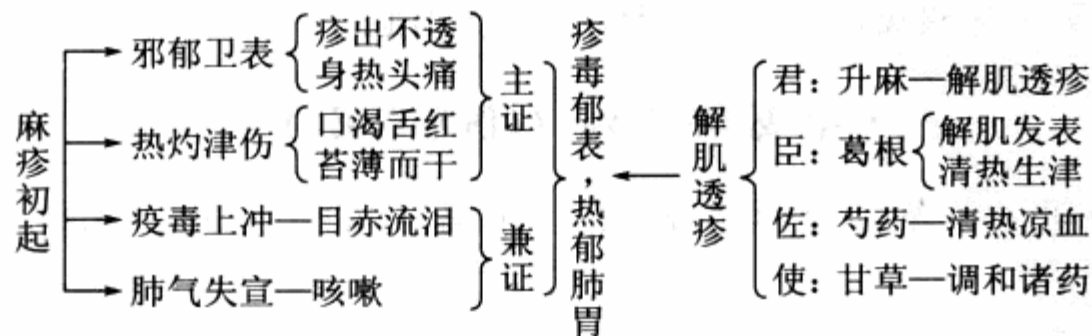
【组成】 升麻 芍药 甘草炙 各十两（300g） 葛根十五两（450g）

【功用】 解肌透疹。

【主治】 麻疹初起。疹出不透，身热头痛，咳嗽，目赤流泪，口渴，舌红，苔薄而干，脉浮数。

【方歌】 阎氏升麻葛根汤，芍药甘草合成方，
麻疹初期发不透，解肌透疹此方良。

【表解】



【应用要点】 本方为治疗麻疹未发或发而不透的基础方。以疹出不畅，舌红，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于麻疹初起、疹发不透，以及单纯疱疹、水痘等属疹毒郁表，热郁肺胃者。

【使用注意】若麻疹已透，以及疹毒内陷而见气急喘咳者不宜使用。

第三节 扶正解表

扶正解表剂适用于体质素虚而兼表证者。人体之虚，又有阴阳气血之不同，故常以解表药分别配伍益气、助阳、滋阴、养血药物组成方剂，使表证得解，正气不伤。以败毒散、参苏饮、再造散、加减葳蕤汤为代表方剂。

• 败毒散（《太平惠民和剂局方》）•

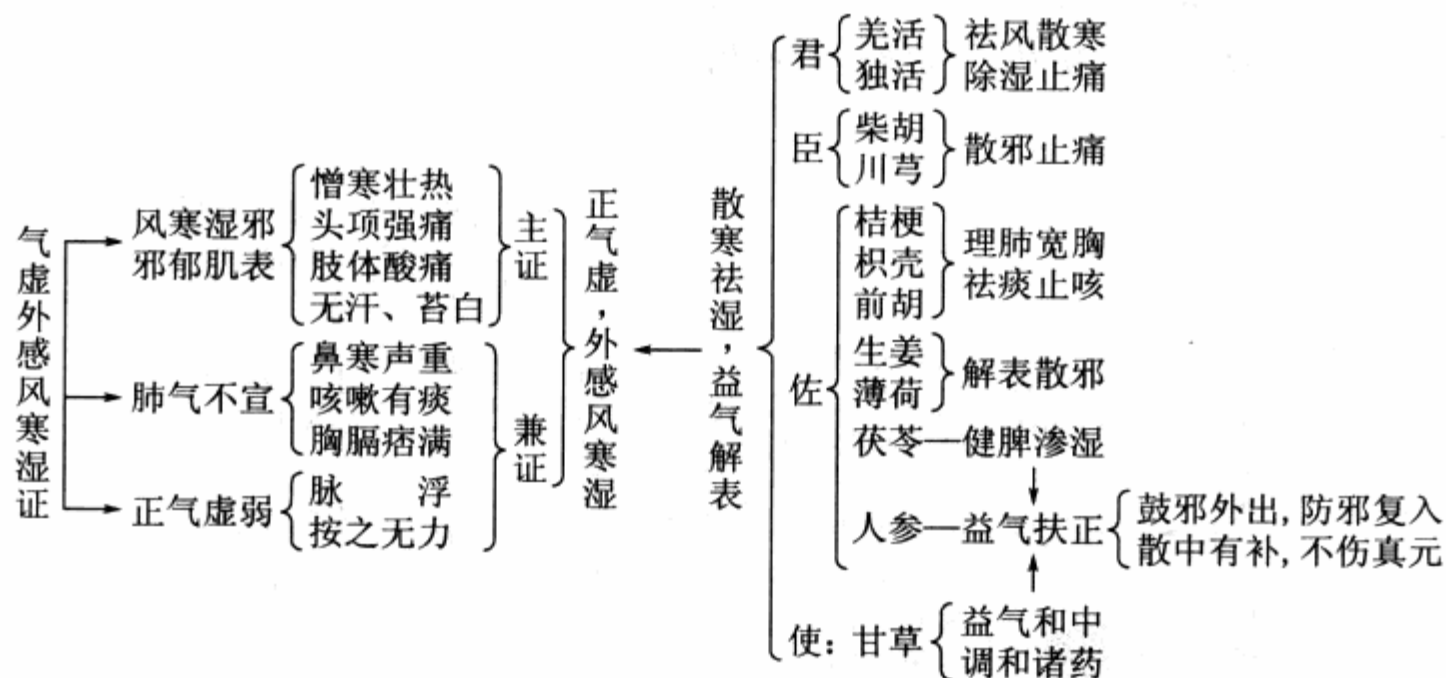
【组成】柴胡去苗 前胡去苗，洗 川芎 枳壳去瓢，麸炒 羌活去苗 独活去苗 茯苓去皮 桔梗 人参去芦 甘草各三十两（各 900g）

【功用】散寒祛湿，益气解表。

【主治】气虚，外感风寒湿证。憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉浮而按之无力。

【方歌】人参败毒茯苓草，枳桔柴前羌独芎，
薄荷少许姜三片，时行感冒有奇功。

【表解】



【配伍特点】

- ① 寓补于散（解表散邪兼益气扶正）。
- ② 内外并调（解表散邪兼健脾、渗湿、理气、化痰）。

【难点提示】

(1) 逆流挽舟 这是本方治疗外感夹湿型痢疾所体现的独特治法。痢疾初起兼有恶寒、发热、头痛、身痛、无汗等表证者使用该方。该方疏表除湿，寓散于通，使表解而里滞亦除。即前人所谓从表陷者仍当由里出表，如逆水挽船上行之意，故称逆流挽舟。

(2) 人参的配伍意义 该方配伍少量人参（约为全方十分之一），原为小儿外感而

设，虑及小儿脏腑娇嫩，元气未充，意在培其元气，以败邪毒。后用于成人气虚外感风寒湿证，其意在于通过扶助正气鼓邪外出，防邪复入及散中有补，不伤真元，全非补虚之用。

【应用要点】本方是益气解表的常用方剂。以憎寒壮热，肢体酸痛，无汗，脉浮按之无力为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、支气管炎、过敏性皮炎、荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒症等属风寒夹湿者。

【使用注意】

- ① 本方辛温香燥之品较多，外感风热或阴虚外感者都不可使用。
- ② 疫毒、暑湿或湿热导致的痢疾不可用。

• 参 苏 饮 (《太平惠民和剂局方》) •

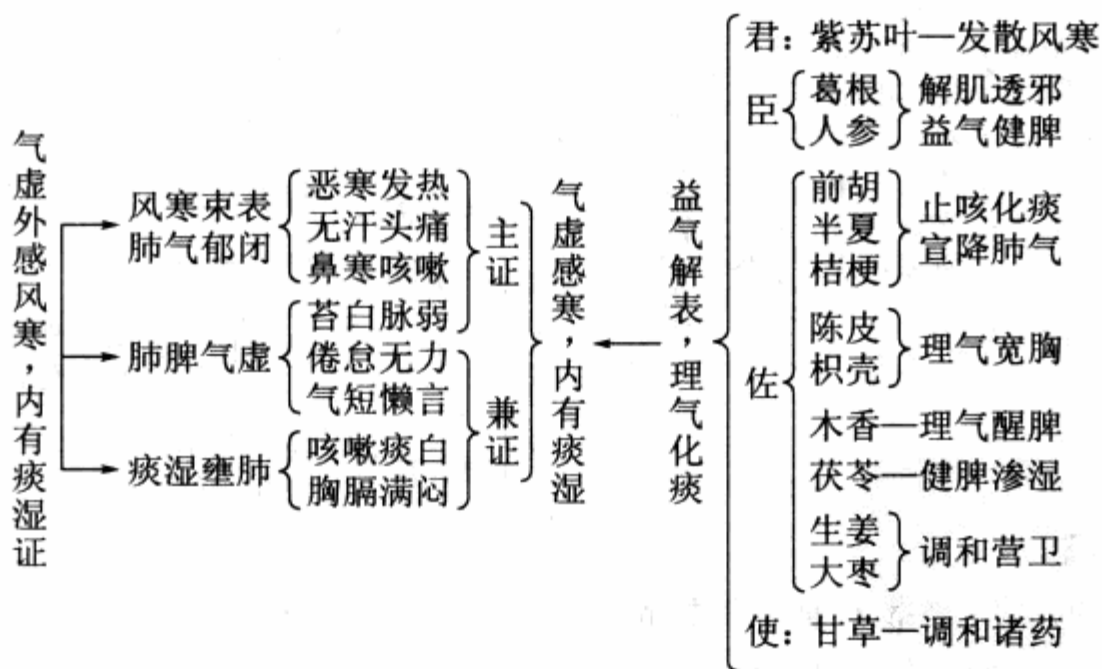
【组成】人参 紫苏叶 干葛 半夏汤洗姜汁炒 前胡 茯苓各三分（各 6g） 木香 枳壳麸炒 桔梗 陈皮 炙甘草各半两（各 4g）

【功用】益气解表，理气化痰。

【主治】气虚外感风寒，内有痰湿证。恶寒发热，无汗，头痛，鼻塞，咳嗽痰白，胸膈满闷，倦怠无力，气短懒言，舌苔白，脉弱。

【方歌】参苏饮内用陈皮，枳壳前胡半夏齐，
干葛木香甘桔茯，气虚外感最相宜。

【表解】



【配伍特点】

- ① 散补并行，则散不伤正，补不留邪。
- ② 气津并调，使气行痰消，津行气畅。

【应用要点】本方为治疗气虚外感风寒，内有痰湿证的常用方剂。以恶寒发热，无汗头痛，咳嗽痰白，胸膈满闷，倦怠乏力，苔白，脉弱为辨证要点。

现代临床常用于感冒、上呼吸道感染等属气虚外感风寒证候者。

• 麻黄细辛附子汤 (《伤寒论》) •

【组成】麻黄去节二两 (6 克) 附子炮，去皮，一枚，破八片 (9 克) 细辛二两 (3 克)

【功用】助阳解表。

【主治】

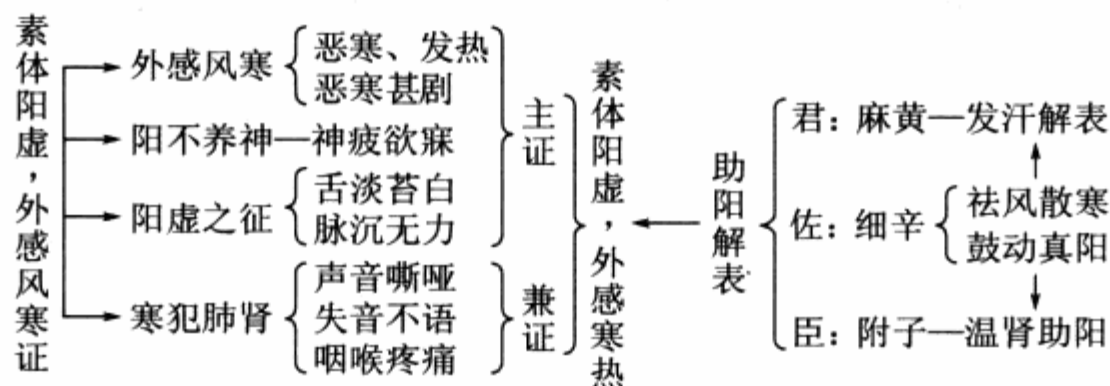
① 素体阳虚，外感风寒证。发热，恶寒甚剧，虽厚衣重被，其寒不解，神疲欲寐，脉沉微。

② 暴哑。突发声音嘶哑，甚至失音不语，或咽喉疼痛，恶寒发热，神疲欲寐，舌淡苔白，脉沉无力。

【方歌】麻黄细辛附子汤，太少两感用此方，

发热恶寒脉不起，温经解表有专长。

【表解】



【配伍特点】

① 补散兼施，表里同治。

② 宣上温下，上下同治。

【应用要点】本方既是治疗少阴阳虚，外感风寒的代表方、基础方，又是治疗大寒客犯肺肾所致咽痛声哑的常用方。以恶寒重，发热轻，神疲欲寐，脉沉为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、流行性感冒、支气管炎、鼻窦炎、风湿性关节炎、过敏性鼻炎、暴盲、暴哑、喉痹、皮肤瘙痒等属阳虚感寒者。

【使用注意】若少阴阳虚而见下利清谷、四肢厥逆、脉微欲绝等症，则应遵仲景“先温其里，乃攻其表”的原则，否则误发其汗，必致亡阳危候。

• 加减葳蕤汤 (《通俗伤寒论》) •

【组成】生葳蕤 (玉竹) 二钱至三钱 (9g) 淡豆豉三钱至四钱 (9g) 红枣二枚 生葱白二枚至三钱 (6g) 炙甘草五分 (1.5g) 桔梗 苏薄荷各一钱至钱半 (各 5g) 东白薇五分至一钱 (3g)

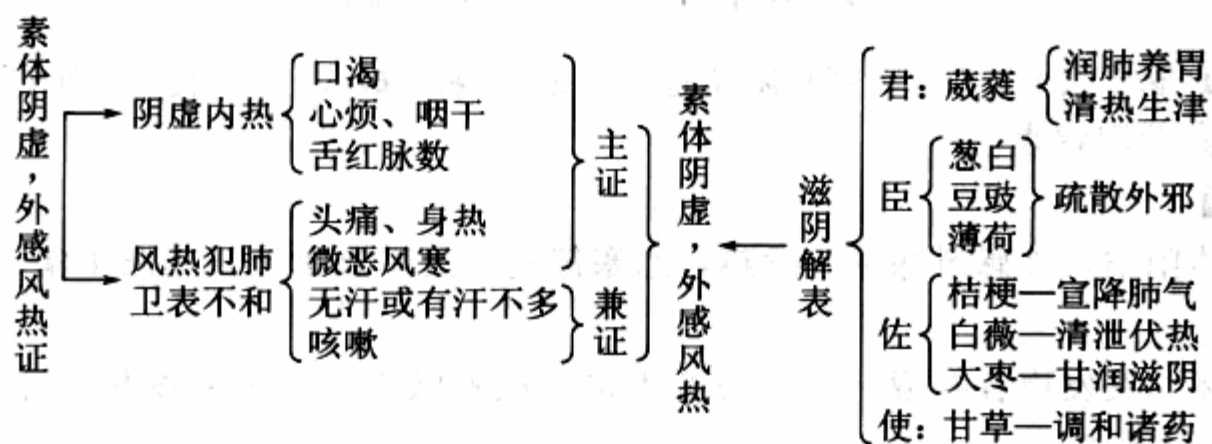
【功用】滋阴解表。

【主治】素体阴虚，外感风热证。头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，咳嗽，心烦，口渴，咽干，舌红脉数。

【方歌】加减葳蕤用白薇，豆豉葱白桔梗随，

草枣薄荷八味共，滋阴发汗功可慰。

【表解】



【配伍特点】发汗不伤阴，滋阴不碍邪。

【应用要点】本方专为素体阴虚，感受风热而设。以身热微寒，咽干口燥，舌红，苔薄白，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于老年人及产后感冒、急性扁桃体炎、咽炎等属阴虚外感者。

第二章 泻下剂

一、定义

凡以泻下药为主组成，具有通便、泻热、攻积、逐水等作用，用以治疗里实证的方剂，统称为泻下剂。属于“八法”中的“下法”。

二、立法依据

“其下者，引而竭之”，“其实者，散而泻之”。

三、适应范围

凡因燥屎内结、冷积不化、瘀血内停、宿食不消、结痰停饮、虫积所致的里结成实之证，均可用泻下剂治疗。

四、分类与配伍规律

泻下剂	寒下剂—热结证—以寒下药为主，配伍理气药
	温下剂—寒结证—常用泻下药配伍温里药
	润下剂—燥结证—常用润下药配伍寒下药
	逐水剂—水结证—常用逐水药配伍益胃药
	攻补兼施剂—里实正虚证—常用泻下药配伍补益药

五、使用注意

- ① 明辨表里。表证未解，里实已成，先表后里或表里双解。
- ② 兼顾体质。本类方剂较为峻烈，年老体弱、孕妇、产后、病后、经期要慎用，最好用润下或攻补兼施。
- ③ 中病即止。本类方剂较为峻烈，易伤胃气，故得效即止，慎勿过剂。
- ④ 服药忌口。忌油腻、不易消化的食物，否则加重胃气损伤。

第一节 寒 下

寒下剂具有攻下清热的作用；适用于里热积滞实证。症见大便秘结、腹部胀满疼痛、甚或潮热、舌苔厚、脉实等。常以寒下药如大黄、芒硝等为主组成方剂。代表方为大承气汤、大陷胸汤、大黄牡丹皮汤等。

• 大承气汤（《伤寒论》）•

【组成】大黄酒洗，四两（12g） 厚朴去皮，炙，八两（24g） 枳实炙，五枚（12g） 芒硝三合（9g）

【功用】峻下热结。

【主治】

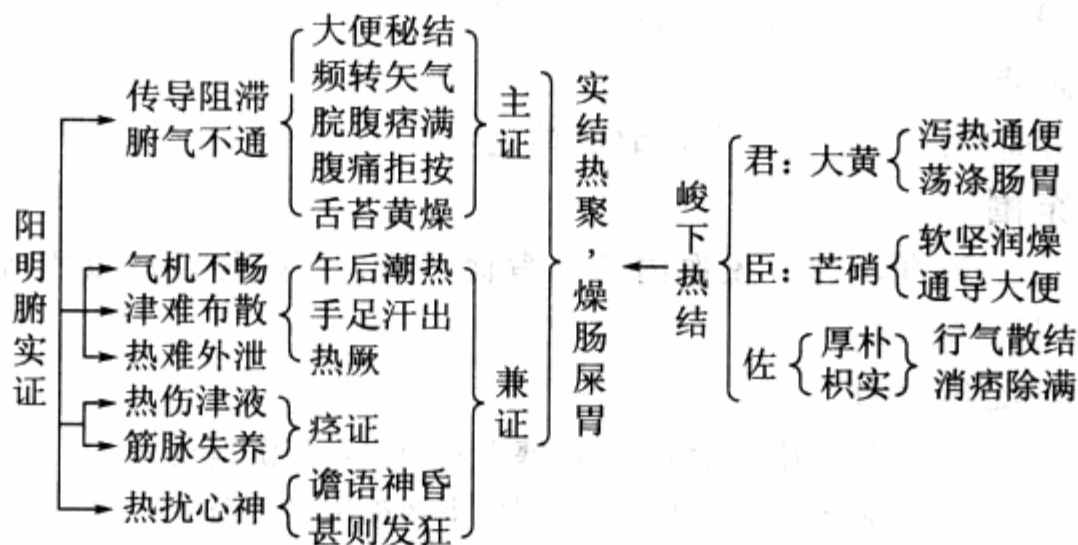
① 阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。

② 热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。

③ 里实热证之热厥、痉病或发狂等。

【方歌】 大承气汤用硝黄，配伍枳朴泻力强，
痞满燥实四症见，峻下热结宜此方，
去硝名曰小承气，便鞭痞满泻热良，
调胃承气硝黄草，便秘口渴急煎尝。

【表解】



【配伍特点】 泻下与行气并用。

【难点提示】

(1) 通因通用 本方用治热结旁流，乃取“通因通用”之意。“热结旁流”是因为燥粪结于肠中，逼迫津液从旁而下，故下利清水，色纯青，气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。旁流是假象，热结是本质，可因势利导，“通因通用”。为反治之法。

(2) 寒因寒用 本方用治热厥，乃取“寒因寒用”之意。因实热积滞闭阻于里，阳气内郁，不达四肢，可见四肢厥冷之热证。厥冷是假象，热结是本质。可用寒下使热结得下，阳气自可敷布外达。为反治之法。

(3) 釜底抽薪、急下存阴 本证由于实热积滞胃肠，热盛而津液大伤，全方峻下实热燥结，从根本上图治，好比抽去锅底燃烧的柴草，以存阴救阳，而不可用滋阴之品，此法称“釜底抽薪、急下存阴”。为正治之法。

【应用要点】 本方为治疗阳明腑实证的基础方，又是寒下法的代表方。临床以痞、满、燥、实四症，以及舌红苔黄、脉沉实为辨证要点。

现代临床本方常用于急性单纯性肠梗阻、急性胆囊炎、急性阑尾炎、急性胰腺炎等属阳明腑实证者。

【使用注意】

① 煎服方法。先煎枳实、厚朴，后下大黄，芒硝溶服。

② 中病即止。本方药力峻猛，应中病即止，慎勿过剂。

③ 凡表证未解、肠胃热结尚未成实、气虚阴亏、年老体弱、孕妇等，均不宜使用本方。

④ 急性阑尾炎合并腹膜炎或有休克症状者，以及绞窄性肠梗阻及肿瘤梗阻者，均不宜使用本方。

【类方比较】

大承气汤、小承气汤与调胃承气汤比较表

比较 \ 方名		大承气汤	小承气汤	调胃承气汤
组成	同	大黄		
	异	芒硝、枳实、厚朴	厚朴、枳实	甘草、芒硝
功用	同	泻下热结		
	异	峻下热结	轻下热结	缓下热结
主治	同	阳明病		
	异	阳明腑实证里热结实。症见腑气不通，大便不通，频传矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之硬，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉实	阳明腑实证。症见谵语便硬，潮热，舌苔老黄，脉滑而疾	阳明病胃肠燥热证。症见恶热，口渴，便秘，腹满拒按，舌苔正黄，脉滑数

• 大黄牡丹汤（《金匮要略》） •

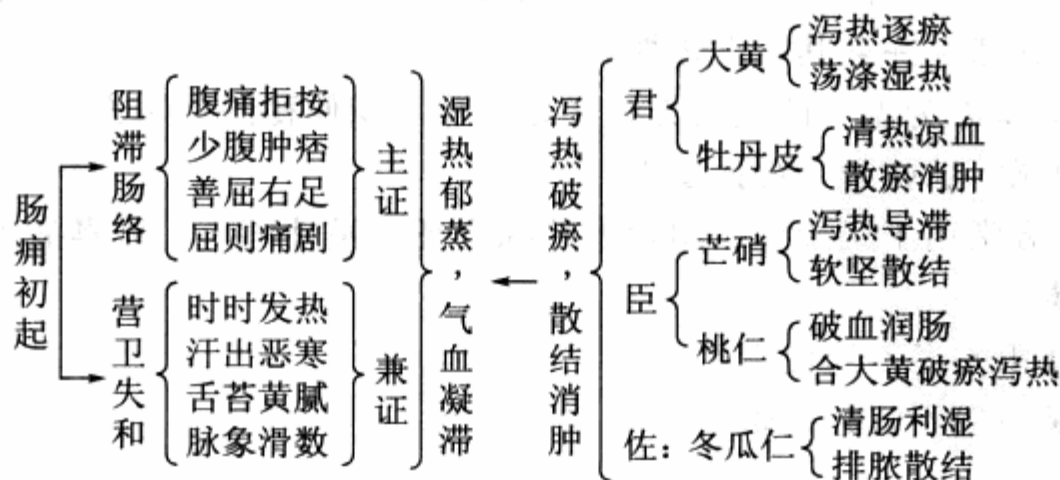
【组成】 大黄四两（12g） 牡丹一两（9g） 桃仁五十个（12g） 瓜子半升（30g） 芒硝三合（9g）

【功用】 泻热破瘀，散结消肿。

【主治】 肠痈初起，湿热瘀滞证。右少腹疼痛拒按，按之其痛如淋，甚则局部肿痞，或右足屈而不伸，伸则痛剧，小便自调，或时时发热，自汗恶寒，舌苔薄腻而黄，脉滑数。

【方歌】 金匮大黄牡丹汤，桃仁瓜子芒硝襄，
肠痈初起腹按痛，苔黄脉数服之康。

【表解】



【配伍特点】 泻下、清利、破瘀并用。

【应用要点】 本方为治疗湿热血瘀肠痈的常用方。以少腹疼痛拒按，右足屈而不伸，舌苔黄，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性单纯性阑尾炎、子宫附件炎、盆腔炎、输精管结扎后感染

等属于湿热瘀滞者。

【使用注意】

- ① 肠痈有湿热瘀滞与寒湿瘀滞之分，本方只宜用于湿热瘀滞证。
- ② 本方之煎法。大黄与他药同煎，后下芒硝，取大黄苦寒清热及活血化瘀之功。
- ③ 老人、孕妇或体质过于虚弱者，均应慎用。

第二节 温 下

温下剂适用于因寒成结之里实证，症见大便秘积、脘腹胀满、腹痛喜按、手足不温、甚或厥冷、脉沉等。常用泻下药配伍温里药组成方剂，代表方为大黄附子汤、温脾汤。

• 大黄附子汤（《金匮要略》）•

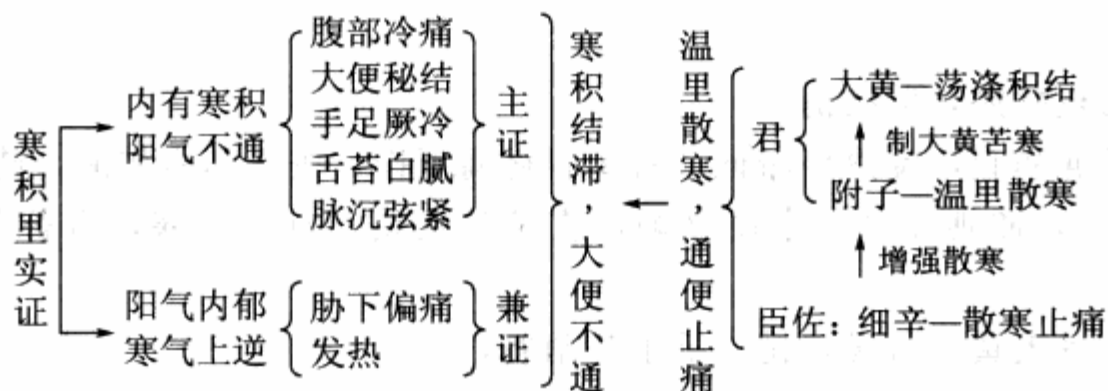
【组成】 大黄三两（9g） 附子炮，三枚（9g） 细辛二两（3g）

【功用】 温里散寒，通便止痛。

【主治】 寒积里实证。腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥冷，舌苔白腻，脉弦紧。

【方歌】 金匮大黄附子汤，细辛散寒止痛良，
冷积内结成实证，攻专温下妙非常。

【表解】



【配伍特点】 辛热苦寒并用，体现温下。

【难点提示】 全方体现制性存用之法，大黄虽为苦寒之品，但配伍附子、细辛辛散大热之品，则制其寒性并存其泻下之性。

【应用要点】 本方为温下的代表方，又是治疗寒积便秘的常用方。临床以便秘腹痛，手足不温，苔白腻，脉弦紧为辨证要点。

现代临床本方常用于胆绞痛、胆囊术后综合征、慢性痢疾、尿毒症等属寒积者。

【使用注意】

- ① 有实热或阳亢者不能使用。
- ② 大黄用量一般不宜超过附子。

• 温脾汤（《备急千金要方》）•

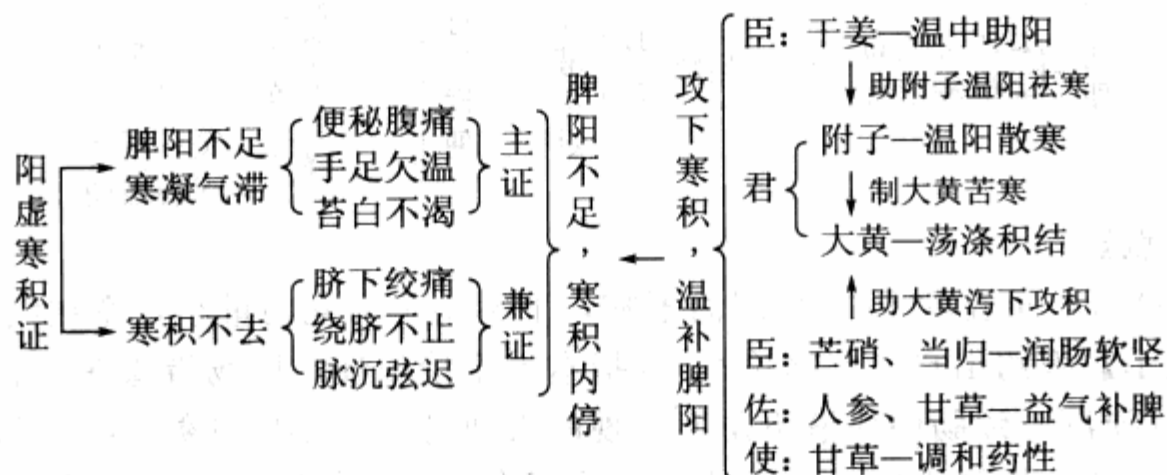
【组成】 大黄五两（15g） 附子 人参 芒硝 甘草各二两（各 6g） 干姜 当归各三两（各 9g）

【功用】 攻下寒积，温补脾阳。

【主治】阳虚寒积证。便秘腹痛，脐下绞痛，绕脐不止，手足欠温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

【方歌】温脾参附与干姜，甘草当归硝大黄，
寒热并行治寒积，脐腹绞结痛非常。

【表解】



【配伍特点】

- ① 攻下与温里并用。
- ② 攻补兼施，攻而不伤正，补而不碍邪。

【难点提示】全方亦体现制性存用之法，大黄、芒硝虽为寒凉之品，但与辛散大热之附子、干姜和甘温之人参、炙甘草配伍，则硝、黄之寒性被制约而泻下之用仍存。

【应用要点】本方为温下剂的常用方剂。以腹痛，便秘，手足不温，畏寒喜热，苔白，脉沉弦而迟为辨证要点。

现代临床本方常用于急性单纯性肠梗阻或不全梗阻等属寒积内停证者。

【使用注意】

- ① 寒凉药用量小于温热药。
- ② 《备急千金要方》还另有一“温脾汤”组方与本方大同小异。

第三节 润下

润下剂适用于肠燥津亏，大便秘结之证。症见大便秘结，小便短赤，或有身热，口干，腹胀或痛，舌红苔黄，脉滑数等。

• 麻子仁丸（《伤寒论》）•

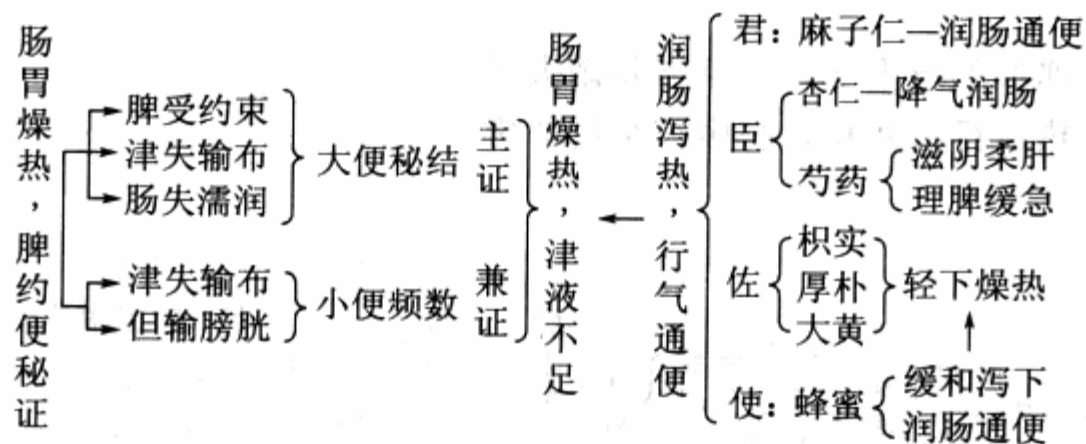
【组成】麻子仁二升（500g） 芍药半斤（250g） 枳实半斤，炙（250g） 大黄一斤，去皮（500g） 厚朴一尺，炙，去皮（250g） 杏仁一升，去皮、尖，熬，别作脂（250g）

【功用】润肠泻热，行气通便。

【主治】肠胃燥热，脾约便秘证。大便秘结，小便频数。

【方歌】麻子仁丸治脾约，大黄枳朴杏仁芍，
胃热津枯便难解，润肠通便功效高。

【表解】



【配伍特点】

① 攻润结合，重在润下。② 润而不膩，下不伤正（丸剂量小，意在缓下）。

【难点提示】脾约出自《伤寒论》，专指本方主治病证，即肠胃燥热，脾受约束，脾不能为胃行其津液，致肠中津液不足而出现的大便秘结、小便频数。《注解伤寒论》曰：“约者，约束之约，胃强脾弱，约束津液不得四布，但输膀胱，致小便数大便难。”

【应用要点】本方为治疗脾约证的常用方，又是润下法的代表方。以大便秘结，小便频数，舌苔微黄为辨证要点。

现代临床本方常用于习惯性便秘、老人与产后便秘、痔疮术后便秘等属肠胃燥热者。

【使用注意】

① 年老体虚者不能常服。② 孕妇慎用。③ 纯属血少津亏的便秘慎用。

• 济川煎（《景岳全书》）•

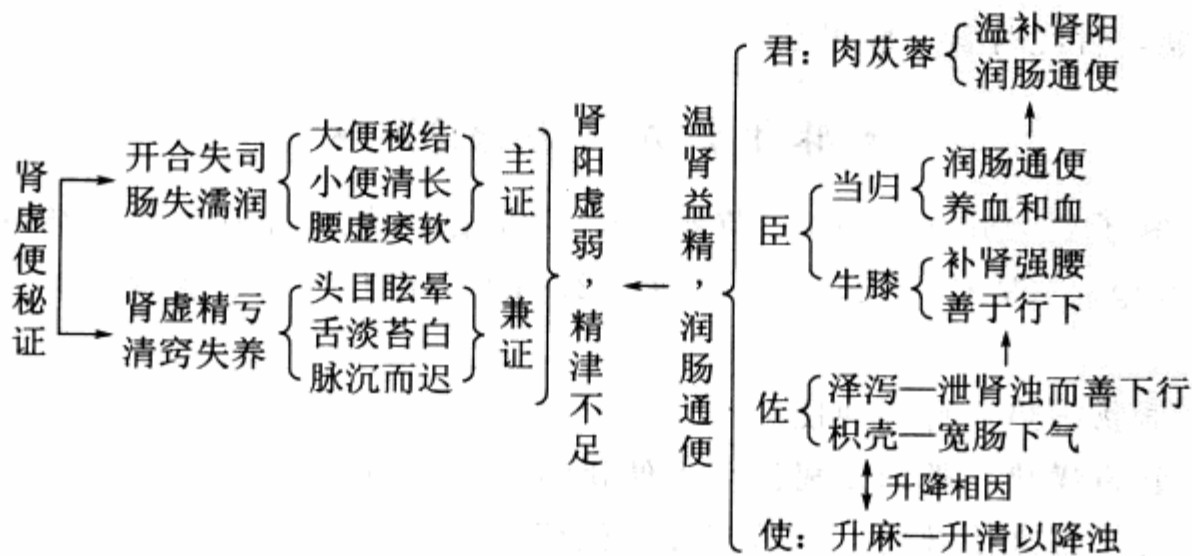
【组成】当归三至五钱（9~15g） 牛膝二钱（6g） 肉苁蓉酒洗去咸，二至三钱（6~9g） 泽泻一钱半（4.5g） 升麻五分至七分或一钱（1.5~2.5g 或 3g） 枳壳一钱（3g）

【功用】温肾益精，润肠通便。

【主治】肾阳虚弱，精津不足证。大便秘结，小便清长，腰虚痿软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟。

【方歌】济川归膝肉苁蓉，泽泻升麻枳壳从，
肾虚津亏肠中燥，寓通于补法堪宗。

【表解】



【配伍特点】寓通于补，寄降于升。

【应用要点】本方为治疗肾虚便秘的常用方。以大便秘结，小便清长，腰虚痿软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟为辨证要点。

现代临床本方常用于习惯性便秘、老年人便秘等属肾虚津亏肠燥者。

【使用注意】热甚伤津及阴虚者忌用。

第四节 逐 水

逐水剂适用于水饮壅盛于里之实证。本类方剂具有攻逐水饮的作用，能使体内积水通过大小便排出，从而达到消除积水肿胀的目的。常以峻泻逐水药如芫花、甘遂、大戟、牵牛子等为主组成。代表方为十枣汤。

• 十 枣 汤 (《伤寒论》) •

【组成】芫花熬 甘遂 大戟各等分

【功用】攻逐水饮。

【主治】

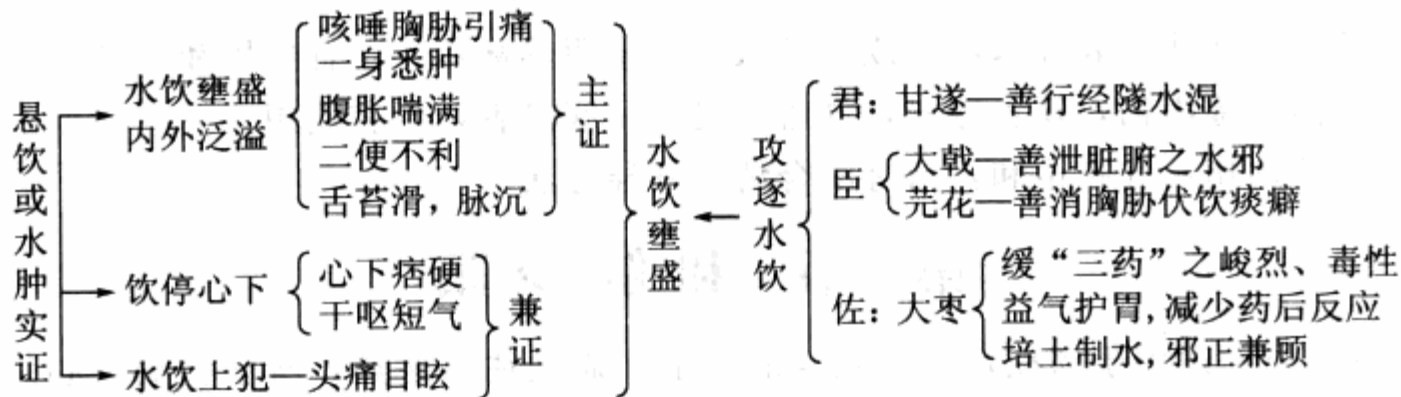
① 悬饮。咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦。

② 水肿。一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利。

【方歌】十枣逐水效甚夸，大戟甘遂与芫花，

悬饮内停胸胁痛，大腹肿满用无恙。

【表解】



【配伍特点】

① 三药相须，攻逐水饮。

② 大枣汤服，邪正兼顾。

【应用要点】本方为攻逐水饮之峻剂，亦为攻逐水饮的代表方。以咳唾胸胁引痛，或水肿腹胀，二便不利，脉沉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于渗出性胸膜炎、肝硬化腹水、肾炎水肿及晚期血吸虫病所致的腹水等属形气俱实者。

【使用注意】

① 辨清虚实。剧泻，必须为体格壮实之实证者；年老体虚、孕妇慎服，若邪实、非攻不可的，要与补益剂交替使用。

② 服用方法。清晨，空腹服；“三药”为末，或装入胶囊，用大枣十枚煎汤送服；从小剂量（0.5g）开始，逐渐增大（3g）；得快下利后，糜粥自养。

第三章 和解剂

一、定义

凡是采用调和的方法，以解除少阳半表半里之邪，治疗肝脾功能失调、上下寒热互结者、表里同病者，统称和解剂。属于“八法”中的“和”法范畴。

二、立法依据

伤寒邪气在表者，必渍形以为汗；邪气在里者，必荡涤以为利；其于不外不内，半表半里者，既非发汗之所宜，又非吐下之所对，是当和解之可矣。

三、适应范围

和解剂原为治疗足少阳胆经病证而设。然而，胆附于肝，表里关系至为密切，无论肝胆受邪，或本身功能失调，常相互影响，并往往累及脾胃，故肝脾之间失调，上下寒热互结而气机升降失常者，皆可用和解剂治疗。此外，前人认为“疟不离少阳”，故多将治疟方剂列入和解剂中。

四、分类与配伍规律

解表剂	{	和解少阳剂—少阳证—常以内清外透药为主，配伍和胃降逆药
		调和肝脾剂—肝脾不和证—常以疏肝理气药为主，配伍益气健脾药
		调和肠胃剂—肠胃不和证—常以辛开苦降药为主，配伍益气和中药

五、使用注意

- ① 凡外感疾病，表邪未解，或邪已入里，阳明热甚者，不宜使用和解剂。
- ② 凡由劳倦内伤，饮食停滞，气血不足而见寒热者，不宜使用。
- ③ 七情内伤，肝脾不和，治宜配合情志开导方法。

第一节 和解少阳

和解少阳剂适用于邪在足少阳胆经的病证。症见往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，以及口苦、眼干、目眩等。配伍特点是解表药与清里药同用，祛邪药与扶正药同施，以达到和解表里、调节寒热的目的。常选用柴胡、黄芩、半夏、青蒿等组合成方。代表方有小柴胡汤。

• 小柴胡汤（《伤寒论》） •

【组成】 柴胡半斤（12g） 黄芩三两（9g） 人参三两（6g） 半夏洗，半升（9g） 甘草炙，三两（9g） 生姜切，三两（9g） 大枣擘，十二枚（4枚）

【功用】 和解少阳。

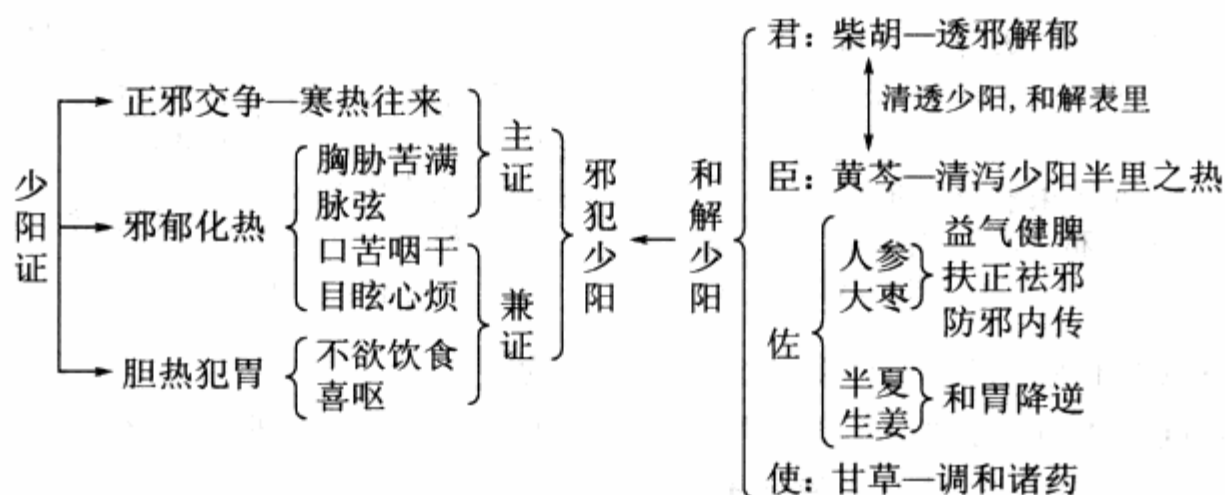
【主治】

- ① 伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者。
- ② 妇人热入血室。经水适断，寒热发作有时。

③ 疟疾、黄疸等病而见少阳证者。

【方歌】 小柴胡汤和解攻，半夏人参甘草从，
更用黄芩加姜枣，少阳百病此为宗。

【表解】



【配伍特点】

- ① 祛邪（清透）为主，兼扶正气。
- ② 和解少阳为主，兼和胃气。

【应用要点】 本方为和解少阳的基础方，也为和解少阳的代表方。临床以往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于感冒、流行性感冒、疟疾、慢性肝炎、肝硬化、急慢性胆囊炎、胆结石、急性胰腺炎、胸膜炎、淋巴腺炎、中耳炎、产褥热、急性乳腺炎、睾丸炎、胆汁反流性胃炎、胃溃疡等属少阳证者。

【使用注意】

- ① 服本方后，一般是不汗出而病解，但也有药后得汗而愈者，这是正复邪去、胃气和降而致。若少阳病证经误治损伤正气，或患者素体正气不足，服用本方，亦可见到先寒战后发热而汗出的“战汗”现象，此种情况虽属正盛邪却，但也应严密观察，防其虚脱。
- ② 肝火偏盛，肝阴虚，肝阳上亢者不宜使用。
- ③ 柴胡用量大于黄芩、人参、甘草，否则会引邪入里。

• 大柴胡汤（《金匱要略》）•

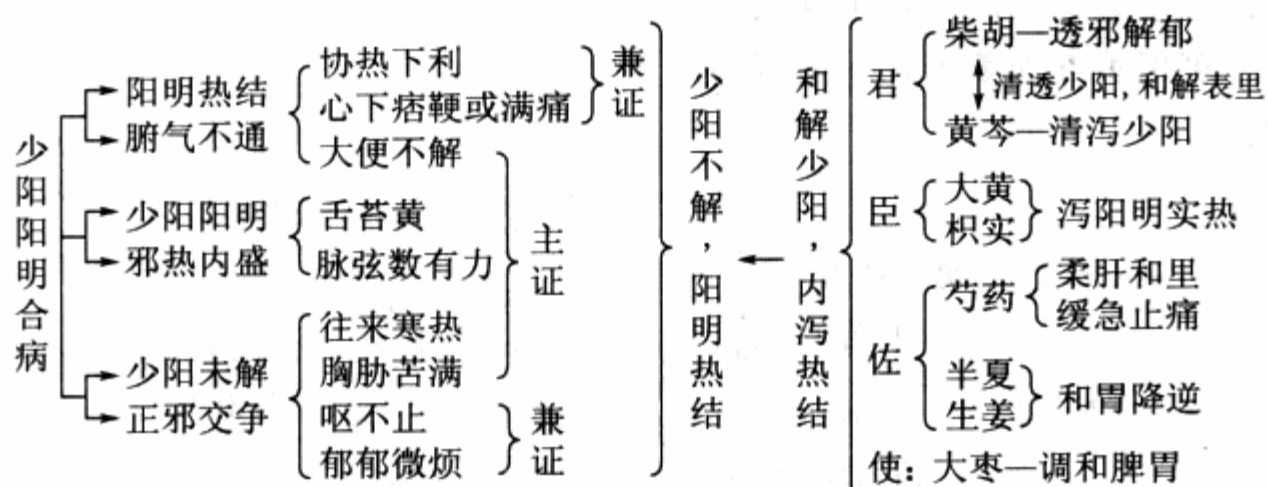
【组成】 柴胡半斤（12g） 黄芩三两（9g） 芍药三两（9g） 半夏半升，洗（9g） 生姜五两，切（15g） 枳实四枚，炙（9g） 大枣十二枚，擘（4枚） 大黄二两（6g）

【功用】 和解少阳，内泻热结。

【主治】 少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬或心下满痛，大便不解或下利，舌苔黄，脉弦数有力。

【方歌】 大柴胡汤用大黄，枳实芩夏白芍将，
煎加姜枣表兼里，妙法内攻并外攘。

【表解】



【配伍特点】和解与泻下并用，以和解少阳为主。

【应用要点】本方为治疗少阳阳明合病的常用方。以往来寒热，胸胁苦满，心下满痛，呕吐，苔黄，脉弦数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症等属少阳阳明合病者。

• 蒿芩清胆汤（《重订通俗伤寒论》）•

【组成】青蒿脑钱半至二钱（4.5~6g） 淡竹茹三钱（9g） 仙半夏钱半（4.5g） 赤茯苓三钱（9g） 青子芩钱半至三钱（4.5g） 生枳壳钱半（4.5g） 陈广皮钱半（4.5g） 碧玉散（滑石、甘草、青黛）包，三钱（9g）

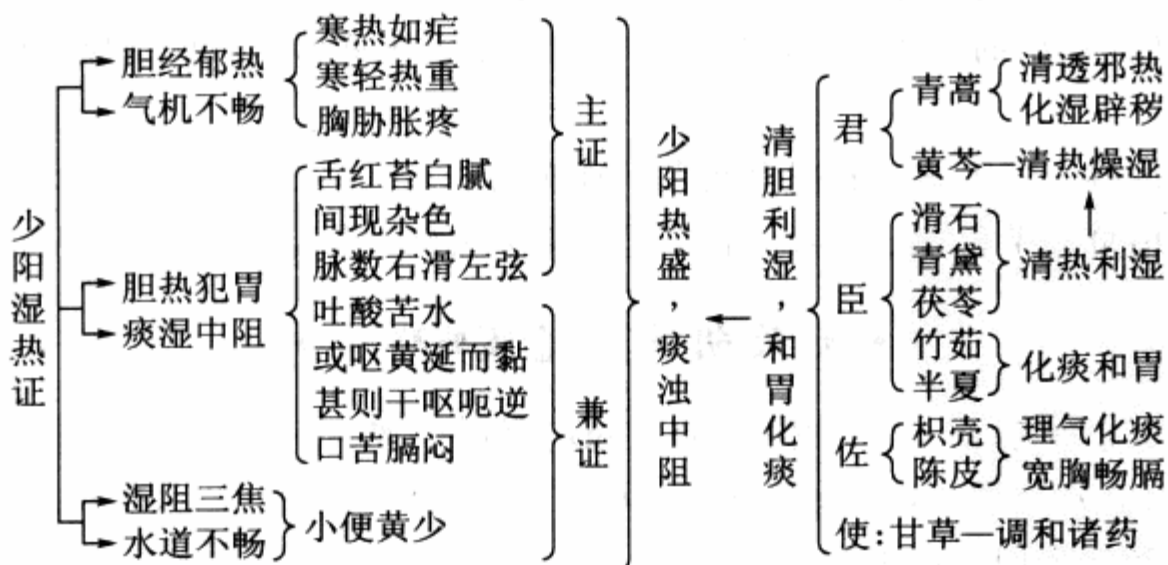
【功用】清胆利湿，和胃化痰。

【主治】少阳湿热证。寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而黏，甚则干呕呃逆，胸胁胀疼，小便黄少，舌红苔白腻，间现杂色，脉数而右滑左弦者。

【方歌】蒿芩清胆碧玉需，陈夏茯苓枳竹茹，

热重寒轻痰夹湿，胸痞呕恶总能除。

【表解】



【配伍特点】

① 芳香透邪与苦寒清泻并用。② 和解少阳与和中化湿同用。③ 透上、和中、导下兼顾，以畅行三焦，分消上下。

【应用要点】本方为治疗少阳湿热证的代表方，也是“和解胆经法”的代表方。以

寒热如疟，寒轻热重，胸胁胀闷，吐酸苦水，舌红苔腻，脉弦滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于肠伤寒、急性胆囊炎、急性黄疸型肝炎、胆汁反流性胃炎、肾盂肾炎、疟疾、盆腔炎、钩端螺旋体病属少阳胆与三焦湿遏热郁者。

第二节 调和肝脾

调和肝脾剂适用于肝脾不和的病证。其证多由肝气郁结，横犯脾土；或因脾虚不充，肝失疏泄而肝木乘脾，以致脘腹胸胁胀痛、神疲食少、月经不调、腹痛泄泻，以及手足不温等症。常用疏肝理气药如柴胡、枳壳、陈皮等，与健脾药如白术、茯苓、甘草等配伍组方。代表方有四逆散、逍遥散、痛泻要方。

• 四逆散（《伤寒论》）•

【组成】甘草炙（6g） 枳实破，水渍，炙干（6g） 柴胡 芍药各十分（各 6g）

【功用】透邪解郁，疏肝理气。

【主治】

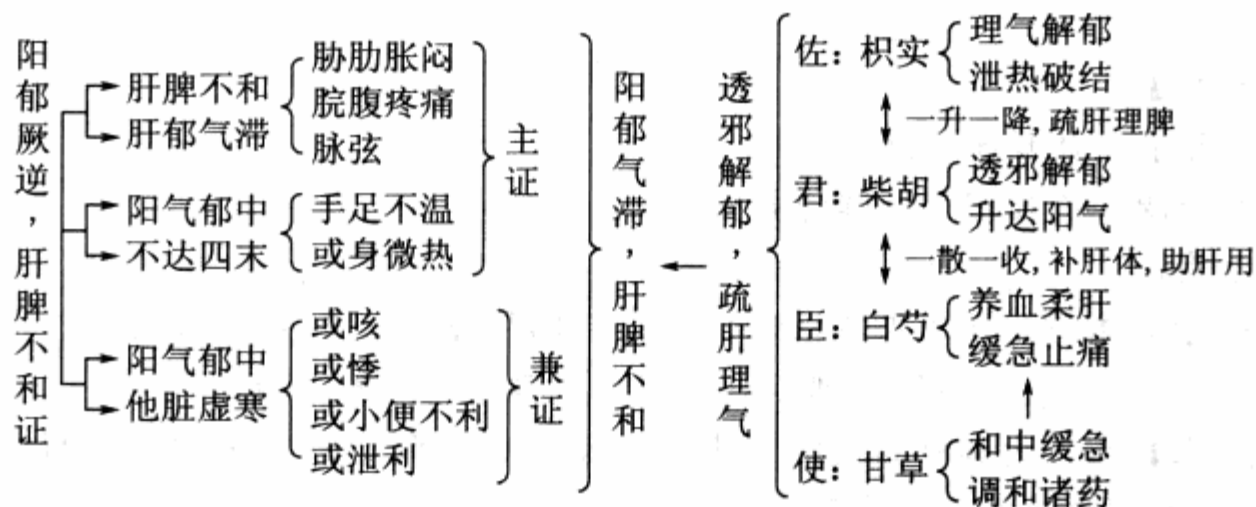
① 阳郁厥逆证。手足不温，或身微热，或咳，或悸，或小便不利，或腹痛，或泄利，脉弦。

② 肝脾不和证。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦等。

【方歌】柴芍枳草四逆散，肝郁气结肢不暖，

脉沉而弦胸胁痛，随证治疗需加减。

【表解】



【配伍特点】

- ① 散收结合，疏中兼养。
- ② 升降兼施，调畅气机。
- ③ 肝脾同调，气血兼理。

【难点提示】本方所治“四逆”乃阳气内郁、不达四末所致，属“热厥”范畴，非心肾阳虚、阴寒内盛之“寒厥”。临床特点是：冷不过肘膝，久按有热感，冷度轻。

【应用要点】本方原治阳郁厥逆证，后世多用作疏肝理脾之基础方。以手足不温，或胁肋疼痛，脉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肝炎、胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、肋间神经痛、胃溃疡、胃炎、胃肠神经官能症、附件炎、输卵管阻塞、急性乳腺炎等属肝胆气郁、肝脾

(或胆胃)不和者。

• 逍遥散 (《太平惠民和剂局方》) •

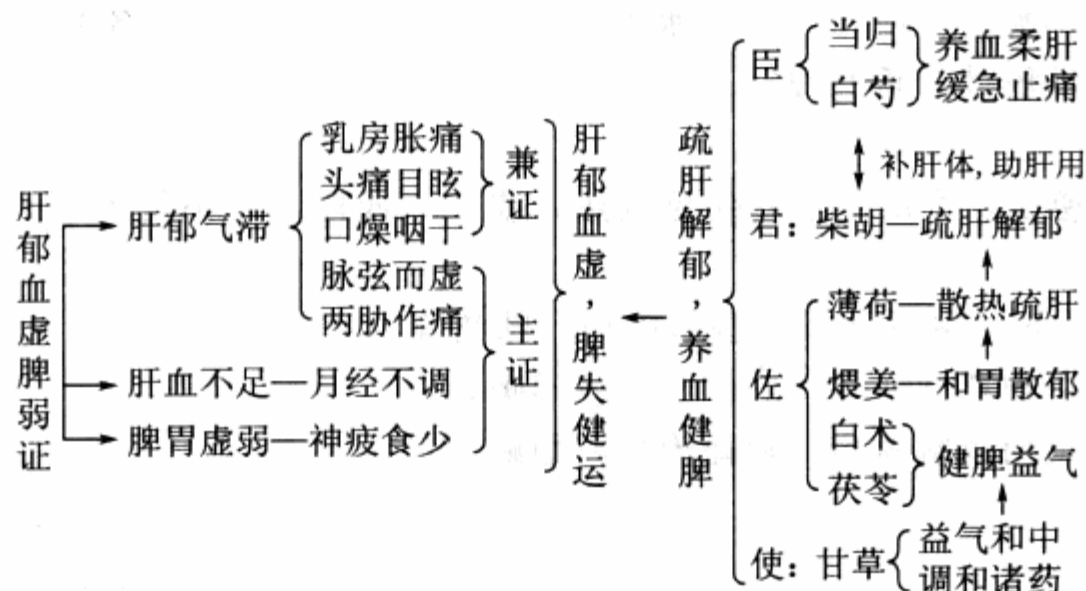
【组成】 甘草微炙赤，半两 (4.5g) 当归去苗，锉，微炒 茯苓去皮，白者 白芍药 白术 柴胡去苗，各一两 (各 9g)

【功用】 疏肝解郁，养血健脾。

【主治】 肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者。

【方歌】 逍遥散用柴芍归，薄荷苓术草姜煨，
疏肝健脾兼养血，调经八味丹栀随。

【表解】



【配伍特点】

- ① 体用并治 (补肝体，助肝用)。
- ② 肝脾同调 (疏肝理气，健脾养血)。
- ③ 气血兼顾。

【难点提示】 本方为培土抑木法的代表方。即用柴胡、白芍配伍白术、茯苓，可疏肝理气以促进脾胃运化，益气健脾以御木侮，共奏培土抑木之效。

【应用要点】 本方为调肝养血的代表方，又是妇科调经的常用方。以两胁作痛，神疲食少，月经不调，脉弦而虚为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肝炎、肝硬化、胆石症、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、胃肠神经官能症、经前期紧张症、乳腺小叶增生、更年期综合征、盆腔炎、子宫肌瘤等属肝郁血虚脾弱者。

• 痛泻要方 (《丹溪心法》) •

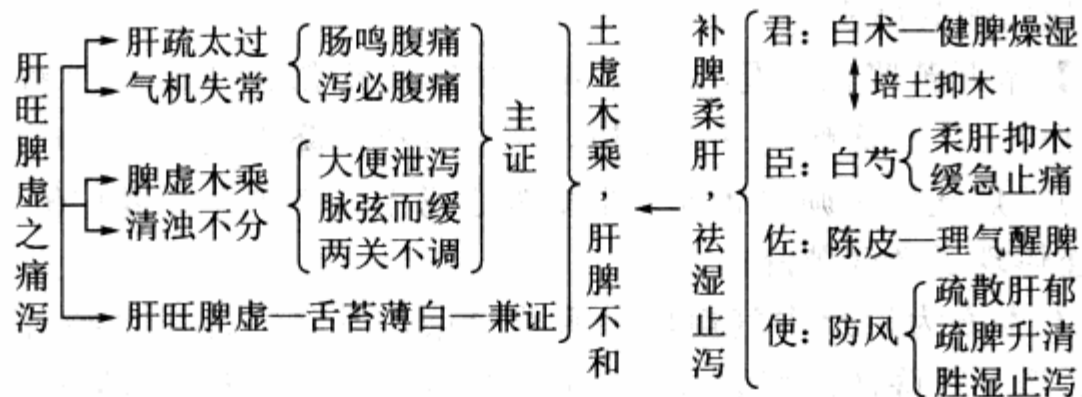
【组成】 白术炒，三两 (6g) 白芍药炒，二两 (6g) 陈皮炒，一两五钱 (4.5g) 防风一两 (3g)

【功用】 补脾柔肝，祛湿止泻。

【主治】 肝旺脾虚之痛泻。肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉两关不调，弦而缓。

【方歌】痛泻要方用陈皮，术芍防风共成剂，
肠鸣泄泻腹又痛，治在泻肝与实脾。

【表解】



【配伍特点】

- ① 补脾柔肝，培土抑木。
- ② 寓升于补，寓散于泻。

【应用要点】本方为治痛泻的要方。以肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，脉弦而缓为辨证要点。

现代临床本方常用于急性肠炎、慢性结肠炎、神经性腹泻等属肝木乘脾者，均可加减治之。

第三节 调和肠胃

调和肠胃剂适用肠胃不和之寒热错杂、虚实夹杂、升降失常证。症见心下痞满，恶心呕吐，肠鸣下利等。常以辛温药与苦寒药如干姜、生姜、黄连、黄芩、半夏等为主组成寒热并用的方剂。代表方有半夏泻心汤。

• 半夏泻心汤（《伤寒论》）•

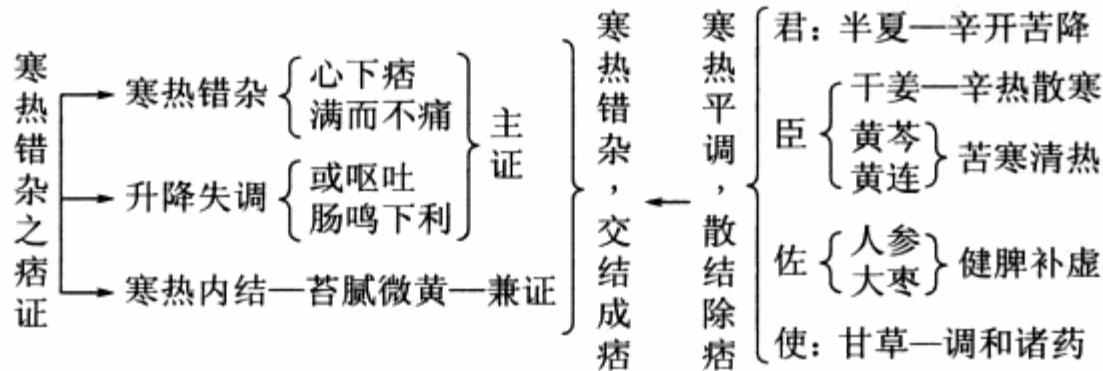
【组成】半夏半升，洗（12g） 黄芩 干姜 人参各三两（各 9g） 黄连一两（3g） 大枣十二枚，擘（4 枚） 甘草三两，炙（9g）

【功用】寒热平调，散结除痞。

【主治】寒热错杂之痞证。心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。

【方歌】半夏泻心芩连姜，人参草枣合成方，
心下痞满兼呕吐，去渣重煎调胃肠。

【表解】



【配伍特点】

- ① 苦辛并进以调其升降。
- ② 寒热并用以平调寒热。
- ③ 补泻兼施以顾其虚实。

【难点提示】辛开苦降法，是以辛味升开的药物配伍苦味沉降的药物以开结散痞、平调寒热，斡旋中土，从而畅达三焦通道，调节气机升降出入，以治疗寒热虚实错杂或痰湿中阻而致的三焦气机失调之病证。半夏泻心汤中以辛苦之半夏配伍辛热之干姜和苦寒之黄芩、黄连体现了辛开苦降法。

【应用要点】本方为治疗中气虚弱，寒热错杂，升降失常而致肠胃不和的常用方，也为调和寒热、辛开苦降法的代表方。以心下痞满，呕吐下利，苔腻微黄为辨证要点。

现代临床本方常用于急慢性胃肠炎、慢性结肠炎、神经性胃炎、慢性肝炎、早期肝硬化等属中气虚弱，寒热互结者。

第四章 清热剂

一、定义

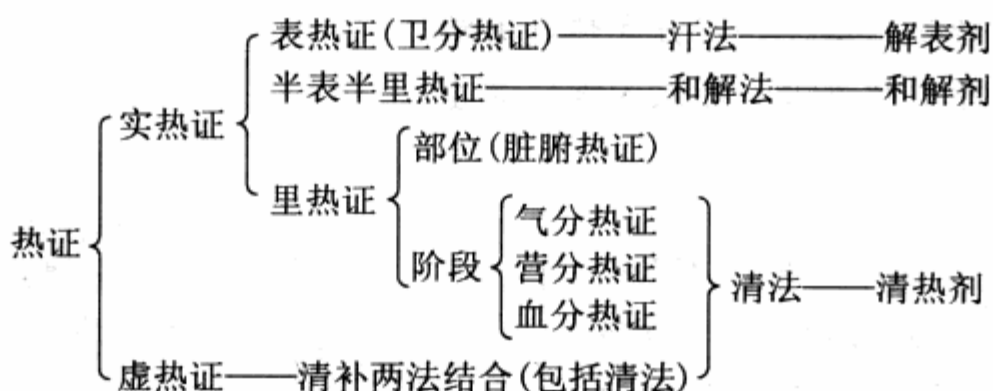
凡以清热药为主组成，具有清热、泻火、凉血、解毒等作用，用以治疗里热证的方剂，统称清热剂。属于“八法”中的“清法”。

二、立法依据

“清法”是以《素问·至真要大论》“热者寒之”、“温者清之”，《素问·五常政大论》“治温以清”、“治热以寒”，以及《神农本草经》“疗热以寒药”的治疗原则而立法的。

三、适应范围

本类方剂适用于里热证（包括实热证和虚热证）。



四、分类与配伍规律

清热剂	清气分热剂	—热入气分证—	常以清热泻火药为主，配伍清热生津药
	清营凉血剂	—热入营血证—	常以清营凉血药为主，配伍清热解毒药
	清热解毒剂	—火毒炽盛证—	常以清热解毒药为主，配伍辛凉疏散药
	清脏腑热剂	—脏腑热盛证—	常依脏腑不同选相应归经的清热药
	清虚热剂	—阴虚发热证—	常用养阴药，配伍清热降火药

五、使用注意

1. 明辨病位

- ① 邪热在表，未入里者，不宜，应辛凉解表。
- ② 表热入里，热与积滞互结者，不宜，应寒下。

2. 明辨真假

- ① 真热假寒（阳盛格阴），应用清法或寒下，忌用温法，否则等同于火上加油。
- ② 真寒假热（阴盛格阳），应用温法，忌用清法，否则等同于雪上加霜。

3. 明辨虚实

实热证一般应用苦寒泻火之法；而虚热证一般应用甘寒养阴法。屡用清热泻火而热不退者应立即改用壮水滋阴之法（“寒之不寒，是无水也”）。

4. 病重邪盛注意反佐（“甚者从之”、“治热以寒，温而行之”）

方法：①寒药热服；②加入少量热药（如姜汁）。

5. 顾护脾胃（泻火莫伤胃）

清法皆用寒凉之药，易败胃伤阳，需注意保护脾胃功能。

第一节 清气分热

清气分热的方剂，适用于热在气分、热盛伤津或气阴两伤之证，症见壮热烦渴、大汗、脉洪大、舌红苔黄、脉洪大或滑数；或余热未清，气阴皆伤，症见身热多汗、心胸烦闷、口干舌红等。本类方剂常用清热泻火、除烦止渴的石膏、知母等组成，代表方有白虎汤、竹叶石膏汤。

• 白虎汤（《伤寒论》）•

【组成】石膏一斤，碎（50g） 知母六两（18g） 甘草二两，炙（6g） 粳米六合（9g）

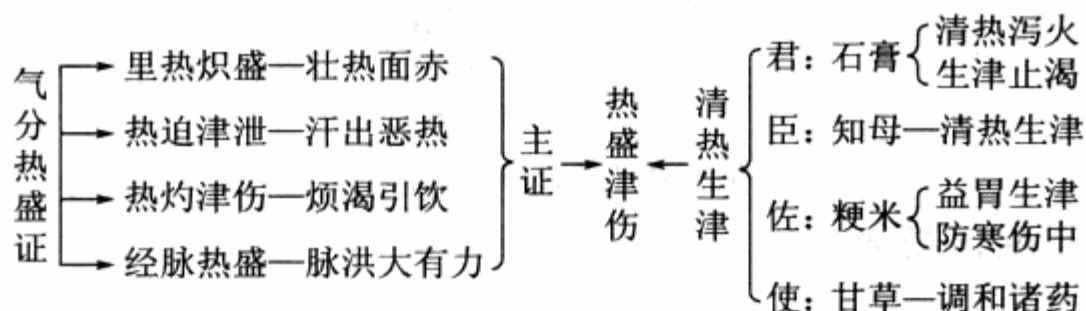
【功用】清热生津。

【主治】气分热盛证。壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

【方歌】白虎膏知甘草粳，气分大热此方清，

热渴汗出脉洪大，加入人参气津生。

【表解】



【配伍特点】

① 辛、甘、寒合施，清透、滋养并用。

② 寒凉少佐甘缓，泻火补伤胃。

【难点提示】本方既治气分热盛，为何不用苦寒之芩、连以清热泻火？

本方主治热盛伤津者，若用苦寒之品，虽苦寒直折，泻火力强，但易伤其津，且无生津之效。诚如柯琴言“火炎土燥，终非苦寒之味所能治。经曰：‘甘先入脾’，又曰‘以甘泻之’是以知甘寒之品，乃泻胃火，生津液之上剂也”。所以，本方选用甘寒滋润、清热生津之法较为适宜。

【应用要点】本方为治疗阳明气分热盛证的基础方。临床以身大热，汗大出，口大渴，脉洪大为辨证要点。

现代临床本方常用于感染性疾病，如大叶性肺炎、流行性乙型脑炎、流行性出血热、牙龈炎及小儿夏季热、糖尿病、风湿性关节炎等属气分热盛者。

【使用注意】

① 表证未解的发热无汗、口不渴者不可用本方。

② 脉浮弦而细者或脉沉者（里寒证）不可用本方。

③ 血虚发热、脉洪不胜重按者不可用本方。

④ 真寒假热之阴盛格阳证不可用本方。

• 竹叶石膏汤 (《伤寒论》) •

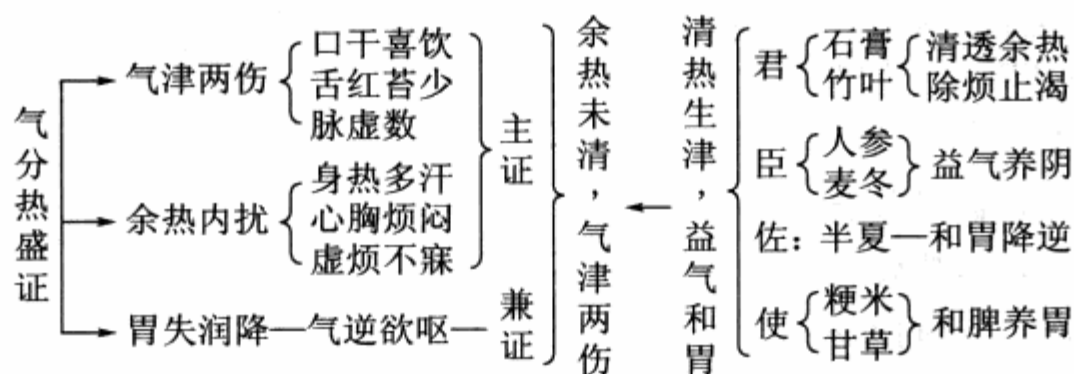
【组成】 竹叶二把 (6g) 石膏一斤 (50g) 半夏半升，洗 (9g) 麦门冬一升，去心 (20g) 人参二两 (6g) 甘草二两，炙 (6g) 粳米半升 (10g)

【功用】 清热生津，益气和胃。

【主治】 伤寒、温病、暑病余热未清，气津两伤证。身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数。

【方歌】 竹叶石膏汤人参，麦冬半夏甘草临，
再加粳米同煎服，清热益气养阴津。

【表解】



【配伍特点】 清补并用，清而不寒，补而不滞。

【应用要点】 本方为治疗热病后期，余热未清，气阴耗伤的常用方。以身热多汗，气逆欲呕，烦渴喜饮，口干，舌红少津，脉虚数为辨证要点。

现代临床本方常用于中暑、夏季热、流脑后期等发热气津已伤者。糖尿病的干渴多饮属胃热阴伤者，亦可应用。

第二节 清营凉血

清营凉血剂适用于邪热传营，热入血分诸症。入营之证见有身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，或外布隐隐斑疹等；入血之证见有出血、发斑、如狂、谵语、舌绛起刺等。本类方剂的组合，入营、入血均用犀角、生地黄以清营凉血，其中由于入营邪热多由气分传来，故配用金银花、连翘、竹叶促其透热转气。入血邪热每多迫血妄行而致出血、发斑，而且络伤血溢每易留瘀，热与血结亦可成瘀，故配用牡丹皮、芍药等，既能散瘀，又能凉血，止血而不留瘀。代表方为清营汤、犀角地黄汤。

• 清营汤 (《温病条辨》) •

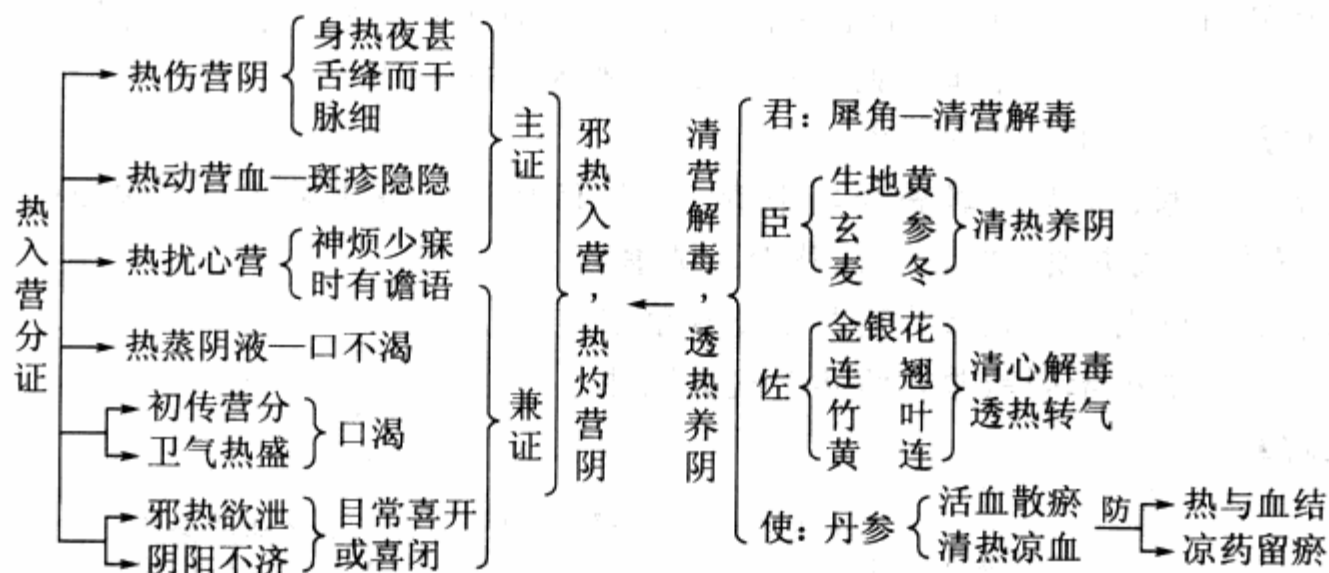
【组成】 犀角 (水牛角代) (30g) 生地黄五钱 (15g) 玄参三钱 (9g) 竹叶心一钱 (3g) 麦冬三钱 (9g) 丹参二钱 (6g) 黄连一钱五分 (5g) 银花三钱 (9g) 连翘二钱，连心用 (6g)

【功用】 清营解毒，透热养阴。

【主治】 热入营分证。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，目常喜开或喜闭，口渴或不渴，斑疹隐隐，脉数，舌绛而干。

【方歌】 清营汤是鞠通方，热入心包营血伤，
角地银翘玄连竹，丹麦清热佐之良。

【表解】



【配伍特点】

- ① 咸寒为主，佐以甘苦。
- ② 轻清宣透，透热转气。
- ③ 清热凉血，活血散瘀。

【难点提示】 清营汤体现了“透热转气”法，叶天士之《外感温热论》云：“入营犹可透热转气。”是指温热病邪入于营分时，不可一味地清营养阴，而应在其中辅以轻清透泄之品，使热邪从营分转出气分而解。方中金银花、连翘、竹叶清轻透泄，可使营分之热邪有外达之机，促其透出气分而解。

【应用要点】 本方为治疗热入营分证的代表方。以身热夜甚，神烦少寐，斑疹隐隐，舌绛而干，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症、肠伤寒或其他热性病等证属热入营分者。

【使用注意】 使用本方应注意舌诊，原著说：“白滑者，不可与也。”苔白滑为湿郁之象，禁用本方，以防滋腻而助湿留邪。

• 犀角地黄汤（《小品方》，录自《外台秘要》）•

【组成】 犀角（水牛角代）一两（30g） 生地黄半斤（24g） 芍药三分（12g） 牡丹皮一两（9g）

【功用】 清热解毒，凉血散瘀。

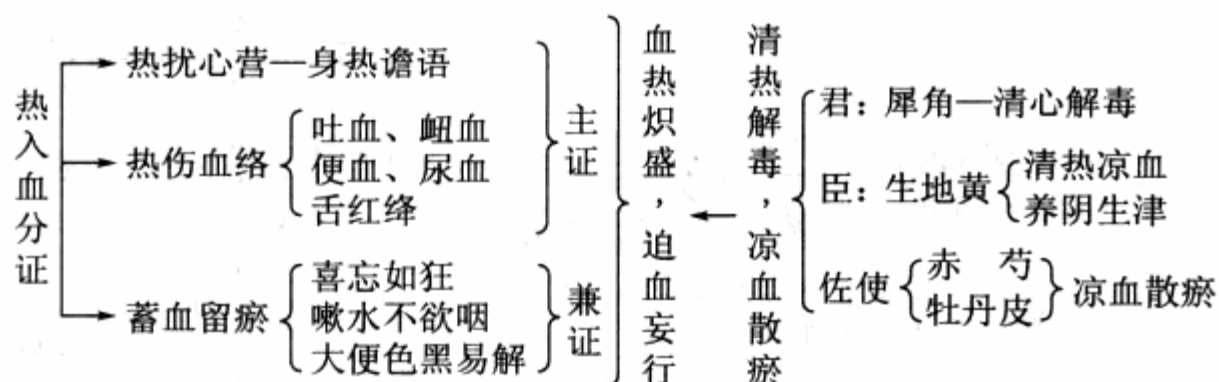
【主治】

- ① 热入血分证。身热谵语，斑色紫黑，舌绛起刺，脉细数。
- ② 热伤血络证。吐血、衄血、便血、尿血等，舌红绛，脉数。
- ③ 蓄血留瘀。喜忘如狂，漱水不欲咽，大便色黑易解等。

【方歌】 犀角地黄芍药丹，血热妄行吐衄斑。

蓄血发狂舌质绛，凉血散瘀病可痊。

【表解】



【配伍特点】

- ① 凉血血自宁。
- ② 滋阴火自息。
- ③ 散血防留瘀。

【应用要点】本方为治疗热入血分证的代表方。以各种失血，斑色紫黑，神昏谵语，身热舌绛为辨证要点。

现代临床本方常用于急性黄色肝萎缩、肝昏迷、弥散性血管内凝血、尿毒症、紫癜、急性白血病、败血症等属血分热盛者。

【使用注意】

- ① 本方多用赤芍，如果热伤阴血较盛，可使用白芍。
- ② 阳虚失血及脾胃虚弱者不宜用本方治疗。

第三节 清 热 解 毒

清热解毒剂具有清热、泻火、解毒的作用，适用于温疫、温毒或疮疡疔毒等证。本类方剂常以黄芩、黄连、连翘、金银花、蒲公英等清热解毒泻火药物为主组成。若便秘溲赤，可配伍芒硝、大黄等以导热下行；疫毒发于头面而致红肿者，可在清热解毒药中配伍辛凉疏散之品，如牛蒡子、薄荷、僵蚕等；热在气分则配伍泻火药；热在血分则配伍凉血药。代表方有黄连解毒汤、普济消毒饮、凉膈散、仙方活命饮。

• 普济消毒饮（《东垣试效方》）•

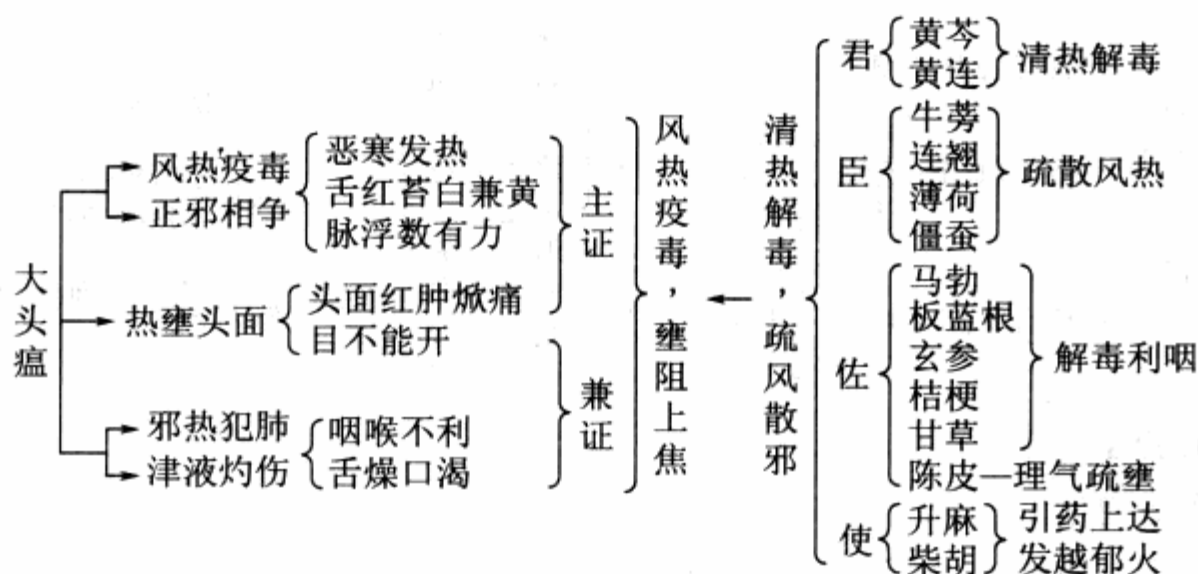
【组成】黄芩 黄连酒炒，各五钱（各 15g） 连翘 板蓝根 马勃 牛蒡子 薄荷各一钱（各 3g） 陈皮去白 甘草生用 玄参 柴胡 桔梗各二钱（各 6g） 僵蚕 升麻各七分（各 2g）

【功用】清热解毒，疏风散邪。

【主治】大头瘟。恶寒发热，头面焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔白兼黄，脉浮数有力。

【方歌】普济消毒芩连芩，玄翘桔勃草蓝根，
升柴陈薄僵蚕合，专治风热大头瘟。

【表解】



【配伍特点】

- ① 内清外疏，以清为主。
- ② 苦降辛散，相反相成。

【应用要点】本方为治疗大头瘟的常用方剂。以头面肿盛，恶寒发热，舌红苔白兼黄，脉浮数为辨证要点。

现代临床本方常用于丹毒、腮腺炎、急性扁桃体炎、淋巴结炎伴淋巴管回流障碍等属风热毒邪为患者。

• 黄连解毒汤（《外台秘要》引崔氏方）•

【组成】黄连三两（9g） 黄芩 黄柏各二两（各6g） 栀子十四枚，擘（9g）

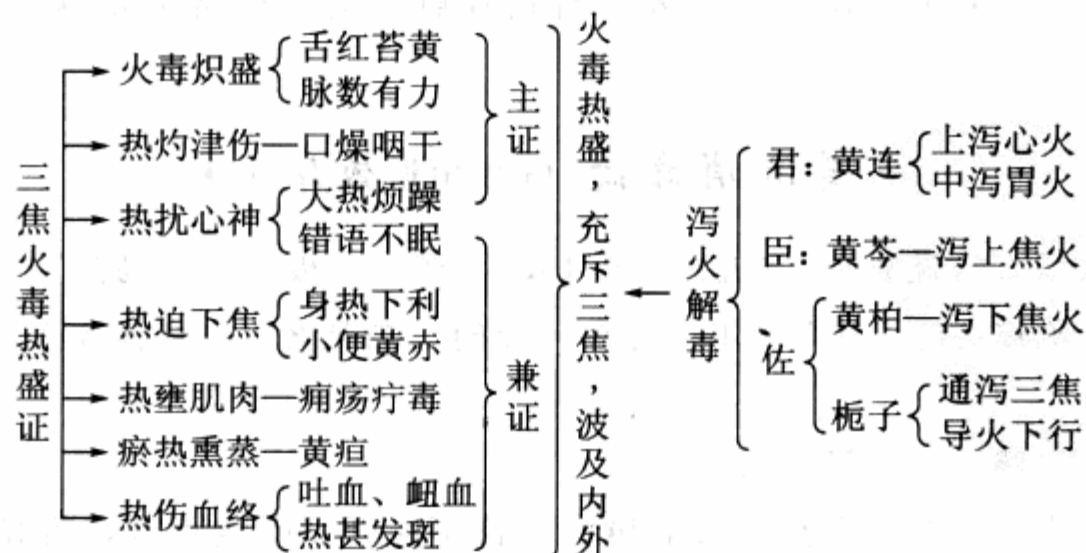
【功用】泻火解毒。

【主治】三焦火毒热盛证。大热烦躁，口燥咽干，错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑，身热下利，湿热黄疸；外科痈疡疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力。

【方歌】黄连解毒汤四味，黄芩黄柏栀子备。

躁狂大热呕不眠，吐衄斑黄均可为。

【表解】



【配伍特点】

- ① 苦寒直折。② 三焦同治。

【难点提示】苦寒直折为一种用药方法。是指方中用味苦性寒的药物直接治疗火热

实证，而不用其他性味药物。苦寒药物易化燥伤津，因此热盛伤津者不宜使用。

【应用要点】本方为苦寒直折、清热解毒的基础方。临床应用以大热烦躁，口燥咽干，舌红苔黄，脉数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于败血症、脓毒血症、痢疾、肺炎、泌尿系感染、流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎及感染性炎症等属热毒为患者。

【使用注意】黄连解毒汤为大苦大寒之剂，久服易伤脾胃，非火盛者不宜使用。

• 凉膈散（《丹溪心法》）•

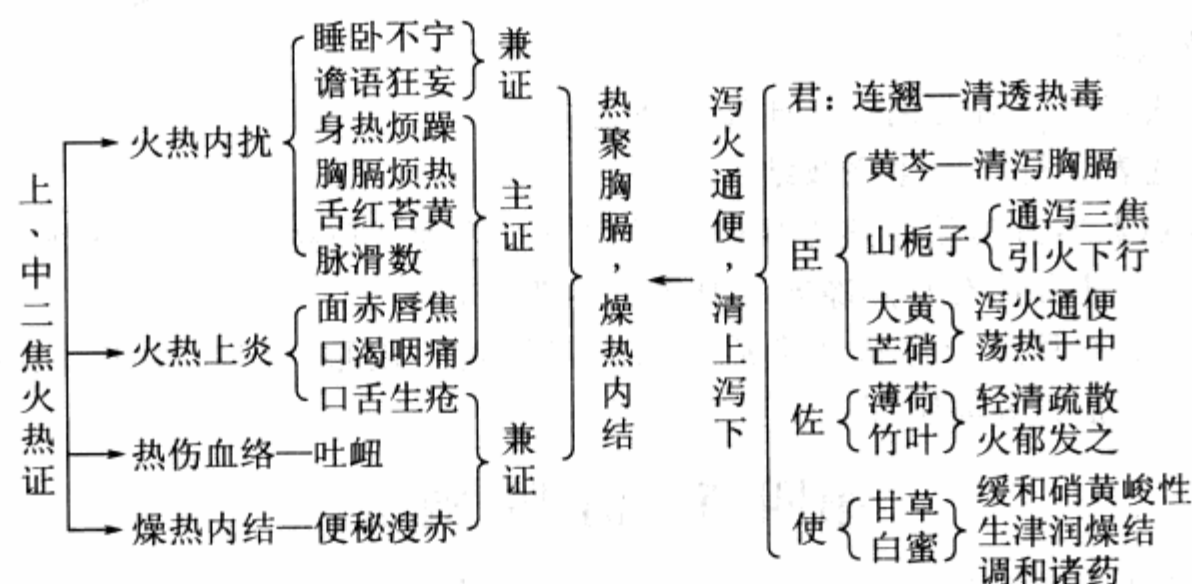
【组成】川大黄 朴硝 甘草炙，各二十两（各 9g） 山栀子仁 薄荷去梗 黄芩各十两（各 5g） 连翘二斤半（18g）

【功用】泻火通便，清上泻下。

【主治】上、中二焦火热证。烦躁口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，口舌生疮，睡卧不宁，谵语狂妄，或咽痛吐衄，便秘溲赤，或大便不畅，舌红苔黄，脉滑数。

【方歌】凉膈硝黄栀子翘，黄芩甘草薄荷饶，
竹叶蜜煎疗膈上，中焦燥实服之消。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清上与泻下并行。
- ② 以泻代清。

【难点提示】凉膈散为清下合用，以泻代清之剂，重在清泻，本病虽在上焦，但三焦同治，用硝、黄泻下，意在釜底抽薪，有助胸膈郁热的清除，又可防无形邪热积于肠腑和肠中糟粕相结而成阳明腑实之证，故清、下合用可及早截断病势。

【应用要点】本方为治疗上、中二焦火热炽盛证的常用方。以胸膈烦热，面赤唇焦，烦躁口渴，舌红苔黄，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于咽炎、口腔炎、急性扁桃体炎、胆道感染、急性黄疸型肝炎等属上、中二焦火热者，均可加减用之。

• 仙方活命饮（《校注妇人良方》）•

【组成】白芷 贝母 防风 赤芍药 当归尾 甘草节 皂角刺炒 穿山甲炙 天

花粉 乳香 没药各一钱（各 3g） 金银花 陈皮各三钱（9g）

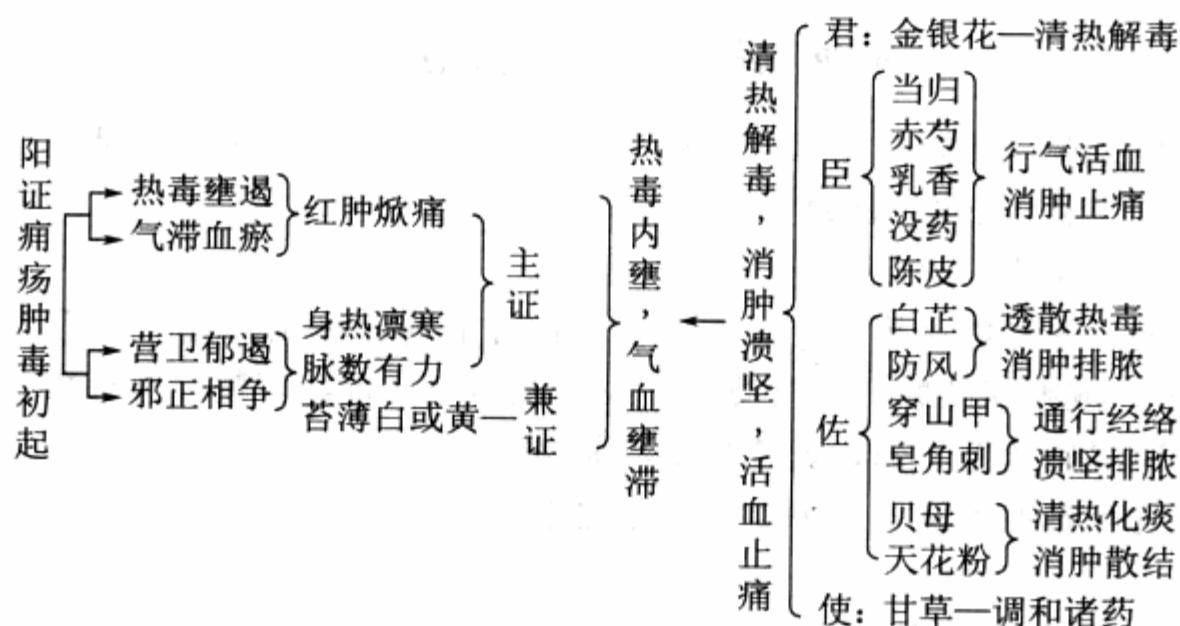
【功用】清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

【主治】阳证痈疡肿毒初起。红肿焮痛，或身热凛寒，苔薄白或黄，脉数有力。

【方歌】仙方活命银花芷，归芍乳没防草刺，

贝母花粉陈山甲，疮疡肿毒阳证治。

【表解】



【配伍特点】

① 以清热解毒、活血化痰、通经溃坚为主。

② 佐以透表、行气、化痰散结。

【应用要点】本方为治疗热毒痈肿的常用方，亦为“疮疡之圣药，外科之首方”。以局部红肿焮痛，甚者伴有身热凛寒，脉数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于化脓性炎症，如蜂窝织炎、化脓性扁桃体炎、乳腺炎、脓疱疮、疖肿、深部脓肿等属阳证、实证者。

第四节 清脏腑热

清脏腑热剂适用于邪热偏盛于某一脏腑所产生的火热证候。本类方剂是按所治脏腑火热证候不同，分别使用不同的清热方药。如心经热盛，用黄连、栀子、莲子心、木通等以泻火清心；肝胆实火，用龙胆草、夏枯草、青黛等以泻火清肝；肺中有热，用黄芩、桑白皮、石膏、知母等以清肺泻热；热在脾胃，用石膏、黄连等以清胃泻热；热在大肠，用白头翁、黄连、黄柏等以清肠解毒。代表方有导赤散、龙胆泻肝汤、左金丸、泻白散、苇茎汤、清胃散、玉女煎、芍药汤、白头翁汤等。

• 导赤散（《小儿药证直诀》）•

【组成】生地黄 木通 生甘草梢各等分（各 6g）

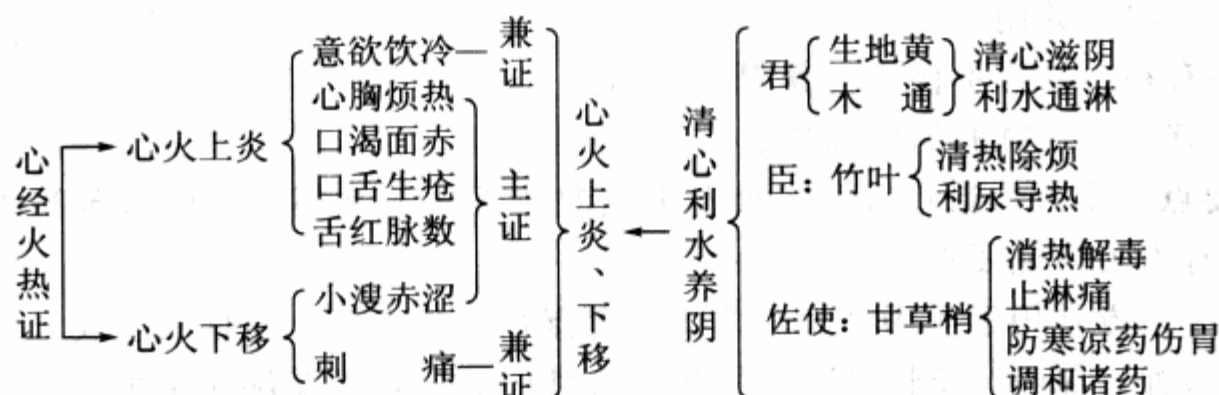
【功用】清心利水养阴。

【主治】心经火热证。心胸烦热，口渴面赤，意欲饮冷，以及口舌生疮；或心热移于小肠，小溲赤涩刺痛，舌红，脉数。

【方歌】导赤生地与木通，草梢竹叶四般攻，

口糜淋痛小肠火，引热同归小便中。

【表解】



【配伍特点】

① 清心与养阴兼顾，利尿以导热下行。② 利水而不伤阴，滋阴而不恋邪。

【难点提示】本方主治病机，《医宗金鉴》以“水虚火不实”概括，即水虚不甚，火实亦不显。这是钱乙根据小儿稚阴稚阳、易寒易热、易实易虚的生理特点，在用药原则方面治实防其虚、治虚防其实而创立的。

【应用要点】本方为治疗心经火热证的常用方。以心胸烦热，口渴，口舌生疮或小便赤涩，舌红脉数为辨证要点。现代临床本方常用于口腔炎、鹅口疮、小儿夜啼等心经有热者；小儿急性泌尿系感染属下焦湿热者。

• 龙胆泻肝汤（《医方集解》）•

【组成】龙胆草酒炒（6g） 黄芩炒（9g） 栀子酒炒（9g） 泽泻（9g） 木通（6g） 当归酒炒（3g） 生地黄酒炒（6g） 柴胡（6g） 生甘草（6g） 车前子（6g）

【功用】清肝胆实火，泻下焦湿热。

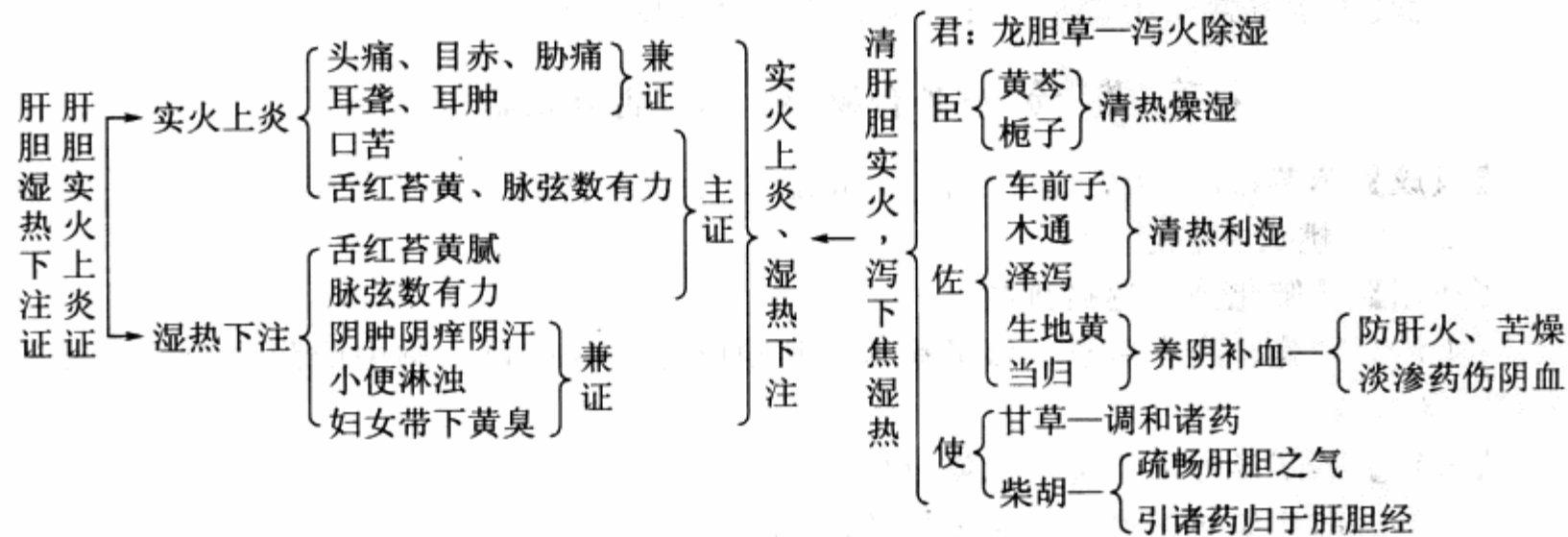
【主治】

① 肝胆实火上炎证。症见头痛目赤，胁痛，口苦，耳聋，耳肿，舌红苔黄，脉弦数有力。

② 肝胆湿热下注证。症见阴肿，阴痒，阴汗，小便淋浊，或妇女带下黄臭，舌红苔黄腻，脉弦数有力。

【方歌】龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕，
木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清泻与渗利并用。
- ② 泻中有补，祛邪不伤正，养阴不敛邪。
- ③ 清中有疏，兼顾肝的生理特点。

【应用要点】本方为治疗肝胆实火上炎或湿热下注的常用方。以口苦溺赤，舌红苔黄，脉弦数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于顽固性偏头痛、头部湿疹、高血压、急性结膜炎、虹膜睫状体炎、外耳道疖肿、鼻炎、急性黄疸型肝炎、急性胆囊炎，以及泌尿生殖系炎症、急性肾盂肾炎、急性膀胱炎、尿道炎、外阴炎、睾丸炎、腹股沟淋巴腺炎、急性盆腔炎、带状疱疹等病属肝经实火湿热者。

• 左金丸（《丹溪心法》）•

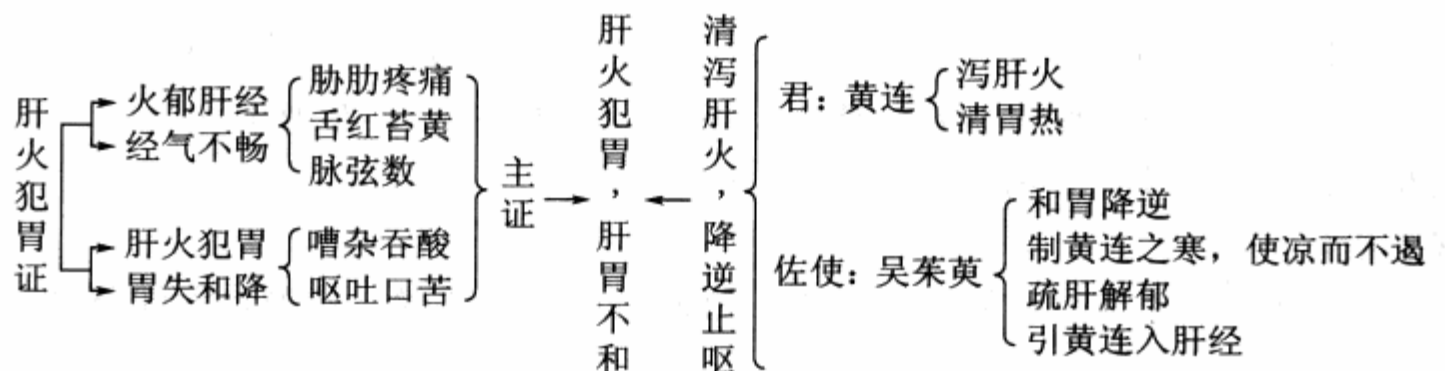
【组成】黄连六两（9g） 吴茱萸一两（1.5g）

【功用】清泻肝火，降逆止呕。

【主治】肝火犯胃证。症见胁肋疼痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，舌红苔黄，脉弦数。

【方歌】左金连茱六一丸，肝火犯胃吐吞酸，
再加芍药名戊己，热泻热痢服之安。

【表解】



【配伍特点】

- ① 辛开苦降，寒热并用。泻火而不至凉遏，降逆而不碍火郁（黄连：吴茱萸=6：1）。
- ② 肝胃同治。以清泻肝火为主，肝火得清，胃气自降。

【应用要点】本方为治疗肝火犯胃，肝胃不和证的常用方。以呕吐吞酸，胁痛口苦，舌红苔黄，脉弦数为辨证要点。

现代临床本方常用于胃炎、食管炎、胃溃疡等属肝火犯胃者。

• 苇茎汤（《外台秘要》引《古今录验方》）•

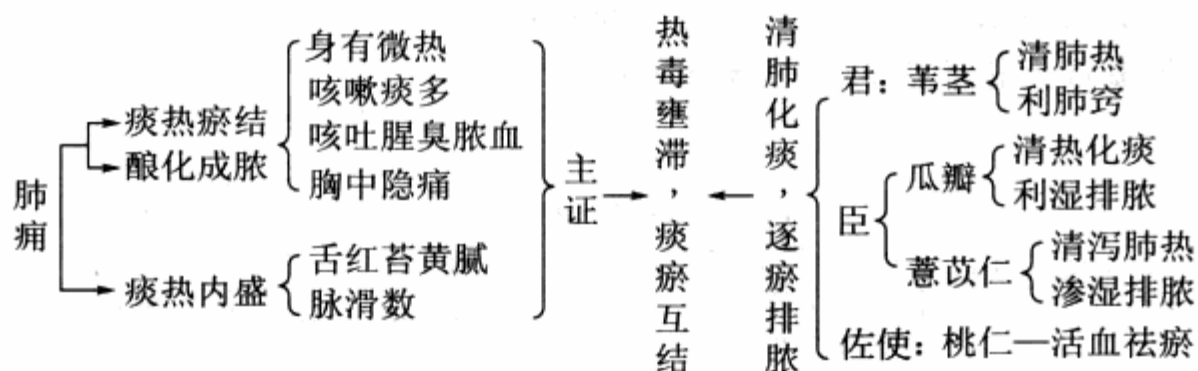
【组成】苇茎切，二升，以水二斗，煮取五升，去滓（60g） 薏苡仁半升（30g） 瓜瓣半升（24g） 桃仁三十枚（9g）

【功用】清肺化痰，逐瘀排脓。

【主治】肺痈。身有微热，咳嗽痰多，甚则咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，舌红苔黄腻，脉滑数。

【方歌】苇茎汤方出千金，瓜瓣苡仁与桃仁，
肺痈痰热兼瘀血，化浊排脓病自宁。

【表解】



【配伍特点】清热、化痰、逐瘀、排脓四法同用。

【应用要点】本方为治疗肺痈的常用方剂。以胸痛，咳嗽，吐腥臭痰或吐脓血，舌红苔黄腻，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于肺化脓症、大叶性肺炎、支气管炎、百日咳等属肺热痰瘀互结者。

• 泻白散（《小儿药证直诀》）•

【组成】地骨皮 桑白皮炒，各一两（各 15g） 甘草炙，一钱（1g）

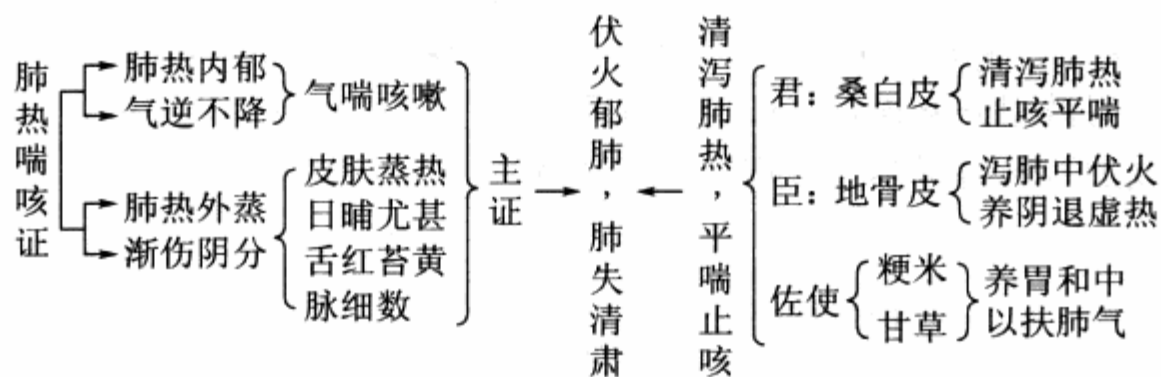
【功用】清泻肺热，平喘止咳。

【主治】肺热喘咳证。气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。

【方歌】泻白桑皮地骨皮，甘草粳米四般宜，

参茯知芩皆可入，肺热喘嗽此方施。

【表解】



【配伍特点】

① 清中有润，泻中有补。

② 培土生金，肺脾同调。

【应用要点】本方为治疗肺热咳嗽的常用方。以咳喘气急，皮肤蒸热，舌红苔黄，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于小儿麻疹初期、肺炎或支气管炎等属肺热者。

• 玉女煎（《景岳全书》）•

【组成】石膏三至五钱（15~30g） 熟地三至五钱或一两（9~30g） 麦冬二钱（6g） 知母 牛膝一钱半（各 5g）

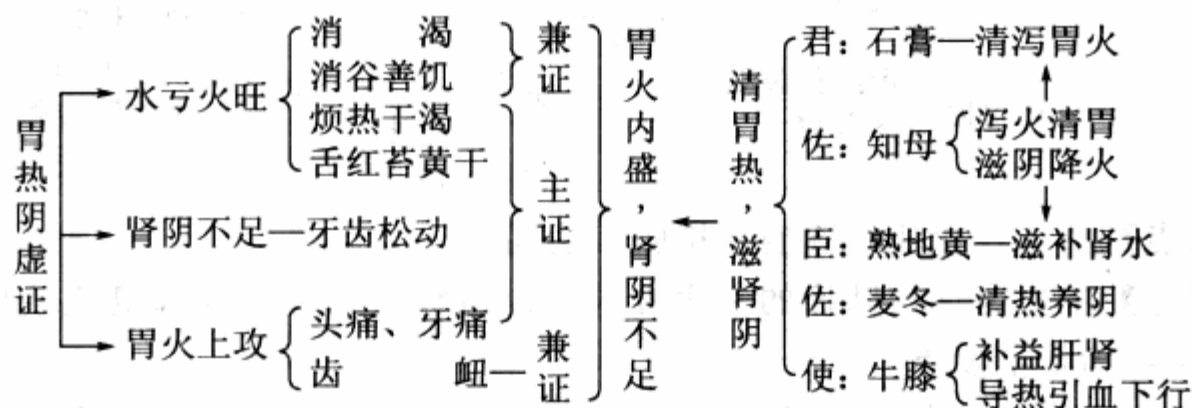
【功用】清胃热，滋肾阴。

【主治】胃热阴虚证。头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干。亦治消

渴，消谷善饥等。

【方歌】 玉女煎乃景岳方，石膏知麦牛地黄，
阴虚胃火相兼病，烦热牙痛吐衄尝。

【表解】



【配伍特点】 清胃火、壮肾水并用，兼以导热下行。

【应用要点】 本方为治疗胃热阴虚牙痛的常用方剂。以牙痛齿松，烦热干渴，舌红苔黄而干为辨证要点。

现代临床本方常用于牙龈炎、糖尿病、急性口腔炎、舌炎等属阴亏而胃火盛者。

• 清 胃 散 (《脾胃论》) •

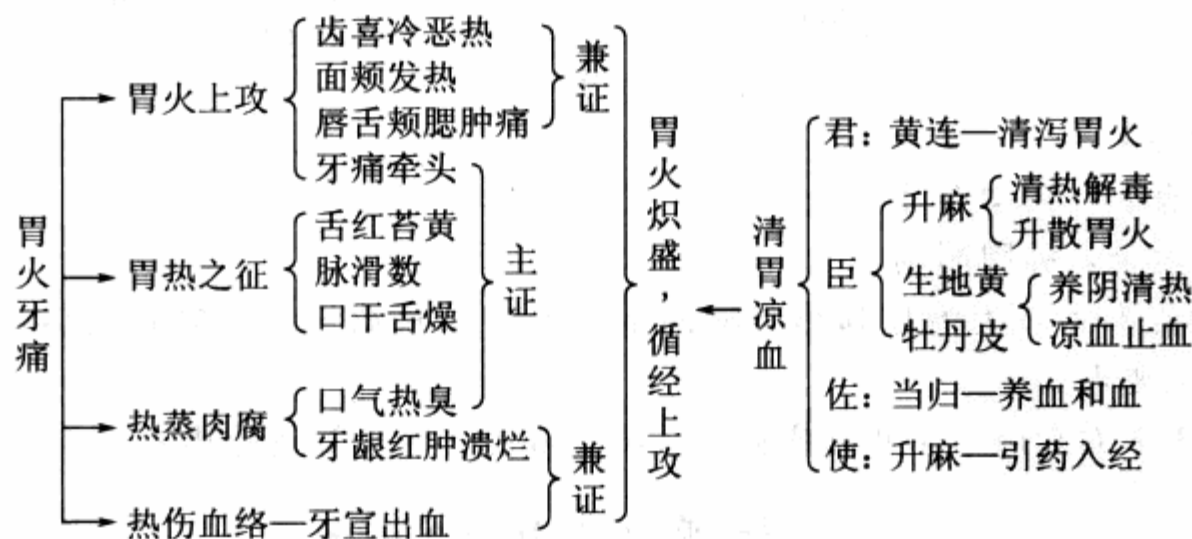
【组成】 生地黄、当归身各三分 (各 6g) 牡丹皮半钱 (9g) 黄连六分，夏月倍之 (6g) 升麻一钱 (9g)

【功用】 清胃凉血。

【主治】 胃火牙痛。牙痛牵引头痛，面颊发热，其齿喜冷恶热，或牙宣出血，或牙龈红肿溃烂，或唇舌颊腮肿痛，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。

【方歌】 清胃散用升麻连，当归生地牡丹全，
或加石膏清胃热，口疮吐衄与牙宣。

【表解】



【配伍特点】

- ① 气血两清。
- ② 升降并用。
- ③ 泻中有补。

【应用要点】本方为治疗胃火牙痛的常用方剂。以牙痛牵引头痛，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于口腔炎、牙周炎、三叉神经痛等属胃火上攻者。

【类方比较】

清胃散与玉女煎比较表

比较 \ 方名	清 胃 散		玉 女 煎
组成		生地黄、当归、牡丹皮、黄连、升麻	石膏、熟地黄、麦冬、知母、牛膝
功用	同	清泻胃火为主	
	异	兼活血散瘀、散火解毒，为苦寒之剂	兼滋肾阴，为清润之剂
主治	同	胃热牙痛	
	异	胃火炽盛的牙痛	胃热阴虚的牙痛

• 葛根黄芩黄连汤（《伤寒论》） •

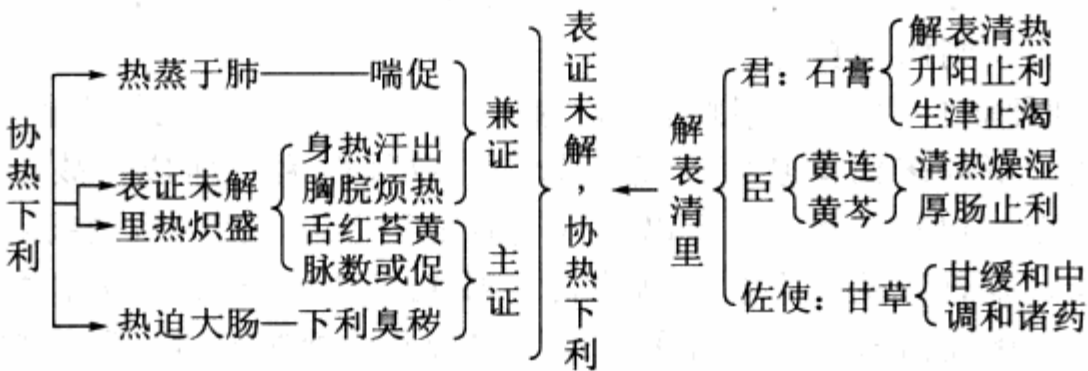
【组成】葛根半斤（15g） 甘草二两，炙（6g） 黄芩三两（9g） 黄连三两（9g）

【功用】解表清里。

【主治】协热下利。身热下利，胸脘烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。

【方歌】葛根芩连加甘草，协热下利喘汗宝，
清热生津解表里，重用葛根效果好。

【表解】



【配伍特点】

- ① 外疏内清，表里同治，以清里热为主。
- ② 辛凉升散与苦寒清降并用，寓“清热升阳止利法”。

【应用要点】本方为治疗热泻、热利的常用方，不论有无表证，皆可用之。以身热下利，苔黄脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性肠炎、细菌性痢疾、肠伤寒、胃肠型感冒等属表证未解，里热甚者。

• 芍药汤（《素问病机气宜保命集》） •

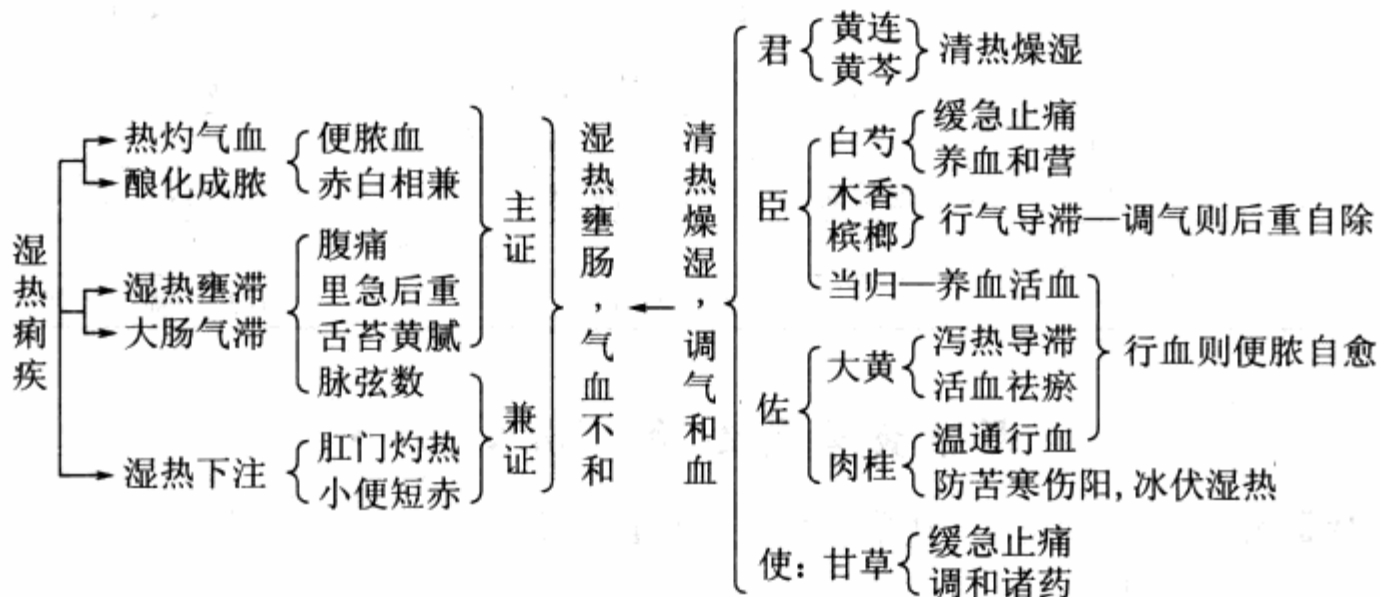
【组成】芍药一两（15~20g） 当归半两（9g） 黄连半两（5~9g） 大黄三钱（6g） 槟榔 木香 甘草炒，各二钱（各 5g） 黄芩半两（9g） 官桂二钱半（2~5g）

【功用】清热燥湿，调气和血。

【主治】湿热痢疾。腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。

【方歌】芍药汤中用大黄，芩连归桂槟草香，
清热燥湿调气血，里急腹痛自安康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清热燥湿为本，兼气血并治。
- ② 通因通用，以通祛邪。
- ③ 寒热并投（使寒而不遏，苦寒不伤阳，辛热不伤阴）。

【难点提示】

(1) 通因通用 方中用大黄，其意不在泻下通便，而在于通过大黄荡涤肠胃，使湿热积滞从大便而去，则泻痢自止。

(2) “行血则便脓自愈，调气则后重自除” 语出《素问病机气宜保命集》，为治疗痢疾的基本大法。下利多因湿热疫毒蓄积肠中，致气血瘀滞而成，故见腹痛、里急后重、下利脓血、赤白相兼。此时，当以“行气活血”之法，使气机调畅，血行畅达，气血调和，则腹痛、里急后重、下利脓血自除。故刘完素在该方中以木香、槟榔行气导滞，当归、大黄、肉桂活血祛瘀，合用体现了“行血则便脓自愈，调气则后重自除”的用药方法。

【应用要点】本方为治疗湿热痢疾的常用方剂。以痢下赤白，腹痛里急，苔腻微黄为辨证要点。

现代临床本方常用于细菌性痢疾、阿米巴痢疾、过敏性结肠炎、急性肠炎等属湿热为患者。

【注意事项】

- ① 本方芍药多用白芍（可和营缓急止痛）。
- ② 痢疾初起有表证者忌用，久痢、虚寒痢不宜用。

• 白头翁汤（《伤寒论》）•

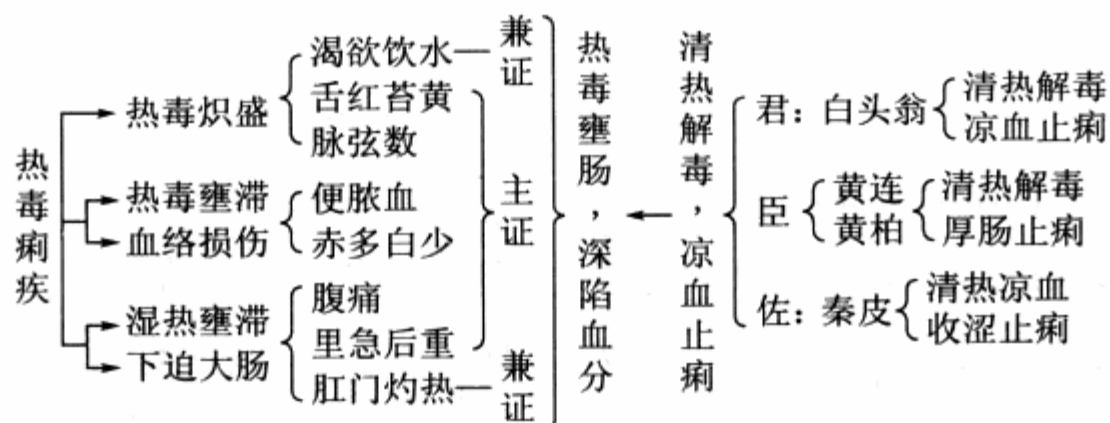
【组成】白头翁二两（15g） 黄柏三两（12g） 黄连三两（6g） 秦皮三两（12g）

【功用】清热解毒，凉血止痢。

【主治】热毒痢疾。腹痛，里急后重，肛门灼热，下痢脓血，赤多白少，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。

【方歌】白头翁汤治热痢，黄连黄柏与秦皮，
味苦性寒能凉血，解毒坚阴功效奇。

【表解】



【配伍特点】

- ① 气血两清（苦寒直折，清热解毒）。
- ② 标本兼顾（清热治本；止痢治标）。

【应用要点】本方为治疗热毒血痢的常用方。以下痢赤多白少，腹痛，里急后重，舌红苔黄，脉弦数为辨证要点。

现代临床本方常用于阿米巴痢疾、细菌性痢疾属热毒偏盛者，亦可加减用之。

【类方比较】

芍药汤与白头翁汤比较表

比较	方名	芍药汤	白头翁汤
组成	同	黄连	
	异	芍药、当归、大黄、槟榔、木香、甘草、黄芩、肉桂	白头翁、黄柏、秦皮
功用	同	清热解毒	
	异	清热燥湿与调气和血并用，兼用通因通用法	以清热解毒凉血为主，兼收涩止痢
主治	同	热痢：腹痛，里急后重，肛门灼热，下痢脓血	
	异	湿热痢疾：赤白相兼，舌苔黄腻	热毒痢疾：下痢脓血，赤多白少，舌红苔黄

第五节 清 虚 热

清虚热剂适用于热病后期，邪留未尽，阴液已伤，出现暮热早凉、舌红少苔；或由肝肾阴虚，以致骨蒸潮热或久热不退的虚热证。本类方剂常以滋阴清热的鳖甲、知母、生地黄与清透伏热的青蒿、秦艽、柴胡、地骨皮等配合成方。代表方剂有青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤等。

• 青蒿鳖甲汤（《温病条辨》） •

【组成】青蒿二钱（6g） 鳖甲五钱（15g） 细生地四钱（12g） 知母二钱（6g） 丹

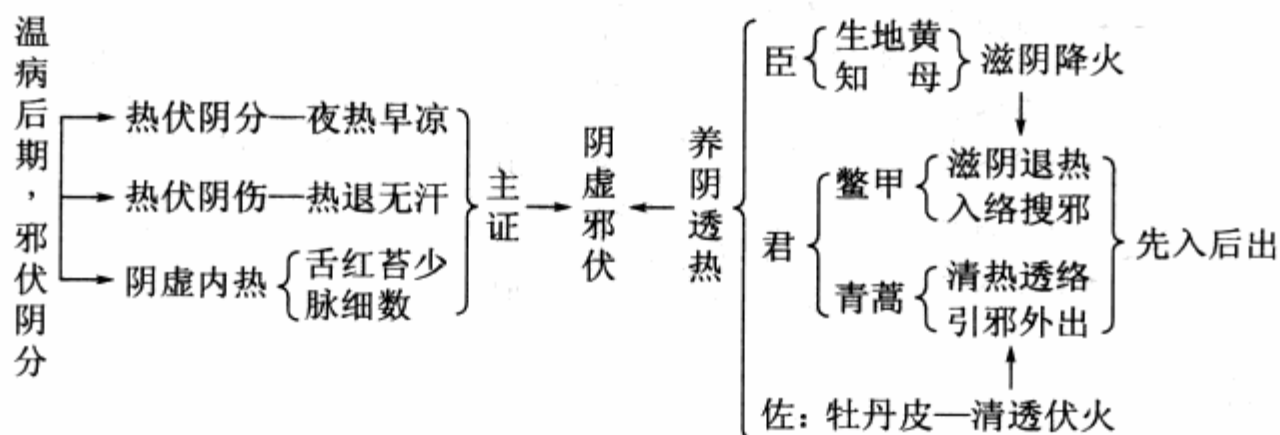
皮三钱 (9g)

【功用】养阴透热。

【主治】温病后期，邪伏阴分证。夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。

【方歌】青蒿鳖甲地知丹，热自阴来仔细辨，
夜热早凉无汗出，养阴透热服之安。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清养兼备，清中有透。
- ② 养阴不恋邪，祛邪不伤正。

【应用要点】本方为治疗余热未尽，阴液不足之虚热证的常用方。以夜热早凉，热退无汗，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于阿米巴痢疾、细菌性痢疾属热毒偏盛者。

• 清 骨 散 (《证治准绳》) •

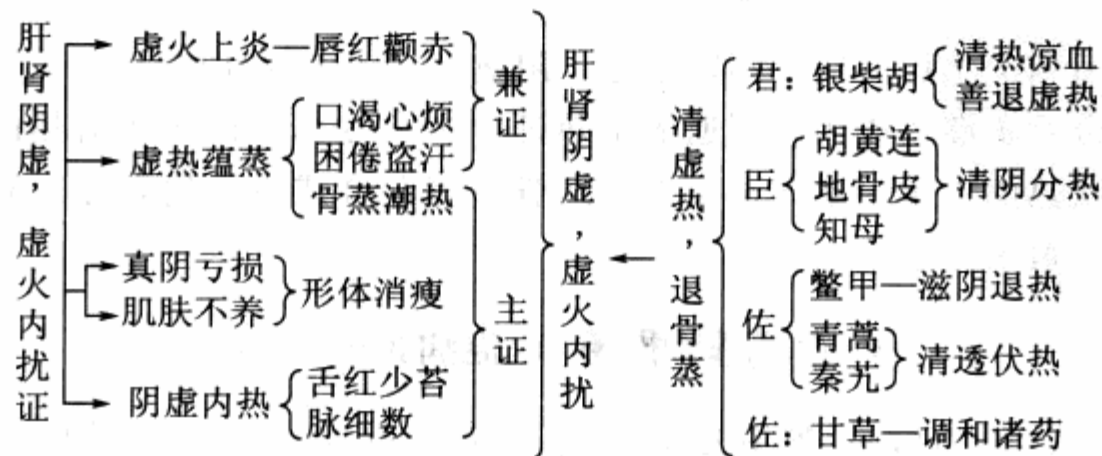
【组成】银柴胡一钱五分 (5g) 胡黄连 秦艽 鳖甲醋炙 地骨皮 青蒿 知母各一钱 (各 3g) 甘草五分 (2g)

【功用】清虚热，退骨蒸。

【主治】肝肾阴虚，虚火内扰证。骨蒸潮热，或低热日久不退，形体消瘦，唇红颧赤，困倦盗汗，或口渴心烦，舌红少苔，脉细数等。

【方歌】清骨散治热如潮，银柴胡连鳖甲蒿，
秦艽知母地骨草，滋肾填阴复虚劳。

【表解】



【应用要点】本方为治疗骨蒸劳热的常用方剂。以骨蒸潮热，形瘦盗汗，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于结核病或其他慢性消耗性疾病的发热骨蒸属阴虚内热者。

• 当归六黄汤（《兰室秘藏》）•

【组成】当归 生地黄 黄芩 黄柏 黄连 熟地黄各等分（各 6g） 黄芪加一倍（12g）

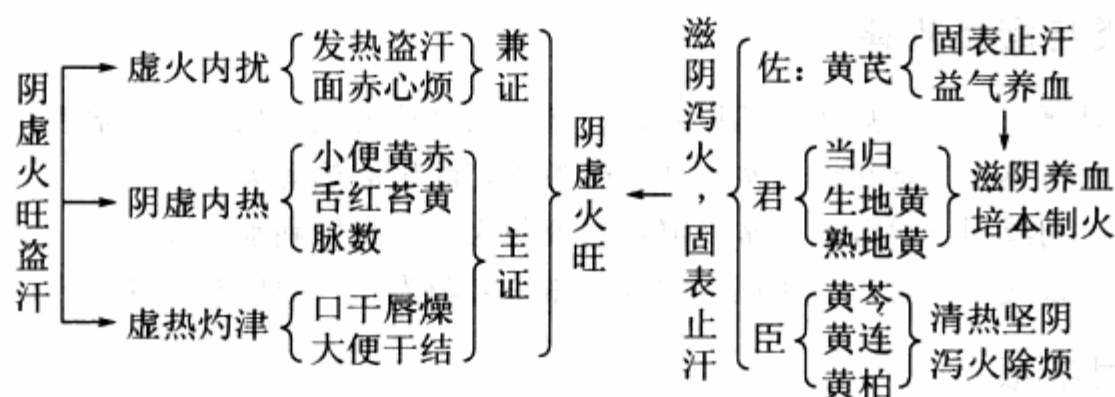
【功用】滋阴泻火，固表止汗。

【主治】阴虚火旺盗汗。发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数。

【方歌】当归六黄二地黄，芩连芪柏共煎尝，

滋阴泻火兼顾表，阴虚火旺盗汗良。

【表解】



【配伍特点】

① 养血育阴与泻火清热并进，使水能制火，热清而不耗阴。

② 益气固表与育阴泻火相配，使营阴内守，卫外固密。

【应用要点】本方为治疗阴虚火旺盗汗的常用方。以盗汗面赤，心烦溲赤，舌红，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于甲状腺功能亢进、结核病、糖尿病、更年期综合征属阴虚火旺者。

第五章 祛暑剂

一、定义

凡是以祛暑药为主组成，具祛除暑邪的作用，用于治疗暑病的方剂，称为祛暑剂。

二、立法依据

暑为火热之邪，故祛暑剂立法与温热病基本相同，即以清暑热为基本治法，当属八法“清”法范畴。但暑病多兼夹他邪，故治法又随证多变，历代医家多有论述。

三、适应范围

适用于夏月暑热证。症见身热烦渴，汗出体倦，小便不利，脉数等。

四、分类与配伍规律

祛暑剂	祛暑解表剂—暑病兼外感风寒证—常以祛暑药为主，配伍辛温解表药
	祛暑清热剂—暑热证—常以祛暑药为主，配伍清热泻火药
	祛暑利湿剂—暑湿证—常以清热祛暑药为主，配伍利水渗湿药
	清暑益气剂—暑伤气阴证—常以清热祛暑药为主，配伍益气养阴药

五、使用注意

使用祛暑剂应注意辨清有无兼夹病邪，暑病夹湿者，应分清暑与湿之主次轻重，酌用祛暑、除湿之品：暑重湿轻，除湿不可过用温燥；湿重暑轻，祛暑不宜过用甘寒。

• 清 络 饮 (《温病条辨》) •

【组成】 鲜银花 鲜扁豆花 西瓜翠衣 丝瓜络 鲜荷叶边 鲜竹叶心各二钱 (各 6g)

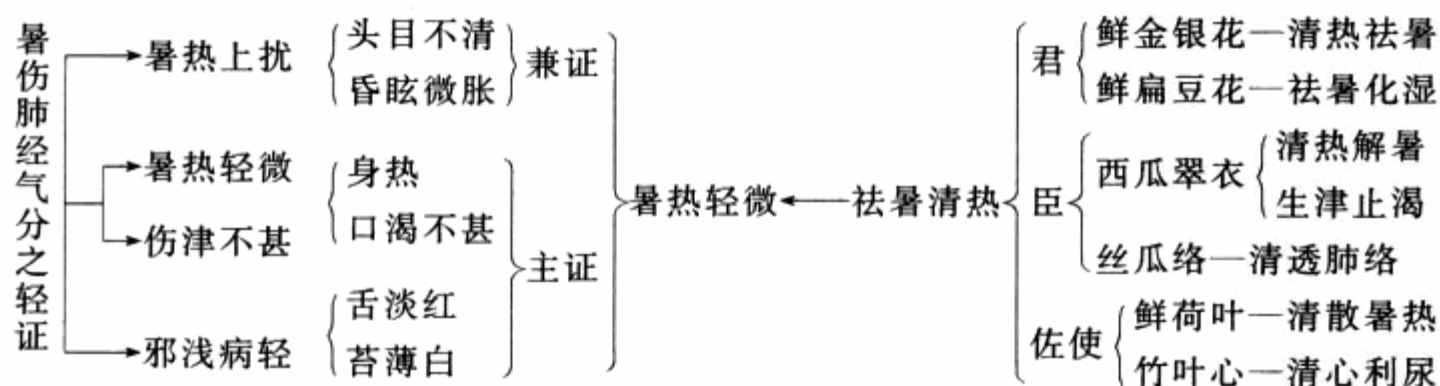
【功用】 祛暑清热。

【主治】 暑伤肺经气分之轻证。身热口渴不甚，头目不清，昏眩微胀，舌淡红，苔薄白。

【方歌】 清络丝瓜荷叶银，扁豆翠衣竹叶心，

芳香轻清需生用，暑伤肺络效最灵。

【表解】



【应用要点】 本方为治疗暑伤肺经气分轻证的常用方。以身热口渴不甚，舌淡红，

苔薄白为辨证要点。

• 香 薷 散 (《太平惠民和剂局方》) •

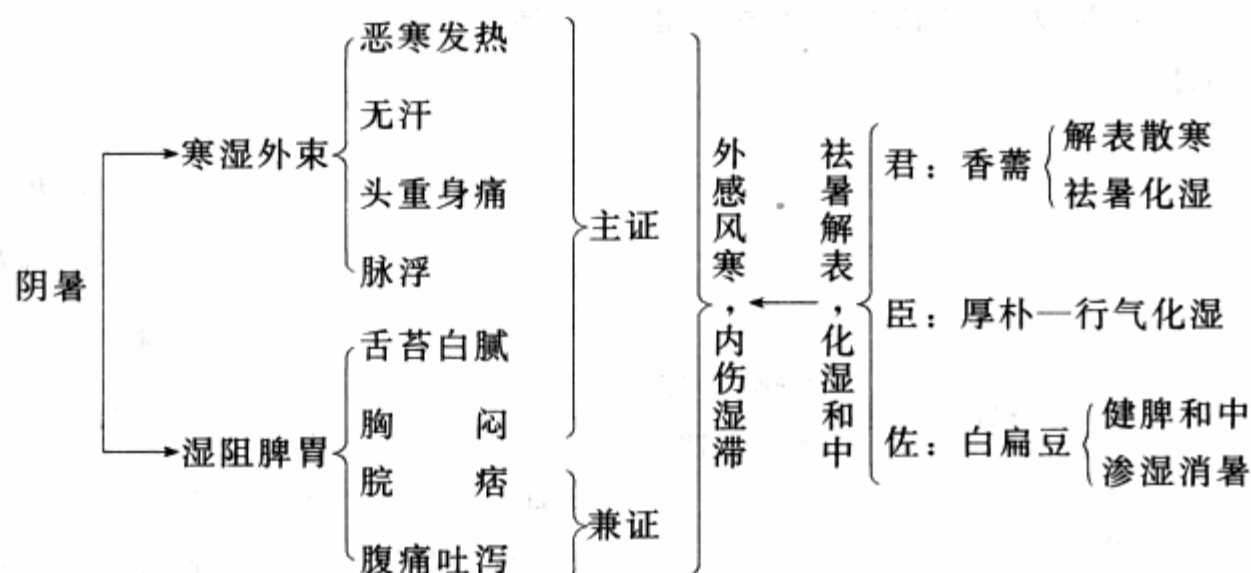
【组成】香薷一斤(9g) 白扁豆微炒 厚朴姜制, 各半斤(各6g)

【功用】祛暑解表, 化湿和中。

【主治】阴暑。恶寒发热, 腹痛吐泻, 头重身痛, 无汗, 胸脘痞闷, 舌苔白腻, 脉浮。

【方歌】香薷散中扁豆朴, 祛暑解表化湿阻,
易豆为花加银翘, 新加香薷治阴暑。

【表解】



【配伍特点】解表与化湿并用, 健脾与行气兼顾。

【应用要点】本方为治疗夏月乘凉饮冷, 外感风寒, 内伤湿滞的常用方剂。以恶寒发热, 头重身痛, 无汗, 胸闷, 苔白腻, 脉浮为辨证要点。

现代临床本方常用于夏季感冒、急性胃肠炎等属暑湿外感风寒证者。

• 六 一 散 (《黄帝素问宣明论方》) •

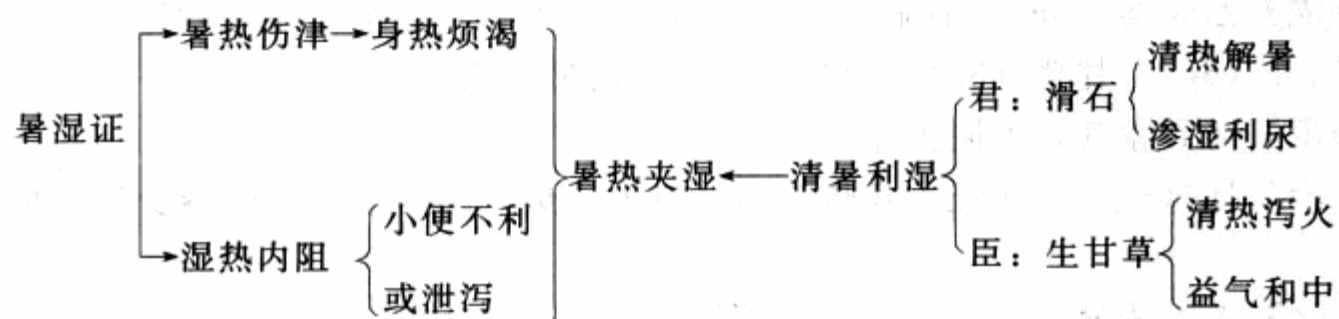
【组成】滑石六两(18g) 甘草一两(3g)

【功用】清暑利湿。

【主治】暑湿证。身热烦渴, 小便不利, 或泄泻。

【方歌】六一散用滑石草, 清暑利湿有功效,
益元碧玉与鸡苏, 砂黛薄荷加之好。

【表解】



【应用要点】本方为治疗暑湿及湿热壅滞证的基础方。以身热烦渴, 小便不利为辨

证要点。

现代临床本方常用于膀胱炎、尿道炎等属湿热者，亦可加减用之。

• 桂苓甘露饮（《宣明论方》）•

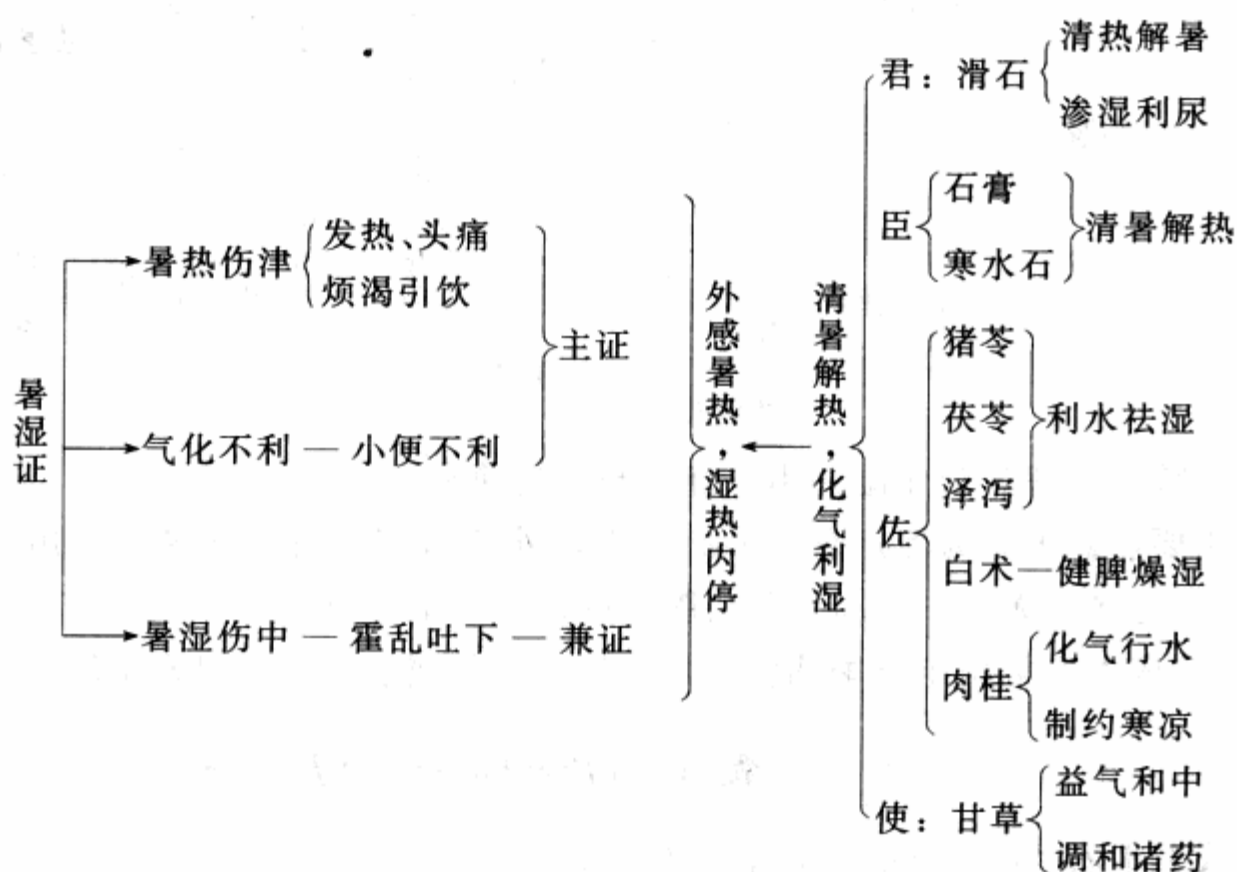
【组成】茯苓一两（15g） 甘草二两（6g） 白术炙，半两（12g） 泽泻一两（15g） 官桂去皮，二两（3g） 石膏二两（30g） 寒水石二两（30g） 滑石四两（30g） 猪苓半两（15g）

【功用】清暑解热，化气利湿。

【主治】暑湿证。发热头痛，烦渴引饮，小便不利，以及霍乱吐下。

【方歌】桂苓甘露猪苓膏，术泽寒水滑石草，
祛暑清热又利湿，发热烦渴吐泻消。

【表解】



【应用要点】本方为祛暑利湿的常用方。以发热，烦渴引饮，小便不利为辨证要点。

现代临床本方常用于中暑、尿路感染属暑热者。

• 清暑益气汤（《温热经纬》）•

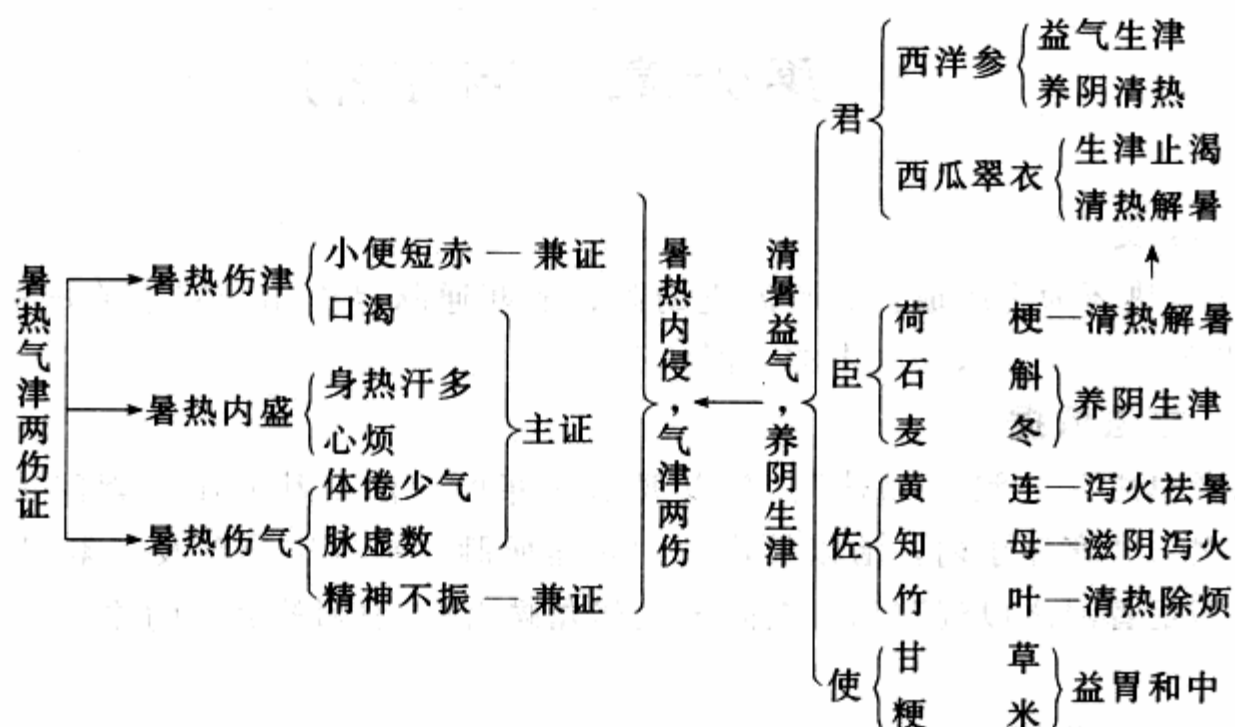
【组成】西洋参（5g） 石斛（15g） 麦冬（9g） 黄连（3g） 竹叶（6g） 荷梗（6g） 知母（6g） 甘草（3g） 粳米（15g） 西瓜翠衣（30g）

【功用】清暑益气，养阴生津。

【主治】暑热气津两伤证。身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数。

【方歌】王氏清暑益气汤，善治中暑气阴伤，
洋参冬斛荷瓜翠，连竹知母甘梗襄。

【表解】



【配伍特点】清补并用，既清暑热，又补气津。

【应用要点】本方为治疗夏月感暑，伤津耗气证的常用方。以体倦少气，口渴汗多，脉虚数为辨证要点。

现代临床本方常用于小儿夏季热，久热不退，烦渴体倦，属气津不足者。

第六章 温里剂

一、定义

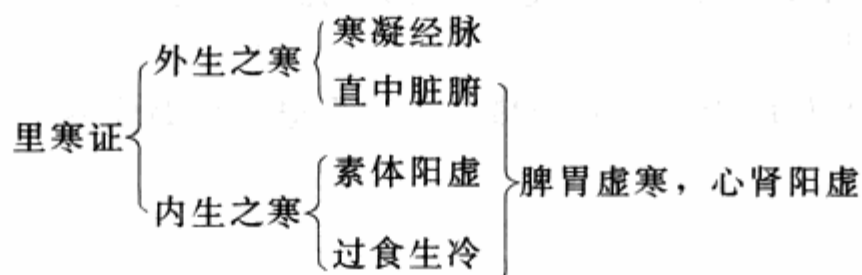
凡以温热药为主组成，具有温里助阳、散寒通脉等作用，用于治疗里寒证的方剂，统称温里剂。属于“八法”中的“温法”。

二、立法依据

“寒者热之”、“治寒以热”。总以温阳祛寒而立法。其原则《素问·至真要大论》“寒者热之”、“寒淫于内，治以甘热”、“寒淫所胜，平以辛热”及《素问·阴阳应象大论》“形不足者温之以气”和《素问·三部九候论》“虚则补之”的原则。属于八法中的“温法”。

三、适应范围

本类方剂适用于治疗里寒证。



四、分类与配伍规律

里寒证	{	温中祛寒剂—脾胃虚寒证	—常以温中散寒药为主，配伍益气健脾药
		回阳救逆剂—心肾阳虚证	—常以温肾祛寒药为主，配伍益气固脱药
		温经散寒剂—寒凝经脉证	—常以辛温发散药为主，配伍养血通脉药

五、使用注意

- ① 辨别部位，明确脏腑。
- ② 明辨真假寒热。真热假寒者忌用。
- ③ 三因治宜。
- ④ 阴寒太盛，注意反佐。服热药入口即吐者，可少佐寒凉之品，或热药冷服。

第一节 温中祛寒

温中祛寒剂适用于中焦虚寒证。若脾胃阳气虚弱，则运化无权，升降失职，势必导致寒湿内生，出现脘腹胀痛、肢体倦怠、手足不温，或吞酸吐涎、恶心呕吐，或腹痛不利、不思饮食、口淡不渴、舌苔白滑、脉沉细或沉迟等症。常用温中散寒药如干姜、吴茱萸等配伍益气健脾药如人参、白术、饴糖等组成方剂。代表方有理中丸、小建中汤、吴茱萸汤。

• 理中丸（《伤寒论》） •

【组成】 人参 干姜 甘草炙 白术各三两（各 9g）

【功用】温中散寒，补气健脾。

【主治】

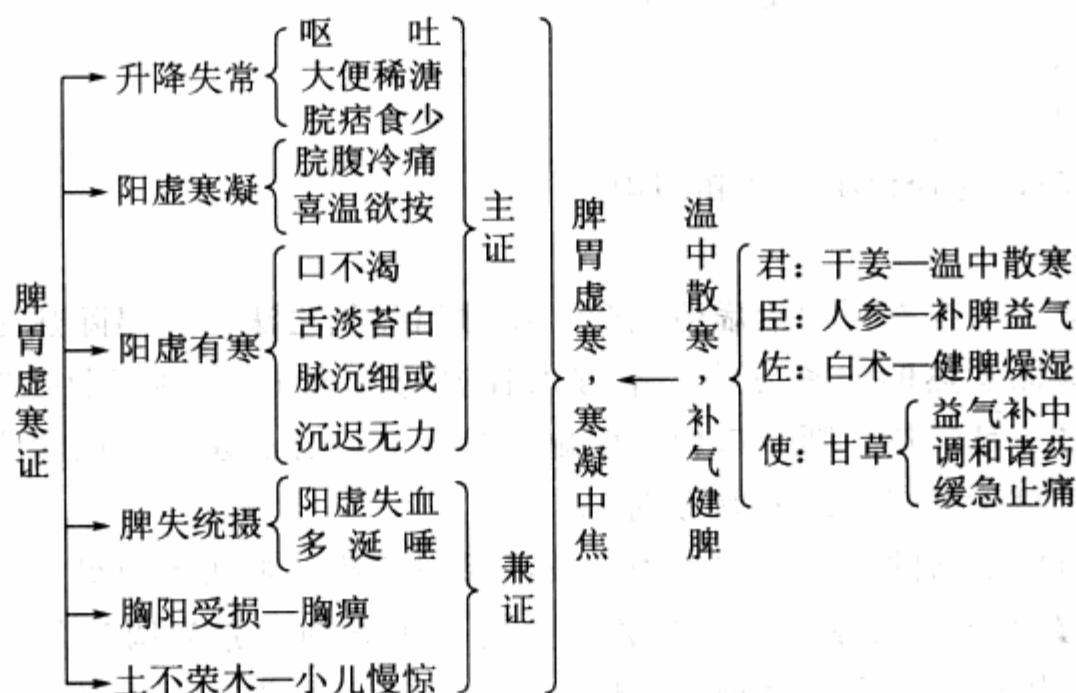
① 脾胃虚寒证。脘腹冷痛，喜温欲按，畏寒肢冷，呕吐，大便稀溏，脘痞食少，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或沉迟无力。

② 阳虚失血证。便血、吐血或崩漏等，血色暗淡，质清稀。

③ 脾胃虚寒所致胸痹；或小儿慢惊；或病后多涎唾。

【方歌】理中汤主理中阳，人参白术草干姜，
中阳虚甚加附子，增桂温里力更强。

【表解】



【配伍特点】温补并用，以温为主。

【应用要点】本方为治疗脾胃虚寒证的基础方。以畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟或沉细为辨证要点。

现代临床本方常用于急慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃下垂、胃扩张、慢性结肠炎等属脾胃虚寒者。

【使用注意】方中药性偏于温燥，故对湿热内蕴或脾胃阴虚者忌用。

• 小建中汤（《伤寒论》）•

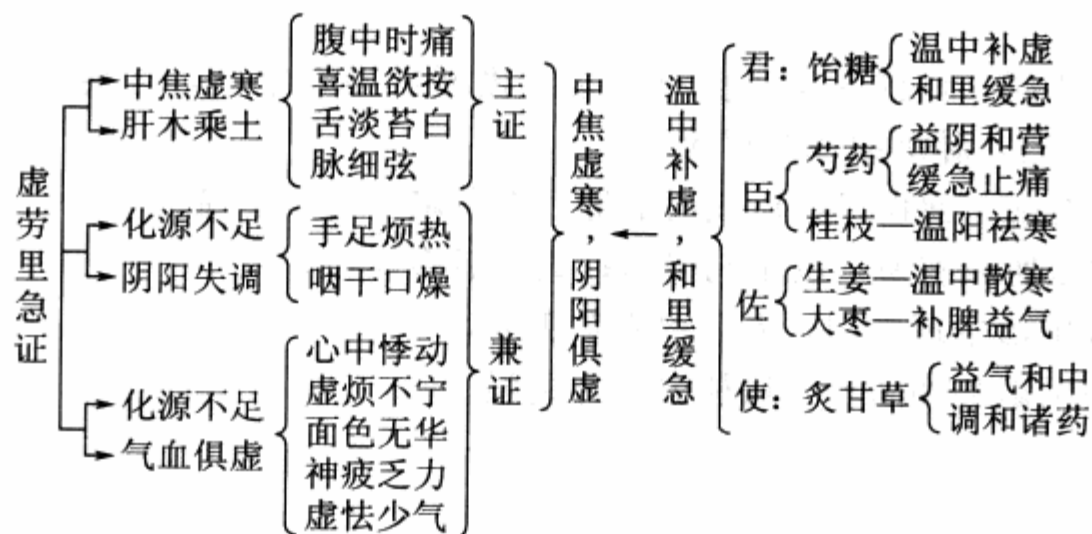
【组成】芍药六两，酒炒（18g） 桂枝三两，去皮（9g） 炙甘草二两（6g） 生姜切，三两（9g） 大枣十二枚，擘（4枚） 饴糖一升（30g）

【功用】温中补虚，和里缓急。

【主治】虚劳里急证。腹中时痛，喜温欲按，神疲乏力，虚怯少气；或心中悸动，虚烦不宁，面色无华；或四肢酸楚，手足烦热，咽干口燥等。舌淡苔白，脉细弦。

【方歌】桂枝汤方芍药重，煎加饴糖小建中，
参姜蜀椒冲饴糖，大建中汤力更宏。

【表解】



【配伍特点】

- ① 重用甘温，建立中气。
- ② 辛甘化阳，酸甘化阴，调和阴阳。

【难点提示】

(1) 甘温除热 本方可用治虚劳发热，属甘温除热之法。甘温除热是指以甘温的药物为主，治疗虚证发热的一种方法。本方以甘温药物为主，治疗因中焦阳虚，阴阳失调，阴不维阳之手足烦热、咽干口渴等阳虚发热。故以甘温建中，调和阴阳则热除。本方可看做甘温除热法的祖方或原始方剂。

(2) 本方与桂枝汤的关系 本方为桂枝汤倍用芍药，重加饴糖组成。

【应用要点】本方为温中补虚、缓急止痛的代表方剂，亦为调和阴阳、柔肝理脾的常用方。临床应用以腹痛喜温喜按、心悸、发热、面色无华、舌质淡、脉沉弱或细弦为辨证要点。

现代临床本方常用于胃及十二指肠溃疡、慢性肝炎、神经衰弱、再生障碍性贫血、功能性发热等属中焦虚寒、肝脾不和者。

【使用注意】

- ① 阴虚火旺者忌用。
- ② 呕家不宜用，恐甜助呕。
- ③ 吐蛔者不可用，因蛔得甘则逆上。
- ④ 中满不可用，因甘能填实助满。

• 吴茱萸汤（《伤寒论》）•

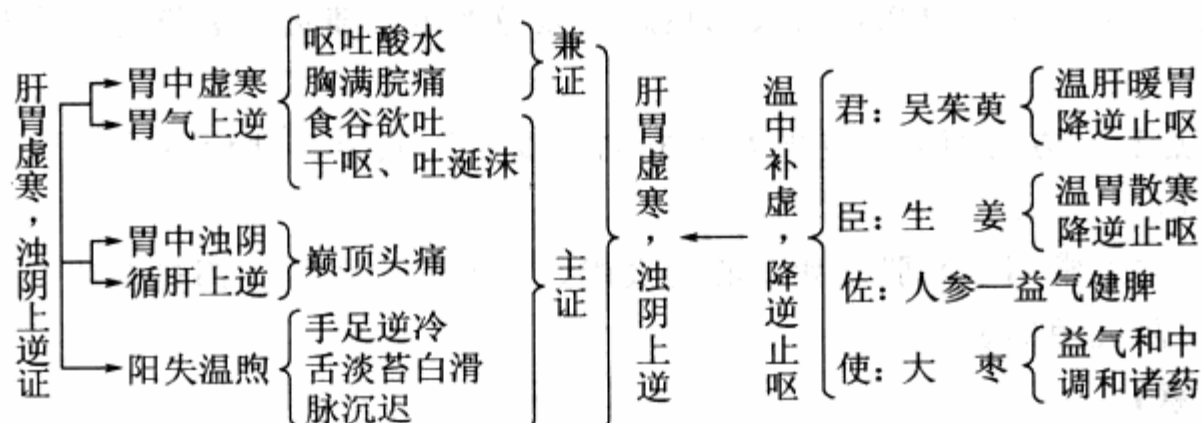
【组成】吴茱萸一升，汤洗（9g） 人参三两（各9g） 大枣十二枚，擘（4枚） 生姜切，六两（18g）

【功用】温中补虚，降逆止呕。

【主治】肝胃虚寒，浊阴上逆证。食谷欲呕，畏寒喜热，或胸满脘痛，吞酸嘈杂；或厥阴头痛，干呕、吐涎沫；或少阴吐利，手足逆冷，烦躁欲死。

【方歌】吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，
阳明寒呕少阴利，厥阴头痛皆能保。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温中与降逆并施，肝胃同治。
- ② 寓补益于温降之中。

【应用要点】本方为治疗肝胃虚寒，浊阴上逆证的常用方剂。以呕吐，或干呕、吐涎沫，舌淡苔滑，脉细、迟或弦细为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃炎、妊娠呕吐、神经性头痛、耳源性眩晕等属中焦虚寒者。

第二节 回阳救逆

回阳救逆剂适用于阳气衰微，阴寒内盛，甚至阴盛格阳或戴阳等证。症见四肢厥逆，精神萎靡，恶寒踡卧，下利清谷，甚则大汗淋漓，脉微细或脉微欲绝等。故常以附子、干姜、肉桂等为主组成方剂，若出现亡阳气脱者，又需与补气之人参配伍。代表方剂有四逆汤、回阳救急汤。

• 四逆汤（《伤寒论》）•

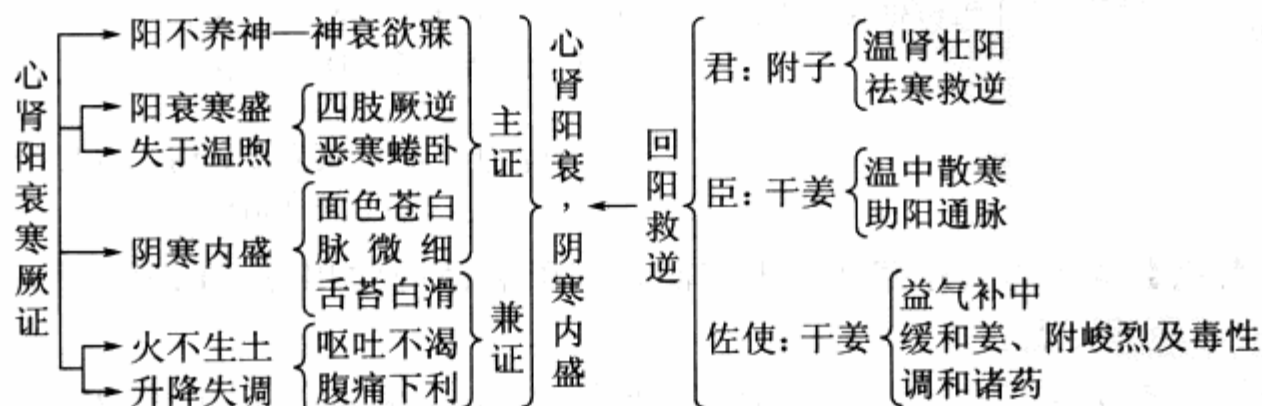
【组成】附子一枚，生用，去皮、破八片（15g） 干姜一两半（9g） 甘草炙，二两（6g）

【功用】回阳救逆。

【主治】心肾阳衰寒厥证。四肢厥逆，恶寒踡卧，神衰欲寐，面色苍白，腹痛下利，呕吐不渴，舌苔白滑，脉微细；或太阳病误汗亡阳。

【方歌】四逆汤中附草姜，四肢厥冷急煎尝，
腹痛吐泻脉微细，急投此方可回阳。

【表解】



【配伍特点】脾肾兼顾，温补结合。

【难点提示】本方所治“四逆”乃阴寒内盛，阳气衰微，不达四末所致，属“寒厥”范畴。临床特点是：冷过肘膝，久按无热感，厥逆严重，兼见神衰欲寐、腹痛下利、脉微欲绝等。

【应用要点】本方为回阳救逆的基础方剂。以四肢厥冷、神疲欲寐、舌淡苔白、脉微为辨证要点。

现代临床本方常用于心肌梗死、心力衰竭、急慢性胃肠炎吐泻过多或某些急证大汗出而见休克属阳衰阴盛者。

【使用注意】

- ① 真热假寒者忌用。
- ② 热厥及阳郁厥逆之证禁用。
- ③ 服药呕吐者，可采用冷服法。

• 回阳救急汤（《伤寒六书》） •

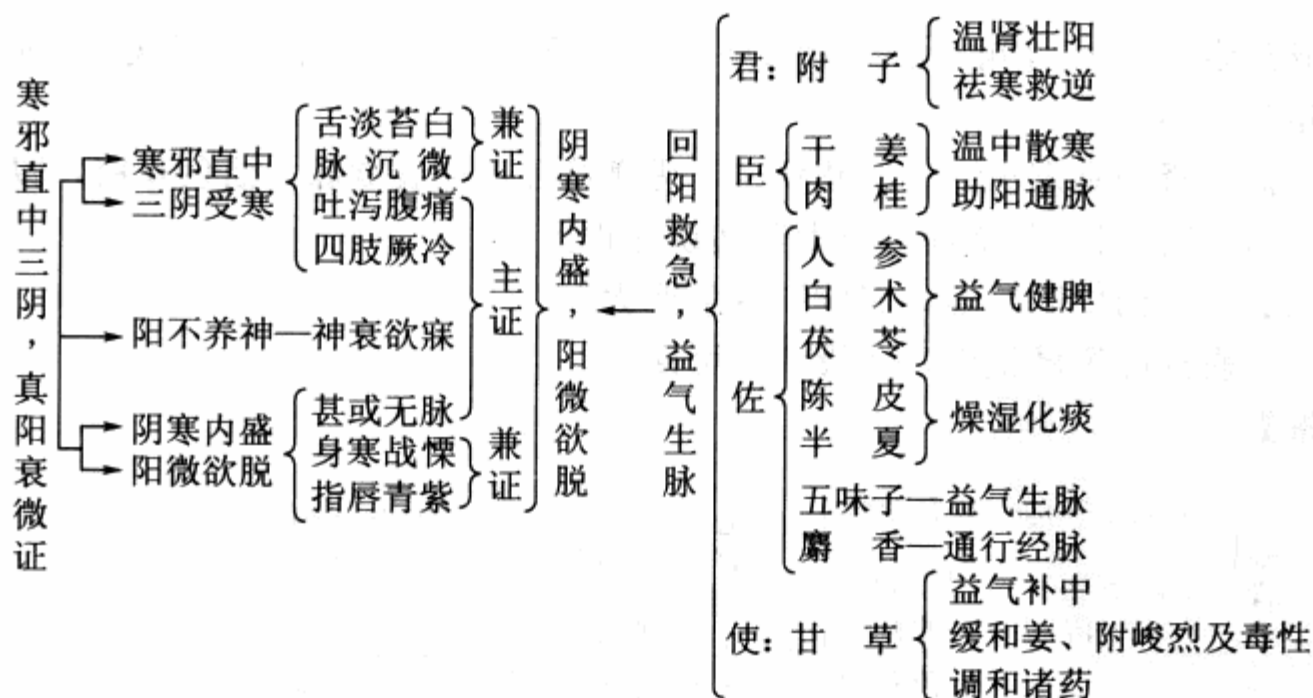
【组成】熟附子（9g） 干姜（5g） 肉桂（3g） 人参（6g） 白术炒（9g） 茯苓（9g） 陈皮（6g） 甘草炙（5g） 五味子（3g） 半夏制（9g）

【功用】回阳救急，益气生脉。

【主治】寒邪直中三阴，真阳衰微证。恶寒踡卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，或身寒战慄，或指甲口唇青紫，或吐涎沫，舌淡苔白，脉沉微，甚或无脉等。

【方歌】回阳救急用六君，桂附干姜五味寻，
加麝三厘或胆汁，三阴寒厥建奇勋。

【表解】



【应用要点】本方为治疗寒邪直中三阴，真阳衰微的常用方。以厥、利、脉微、神衰欲寐并重为辨证要点。

现代临床本方常用于急性胃肠炎吐泻过多、休克、心力衰竭等属亡阳欲脱者。

第三节 温经散寒

温经散寒剂适用于寒邪凝滞经脉之血痹寒厥、阴疽等证。此类疾病多系阳气不足，阴血内弱，寒滞经脉所致。故本类方剂的配伍特点是辛温散寒与温养气血药合用。主药有桂枝、细辛、当归、白芍、黄芪、熟地黄等。代表方有当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤、阳和汤等。

• 当归四逆汤（《伤寒论》）•

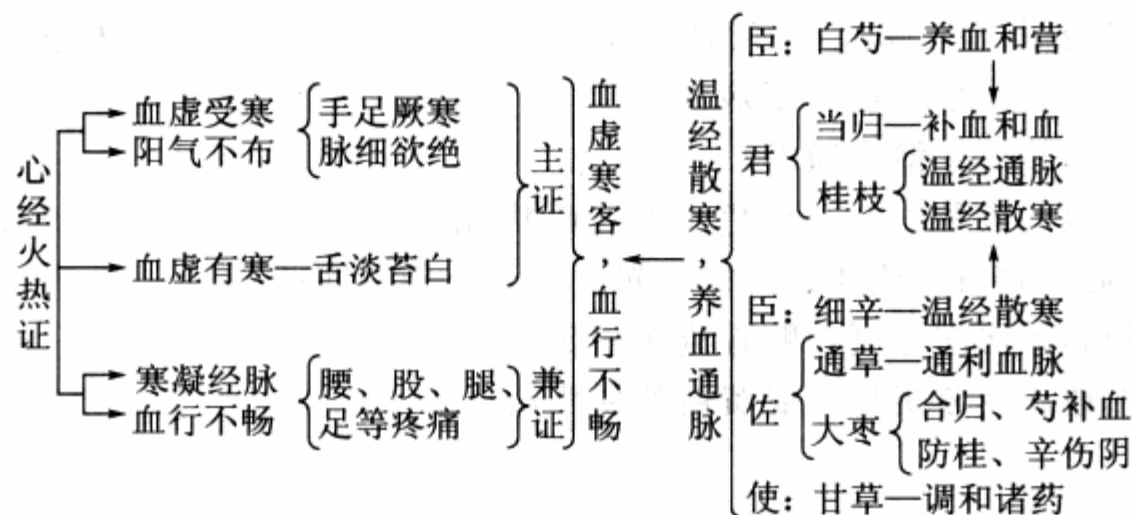
【组成】 当归三两（12g） 桂枝三两，去皮（9g） 细辛三两（3g） 芍药三两（9g） 甘草二两，炙（6g） 通草二两（6g） 大枣二十五枚，擘（8枚）

【功用】 温经散寒，养血通脉。

【主治】 血虚寒厥证。手足厥寒，口不渴，或腰、股、腿、足、肩疼痛，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。

【方歌】 当归四逆桂芍枣，细辛甘草与通草，
血虚肝寒手足冷，煎服此方乐陶陶。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温阳与散寒并用。
- ② 养血与通脉兼施。

【难点提示】

(1) “四逆”的病机及临床特点 本方所治“四逆”乃血虚阳弱，寒凝经脉所致，病位在经不在脏，属“寒厥”范畴。临床特点是：厥逆程度轻，兼见肢体疼痛症。

(2) 本方与桂枝汤的关系 本方为桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛组成。

【应用要点】 本方为温经散寒，养血通脉的常用方。以手足厥寒，脉细欲绝，舌淡为辨证要点。

现代临床本方常用于血栓闭塞性脉管炎、无脉症、雷诺病、小儿下肢麻痹等属血虚寒凝者。

【类方比较】

四逆散、四逆汤与当归四逆汤比较表

比较 \ 方名		四逆散	四逆汤	当归四逆汤
组成	同	甘草		
	异	柴胡、白芍、枳实	附子、干姜	当归、桂枝、细辛、芍药、通草、大枣
功效	异	透邪解郁，疏肝理脾	回阳救逆	温经散寒，养血通脉
主治	同	“四逆”之手足厥逆		
	异	邪在少阳，阳郁不达之厥逆证，属“寒厥”范畴。兼见身微热，或咳，或悸，或小便不利，或腹痛，或泄利，脉弦	邪在少阴，阴寒内盛，阳气衰微，不达四末所致，属“寒厥”范畴。厥逆严重，兼见神衰欲寐、腹痛下利、脉微欲绝等	邪在厥阴，血虚阳弱，寒凝经脉所致，属“寒厥”范畴。厥逆较轻，兼见肢体疼痛症

• 阳和汤（《外科证治全生集》） •

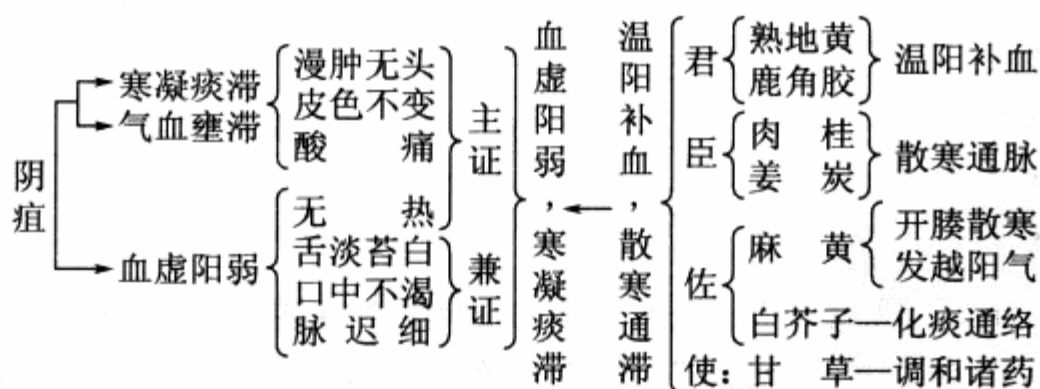
【组成】熟地黄一两（30g） 肉桂一钱，去皮，研粉（3g） 麻黄五分（2g） 鹿角胶三钱（9g） 白芥子二钱（6g） 姜炭五分（2g） 生甘草一钱（3g）

【功用】温阳补血，散寒通滞。

【主治】阴疽。漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细。或贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等属于阴寒证者。

【方歌】阳和汤法解寒凝，贴骨流注鹤膝风，
熟地鹿胶姜炭桂，麻黄白芥甘草从。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温阳与补血并用（一阴一阳，阴阳互生）。
- ② 辛散与滋腻并用（补而不滞，温通宣发不伤正）。
- ③ 逐层宣通，化寒凝而布阳气。

筋骨（熟地黄、鹿角胶）→肌肉、血脉（肉桂、姜炭）→皮里膜外（白芥子）→腠理（麻黄）

【难点提示】本方中麻黄只起发越阳气以散阴寒的作用，故用量宜轻（五分），熟地

黄补血固本，用量宜重（一两）。

【应用要点】本方为治疗阴疽的常用方剂，亦为治疗外科疮疡阴证的基础方。以患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，脉迟细或沉细为辨证要点。

现代临床本方常用于骨结核、腹膜结核、慢性骨髓炎、骨膜炎、慢性淋巴结炎、类风湿性关节炎、血栓闭塞性脉管炎、肌肉深部脓疡等属血虚寒凝者。

【使用注意】

- ① 本方适用于阴疽，阳证忌用。
- ② 疮疡红肿热痛及阴虚有热者，或疽已溃破，不宜用本方。

第七章 补益剂

一、定义

凡以补益药为主组成，具有补养人体气、血、阴、阳等作用，主治各种虚证的方剂，统称补益剂。属于“八法”中的“补法”。

二、立法依据

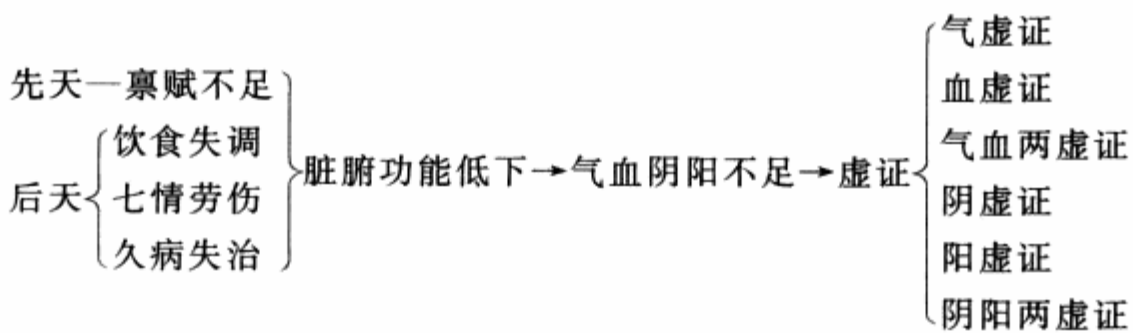
“虚则补之”、“损则益之”。补益剂的补益方法有多种，具体如下。

直接补益法：即某脏虚即补某脏。《难经·十四难》：“损其肺者，益其气。”“损其肾者，益其精”。

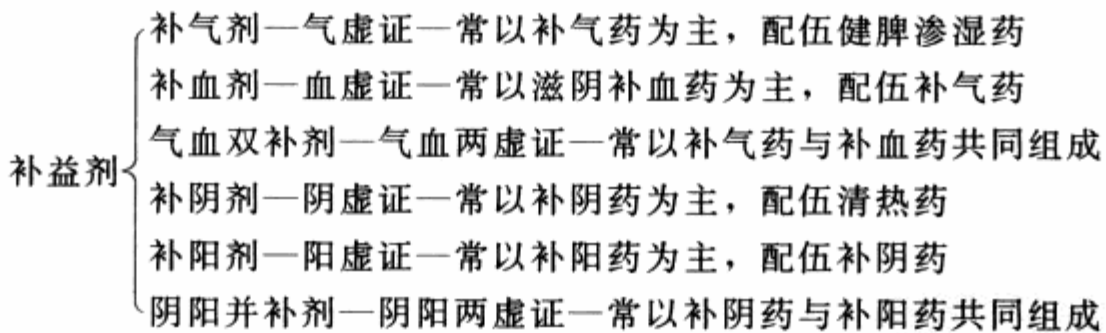
间接补益法：即通过间接补益的方法以补其不足。按五行相生理论，采用“虚则补其母”的方法。如肺虚者补其脾，即培土生金；脾阳虚者补其命门，即补火生土；肝阴虚者补其肾，即滋水涵木等。

补益脾肾法：即间接补养虚损之脏，其理论根据为肾为先天之本，是真阴真阳之所在；脾为后天之本，气血生化之源，通过补益脾肾之根本达到治疗虚损的目的。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

- ① 辨清病位，据因而补。
- ② 明辨虚实真假。
- ③ 调整脾胃功能。
- ④ 慢火久煮，空腹或饭前服用。

第一节 补 气

补气剂适用于脾肺气虚的病证。症见肢体倦怠乏力，少气懒言，语音低微，动则气促，面色萎白，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱，甚或虚热自汗，或脱肛、子宫脱垂等。

常以补气药如人参、党参、黄芪、白术、甘草等为主，根据兼夹证的不同，分别配伍理气、渗湿、升阳举陷、补血等。代表方如四君子汤、参苓白术散、补中益气汤、玉屏风散、生脉散。

• 四君子汤（《伤寒论》）•

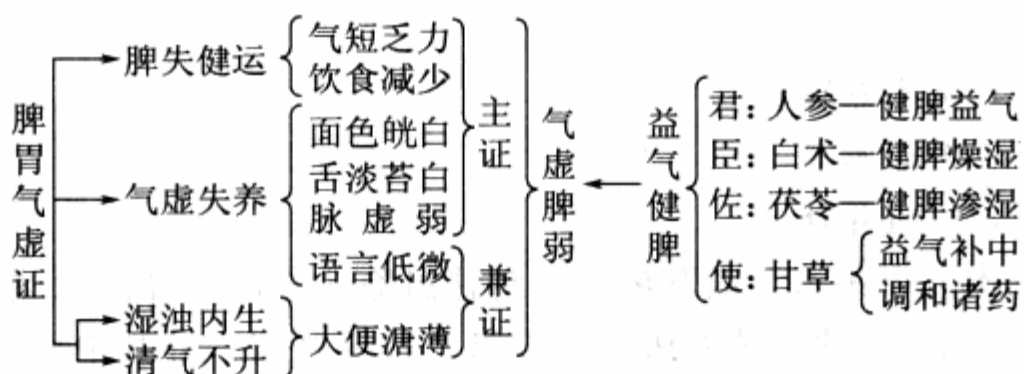
【组成】人参去芦 白术 茯苓去皮（各 9g） 甘草炙（6g） 各等分

【功用】益气健脾。

【主治】脾胃气虚证。面色㿔白，语言低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱。

【方歌】四君子汤补中气，参苓术草甘温剂，
益以半夏名异功，补虚行滞调气机。

【表解】



【配伍特点】

- ① 补脾与补气兼顾。药性平和，温而不燥。
- ② 燥湿与渗湿同用，防湿困阻脾胃。

【应用要点】本方为治疗脾胃气虚的常用方，亦是补气的基础方。以面色㿔白，食少，气短，四肢无力，舌淡苔白，脉虚弱为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡等属脾胃气虚者。

• 补中益气汤（《内外伤辨惑论》）•

【组成】黄芪病甚劳役热甚者一钱（18g） 甘草炙，五分（9g） 白术三分（9g） 人参去芦，三分（6g） 当归酒焙干或晒干，二分（3g） 升麻 柴胡 橘皮不去白，各二分或三分（各 6g）

【功用】补中益气，升阳举陷。

【主治】

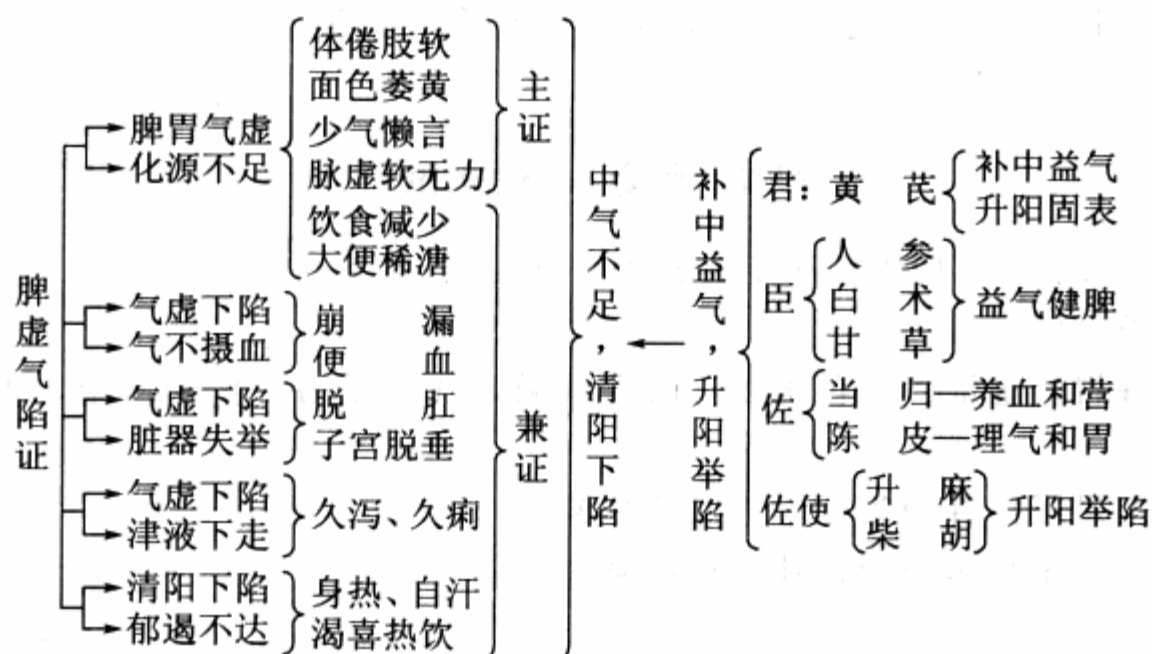
① 脾胃气虚证。饮食减少，体倦肢软，少气懒言，面色萎黄，大便稀溏，脉大而虚软。

② 气虚下陷证。脱肛、子宫脱垂、久泻、久痢、崩漏等，气短乏力，舌淡，脉虚者。

③ 气虚发热证。身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力。

【方歌】补中益气芪术参，升柴陈草当归身，
益气升阳能固脱，甘温除热亦堪珍。

【表解】



【配伍特点】

- ① 补中寓升，标本兼顾。
- ② 补中兼行，补而不滞。
- ③ 补血寓气，气血并补。

【难点提示】本方可用治气虚发热证，属甘温除热之法。甘温除热法是指以甘温的药物为主，治疗虚证发热的一种方法。本方以“甘温之剂，补其中而升其阳”，治疗因内伤劳倦，脾胃气虚所引起的发热，体现甘温除热之法，且可看做甘温除热法的代表方剂。

参考：

目前，一般认为，具备以下4项中的2项以上表现者，即可确诊为气虚发热证。

- ① 病程较长，一般在数月至1~2年之间。
- ② 持续低热，或壮热不退，饮食失节或过度疲劳时加重。
- ③ 兼有脾气亏虚或气血两虚的症状。
- ④ 用甘寒养阴、苦寒清热之剂，或使用多种抗生素无效。

【应用要点】本方为补气升阳，甘温除热的代表方。以体倦乏力，少气懒言，面色萎黄，脉虚软无力为辨证要点。

现代临床本方常用于内脏下垂、久泻、久痢、脱肛、重症肌无力、乳糜尿、慢性肝炎等；妇科之子宫脱垂、妊娠及产后癃闭、胎动不安、月经过多；眼科之眼睑下垂、麻痹性斜视等属脾胃气虚或中气下陷者。

【使用注意】

- ① 阴虚内热及外感发热者慎用。
- ② 命门火衰，虚寒泻痢、湿热泻痢者禁用。
- ③ 剂量要小，特别是升麻和柴胡（原方共用3钱3分）。

• 参苓白术散（《太平惠民和剂局方》）•

【组成】莲子肉去皮，一斤（9g） 薏苡仁一斤（9g） 缩砂仁一斤（6g） 桔梗炒，令

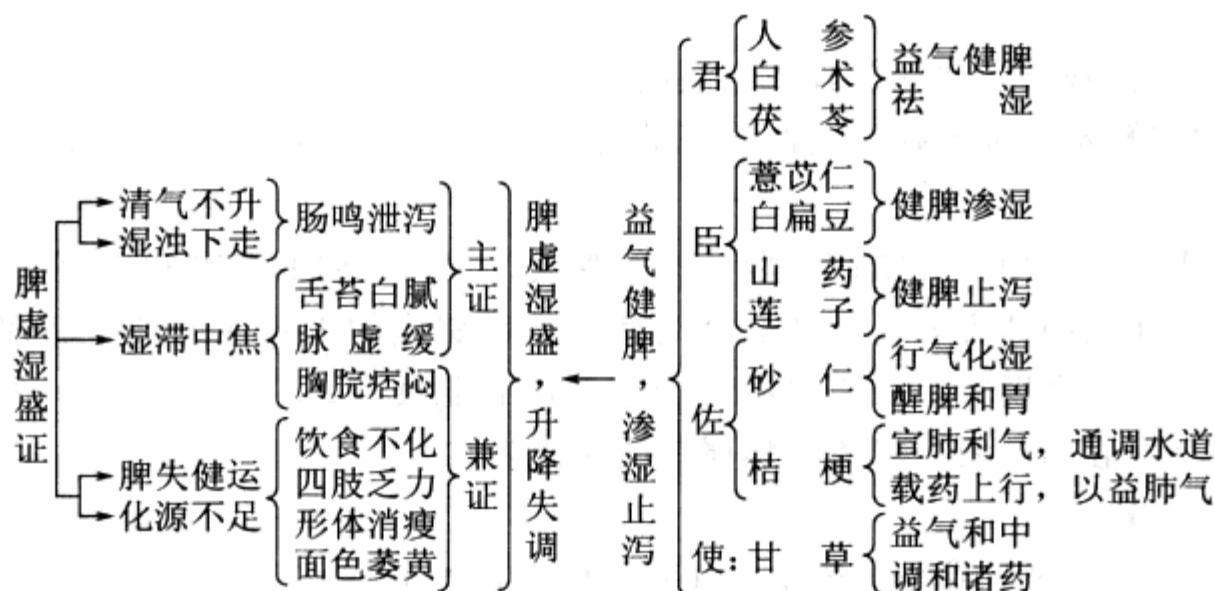
深黄色，一斤（6g） 甘草炒，二斤（9g） 白茯苓 人参 白术 山药各二斤（各 15g）
白扁豆姜汁浸，去皮，微炒，一斤半（12g）

【功用】益气健脾，渗湿止泻。

【主治】脾虚湿盛证。饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓。

【方歌】参苓白术扁豆陈，山药甘莲砂薏仁，
桔梗上浮兼保肺，枣汤调服益脾神。

【表解】



【配伍特点】

- ① 补中有行，通中有涩（补气健脾为主，兼调气行滞）。
- ② 药力平和，温而不燥。

【难点提示】培土生金法，即补脾益肺法，是借五行相生的理论，用补脾益气的方药补益肺气的方法。临床多用于咳嗽日久，痰多清稀，兼见食欲减退、大便溏、四肢无力、舌淡脉弱等肺虚脾弱的证候。本方用桔梗载药上行，可补益肺气，故称培土生金法。

【应用要点】本方为治疗脾虚湿盛泄泻的常用方，也是“培土生金”的代表方。临床以泄泻，舌苔白腻，脉虚缓为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃肠炎、贫血、慢性支气管炎、慢性肾炎及妇女带下病等脾虚夹湿者。

• 生 脉 散（《医学启源》）•

【组成】人参五分（9g） 麦门冬五分（9g） 五味子七粒（6g）

【功用】益气生津，敛阴止汗。

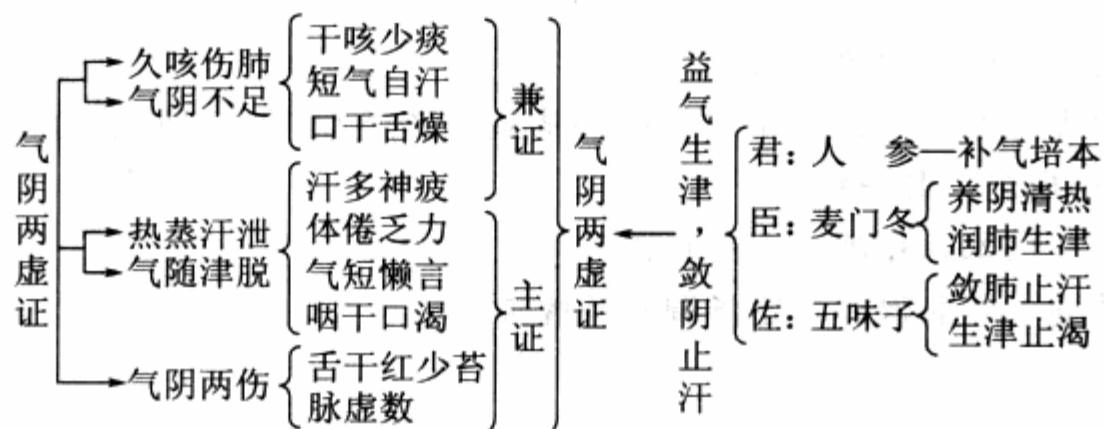
【主治】

① 温热、暑热，耗气伤阴证。汗多神疲，体倦乏力，气短懒言，咽干口渴，舌干红少苔，脉虚数。

② 久咳肺虚，气阴两虚证。干咳少痰，短气自汗，口干舌燥，脉虚细。

【方歌】生脉麦味与人参，保肺清心治暑淫，
气少汗多兼口渴，病危脉绝急煎斟。

【表解】



【配伍特点】补养、清润、收敛三法结合。

【应用要点】本方为治疗气阴两虚证的常用方剂。以体倦，气短，咽干，舌红脉虚为辨证要点。

现代临床本方常用于肺结核、慢性支气管炎、神经衰弱的咳嗽和心烦失眠，以及心脏病心律不齐属气阴两虚者。生脉散经剂型改革后制成的生脉注射液，药理研究证实，该制剂毒性小、安全度大。临床常用于治疗急性心肌梗死、心源性休克、中毒性休克、失血性休克及冠心病、内分泌等疾病属气阴两虚者。

【使用注意】

- ① 若属外邪未解，或暑病热盛，气阴未伤者，均不宜用。
- ② 久咳肺虚，亦应在阴伤气耗，纯虚无邪之时，方为适当。

• 玉屏风散 (《医方类聚》) •

【组成】防风一两 (6g) 黄芪蜜炙 白术各二两 (各 12g)

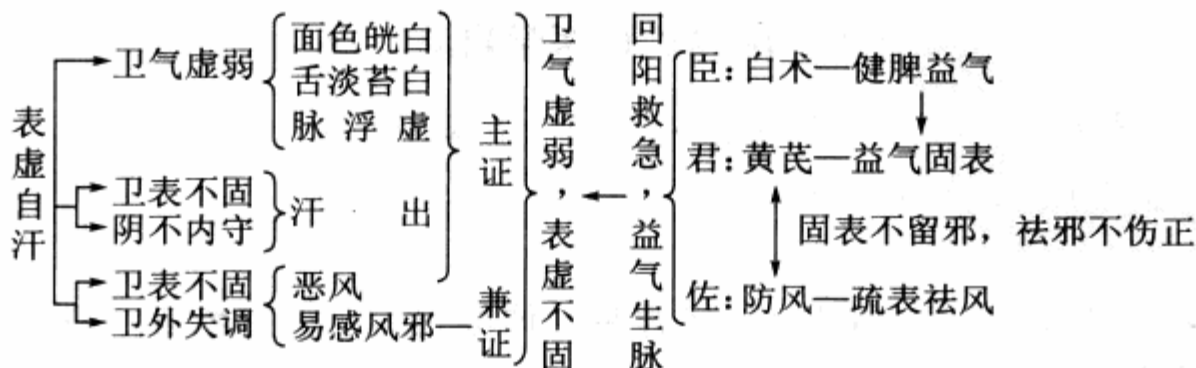
【功用】益气固表止汗。

【主治】表虚自汗。汗出恶风，面色㿔白，舌淡苔薄白，脉浮虚。亦治虚人腠理不固，易感风邪。

【方歌】芪术防风玉屏风，表虚自汗枣煎送，

卫表不固易感冒，药虽相畏效相成。

【表解】



【配伍特点】以补为固，补中有散。

【应用要点】本方为治疗表虚自汗的常用方剂。除自汗恶风外，以面色㿔白、舌淡脉虚为辨证要点。

现代临床本方常用于过敏性鼻炎、上呼吸道感染、因表阳不固而外感风邪者，以及肾小球肾炎易于伤风感冒而诱致病情反复者。

【类方比较】

玉屏风散与桂枝汤比较表

方名		玉屏风散	桂枝汤
比较	组成	黄芪、白术、防风	桂枝、白芍、生姜、大枣
	功用	祛风散邪	解肌发表，调和营卫（邪正兼顾，而以祛邪为主）
主治	同	表虚自汗	表虚自汗
	异	卫气虚弱，卫表不固（责之正气虚）	外感风寒，营卫不和（责之邪气实）

• 完带汤（《傅青主女科》） •

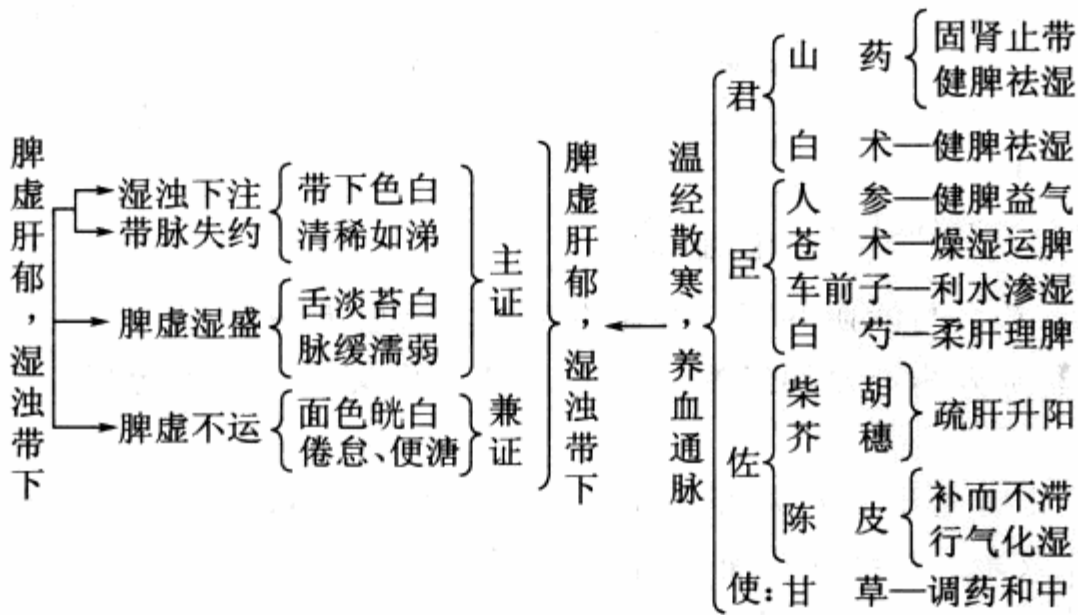
【组成】白术一两，土炒（30g） 山药一两，炒（30g） 人参二钱（6g） 白芍五钱，酒炒（15g） 车前子三钱，酒炒（9g） 苍术三钱制（9g） 甘草一钱（3g） 陈皮五分（2g） 黑芥穗五分（2g） 柴胡六分（2g）

【功用】补脾疏肝，化湿止带。

【主治】脾虚肝郁，湿浊带下。带下色白，清稀如涕，面色㿠白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓或濡弱。

【方歌】完带汤中二术参，柴胡山药芍前仁，
芥穗陈皮车前草，化湿止带是本分。

【表解】



【配伍特点】

① 寓补于散，以散助补（全方重用山药、白术，以补脾气；轻用芥穗、柴胡，以升脾阳）。

② 寓消于升，升清降浊。

消—祛湿 { 升清阳（芥穗、柴胡）
降湿浊（车前子）

③ 培土抑木，肝脾同治。

【应用要点】本方为治疗脾虚肝郁，湿浊带下的常用方。以带下清稀色白，舌淡苔白，脉濡缓为辨证要点。

现代临床本方常用于阴道炎、宫颈糜烂属肝脾不和，湿浊下注者。

第二节 补 血

补血剂适用于血虚证。症见面色萎黄，头晕目眩，唇爪色淡，心悸，失眠，舌淡，脉细，或妇女月经不调，量少色淡，或经闭不行等。常以补血药如熟地黄、当归、芍药、阿胶、龙眼肉等为主，根据病证的需要和药物的特性，适当地配伍活血祛瘀、补气或理气之品组成方剂。代表方如四物汤、当归补血汤、归脾汤。

• 四 物 汤（《仙授理伤续断方》） •

【组成】熟地黄 当归 白芍 川芎各等分

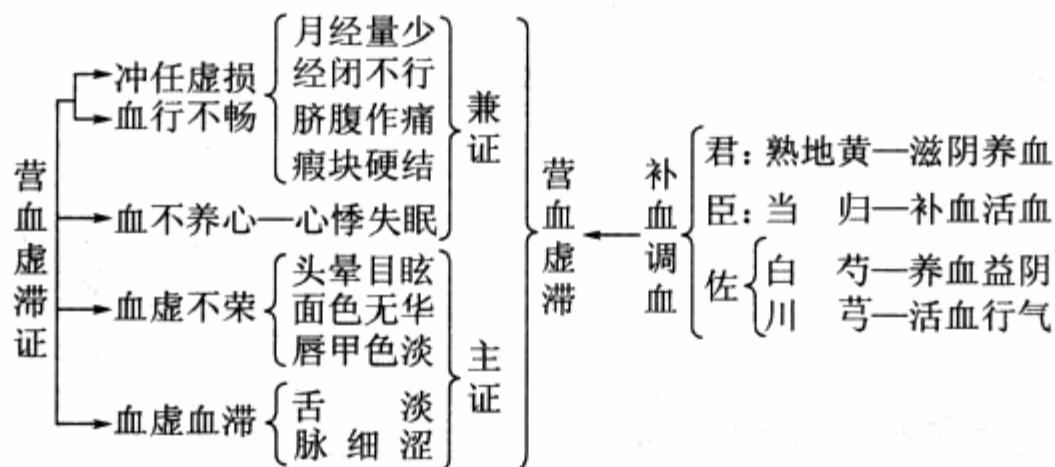
【功用】补血调血。

【主治】营血虚滞证。心悸失眠，头晕目眩，面色无华，妇人月经不调，量少或经闭不行，脐腹作痛，甚或瘕块硬结，舌淡，口唇、爪甲色淡，脉细弦或细涩。

【方歌】四物地芍与归芎，血家百病此方通，

经带胎产俱可治，加减运用在胸中。

【表解】



【配伍特点】补血与活血并用（补血不滞血，活血不伤血）。

【应用要点】本方为补血调经的基础方。以心悸头晕，面色无华，舌淡，脉细为辨证要点。

现代临床本方常用于妇女月经不调、胎产疾病、荨麻疹等慢性皮肤病、骨伤科疾病，以及过敏性紫癜、神经性头痛等属营血虚滞者。

【使用注意】阴虚发热，以及血崩气脱之证，非其所宜。

• 当 归 补 血 汤（《内外伤辨惑论》） •

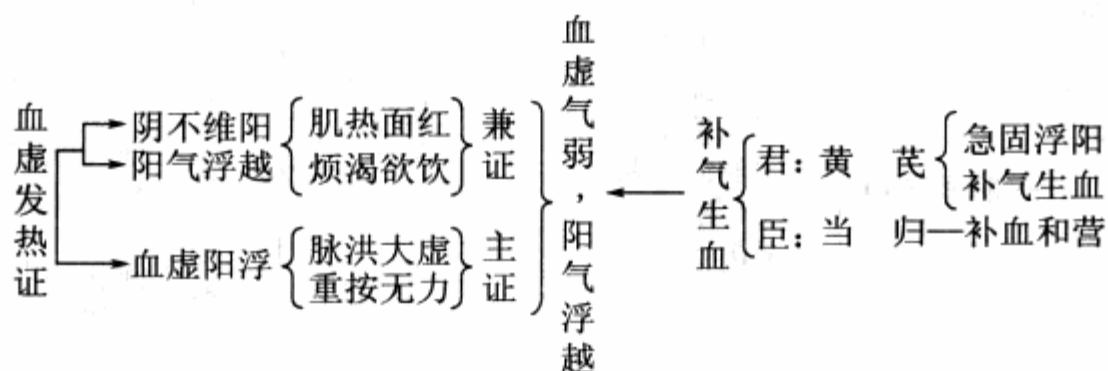
【组成】黄芪一两（30g） 当归酒洗，二钱（6g）

【功用】补气生血。

【主治】血虚阳浮发热证。肌热面红，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力。亦治妇人经期、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后，久不愈合者。

【方歌】当归补血有奇功，芪多归少力最雄，
血虚生热类白虎，劳损失血辨证用。

【表解】



【配伍特点】

① 气血双补，重用补气，以补气生血。

② 以补为固，甘温除热。

【难点提示】

(1) 黄芪与当归的比例 黄芪与当归的比例为 5 : 1。本方重用黄芪，以补气生血、固护阳气，分别体现了“有形之血生于无形之气”及“有形之血不能速生，无形之气所当急固”之理。

(2) 甘温除热 该方以重用甘温之黄芪和甘温之当归治疗血虚阳浮所引起的发热，体现了甘温除热之法。

【应用要点】本方为补气生血的基础方。以脉大而虚，重按无力为辨证要点。

现代临床本方常用于妇人经期、产后血虚发热及贫血、过敏性紫癜等属血虚气弱者。

【使用注意】阴虚发热证忌用。

• 归脾汤 (《正体内要》) •

【组成】白术 (9g) 茯神去木 (9g) 黄芪去芦 龙眼肉 酸枣仁炒，去壳，各一两 (各 12g) 人参 木香不见火，各半两 (各 6g) 甘草炙，二钱半 (3g) 当归 9g 远志各一钱 (6g)

【功用】益气补血，健脾养心。

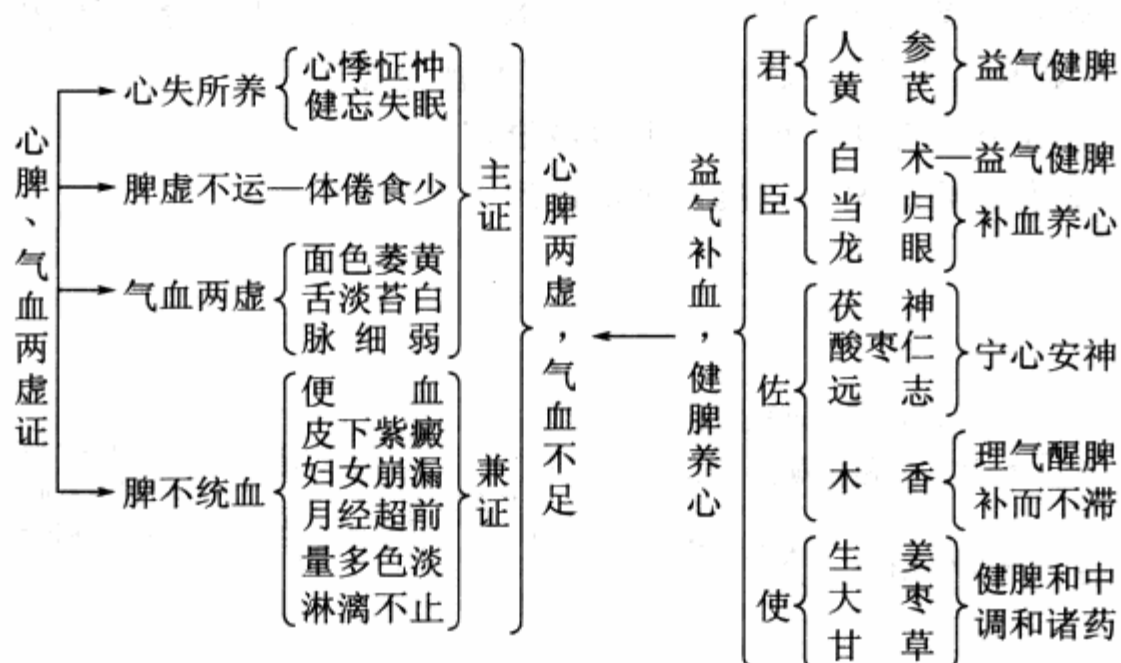
【主治】

① 心脾气血两虚证。心悸怔忡，健忘失眠，盗汗，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。

② 脾不统血证。便血，皮下紫癜，妇女崩漏，月经超前，量多色淡，或淋漓不止，舌淡，脉细者。

【方歌】归脾汤用芪术参，木香龙眼归枣仁，
远志茯神草姜枣，心脾两补气血生。

【表解】



【配伍特点】

- ① 心脾同治，重在治脾。
- ② 气血并补，重在补气。
- ③ 动静结合，补而不滞。

【难点提示】

1. 既然为补血方剂为何不用芍药、生地黄滋阴养血之品，仅用当归、龙眼肉，且当归才是明代薛己所补？

气属阳，主煦之，气虚则不能温煦。故气有余便为火，气不足便为寒。故宜用当归、龙眼肉甘温补血之品。

2. 方中为何选用理气的木香？

本病病因为忧思伤脾，思则气结，故加木香，一则舒畅/鼓舞脾气（醒脾），气结得解；二则针对方中补益药物滋腻碍胃，阻滞气机之弊，故张璐《张氏医通》：“妙以木香调畅诸气。世以木香性燥不用，服之多致痞闷或泄泻减食者，以其纯阴无阳，不能输化药力故耳。”

【应用要点】本方为调补心脾的常用方剂，也是治疗心脾两虚证的常用方。以心悸失眠，体倦食少，便血及崩漏，舌淡，脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于胃及十二指肠溃疡出血、功能性子宫出血、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、神经衰弱、心脏病等属心脾气血两虚而不统血者。

第三节 气血双补

气血双补剂适用于气血两虚的病证。症见面色无华，头晕目眩，心悸怔忡，食少倦怠，气短懒言，舌淡，脉虚无力等。常用补气药如人参、黄芪、白术等与补血药如当归、熟地黄、白芍、阿胶等共同组成方剂。代表方剂如八珍汤、炙甘草汤。

• 炙甘草汤（《伤寒论》）•

【组成】甘草炙，四两（12g） 生姜切，三两（9g） 桂枝去皮，三两（9g） 人参二两

(6g) 生地黄一斤 (50g) 阿胶二两 (6g) 麦门冬去心, 半升 (10g) 麻仁半升 (10g) 大枣擘, 三十枚 (10枚)

【功用】益气滋阴, 温阳复脉。

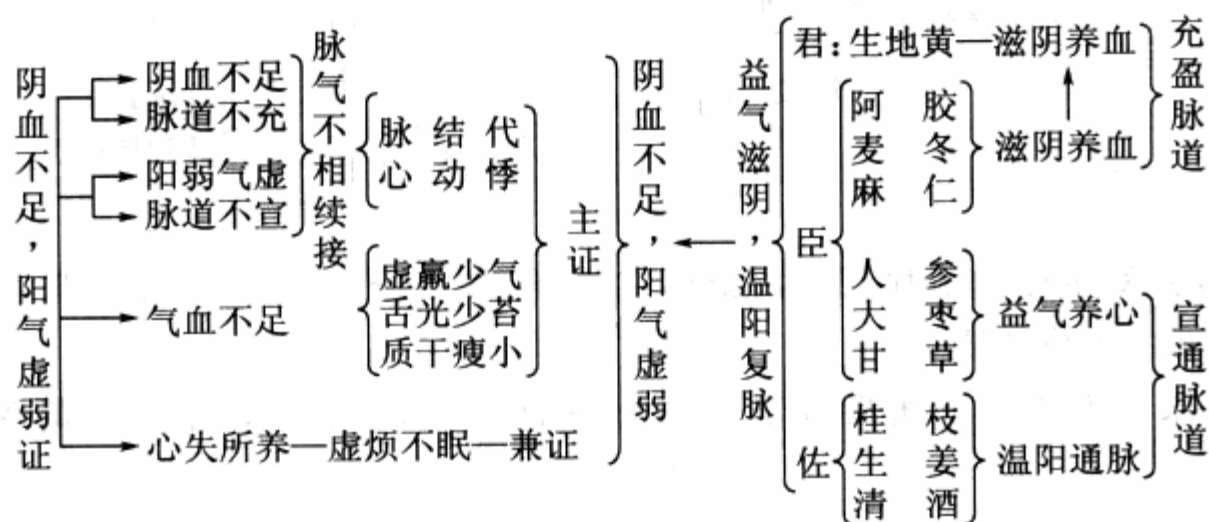
【主治】

① 阴血不足, 阳气虚弱证。脉结代, 心动悸, 虚羸少气, 舌光少苔, 或质干而瘦少者。

② 虚劳肺痿。干咳无痰, 或咳吐涎沫, 形瘦短气, 虚烦不眠, 自汗盗汗, 咽干舌燥, 大便干结, 脉虚数。

【方歌】炙甘草汤参桂姜, 地麦麻仁枣胶烊,
擅治心悸脉结代, 虚劳肺痿效亦彰。

【表解】



【配伍特点】

① 气血阴阳并补。

② 动静结合, 补而不滞, 辛散不燥。

【应用要点】本方为治疗虚证 (阴血不足, 阳气虚弱) 之脉结代、心动悸的常用有效方剂, 也是阴阳气血并补的常用方。以脉结代, 心动悸, 虚羸少气, 舌光少苔脉弱为辨证要点。

现代临床本方常用于功能性心律不齐、期外收缩、冠心病、风湿性心脏病、病毒性心肌炎、甲状腺功能亢进等属阴血不足, 心气虚弱者。并可用于气阴两伤之虚劳干咳等。

【使用注意】

① 采用酒水合煎法, 文火久煎。

② 实证明显或实多虚少者不宜使用。

• 八珍汤 (《瑞竹堂经验方》) •

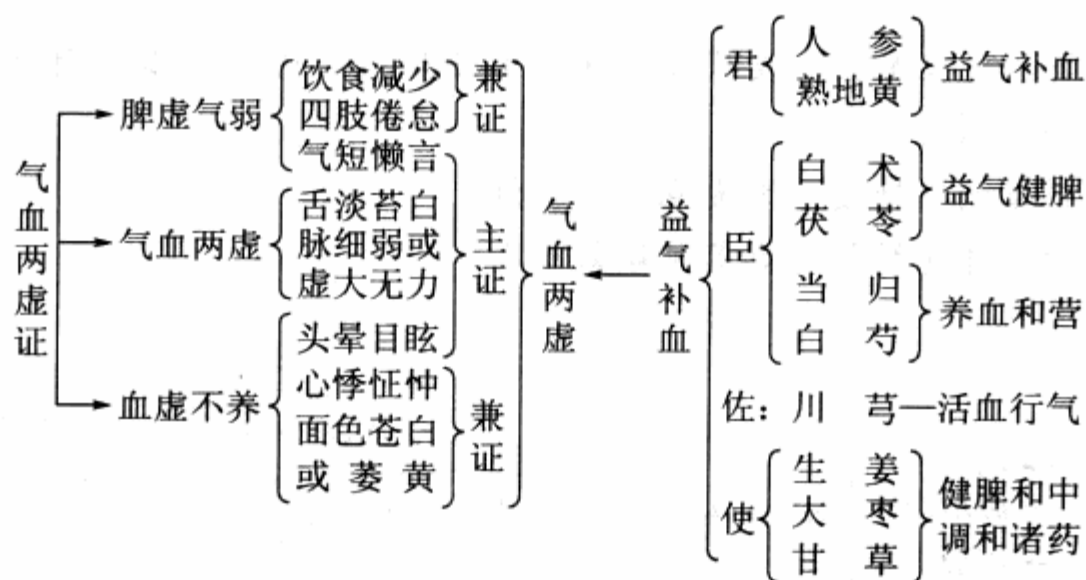
【组成】人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地黄 甘草炙, 各一两 (30g)

【功用】益气补血。

【主治】 气血两虚证。面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

【方歌】 双补气血八珍汤，四君四物合成方，
煎加姜枣调营卫，气血亏虚服之康。

【表解】



【应用要点】 本方为治疗气血两虚的常用方。以气短乏力，心悸失眠，头目眩晕，舌淡，脉细无力为辨证要点。

现代临床本方常用于病后虚弱、各种慢性病，以及妇女月经不调等属气血不足者。

第四节 补 阴

补阴剂适用于阴虚证。症见形体消瘦，头晕耳鸣，潮热颧红，五心烦热，盗汗失眠，腰酸遗精，咳嗽咯血，口燥咽干，舌红少苔，脉细数。常以补阴药如熟地黄、麦冬、沙参、阿胶、龟板等为主组方。由于阴虚易从热化，故应适量配伍清热之品。代表方剂如六味地黄丸、大补阴丸、百合固金汤、一贯煎。

• 六味地黄丸 (《小儿药证真诀》) •

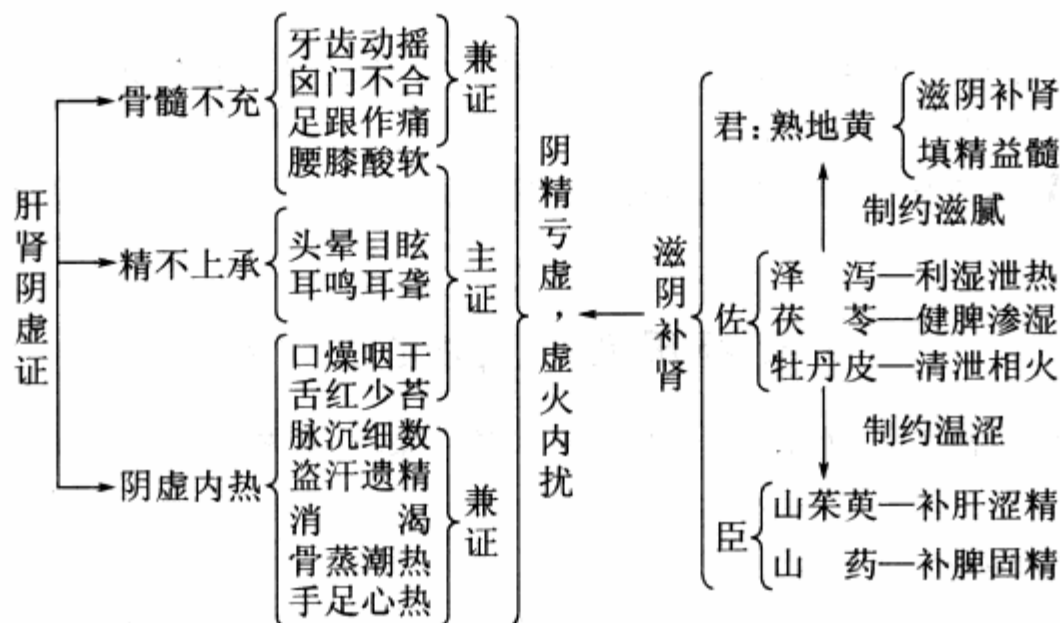
【组成】 熟地黄八钱 (24g) 山萸肉 干山药各四钱 (各 12g) 泽泻 牡丹皮 茯苓去皮，各三钱 (各 9g)

【功用】 滋阴补肾。

【主治】 肝肾阴虚证。腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，舌燥咽痛，牙齿动摇，足跟作痛，小便淋沥，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。

【方歌】 六味地黄补肝肾，山药萸丹泻茯苓，
更加知柏降虚火，擅治劳热与遗精。

【表解】



【配伍特点】① 肝脾肾同补，重在补肾。② 三补三泻，以补为主，以泻助补。

【应用要点】本方是治疗肝肾阴虚证的基础方。以腰膝酸软，头晕目眩，口燥咽干，舌红少苔，脉沉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肾炎、高血压病、糖尿病、肺结核、甲状腺功能亢进、中心性视网膜炎及无排卵性功能性子官出血、更年期综合征等属肾阴虚弱为主者。

【使用注意】脾虚泄泻者慎用。

• 左归丸 (《景岳全书》) •

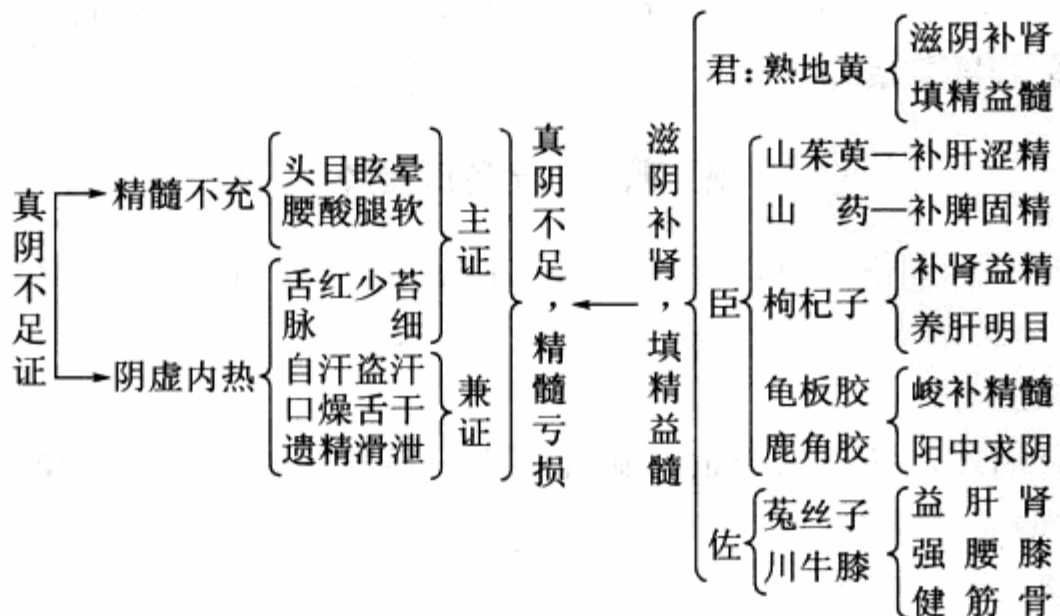
【组成】枸杞子 山茱萸肉 山药炒 菟丝子制 鹿角胶敲碎，炒珠 龟板胶各四钱 (各 12g) 大熟地八两 (24g) 川牛膝酒洗蒸熟，三两 (9g)

【功用】滋阴补肾，填精益髓。

【主治】真阴不足证。头目眩晕，腰酸腿软，遗精滑泄，自汗盗汗，口燥舌干，舌红少苔，脉细。

【方歌】左归丸内山药地，萸肉枸杞与牛膝，
菟丝龟鹿二胶合，壮水之主方第一。

【表解】



【配伍特点】① 纯补无泻。② 阳中求阴。

【应用要点】本方是治疗真阴不足证的常用方。以头目眩晕，腰酸腿软，舌光少苔，脉细为辨证要点。

现代临床本方常用于老年性痴呆、更年期综合征、老年骨质疏松等属真阴不足，精髓亏损者。

【使用注意】本方中组成药物以阴柔滋润为主，久服常服，每易滞脾碍胃，若脾虚泄泻者慎用。

• 大补阴丸（《丹溪心法》）•

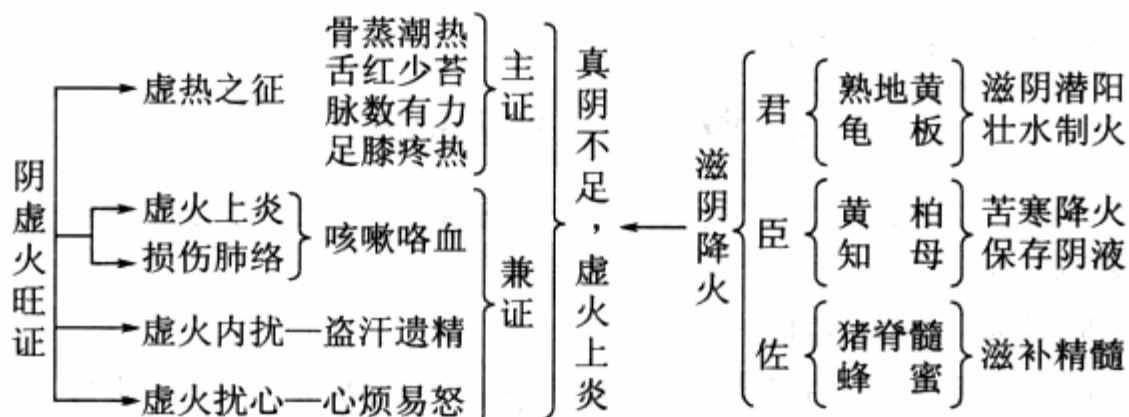
【组成】熟地黄酒蒸 龟板酥炙，各六两（各 18g） 黄柏炒褐色 知母酒浸，炒，各四两（各 12g）

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺证。骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力。

【方歌】大补阴丸知柏黄，龟板脊髓蜜成方，
咳嗽咯血骨蒸热，阴虚火旺制亢阳。

【表解】



【配伍特点】滋阴培本为主，降火清源为辅。

【应用要点】本方为滋阴降火的常用方。以骨蒸潮热，舌红少苔，尺脉数而有力为辨证要点。

现代临床本方常用于甲状腺功能亢进、肾结核、骨结核、糖尿病等属阴虚火旺者。

【使用注意】若脾胃虚弱，食少便溏，以及火热属于实证者不宜使用。

• 一贯煎（《续医类案》）•

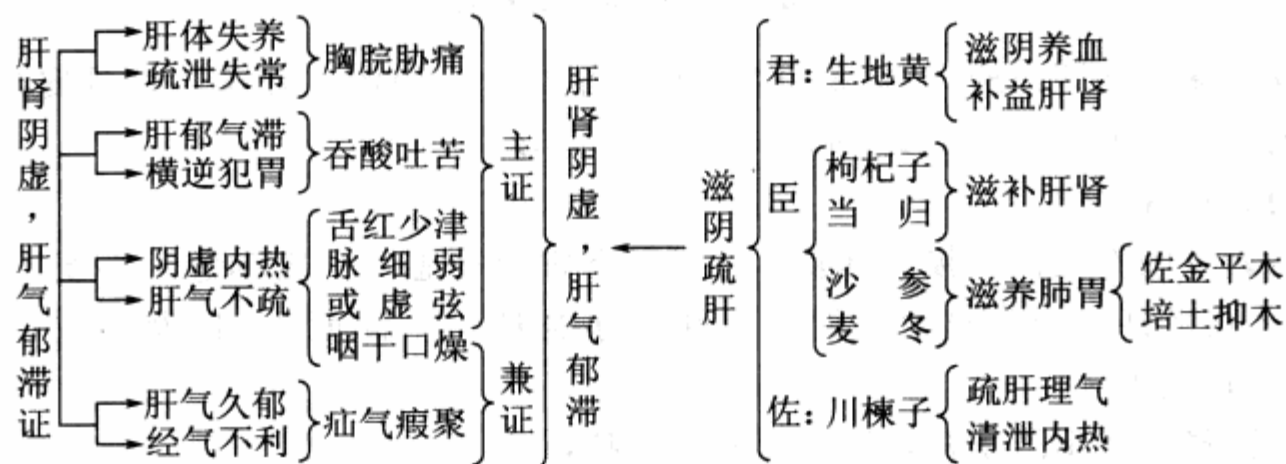
【组成】北沙参 麦冬 当归身各三钱（各 9g） 生地黄六钱至一两五钱（18~30g） 枸杞子三钱至六钱（9~18g） 川楝子一钱半（4.5g）

【功用】滋阴疏肝。

【主治】肝肾阴虚，肝气郁滞证。胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉细弱或虚弦。亦治疝气瘕聚。

【方歌】养阴疏肝一贯煎，地杞沙麦归川楝，
阴虚血燥肝横逆，胸脘胁痛苦吞酸。

【表解】



【配伍特点】

- ① 滋水涵木、佐金平木、培土抑木三法并用。
- ② 补肝与疏肝结合，以补为主，补而不滞。

【难点提示】川楝子为苦寒之品，但与大量甘寒滋阴养血药配伍，则无苦燥伤阴之弊。滋阴养血而不遏滞气机，疏肝理气又不耗伤阴血，照顾到了“肝体阴而用阳”的生理特点。

【应用要点】本方为滋阴疏肝的代表方剂。以胁肋疼痛，吞酸吐苦，舌红少津，脉虚弦为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肝炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肋间神经痛、神经官能症等属阴虚气滞者。

【使用注意】由于本方中滋腻之药较多，故有停痰积饮而舌苔白腻、脉沉弦者，不宜使用。

【类方比较】

逍遥散与一贯煎比较表

方名		逍 遥 散	一 贯 煎
比较	同	当归	
	异	甘草、茯苓、芍药、白术、柴胡	北沙参、麦冬、生地黄、枸杞子、川楝子
功用	同	疏肝理气	
	异	健脾养血	滋养肝肾
主治	同	肝郁气滞之胁痛	
	异	肝郁血虚之胁痛，伴神疲、食少等脾虚症状	肝肾阴虚之胁痛，伴见吞酸吐苦等肝气犯胃症状

第五节 补 阳

补阳剂适用于阳虚证。症见面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸痛，下肢软弱无力，小便不利，或小便频数，尿后余沥，少腹拘急，男子阳痿早泄，女子宫寒不孕，舌淡苔白，脉沉细，尺部尤甚等。常以补阳药如附子、肉桂、巴戟天、肉苁蓉、仙灵脾、鹿角胶、仙茅等为主，配伍利水、补阴之品组成方剂。代表方剂如肾气丸、右归丸。

• 肾 气 丸 (《金匱要略》) •

【组成】薯蓣（即山药） 山茱萸各四两（各 12g） 泽泻 茯苓 牡丹皮各三两（各 9g） 干地黄八两（24g） 桂枝 附子各一两（各 3g）

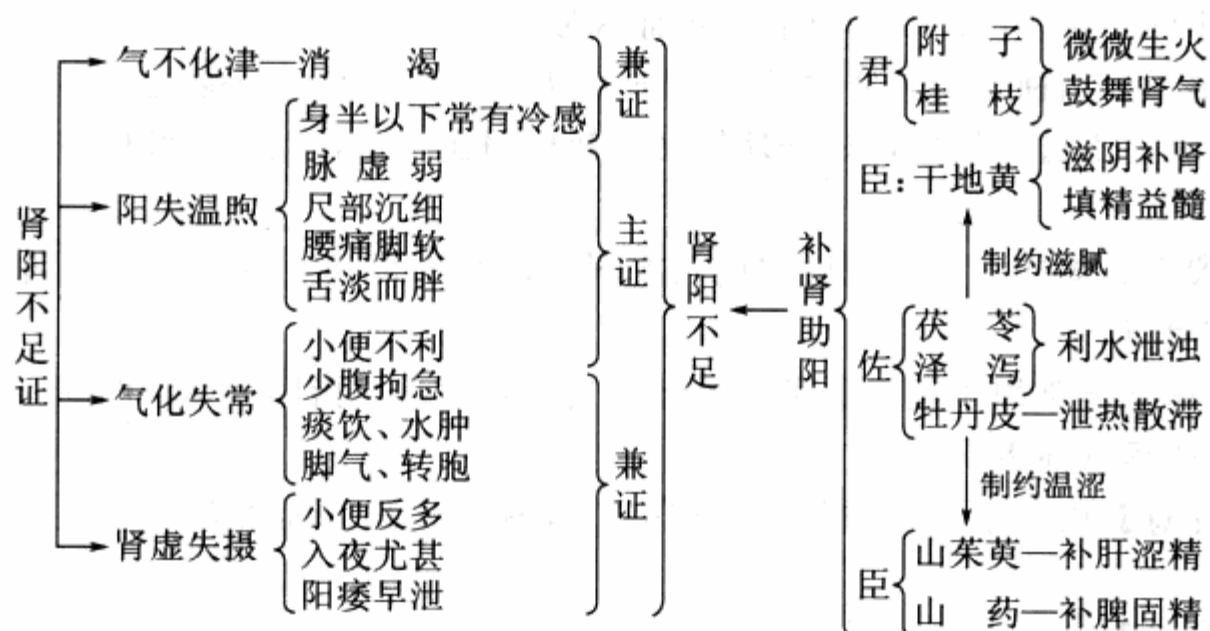
【功用】补肾助阳。

【主治】肾阳不足证。腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，或小便反多，入夜尤甚，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细。以及痰饮，水肿，消渴，脚气，转胞等。

【方歌】肾气丸用附子桂，温补肾阳合六味，

阴中求阳气自旺，虚寒诸证悉可退。

【表解】



【配伍特点】

- ① 补阳之中配伍滋阴之品，阴中求阳，阳有所化。
- ② 少量补阳药与大量滋阴药配伍，微微生火，少火生气。

【应用要点】本方是补肾助阳的常用方剂。以腰痛脚软，小便不利或反多，舌淡而胖，脉虚弱而尺部沉细为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肾炎、糖尿病、醛固酮增多症、甲状腺功能低下、性神经衰弱、肾上腺皮质功能减退、慢性支气管哮喘、更年期综合征等属肾阳不足者。

【使用注意】

- ① 若咽干口渴，舌红少苔，属肾阴不足，虚火上炎者，不宜应用。
- ② 方中干地黄，现多用熟地黄；桂枝，改用肉桂，如此则效果更好。

• 右 归 丸 (《景岳全书》) •

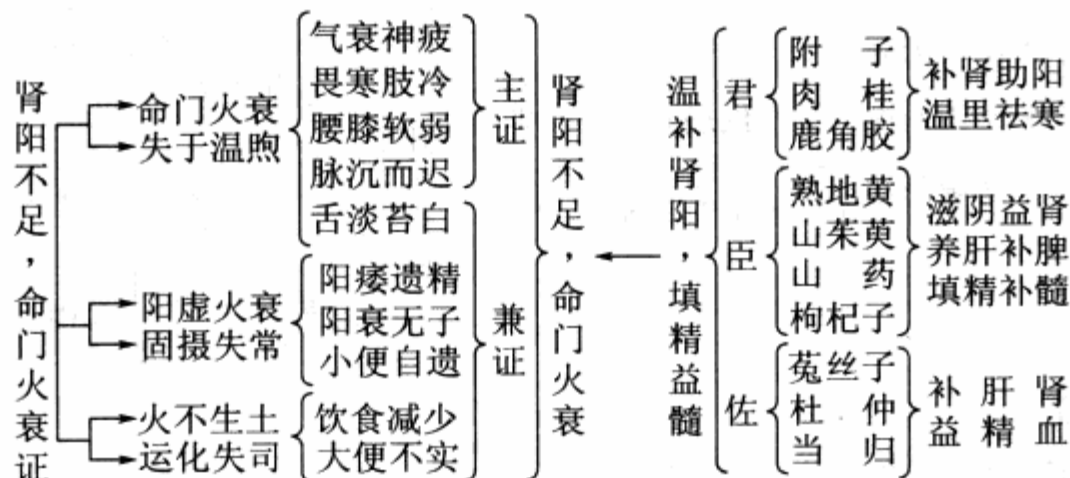
【组成】熟地黄八两（24g） 山药炒，四两（12g） 山茱萸微炒，三两（9g） 枸杞子微炒，三两（9g） 菟丝子制，四两（12g） 鹿角胶炒珠，四两（12g） 杜仲姜汁炒，四两（12g） 肉桂二两（6g） 当归三两（9g） 制附子二两（6g）

【功用】温补肾阳，填精益髓。

【主治】肾阳不足，命门火衰证。年老或久病气衰神疲，畏寒肢冷，腰膝软弱，阳痿遗精，或阳衰无子，或饮食减少，大便不实，或小便自遗，舌淡苔白，脉沉而迟。

【方歌】右归补阳附桂仲，地杞山萸药草同，
右归丸加归菟鹿，去草培元精血充。

【表解】



【配伍特点】

- ① 纯补无泻。
- ② 阴中求阳。

【应用要点】本方为治肾阳不足，命门火衰的常用方。以神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝酸软，脉沉迟为辨证要点。

现代临床本方常用于肾病综合征、老年骨质疏松症、精少不育症，以及贫血、白细胞减少症等属肾阳不足者。

【使用注意】由于本方纯补无泻，故对肾虚而有湿浊者，不宜应用。

第六节 阴阳并补

阴阳并补剂适用于阴阳两虚证。症见头晕目眩，腰膝酸软，阳痿遗精，畏寒肢冷，自汗盗汗，午后潮热等。常用补阴药如熟地黄、山茱萸、龟板、何首乌、枸杞子和补阳药如肉苁蓉、巴戟天、附子、肉桂、鹿角胶等共同组成方剂，并根据阴阳虚损的情况，分别主次轻重。代表方如地黄饮子、龟鹿二仙胶等。

• 地黄饮子（《圣济总录》）•

【组成】熟地黄（12g） 巴戟天去心 山茱萸 石斛 肉苁蓉浸酒，焙 附子炮 五味子 官桂 白茯苓 麦门冬去心 石菖蒲 远志去心，各半两（各 15g）

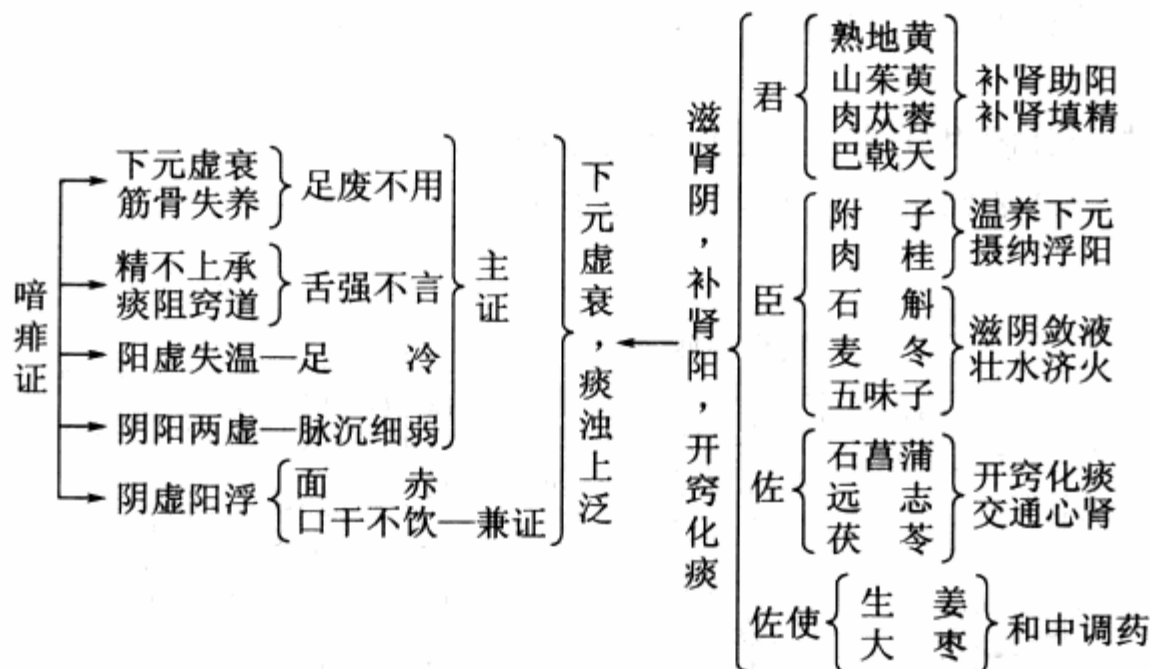
《黄帝素问宣明论方》加少许薄荷，意在清轻上行，清利咽喉窍道。

【功用】滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。

【主治】下元虚衰，痰浊上泛之暗痱证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

【方歌】地黄饮子山茱斛，麦味菖蒲远志茯，
苁蓉桂附巴戟天，少入薄荷姜枣服。

【表解】



【配伍特点】

- ① 上下并治，以治下（下元虚衰）为主。
- ② 标本兼顾，以治本（补肾）为主。
- ③ 阴阳并补，滋而不膩，温而不燥，平补阴阳。

【应用要点】本方是治疗肾虚暗瘕的常用方。以舌暗不语，足废不用，足冷面赤，脉沉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于肾病综合征、老年骨质疏松症、精少不育症，以及贫血、白细胞减少症等属肾阳不足者。

【使用注意】本方阴阳并补，温而不燥，是其特长；然毕竟偏于温补，故对气火上升，肝阳偏亢之证，不宜应用。

• 龟鹿二仙胶（《医便》）•

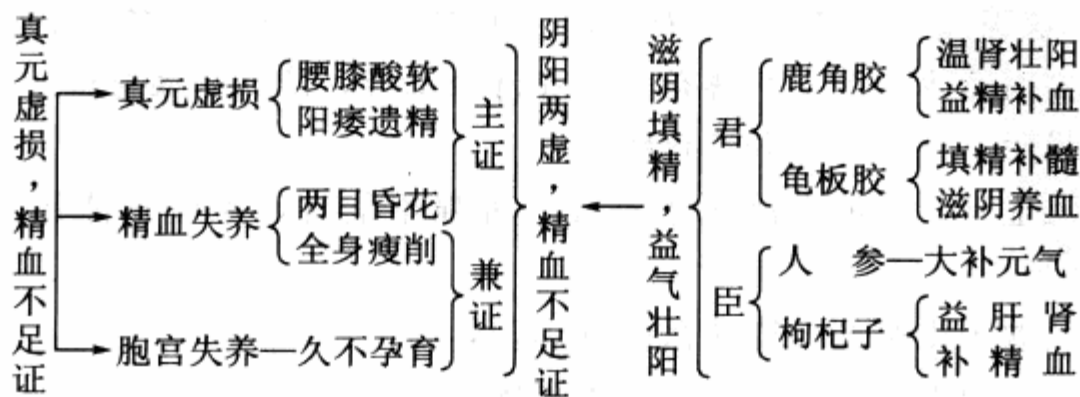
【组成】鹿角用新鲜麋鹿杀，角解的不用，马鹿角不用，去角脑梢角二寸绝断，劈开，净用十斤 龟板去弦，洗净，五斤，捶碎 人参十五两 枸杞子三十两

【功用】滋阴填精，益气壮阳。

【主治】真元虚损，精血不足证。全身瘦削，阳痿遗精，两目昏花，腰膝酸软，久不孕育。

【方歌】龟鹿二仙最守真，补人三宝精气神，
人参枸杞和龟鹿，益寿延年实可珍。

【表解】



【配伍特点】 阴阳并补，气血兼顾。

【应用要点】 本方为滋养阴阳气血之剂，既补肝肾之亏损，又益脾肝之不足。以腰膝酸软，两目昏花，阳痿遗精为辨证要点。

现代临床本方常用于内分泌障碍引起的发育不良、重症贫血、神经衰弱，以及性功能减退等属阴阳两虚者。

【使用注意】 若脾胃虚弱而食少便溏者不宜应用。



第八章 固涩剂

一、定义

凡以固涩药物为主组成，具有收敛固涩作用，用以治疗气、血、精、津液耗散滑脱之证的方剂，统称为固涩剂。属于“十剂”中的涩剂。

二、立法依据

本类方剂是以《素问·至真要大论》“散者收之”，以及“十剂”中“涩可固脱”等原则为立法依据的。这也是治疗滑脱不禁的基本原则。

三、适应范围

耗散滑脱证	{	气—肺气耗散、久咳不止—敛肺止咳
		血—崩漏带下—固崩止带
		津—{ 自汗、盗汗—固表止汗
		久泻、久痢—涩肠固脱
		尿频遗尿—涩精止遗
精—遗精滑泻		

四、分类与配伍规律

固涩剂	{	固表止汗剂—自汗、盗汗证—常以收涩止汗药为主，配伍益气固表药
		敛肺止咳剂—久咳肺虚，气阴耗伤证—常以敛肺止咳药为主，配伍益气养阴药
		涩肠固脱剂—久泻、久痢证—常以涩肠止泻药为主，配伍温补脾肾药
		涩精止遗剂—遗精滑泻、尿频遗尿证—常以补肾涩精药为主，配伍固涩止遗药
		固崩止带剂—崩漏带下证—常以固崩止带药为主，配伍益气健脾药

五、使用注意

(1) 标本兼顾 固涩剂是为正气内虚，耗散滑脱之证而设。在运用时，还应根据患者气、血、津、精耗伤程度的不同，配伍相应的补益药，使之标本兼顾。

(2) 回阳固脱 若是元气大虚，亡阳欲脱所致的大汗淋漓、小便失禁或崩中不止，又非急用大剂参附之类回阳固脱不可，非单纯固涩剂所能治疗。

(3) 实证禁用 固涩剂为正虚无邪者设，故凡外邪未去，误用固涩，则有“闭门留寇”之弊，转生他变。此外，对于由实邪所致的热病多汗、火扰遗泄、热痢初起、食滞泄泻，均非本类方剂之所宜。

第一节 固表止汗

固表止汗剂适用于体虚卫外不固，阴液不能内守而致的自汗、盗汗。常用黄芪、牡蛎、麻黄根等固表止汗药物为主组成方剂。并可根据具体病情，分别选配相应的药物。如属体虚卫阳不固的自汗，可配白术以增强益气固表之功；如属阴虚火扰之盗汗，可用滋阴清热、固表止汗法选配滋阴清热药与泻火药，如熟地黄、生地黄、黄芩、黄连、黄柏等配伍组成方剂。代表方剂如牡蛎散。

• 牡蛎散 (《太平惠民和剂局方》) •

【组成】黄芪去苗土 (30g) 麻黄根洗 (9g) 牡蛎米泔浸, 刷去土, 火烧通赤, 各一两 (30g)

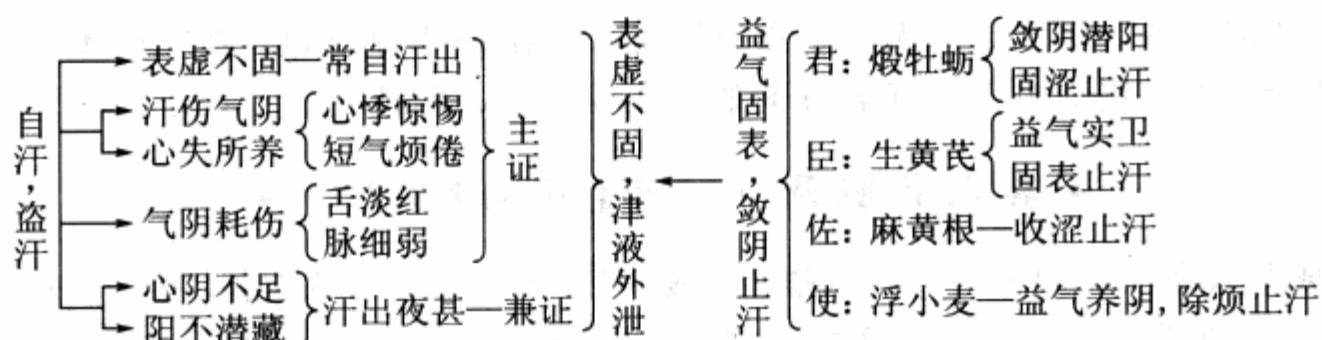
【功用】益气固表, 敛阴止汗。

【主治】自汗, 盗汗。常自汗出, 夜卧更甚, 心悸惊惕, 短气烦倦, 舌淡红, 脉细弱。

【方歌】牡蛎散内用黄芪, 小麦麻根合用宜,

卫虚自汗或盗汗, 固表收敛见效奇。

【表解】



【应用要点】本方为治疗卫气不固, 阴液外泄的自汗、盗汗证的常用方。以汗出, 心悸, 短气, 舌淡, 脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于病后、术后及产后自汗、盗汗属卫外不固, 阴液外泄者。

第二节 敛肺止咳

敛肺止咳剂适用于久咳肺虚, 气阴耗伤证。症见咳嗽, 气喘, 自汗, 脉虚数等。常用敛肺止咳药如五味子、乌梅、罂粟壳等与益气养阴药如人参、阿胶等组成方剂, 代表方如九仙散。

• 九仙散 (《太平惠民和剂局方》) •

【组成】人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅各一两 (各 10g) 贝母半两 (5g) 罂粟壳八两, 去顶, 蜜炒黄 (15g)

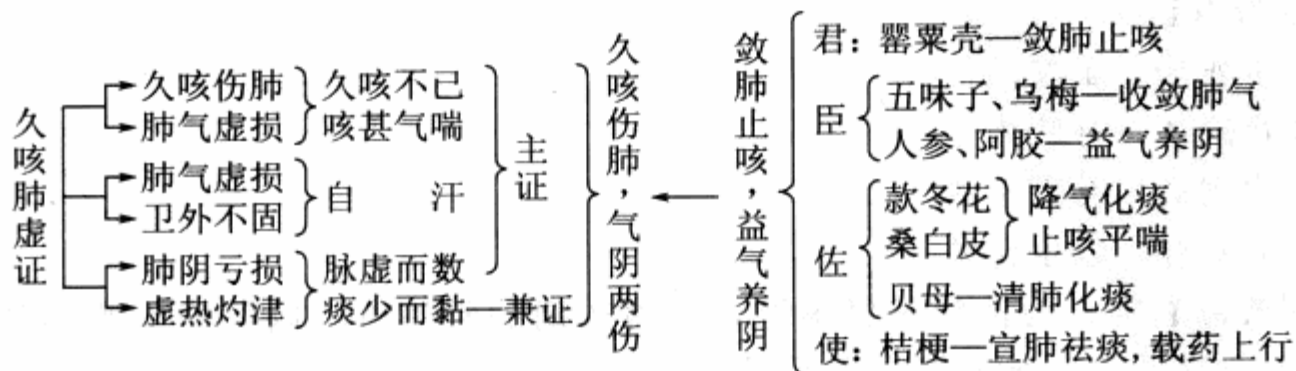
【功用】敛肺止咳, 益气养阴。

【主治】久咳肺虚证。久咳不已, 咳甚则气喘自汗, 痰少而黏, 脉虚数。

【方歌】九仙散中参乌梅, 桑皮桔梗贝五味,

款冬阿胶罂粟壳, 敛肺止咳用毋违。

【表解】



【配伍特点】敛中有散、降中寓升, 但总以降、收为主。

【应用要点】本方为治疗久咳伤肺, 气阴两虚的常用方剂。以久咳不止, 气喘自汗,

脉虚数为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性气管炎、肺气肿属久咳肺虚，气阴两亏者。

【使用注意】

- ① 久咳而内多痰涎，或咳嗽而外有表证者忌用，以免邪留不去。
- ② 方中罂粟壳不宜多服、久服，故方后注曰：“嗽住止后服。”

第三节 涩肠固脱

涩肠固脱剂适用于泻痢日久不止，脾肾虚寒，以致大便滑脱不禁的病证。常以涩肠止泻药物如肉豆蔻、诃子、罂粟壳、赤石脂等，与温补脾肾药如人参、白术、肉桂、干姜、补骨脂等配伍组成方剂。代表方剂如真人养脏汤、四神丸。

• 真人养脏汤（《太平惠民和剂局方》）•

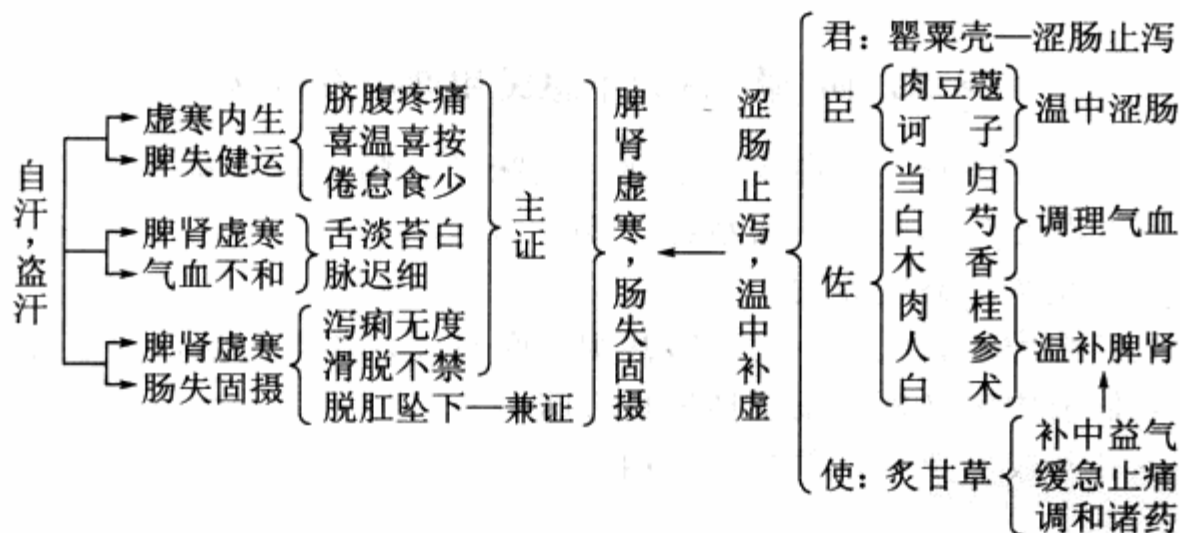
【组成】 人参 当归去芦 白术焙各六钱（各 18g） 肉豆蔻面裹，煨，半两（15g） 肉桂去粗皮 甘草炙各八钱（各 24g） 白芍药一两六钱（48g） 木香不见火，一两四钱（42g） 诃子去核，一两二钱（36g） 罂粟壳去蒂萼，蜜炙，三两六钱（108g）

【功用】 涩肠止泻，温中补虚。

【主治】 久泻久痢。泻痢无度，滑脱不禁，甚至脱肛坠下，脐腹疼痛，喜温喜按，倦怠食少，舌淡苔白，脉迟细。

【方歌】 寒痢需用养脏汤，人参白术广木香，
归芍肉桂炙甘草，粟壳诃子肉蔻良。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼治，重在治标。
- ② 脾肾同调，补脾为主。
- ③ 涩中寓通，补而不滞。
- ④ 气血双补，以生化源。

【应用要点】 本方为治疗脾肾虚寒，久泻久痢的常用方。以泻痢滑脱不禁，腹痛，食少神疲，舌淡苔白，脉迟细为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性结肠炎、糖尿病顽固性腹泻、小儿秋季腹泻、痢疾后综合征（腹泻、黏液便、腹痛、下坠等）、肠结核等久泻久痢属脾肾虚寒证者。

【使用注意】本方为治脾肾虚寒之久泻久痢而设，而湿热积滞之泻痢当禁用。

• 四神丸 (《内科摘要》) •

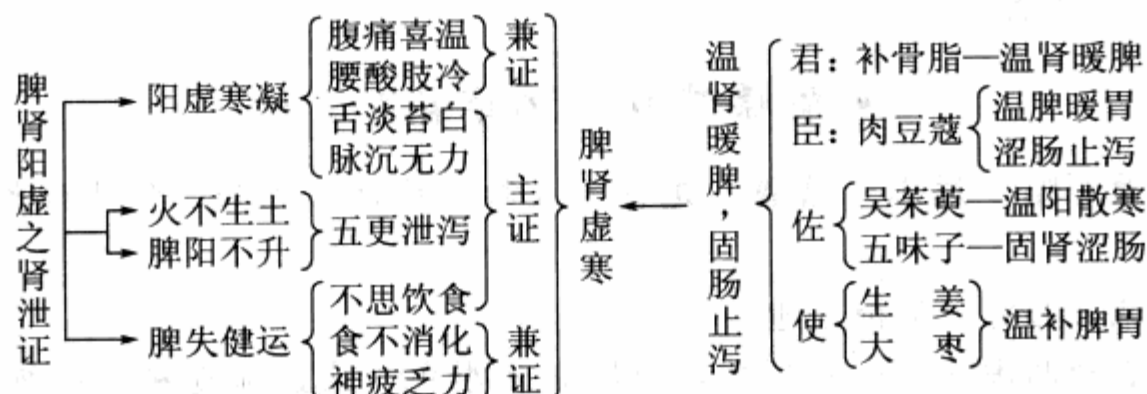
【组成】肉豆蔻二两 (60g) 补骨脂四两 (120g) 五味子二两 (60g) 吴茱萸酒炒，一两 (30g)

【功用】温肾暖脾，固肠止泻。

【主治】脾肾阳虚之肾泄证。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

【方歌】四神肉蔻破故纸，吴萸五味姜枣使，
脾肾虚寒命火衰，五更泄泻本方施。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼治，重在治本。
- ② 脾肾兼顾，温肾为主。

【应用要点】本方为治疗命门火衰，火不生土所致五更泻的常用方。凡属脾肾虚寒的泄泻均可使用。以五更泄泻，不思饮食，舌淡苔白，脉沉迟无力为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性腹泻、溃疡性结肠炎、肠道易激综合征、糖尿病并发顽固性腹泻、五更泄泻、遗尿症、滑精、过敏性鼻炎、脂肪泻、肠结核等属脾肾虚寒者。

第四节 涩精止遗

涩精止遗剂适用于肾虚封藏失职，精关不固所致的遗精滑精；或肾气不足，膀胱失约所致的尿频遗尿等。常以涩精止遗药物如沙苑蒺藜、芡实、莲须、桑螵蛸等为主组成方剂。代表方剂如金锁固精丸、桑螵蛸散。

• 金锁固精丸 (《医方集解》) •

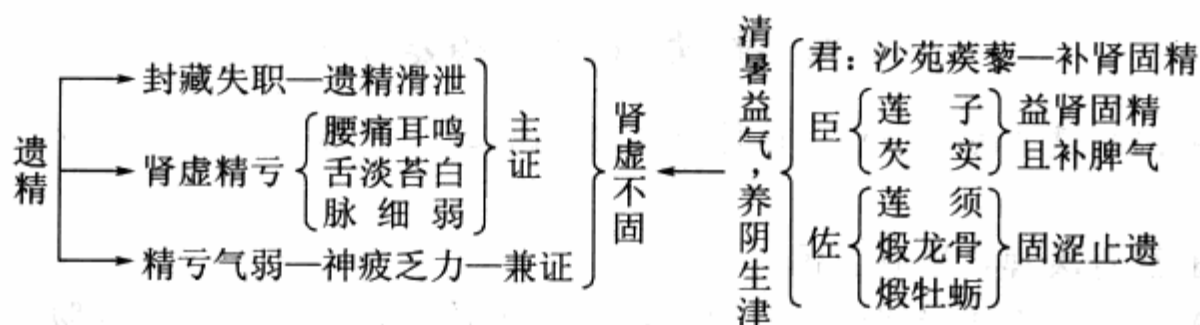
【组成】沙苑蒺藜炒 芡实蒸 莲须各二两 (12g) 龙骨酥炙 牡蛎盐水煮一日一夜，煅粉，各一两 (10g)

【功用】补肾涩精。

【主治】肾虚不固之遗精。遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱。

【方歌】金锁固精芡莲须，蒺藜龙骨与牡蛎，
莲粉糊丸盐汤下，补肾涩精止滑遗。

【表解】



【配伍特点】既能补肾，又能固精，标本兼顾，治本为主。

【应用要点】本方为治疗肾虚精关不固所致各种病证的常用方。以遗精滑泄，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于遗精、滑泄、带下、慢性泄泻、乳糜尿、遗尿、糖尿病、男性不育等属肾虚不固者。

• 桑螵蛸散 (《本草衍义》) •

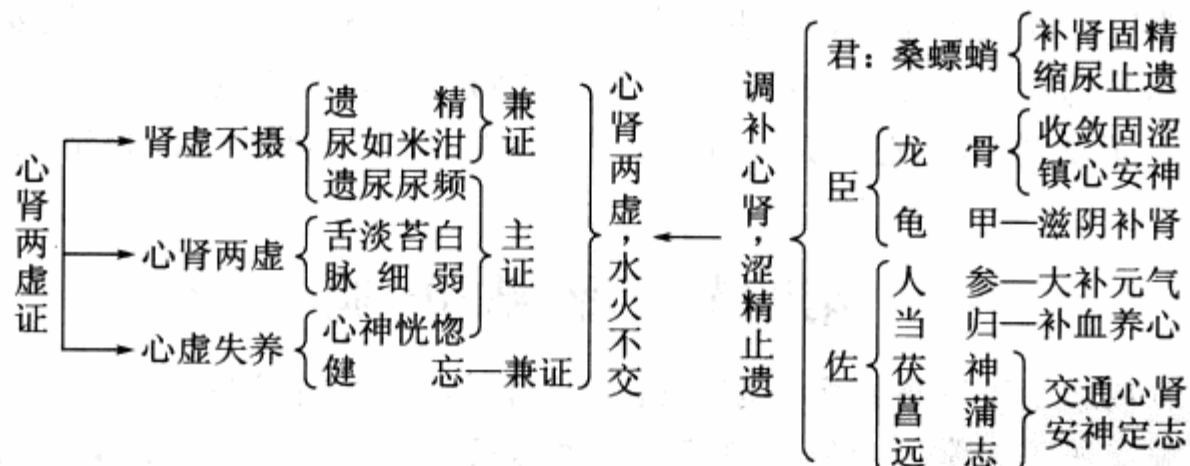
【组成】桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 人参 茯神 当归 龟甲酥炙，以上各一两 (各 30g)

【功用】调补心肾，涩精止遗。

【主治】心肾两虚证。小便频数，或尿如米泔色，或遗尿遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱。

【方歌】桑螵蛸散龙归参，龟甲远志菖茯神，
滑泄遗尿小便数，涩精固脬补心肾。

【表解】



【配伍特点】心肾同调，交通上下，气血并补。

【应用要点】本方为治疗心肾两虚，水火不交的常用方。以尿频或遗尿，遗精，心神恍惚，舌淡苔白，脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于小儿遗尿、糖尿病、神经衰弱等属心肾不交者，可以本方治之。

第五节 固崩止带

固崩止带剂适用于妇女崩中漏下，或带下日久不止等证。常以固崩止带药如椿根皮、龙骨、牡蛎、白果等为主组成方剂。若崩漏因脾气虚弱、冲任不固所致者，宜配黄

芪、白术、山茱萸等补脾益肾药；因阴虚血热，损伤冲任者，宜配龟板、黄柏等滋阴清热药；若带下因湿热下注者，宜配车前子等清热渗湿药。代表方剂如固冲汤、固经丸、易黄汤。

• 固 冲 汤（《医学衷中参西录》）•

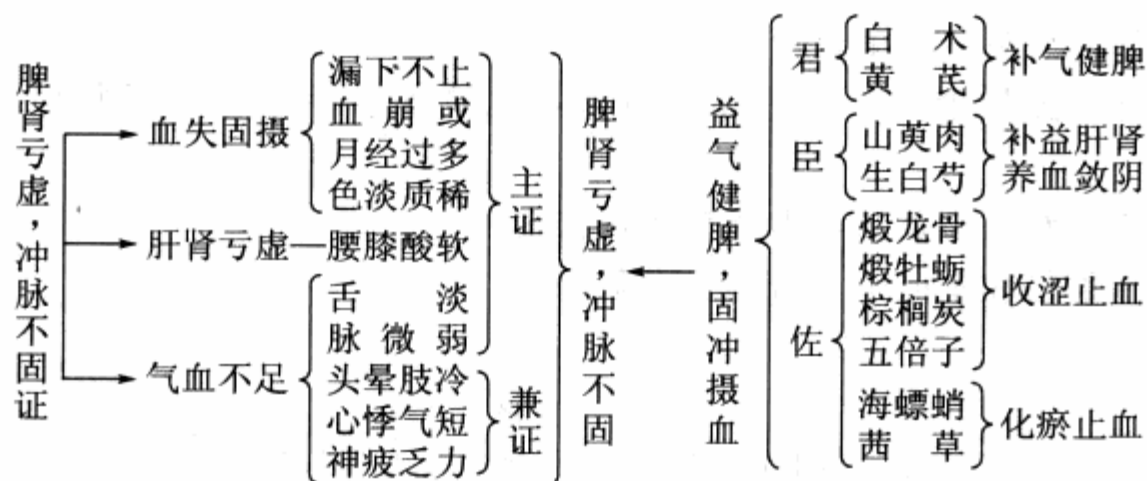
【组成】 白术一两，炒（30g） 生黄芪六钱（18g） 龙骨八钱，煅，捣细（24g） 牡蛎八钱，煅，捣细（24g） 萸肉八钱，去净核（24g） 生杭芍四钱（12g） 海螵蛸四钱，捣细（12g） 茜草三钱（9g） 棕边炭二钱（6g） 五倍子五分，轧细，药汁送服（1.5g）

【功用】 益气健脾，固冲摄血。

【主治】 脾肾亏虚，冲脉不固证。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

【方歌】 固冲汤用术芍芪，山萸茜草龙牡蛎，
螵蛸棕炭五倍子，固冲摄血在健脾。

【表解】



【配伍特点】

① 急则治其标。以收涩止血治其标为主，补气固冲治其本为辅。

② 血止而不留瘀。以益气固涩止血为主，少佐化瘀止血之品。

【应用要点】 本方为治疗脾肾亏虚，冲脉不固之月经过多的常用方。以出血量多，色淡质稀，腰膝酸软，舌淡，脉微弱为辨证要点。

现代临床本方常用于功能性子宫出血、月经过多、消化道溃疡、遗尿等属脾气虚弱、冲任不固者。

• 固 经 丸（《丹溪心法》）•

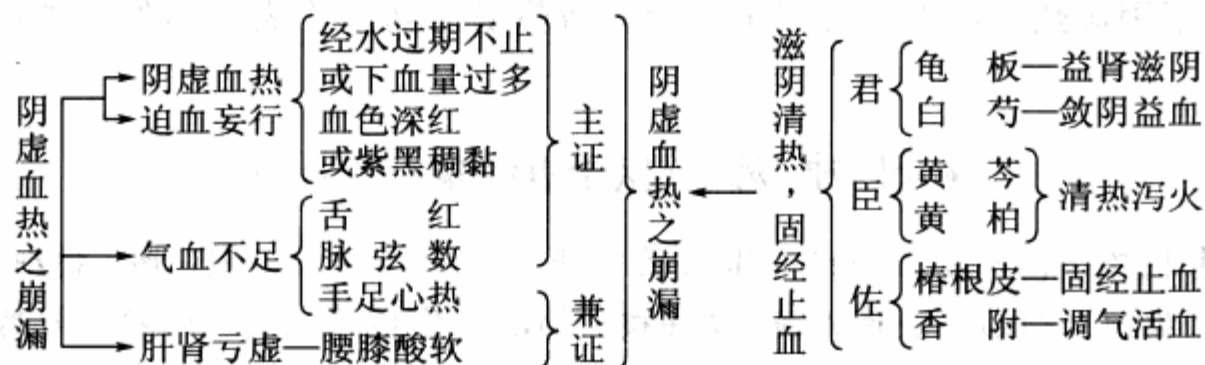
【组成】 黄柏炒，三钱（6g） 黄芩炒，一两（15g） 椿根皮七钱半（12g） 白芍炒，一两（15g） 龟板炙，一两（15g） 香附二钱半（6g）

【功用】 滋阴清热，固经止血。

【主治】 阴虚血热之崩漏。经水过期不止，或下血量过多，血色深红或紫黑稠黏，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数。

【方歌】 固经丸用龟板芩，白芍黄柏附椿根，
滋阴清热冲任固，自无漏下与血崩。

【表解】



【应用要点】本方为治疗阴虚血热之崩漏或月经过多的常用方。以血色深红甚或紫黑稠黏，舌红，脉弦数为辨证要点。

现代临床本方常用于功能性子宫出血或慢性附件炎等属阴虚血热者。

• 易 黄 汤 (《傅青主女科》) •

【组成】山药炒，一两(30g) 芡实炒，一两(30g) 黄柏盐水炒，二钱(6g) 车前子酒炒，一钱(3g) 白果十枚，碎(3g)

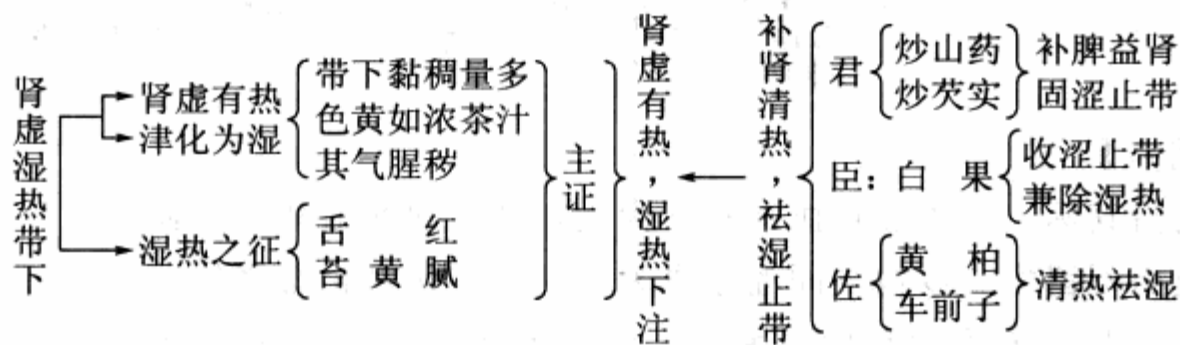
【功用】补肾清热，祛湿止带。

【主治】肾虚湿热带下。带下黏稠量多，色黄如浓茶汁，其气腥秽，舌红，苔黄腻者。

【方歌】傅青女科易黄汤，山药芡实黄柏襄。

白果仁和车前子，清热止带除湿良。

【表解】



【配伍特点】重在补涩，辅以清利。

【应用要点】本方为治疗肾虚湿热带下的常用方。以带下色黄，其气腥秽，舌苔黄腻为辨证要点。

现代临床本方常用于宫颈炎、阴道炎属肾虚湿热下注者。

第九章 安神剂

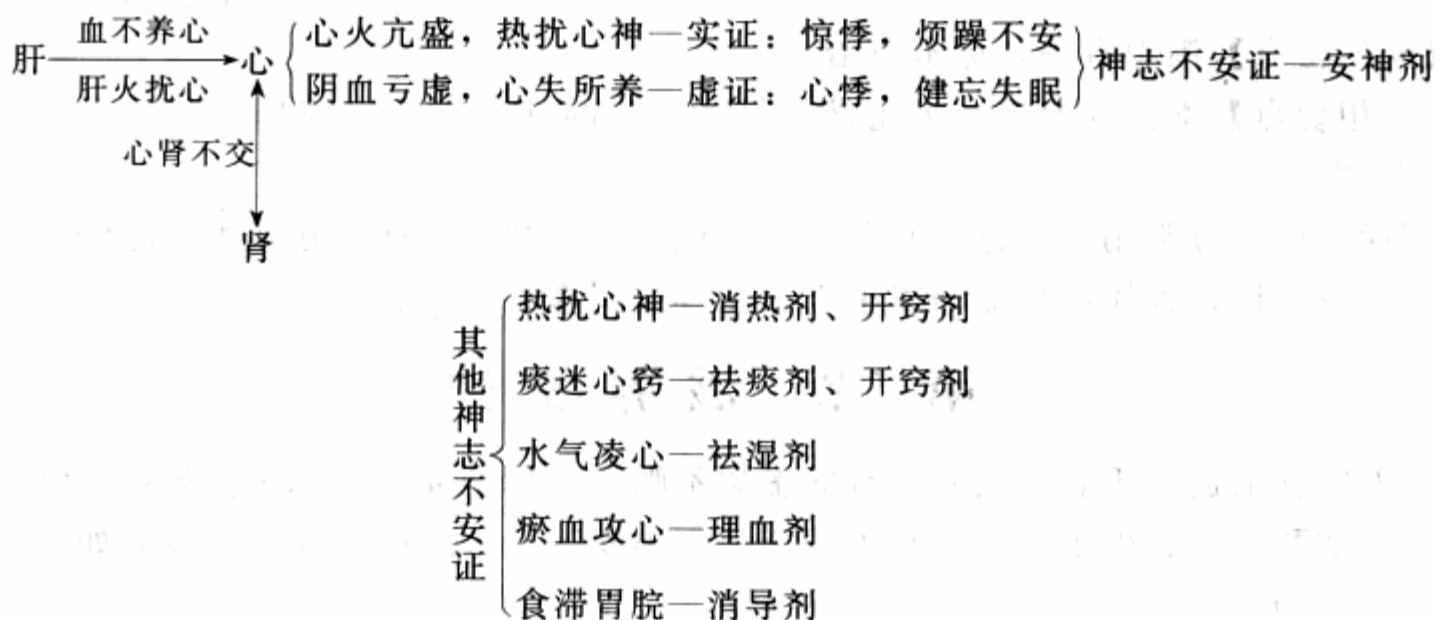
一、定义

凡以安神药为主组成，具有安神定志作用，用于治疗神志不安疾患的方剂，统称安神剂。

二、立法依据

本类方剂属于“十剂”之“重剂”与“八法”中“补法”的范畴。

三、适应范围



四、分类与配伍规律

安神剂 { 重镇安神剂—心火亢盛，热扰心神证—常以重镇安神药为主，配伍清热泻火药
滋养安神剂—阴血亏虚，心失所养证—常以滋养安神药为主，配伍滋阴养血药

五、使用注意

- ① 重镇药多属金石类，碍胃，中病即止，注意脾胃功能。
- ② 质硬打碎久煎，使药力尽出。
- ③ 某些安神药，如朱砂等具有一定毒性，久服能引起慢性中毒，亦应注意。

第一节 重镇安神

重镇安神剂适用于心肝阳亢，热扰心神所致的烦乱、失眠、惊悸、怔忡、癫痫等。常以重镇安神药如朱砂、磁石、珍珠母、龙齿等为主组方。火热扰心，故常配伍黄连等清热泻火药以撤火热；心经火热每多耗伤阴血，故常配伍生地黄、当归等滋阴养血药，补其不足之阴血。代表方剂如朱砂安神丸。

• 朱砂安神丸（《内外伤辨惑论》）•

【组成】朱砂半两（15g） 黄连六钱（18g） 炙甘草五钱半（16.5g） 生地黄一钱半（4.5g） 当归二钱半（7.5g）

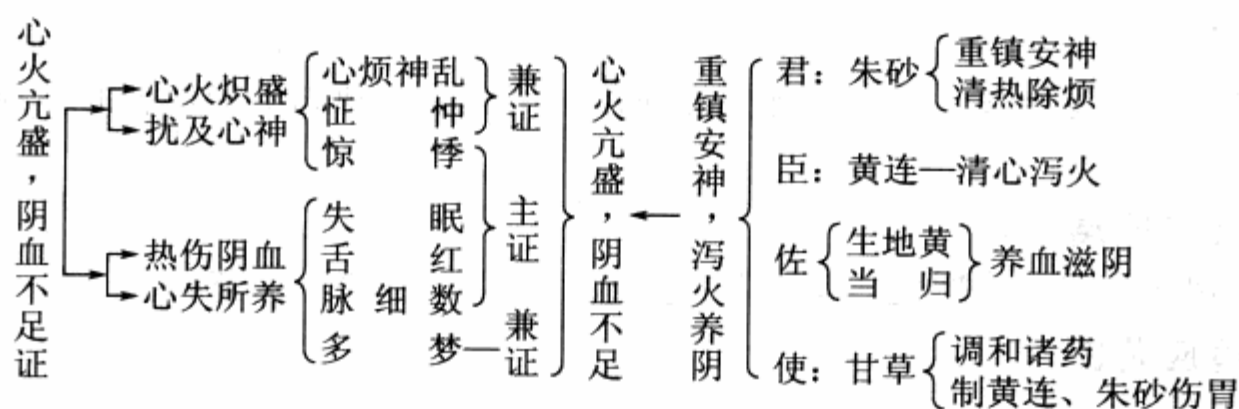
【功用】重镇安神，泻火养阴。

【主治】心火亢盛，阴血不足证。失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，舌红，脉细数。

【方歌】朱砂安神东垣方，归连甘草合地黄，

怔忡不寐心烦乱，清热养阴可复康。

【表解】



【配伍特点】泻中有补，标本兼治。

【应用要点】本方为治疗心火亢盛，阴血不足的常用方。以惊悸失眠，舌红，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于病毒性心肌炎、室性心律失常、经期发狂症等以心悸失眠为主要症状，或汗证、舌体灼热证等属于心火亢盛或阴虚火旺证者。

第二节 滋养安神

滋养安神剂适用于心肝失养所致的虚烦不眠、心悸怔忡、健忘多梦等症。常以补养安神药物如酸枣仁、柏子仁、五味子、茯苓、小麦等为主组成方剂。代表方如天王补心丹、酸枣仁汤。

• 酸枣仁汤（《金匱要略》） •

【组成】酸枣仁二升，炒（15~30g） 茯苓二两（6g） 知母二两（6~9g） 川芎二两（6g） 甘草一两（3g）

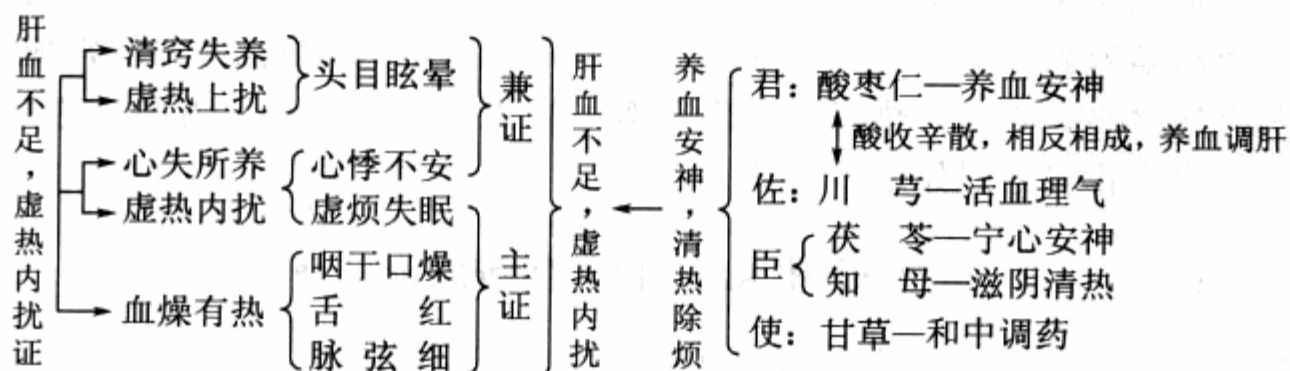
【功用】养血安神，清热除烦。

【主治】肝血不足，虚热内扰证。虚烦失眠，心悸不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉弦细。

【方歌】酸枣二升先煮汤，茯知二两佐之良，

芎二甘一相调剂，服后恬然入梦乡。

【表解】



【配伍特点】

① 养肝血以宁心神，清内热以除虚烦。

② 酸收与辛散并用，相反相成，以养血调肝。

【应用要点】本方为治疗心肝血虚，虚烦失眠的常用方。以虚烦不眠，咽干口燥，舌红，脉弦细为辨证要点。

现代临床本方常用于失眠症、更年期综合征、肢端动脉痉挛性疾病、顽固性频发室性早搏等属肝血不足，虚热内扰者。

• 天王补心丹（《校注妇人良方》）•

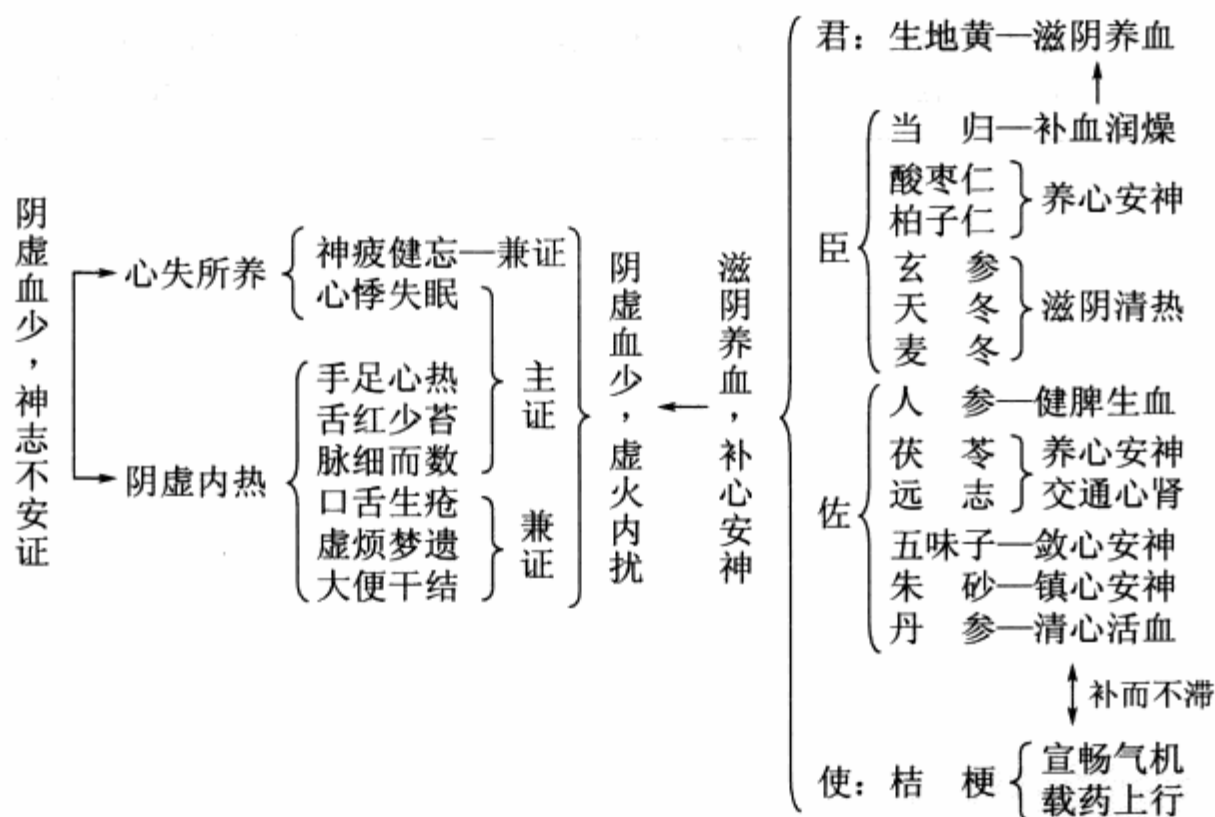
【组成】酸枣仁 柏子仁炒 当归身酒洗 天门冬去心 麦门冬去心，各一两（各30g） 生地黄酒洗，四两（120g） 人参去芦 丹参微炒 玄参微炒 白茯苓去皮 五味子烘 远志去心，炒 桔梗各五钱（各15g）

【功用】滋阴养血，补心安神。

【主治】阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，神疲健忘，虚烦失眠，或梦遗，手足心热，口舌生疮，大便干结，舌红少苔，脉细而数。

【方歌】补心丹用柏枣仁，二冬生地当归身，
三参桔梗朱砂味，远志茯苓共养神。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，补中寓清（以滋阴养血、补心安神为主，兼可滋阴降火）。
- ② 补中寓通，补而不滞（宣通气血津液）。
- ③ 培补后天，滋其化源。

【应用要点】本方为治疗心肾阴血亏虚所致神志不安的常用方剂。以心悸失眠，手足心热，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于多种心血管系统疾病、甲状腺功能亢进、更年期综合征、糖尿病合并心脏病等以心悸为主要临床表现者，以及神经衰弱之失眠、慢性荨麻疹、口腔溃疡、紧张性头痛、皮肤瘙痒症等属心肾阴虚内热，心神失养而致的多种疾患。

【使用注意】

- ① 方中药物较为滋腻，脾胃虚弱或痰浊较盛者慎服。
- ② 本方不宜与溴化物和碘化物类药物同用，如三溴合剂、巴氏合剂、碘化钾合剂。

【类方比较】

天王补心丹与归脾汤比较表

方名		归脾汤	天王补心丹
组成	同	人参、当归、远志、酸枣仁	
	异	白术、茯神、黄芪、龙眼肉、木香、甘草、生姜、大枣	柏子仁、天冬、麦冬、生地黄、五味子、丹参、玄参、桔梗
功用	同	益气补血，养心安神	
	异	重在益气健脾 心脾同治，气血双补	重在滋阴养血 心肾同治，水火相济
主治	同	阴血亏虚，心失所养之心悸怔忡，健忘失眠	
	异	心脾气血两虚证。以心悸失眠体倦食少，舌淡，苔薄白，脉细弱为主治要点	心肾阴血不足证。以心悸失眠，手足心热，舌红少苔，脉细数为主治要点

第十章 开窍剂

一、定义

凡用芳香开窍药为主组成，具有开窍醒神作用，治疗神昏窍闭之证的方剂，统称开窍剂。

二、立法依据

“寒者热之”、“热者寒之”、“客者除之”、“开之发之”。

三、适应范围

神昏 窍闭	闭证（虚证）	{ 热陷心包，痰热蒙闭—热闭 寒湿痰浊，蒙闭心窍—寒闭 }	开窍剂
	脱证（实证）	{ 气虚极—补益剂 阳虚极—温里剂 }	

四、分类与配伍规律

开 窍 剂	凉开剂—热闭证	—常以芳香开窍药主，配伍清热解毒药。
	温开剂—寒闭证	—常以芳香开窍药为主，配伍行气解郁、温里散寒药。

五、使用注意

- ① 辨别病证的虚实，本类方剂只适宜于邪实内闭证。
- ② 阳明腑实证而见神昏谵语者，治宜寒下，不宜应用开窍剂。至于阳明腑实而兼有邪陷心包之证，应根据病情的缓急轻重，或先投寒下，或开窍与泻下并用，才能切合病情。
- ③ 开窍剂多为芳香药物，其性辛散走窜，久服则易伤元气，故临床多用于急救，中病即止，不可久服。
- ④ 本类方剂多制成丸、散剂或注射剂，不宜加热煎煮，以免药性挥发，影响疗效，一般宜温开水化服或鼻饲。
- ⑤ 本类方剂多含辛香走窜之品，有碍胎元，故孕妇慎用。

第一节 凉 开

凉开剂适用于温热之邪内陷心包的热闭证。症见高热烦躁，神昏谵语，甚或痉厥等。其他如中风、气郁、痰厥及感受秽浊之气，以致卒然昏倒、不省人事，有热象者，亦可选用。常以芳香开窍药如麝香、冰片、郁金、石菖蒲等配伍清热泻火、凉血解毒药为主组成方剂。由于热入心包，引起神志不安，故常配镇心安神药，如朱砂、磁石、琥珀、珍珠等；邪热内陷，每易灼液为痰，故宜适当配伍清化痰热之品，如胆南星、川贝母、天竺黄、雄黄等。代表方剂如安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹。

• 安宫牛黄丸（《温病条辨》）•

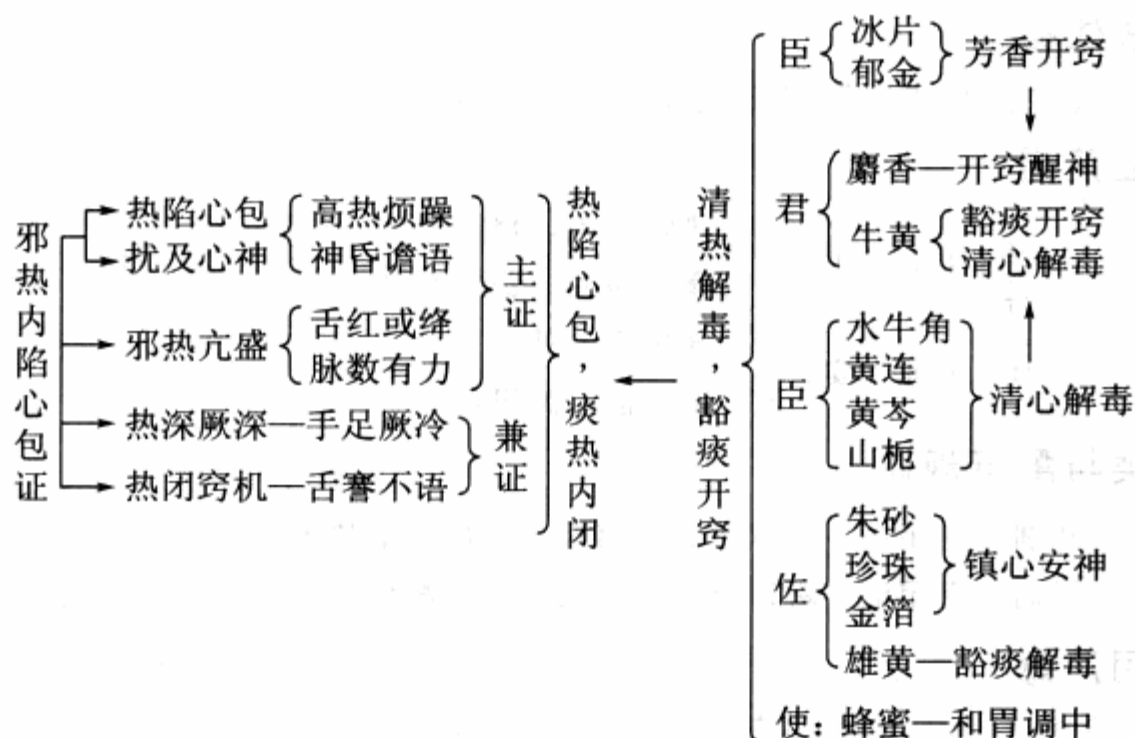
【组成】牛黄 郁金 黄连 朱砂 山栀 雄黄 黄芩各一两（各 30g）水牛角浓缩粉一两（30g）冰片 麝香各二钱五分（各 7.5g）珍珠五钱（15g）金箔衣

【功用】清热解毒，豁痰开窍。

【主治】邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语，舌謇肢厥，舌红或绛，脉数有力。亦治中风昏迷，小儿惊厥属邪热内闭者。

【方歌】安宫牛黄开窍方，芩连栀郁朱雄黄，
牛角珍珠冰麝箔，热闭心包功效良。

【表解】



【配伍特点】凉血解毒、清热泻火与芳香开窍并用。但以清热解毒为主，意在“使邪火随诸香一齐俱散也”。

【应用要点】本方为治疗热陷心包的常用方，也为凉开法的代表方。以神昏谵语，伴高热烦躁，舌红或绛，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于脑卒中（中风）、脑外伤综合征、流行性乙型脑炎、门脉高压术后脑病、原发性肝癌、黄疸型肝炎、急性胰腺炎、顽固性头痛、帕金森综合征、精神分裂症、红斑狼疮、肺炎、脑系疾病、晚期肺癌痰热壅肺证等属热邪内陷心包或痰热闭阻之证。

• 紫 雪 (《外台秘要》) •

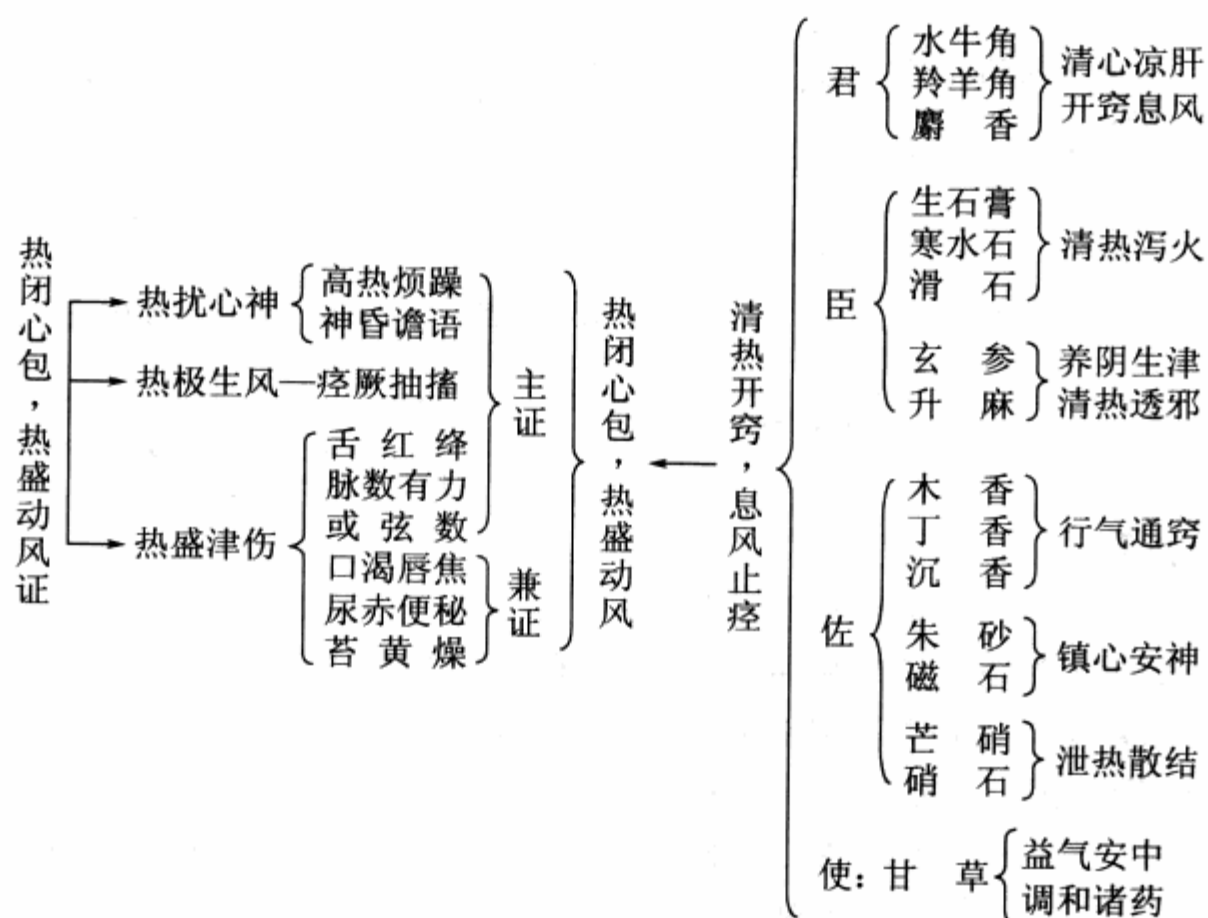
【组成】石膏 寒水石 滑石 磁石各三斤 水牛角浓缩粉 羚羊角屑 沉香 青木香各五两 玄参 升麻各一斤 甘草炙，八两 丁香一两 芒硝制，十斤 硝石精制，四升 麝香五分 朱砂三两 黄金一百两

【功用】清热开窍，息风止痉。

【主治】热闭心包，热盛动风证。高热烦躁，神昏谵语，痉厥，口渴唇焦，尿赤便秘，舌红绛，苔黄燥，脉数有力或弦数，以及小儿热盛惊厥。

【方歌】紫雪羚羊朱朴硝，硝磁寒水滑石膏，
丁沉香麝升玄草，不用赤金法亦超。

【表解】



【配伍特点】

- ① 心肝并治。即清心开窍与凉肝息风止痉并用。
- ② 开上窍与通下窍兼顾。即芳香以开上窍，釜底抽薪，导热下行以通下窍。

【应用要点】本方为治疗热闭心包，热盛动风证的常用方剂。以高热，烦躁，神昏，痉厥，便秘，舌红绛苔干黄，脉数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于各种发热性感染性疾病，如流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎的极期、重症肺炎、猩红热、化脓性感染等疾患的败血症期，肝昏迷及小儿高热惊厥、小儿麻疹热毒炽盛所致的高热神昏抽搐。

【使用注意】本方服用过量有损伤元气之弊，甚至可出现大汗、肢冷、心悸、气促等症，故应中病即止。孕妇禁用。

• 至宝丹（《苏沈良方》）•

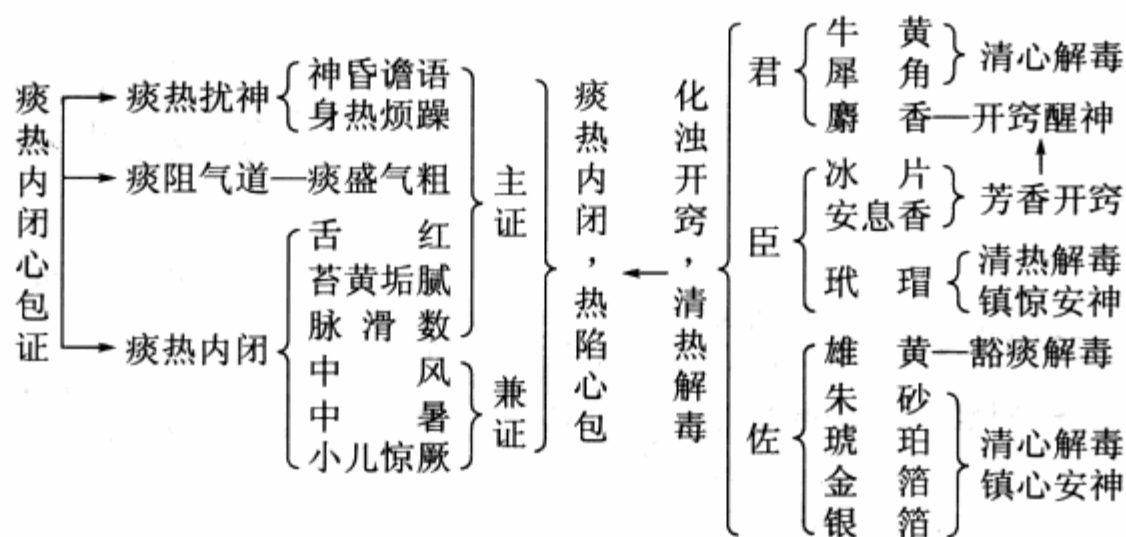
【组成】生乌犀（水牛角代） 生玳瑁 琥珀 朱砂 雄黄各一两 牛黄一分 龙脑一分 麝香一分 安息香一两半，为末，酒浸，重汤煮令化，滤过渣，取约一两净 金银箔各五十片

【功用】化浊开窍，清热解毒。

【主治】痰热内闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数，以及中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭者。

【方歌】至宝朱砂麝息香，雄黄牛角与牛黄，
金银二箔兼龙脑，琥珀还同玳瑁良。

【表解】



【配伍特点】

- ① 以化浊开窍为主，清热解毒为辅。
- ② 以化浊开窍为主，清热解毒之中兼能通络散瘀。

【应用要点】本方为治疗痰热内闭心包证的常用方。以神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、中毒性痢疾、尿毒症、脑血管意外、肝昏迷、中暑、癫痫等属痰热内闭心包证。

【类方比较】

“凉开三宝”比较

方名		安宫牛黄丸	紫雪	至宝丹
比较	同	热闭证		
	异	邪热偏盛，身热较重	热动肝风，痉厥抽搐	痰浊偏盛，昏迷较重
功用	同	清热开窍		
	异	清热解毒	息风止痉	芳香开窍，化浊辟秽

第二节 温 开

温开剂适用于中风、中寒、气郁、痰厥等属于寒闭之证。症见猝然昏倒，牙关紧闭，神昏不语，苔白脉迟等。常以芳香开窍药如麝香、苏合香、冰片等为主，配伍温里、行气之品组成方剂。代表方如苏合香丸。

• 苏合香丸（吃力伽丸）（《外台秘要》）•

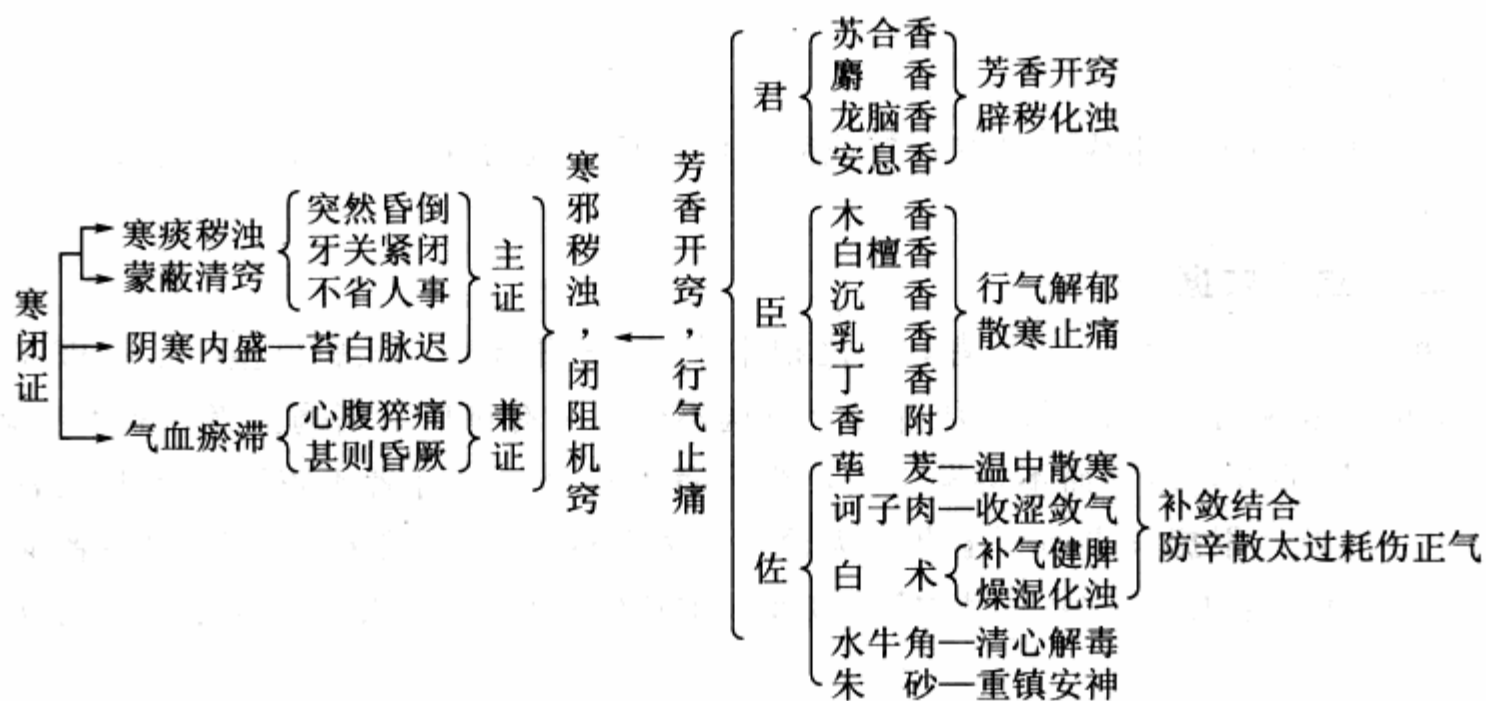
【组成】吃力伽（即白术） 光明砂研 麝香 诃黎勒皮 香附子中白 沉香重者 青木香 丁子香 安息香 白檀香 茛菪 犀角（水牛角代）各一两（各 30g） 熏陆香 苏合香 龙脑香各半两（各 15g）

【功用】芳香开窍，行气止痛。

【主治】寒闭证。突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟；心腹卒痛，甚则昏厥。亦治中风、中气及感受时行瘴疠之气，属于寒闭证者。

【方歌】 苏合香丸麝息香，木丁朱乳草檀襄，
牛冰术沉诃香附，中恶急救莫彷徨。

【表解】



【配伍特点】

① 芳香温开，集十香于一方（苏合香、麝香、龙脑香、安息香、木香、白檀香、沉香、乳香、丁香、香附）。

② 散中寓补，散中寓收，以防伤正。

③ 寒温结合，寓寒于温。

【应用要点】 本方为温开剂的代表方，既是治疗寒闭的常用方，又是腹疼痛属于气滞寒凝的有效方剂。以突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，苔白，脉迟为辨证要点。

现代临床本方常用于流行性乙型脑炎、肝昏迷、冠心病心绞痛、心肌梗死等属于寒闭与寒凝气滞证者。

第十一章 理气剂

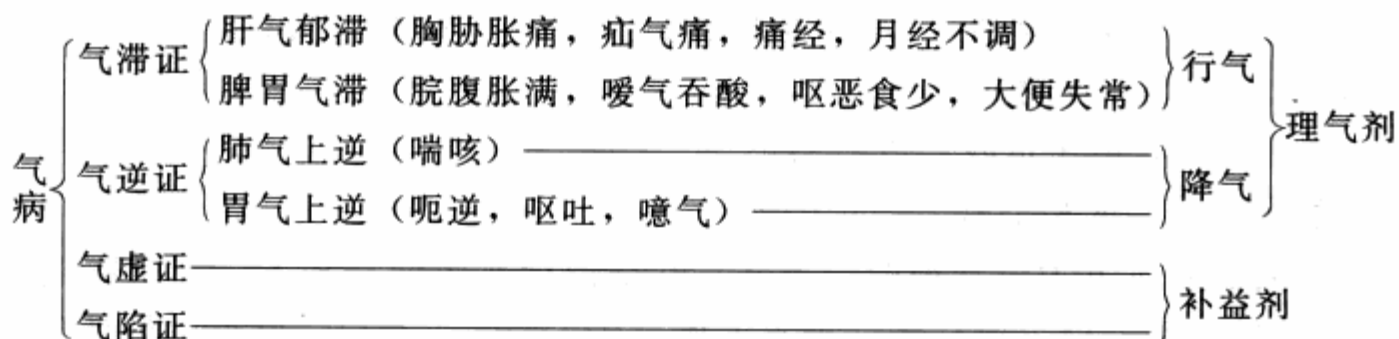
一、定义

凡以理气药为主组成，具有行气或降气的作用，以治气滞、气逆病证的方剂，统称理气剂。

二、立法依据

《难经·八难》指出：“气者，人之根本也。”气贵流通，无病可生，一有郁滞，则变生诸证。故朱丹溪云：“气积压冲和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉，故人身诸病，多生于郁。”郁者，结聚而不得发越也，当升者不得升，当降者不得降，当变化者不得变化也。因此，根据《素问·至真要大论》“逸者行之”、“结者散之”、“高者抑之”，《素问·六元正纪大论》“木郁达之”，以及《本草经疏》“降可去升”等原则，而立理气之法。

三、适应范围



四、分类与配伍规律

理气剂	{	行气剂—气滞证—常以疏肝理气药或行气理脾药为主
		降气剂—气逆证—常以降气平喘或降逆止呕药为主

五、使用注意

- ① 辨清虚实。勿犯虚虚实实之戒。
- ② 辨明兼证。气滞兼有气逆者，宜行气与降气并用；若兼气虚者，则宜配伍补气之品，以虚实兼顾。
- ③ 中病即止。理气剂多属芳香辛燥之品，易伤津耗气，应适可而止，甚勿过剂，尤其是年老体弱者，阴虚火旺者及孕妇均当慎用。

第一节 行 气

行气剂适用于气机郁滞的病证。气滞一般以脾胃气滞和肝气郁滞多见。脾胃气滞主要表现为脘腹胀满、嗳气吞酸、呕恶食少、大便失常等，常选用疏理脾胃气滞的药如陈皮、厚朴、木香、枳壳、砂仁等为主组方。若兼中焦寒凝气滞者，配干姜、高良姜等。若气滞因脾虚所致者，配人参、白术、茯苓、甘草等。气滞兼有痰湿者，配半夏、茯苓、苍术等，如越鞠丸、半夏厚朴汤等。肝气郁滞主要表现为胸胁胀痛，或疝气痛，或

月经不调，或痛经等，常以疏肝理气药如香附、乌药、川楝子、青皮、郁金等为主组方。代表方如越鞠丸、暖肝煎、半夏厚朴汤、厚朴温中汤、天台乌药散、金铃子散、枳实薤白桂枝汤。

• 越鞠丸（《丹溪心法》）•

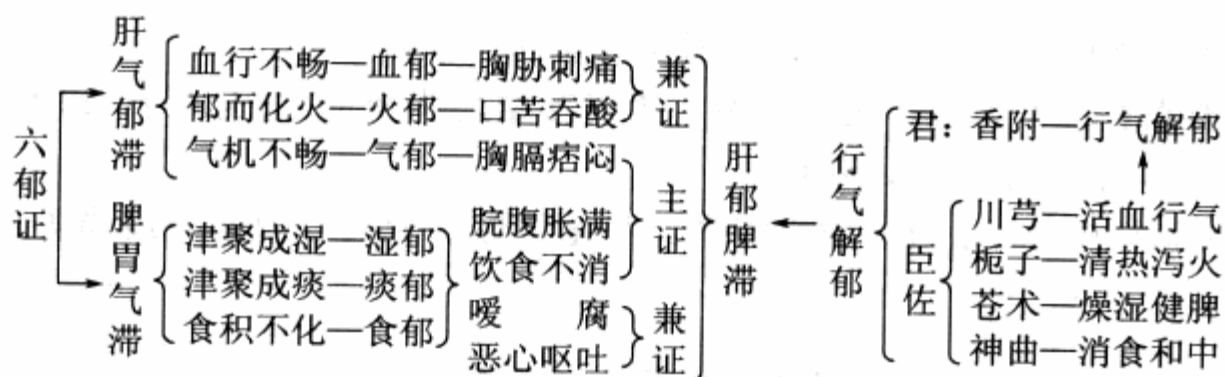
【组成】香附 川芎 苍术 神曲 梔子各等分（各6g）。

【功用】行气解郁。

【主治】六郁证。胸膈痞闷，脘腹胀满，噯腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。

【方歌】行气解郁越鞠丸，香附芎苍梔曲研，
气血痰火湿食郁，随证易君并加减。

【表解】



【配伍特点】以五药治六郁，重在治病求本，行气解郁。

【难点提示】为何以“五药治六郁”？

本方主治气、血、痰、火、食、湿六郁之证，方中分别以香附、川芎、梔子、苍术、神曲治疗气、血、火、湿、食五郁，为什么没有配伍治疗痰郁的药物？气郁则湿聚痰生，若气机流畅，五郁得解，则痰郁随之而解，方中以香附为君药，行气解郁，气顺则痰消，而且方中还用了燥湿健脾的苍术，脾健则湿化而痰无由生，故方中不另加祛痰药。

【应用要点】本方为治疗六郁证的代表方剂。以胸膈痞闷，脘腹胀痛，饮食不消等为辨证要点。

现代临床本方常用于胃神经官能症、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、胆石症、胆囊炎、肝炎、肋间神经痛、妇女痛经、月经不调等而有六郁见症者。

• 枳实薤白桂枝汤（《金匱要略》）•

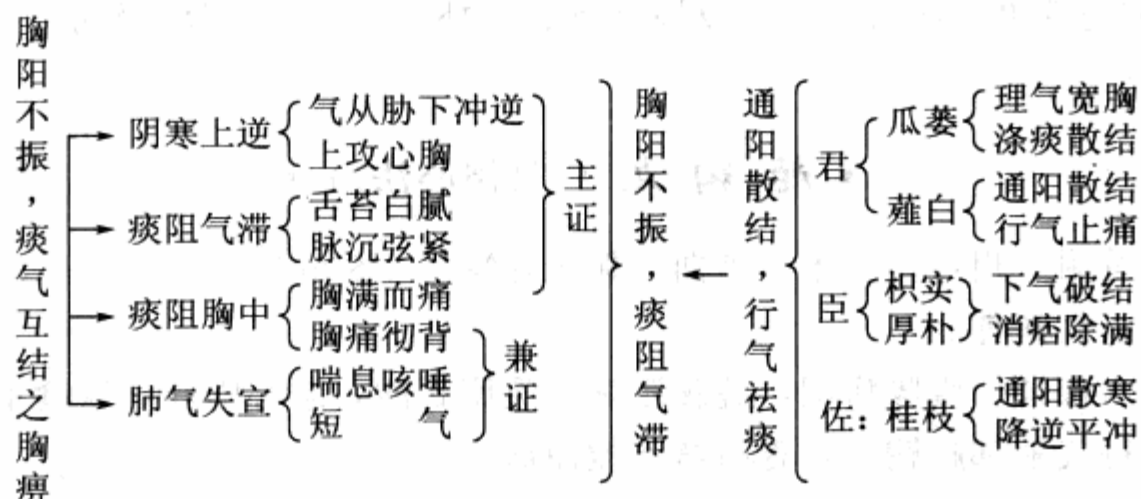
【组成】枳实四枚（12g） 厚朴四两（12g） 薤白半升（9g） 桂枝一两（6g） 瓜蒌一枚（12g）

【功用】通阳散结，行气祛痰。

【主治】胸阳不振，痰气互结之胸痹。胸满而痛，甚或胸痛彻背，喘息咳唾，短气，气从胁下冲逆，上攻心胸，舌苔白膩，脉沉弦或紧。

【方歌】枳实薤白桂枝汤，厚朴瓜蒌合成方，
通阳理气又散结，胸痹心痛皆可尝。

【表解】



【配伍特点】

- ① 寓降逆平冲于行气之中，以恢复气机升降。
- ② 寓散寒化痰于理气之内，以宣通阴寒痰浊之痹阻。

【应用要点】本方为治疗胸阳不振，痰气互结之胸痹的常用方剂。以胸痛，喘息短气，舌苔白腻，脉弦紧为辨证要点。

现代临床本方常用于冠心病心绞痛、非化脓性肋骨炎、肋间神经痛等属胸阳不振，痰浊内阻者。

• 半夏厚朴汤（《金匱要略》）•

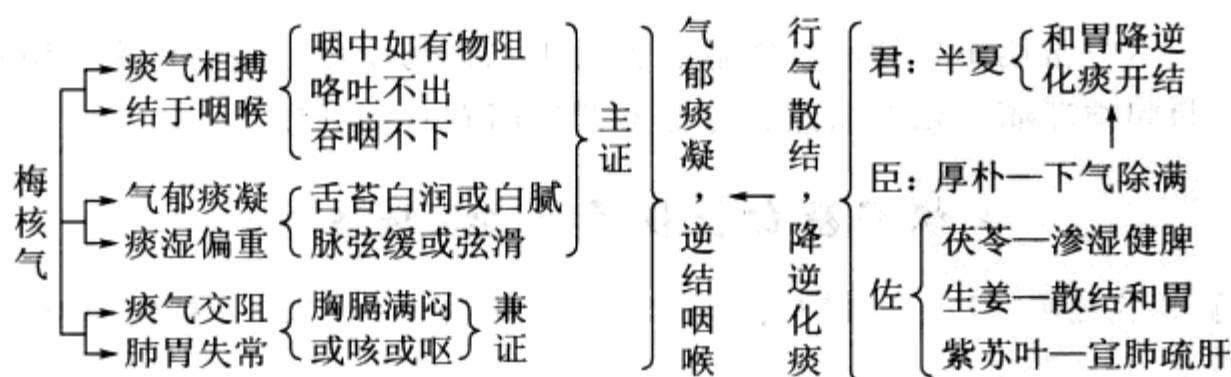
【组成】半夏一升（12g） 厚朴三两（9g） 茯苓四两（12g） 生姜五两（9g） 苏叶二两（6g）

【功用】行气散结，降逆化痰。

【主治】梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白腻，脉弦缓或弦滑。

【方歌】半夏厚朴与紫苏，茯苓生姜共煎服，
痰凝气聚成梅核，降逆开郁气自舒。

【表解】



【配伍特点】本方的配伍特点为辛苦温并用。辛散气滞，宣通郁结；苦能燥湿降逆；温能通气滞，化痰饮。诸药合用，共奏行气散结、降气化痰之功。

【应用要点】本方为治疗情志不畅，痰气互结之梅核气的常用方。以咽如物阻，吞吐不得，苔白腻，脉弦滑为辨证要点。

现代临床本方常用于咽异感症、癔症、癲狂症、食物逆流症、慢性浅表性胃炎及肿

瘤放化疗、术后所致的恶心呕吐等多种病证。

【使用注意】津伤较重或阴虚者不宜使用。如见有咽干颧红，舌红少苔，阴伤津少者，虽有梅核气之特征，亦不宜使用本方。

• 金铃子散（《袖珍方》）•

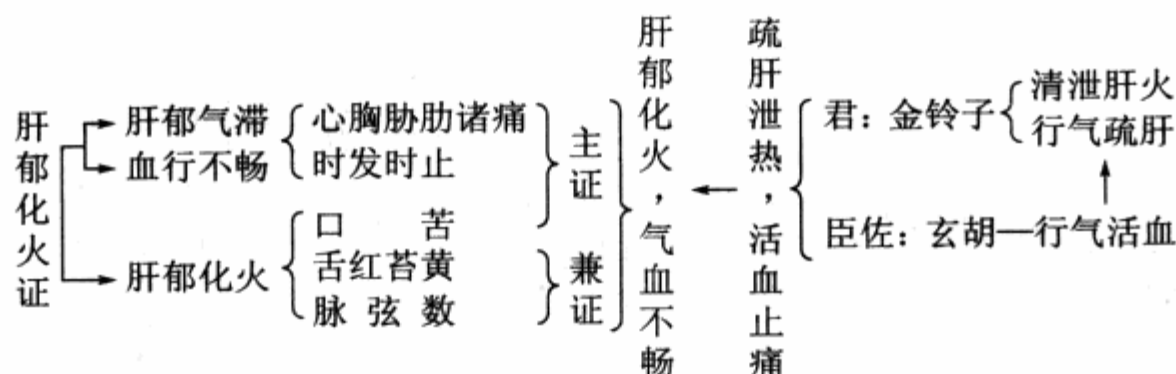
【组成】金铃子 玄胡各一两（各 9g）

【功用】疏肝泻热，活血止痛。

【主治】肝郁化火证。心胸胁肋诸痛，时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。

【方歌】金铃子散止痛方，玄胡酒调效更强，
疏肝泻热行气血，心腹胸肋痛经匡。

【表解】



【应用要点】本方为治疗肝郁化火诸痛证的常用方剂，亦是治疗气郁血滞而致疼痛的基础方。以胸腹胁肋疼痛，口苦，舌红，苔黄，脉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性肝炎、胆囊炎等属肝郁化火者。

【使用注意】因本方具有活血作用，孕妇慎用。若肝郁气滞属寒者，不宜单独使用。

• 厚朴温中汤（《内外伤辨惑论》）•

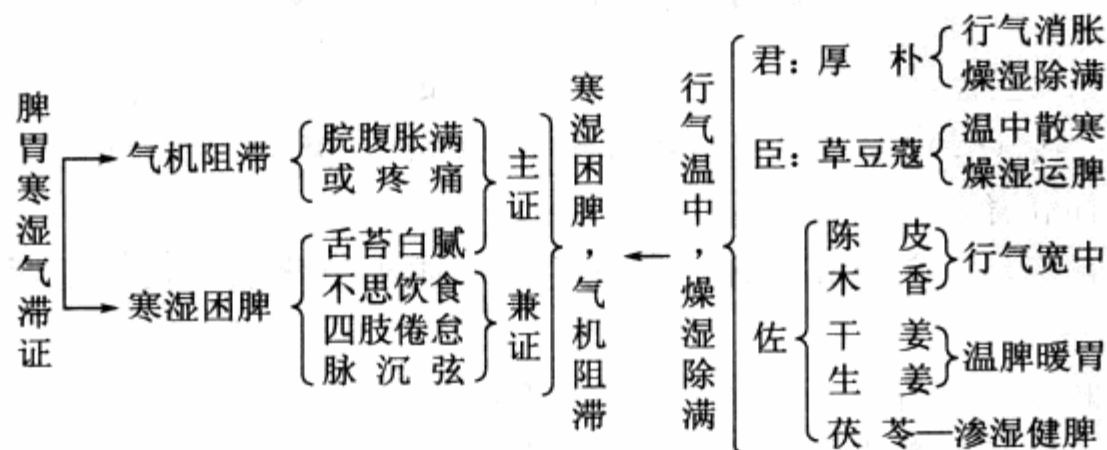
【组成】厚朴姜制 陈皮去白，各一两（各 9g） 甘草炙 茯苓去皮 草豆蔻仁 木香 各五钱（各 5g） 干姜七分（2g）

【功用】行气温中，燥湿除满。

【主治】脾胃寒湿气滞证。脘腹胀满或疼痛，不思饮食，四肢倦怠，舌苔白腻，脉沉弦。

【方歌】厚朴温中姜陈草，苓蔻木香一起熬，
温中行气兼燥湿，脘腹胀痛服之消。

【表解】



【应用要点】本方为治疗脾胃寒湿气滞的常用方。以脘腹作痛，舌苔白腻为辨证要点。现代临床本方常用于慢性胃炎、慢性肠炎、胃溃疡、妇女白带等属寒湿气滞者。

• 天台乌药散（《圣济总录》）•

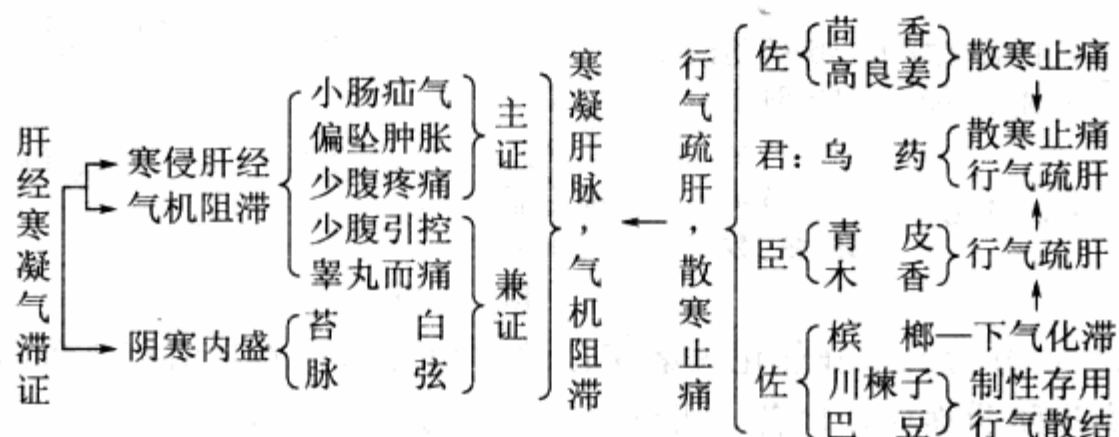
【组成】天台乌药 木香 小茴香 青皮 高良姜各半两（各 15g） 槟榔二个（9g） 川楝子十个（12g） 巴豆七十粒（12g）

【功用】行气疏肝，散寒止痛。

【主治】肝经寒凝气滞证。小肠疝气，少腹引控睾丸而痛，偏坠肿胀。或少腹疼痛，苔白，脉弦。

【方歌】天台乌药木茴香，槟榔青皮高良姜，
巴豆炒楝取其气，寒凝肝经疝痛良。

【表解】



【配伍特点】行气与散寒并用，行气以疏肝，散寒以止痛，气行寒散。

【难点提示】川楝子理气止痛，巴豆与川楝子同炒，去巴豆而用川楝子的炮制方法是本方妙处所在。这种做法是利用两者之长，克服两者之短的一种措施。川楝子与巴豆同炒，则川楝子苦寒之性缓而疏肝止痛作用仍然存在；相反，巴豆辛热散寒破结性存而泻下的弊病又得到克服。川楝子是直接利用其功效，巴豆是间接利用其辛热的性质，是一取其性、一取其用的用药方法。

【应用要点】本方为治疗寒凝气滞之疝气痛的常用方。以少腹痛引睾丸，舌淡苔白，脉沉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于睾丸炎、附睾炎、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎等属气滞寒凝者。

• 暖肝煎（《景岳全书》）•

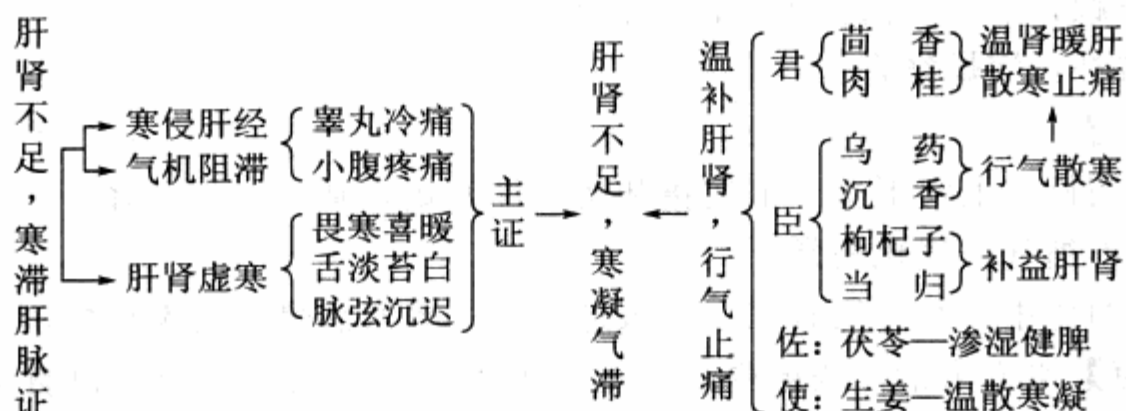
【组成】当归二三钱（6~9g） 枸杞子三钱（9g） 小茴香二钱（6g） 肉桂一二钱（3~6g） 乌药二钱（6g） 沉香一钱（或木香亦可）（3g） 茯苓二钱（6g）

【功用】温补肝肾，行气止痛。

【主治】肝肾不足，寒滞肝脉证。睾丸冷痛，或小腹疼痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉弦沉迟。

【方歌】暖肝煎中桂茴香，归杞乌沉茯加姜，
温补肝肾散寒滞，肝肾虚寒疝痛康。

【表解】



【配伍特点】 标本兼顾，温补肝肾以治其本，行气祛寒以治其标。

【应用要点】 本方为治疗肝肾虚寒，气机阻滞之少腹疼痛、疝气痛的常用方。以睾丸或少腹疼痛，畏寒喜温，得温痛减，舌淡苔白，脉沉迟为辨证要点。

现代临床本方常用于精索静脉曲张、腹股沟疝、鞘膜积液等属肝肾虚寒者。

第二节 降 气

降气剂适用于肺胃气逆不降以致咳喘、呕吐、暖气、呃逆等症。常选用降气平喘药物如紫苏子、杏仁、款冬花、紫菀等为主及降逆止呕药物如旋覆花、代赭石、半夏、竹茹、丁香、柿蒂等为主组方。代表方剂如定喘汤、苏子降气汤、旋覆代赭汤、橘皮竹茹汤。

• 苏子降气汤（《太平惠民和剂局方》）•

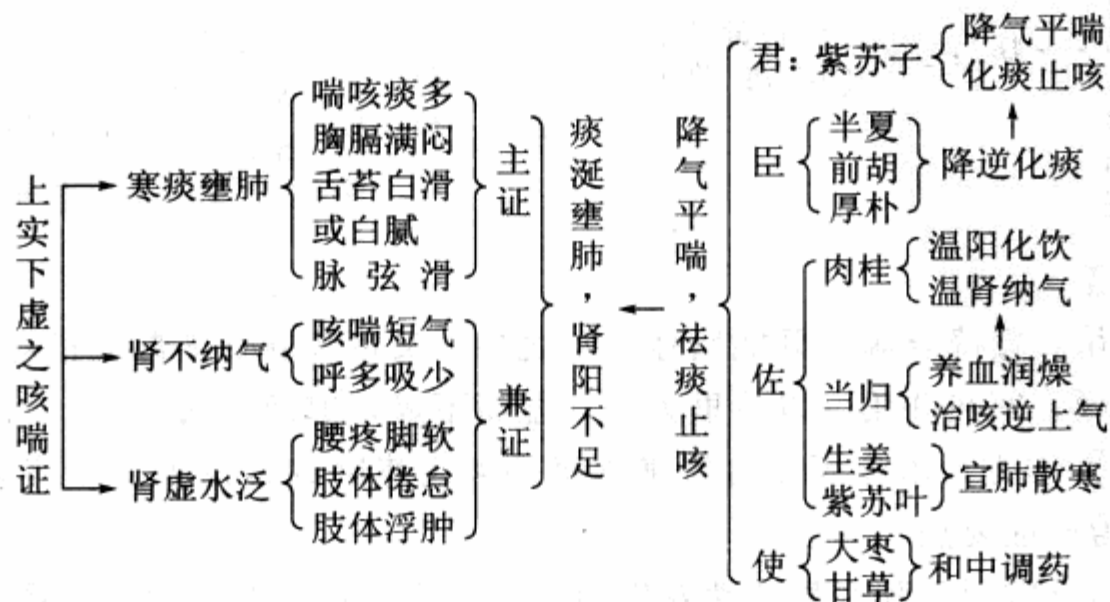
【组成】 紫苏子 半夏汤洗七次，各二两半（各 9g） 川当归去芦，两半（6g） 甘草炙，二两（6g） 肉桂去皮，一两半（3g） 前胡去芦 厚朴去粗皮，姜汁拌炒，各一两（各 6g）

【功用】 降气平喘，祛痰止咳。

【主治】 上实下虚之咳喘证。喘咳痰多，胸膈满闷，短气，呼多吸少，或腰疼脚软，肢体倦怠，或肢体浮肿，舌苔白滑或白腻，脉弦滑。

【方歌】 苏子降气姜肉桂，朴夏草陈前当归，
平喘降逆祛痰湿，温肾纳气喘自退。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，上下并治，重在治上、治标。
- ② 行中有补，润燥结合。

【难点提示】

(1) 方证病机 上实下虚 上实指肺实，即寒痰壅肺，肺失宣降。下虚指肾虚，即肾阳虚衰，肾不纳气，气化失常。

(2) 当归的作用 其作用有三：治咳逆上气；养血润燥；与肉桂配伍温补下元。

【应用要点】本方为治疗痰涎壅盛，上实下虚之喘咳的常用方。以胸膈满闷，痰多稀白，苔白滑或白腻为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘及风湿性心脏病等引起的咳嗽，对于气逆不降之呕吐、噎气、衄血等亦可根据异病同治的原则灵活运用。

【使用注意】方中药多温燥，对肺肾阴虚的喘咳或肺热痰喘，均不宜使用。

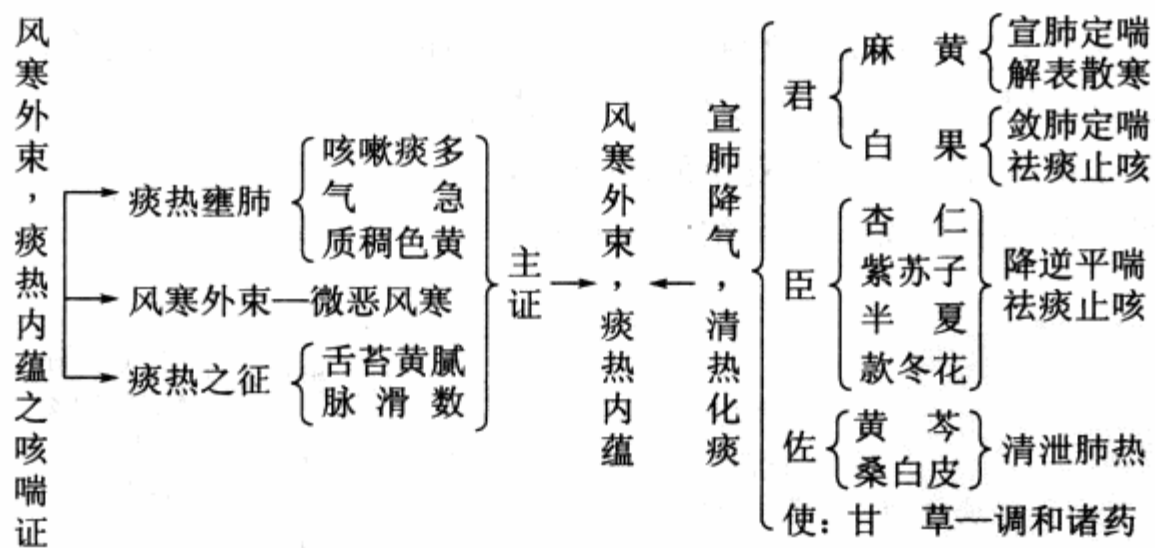
• 定喘汤（《摄生众妙方》）•

【组成】白果去壳，砸碎炒黄，二十一枚（9g） 麻黄三钱（9g） 苏子二钱（6g） 甘草一钱（3g） 款冬花三钱（9g） 杏仁一钱五分（9g） 桑白皮三钱（6g） 黄芩一钱五分（6g） 半夏三钱（9g）

【功用】宣肺降气，清热化痰。

【主治】风寒外束，痰热内蕴之咳喘证。咳嗽痰多气急，质稠色黄，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。

【方歌】定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，
苏子黄芩甘草杏，宣肺平喘效力彰。

【表解】**【配伍特点】**

- ① 散收同用，宣降合施（既能增强平喘之功，又可防麻黄辛散太过耗伤肺气）。
- ② 表里兼顾，寒热并用（以治里为主，温而不燥，凉而不遏）。

【应用要点】本方为治疗痰热内蕴兼风寒外束之哮喘的常用方。以痰多黄稠，舌苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于肺心病急性发作期、支气管哮喘、喘息性支气管炎、自发性气

胸、慢性前列腺炎等属痰热内蕴或兼风寒外束者。

【使用注意】新感风寒，无汗而喘，或无内热之哮喘，或哮喘日久气虚脉弱者，均不宜用。

【类方比较】

定喘汤与苏子降气汤比较表

方名		定喘汤	苏子降气汤
组成	同	紫苏子、半夏、甘草	
	异	白果、麻黄、杏仁、黄芩、桑白皮、款冬花	当归、肉桂、前胡、厚朴
功用	同	降气平喘	
	异	重在宣降肺气，清热化痰，兼解表散寒。表里同治，而以治里为主	重在降气祛痰，兼温肾纳气。治上顾下，标本兼顾，以治上治表为主
主治	同	痰壅气逆之咳喘证	
	异	风寒外束，痰热内蕴之咳喘证。表里同病，以里证为主。症见痰多黄稠，舌苔黄腻，脉滑数等	上实下虚之咳喘证。上下同病，以上实为主。症见胸膈满闷，痰多稀白，苔白滑或白腻等

定喘汤与小青龙汤比较表

方名		定喘汤	小青龙汤
组成	同	麻黄、半夏、甘草	
	异	白果、杏仁、黄芩、紫苏子、桑白皮、款冬花	细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子
功用	同	祛痰平喘，解表散寒	
	异	重在降逆定喘、清热化痰，兼解表散寒	重在解表散寒，兼温肺化饮
主治	同	外感风寒，痰饮内蕴之咳喘证	
	异	痰热蕴肺，复感风寒之咳喘证。表里同病，以里证为主。症见痰多黄稠，舌苔黄腻，脉滑数等	内有寒痰蕴肺，复感风寒之咳喘证。表里同病，以表证为主。症见恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮

• 旋覆代赭汤（《伤寒论》）•

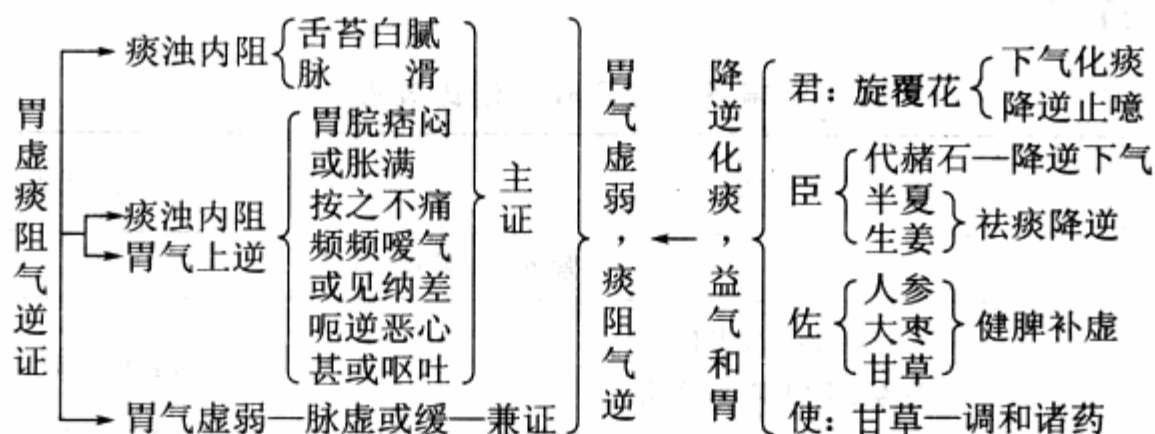
【组成】旋覆花三两（9g） 人参二两（6g） 生姜五两（10g） 代赭石一两（9g） 甘草炙，三两（6g） 半夏洗，半升（9g） 大枣十二枚，擘（4g）

【功用】降逆化痰，益气和胃。

【主治】胃虚痰阻气逆证。胃脘痞闷或胀满，按之不痛，频频嗳气，或见纳差、呃逆、恶心，甚或呕吐，舌苔白腻，脉缓或滑。

【方歌】旋覆代赭痞在中，噎气不除饮气冲，
参草姜枣半夏予，赭轻姜重方奏功。

【表解】



【配伍特点】降逆化痰以治标，益气和胃以治本，标本兼顾。

【应用要点】本方为治疗胃虚痰阻气逆的常用方。以心下痞硬，噎气频作，呃呃，苔白滑，脉弦虚为辨证要点。

现代临床本方常用于高血压病、内耳眩晕症、呕吐、食管癌手术后并发症、胆汁反流性胃炎、咽神经官能症等的治疗。另外，本方还可治疗胃及十二指肠溃疡、胃扩张、幽门不全梗阻、神经性呕吐、慢性肝炎等病而见上述证候者。

• 橘皮竹茹汤 (《金匱要略》) •

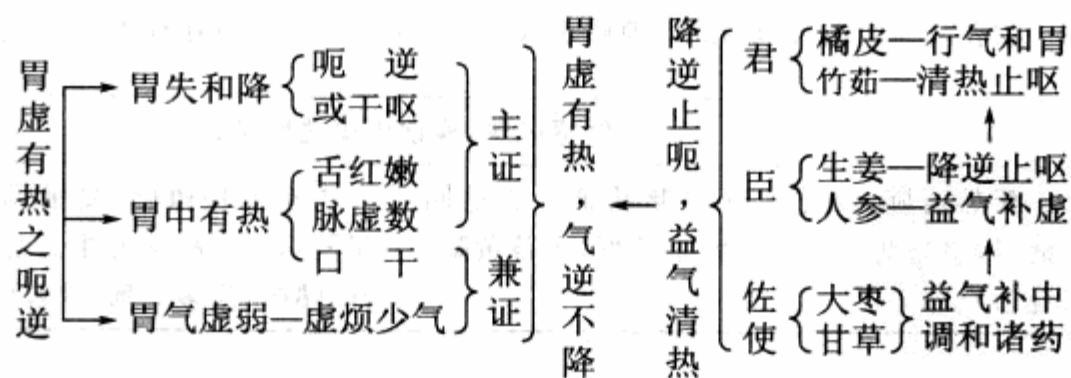
【组成】橘皮二升 (12g) 竹茹二升 (12g) 生姜半斤 (9g) 甘草五两 (6g) 人参一两 (3g) 大枣三十枚 (5枚)

【功用】降逆止呃，益气清热。

【主治】胃虚有热之呃逆。呃逆或干呕，虚烦少气，口干，舌红嫩，脉虚数。

【方歌】橘皮竹茹治呃逆，人参甘草枣姜益，
胃虚有热失和降，久病之后更相宜。

【表解】



【配伍特点】补胃虚，清胃热，降胃逆，补而不滞，清而不寒。

【应用要点】本方为治疗胃虚有热之呃逆的常用方。以呃逆，呕吐，舌红嫩，脉虚数为辨证要点。

现代临床本方常用于妊娠呕吐、幽门不全梗阻、膈肌痉挛及术后呃逆不止等属胃虚有热者。

第十二章 理血剂

一、定义

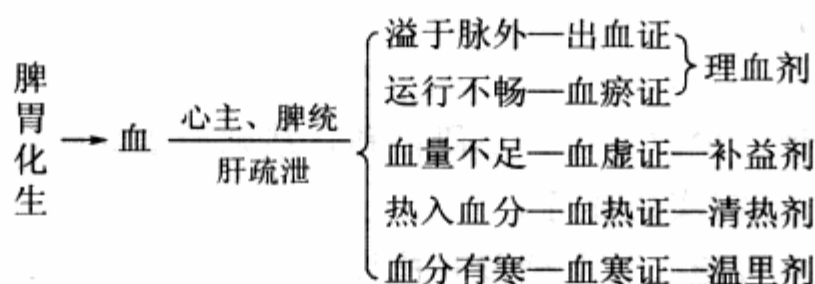
凡以理血药为主组成，具有活血化瘀或止血作用，用于治疗瘀血和出血证的方剂，统称理血剂。

二、立法依据

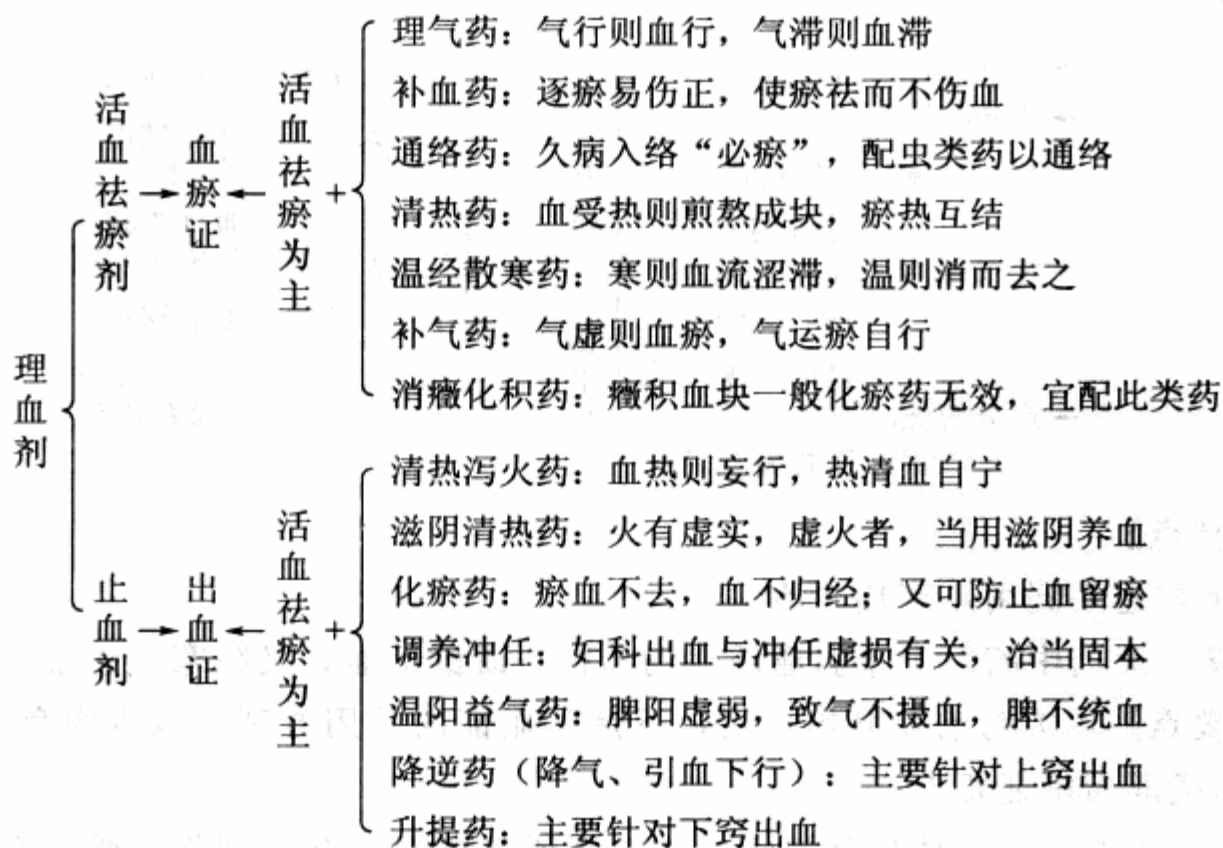
理血剂属“八法”中的“消法”、“清法”等范畴。《素问·阴阳应象大论》指出：“血实者宜决之。”《素问·至真要大论》指出：“疏其血气，令其调达，而致和平。”“坚者消之”、“结者散之”、“留者攻之”。《素问·汤液醪醴论》曰：“去菀陈痼。”《灵枢·小针解篇》曰：“菀陈则除之者，去血脉也。”此为活血化瘀的立法依据。

《素问·阴阳应象大论》又谓：“审其阴阳，以别柔刚。阳病治阴，阴病治阳。定其血气，各守其乡。血实决之，气虚宜掣引之。”此为止血的立法依据。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

① 分清血证致病原因，分清标本缓急。

② 祛瘀须防伤正。活血化瘀剂能促进血行，性多破泄，逐瘀过猛或久用逐瘀，易于伤正，故必要时常辅以扶正之品，使瘀消而不伤正，且月经过多者及孕妇均应慎用。

③ 止血防留瘀。运用止血剂，要避免止血留瘀之弊，故可于止血方中酌配既能化瘀又能止血之药。

第一节 活血祛瘀

活血祛瘀剂适应于各种血瘀证，如蓄血证、经闭、痛经、干血癆、癥瘕、半身不遂、外伤瘀痛等。临床表现以刺痛，痛有定处，舌紫暗，舌上有青紫斑或紫点，腹中等病变部位有肿块，疼痛拒按，按之坚硬，固定不移为特点。常以活血化瘀药如桃仁、红花、川芎、赤芍、丹参等为主组成方剂。代表方如桃核承气汤、血府逐瘀汤、补阳还五汤、复元活血汤、温经汤、生化汤、桂枝茯苓丸。

• 桃核承气汤（《伤寒论》）•

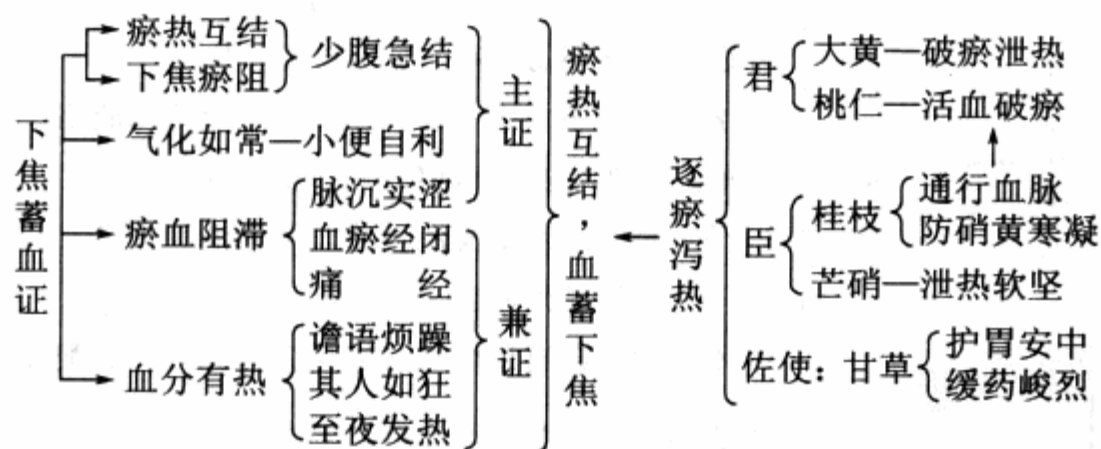
【组成】桃仁去皮尖，五十个（12g） 大黄四两（12g） 桂枝二两（6g） 甘草炙，二两（6g） 芒硝二两（6g）

【功用】逐瘀泻热。

【主治】下焦蓄血证。少腹急结，小便自利，甚则谵语烦躁，其人如狂，至夜发热；以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩等。

【方歌】桃核承气五般施，甘草硝黄并桂枝，
瘀热互结小腹胀，如狂蓄血功最奇。

【表解】



【配伍特点】

① 寒下与逐瘀同用，瘀热并治。

② 大队寒凉药中配以少量温通活血的桂枝，既助活血，又防寒凝血瘀。

【应用要点】本方为治疗瘀热互结，下焦蓄血证的常用方剂。以少腹急结，小便自利，脉沉实或涩为辨证要点。

现代临床本方常用于精神分裂症、急性坏死性肠炎、脊柱胸腰段骨折合并肠麻痹、牙痛、急慢性睾丸附睾炎、原发性血小板减少性紫癜、慢性肾盂肾炎、肝性血卟啉病等属瘀热互结于下焦者。

【类方比较】

桃核承气汤与大承气汤比较表

方名		桃核承气汤	大承气汤
组成	同	大黄、芒硝	
	异	桃仁、桂枝、甘草	厚朴、枳实
功用	同	泻热通下	
	异	破血下瘀	峻下热结
主治	同	实邪(瘀血、燥屎)与热互结	
	异	下焦蓄血证。症见小便自利,甚则谵语烦躁,脉沉实而涩等	阳明腑实证。症见痞、满、燥、实及舌红苔黄、脉沉实

• 血府逐瘀汤 (《医林改错》) •

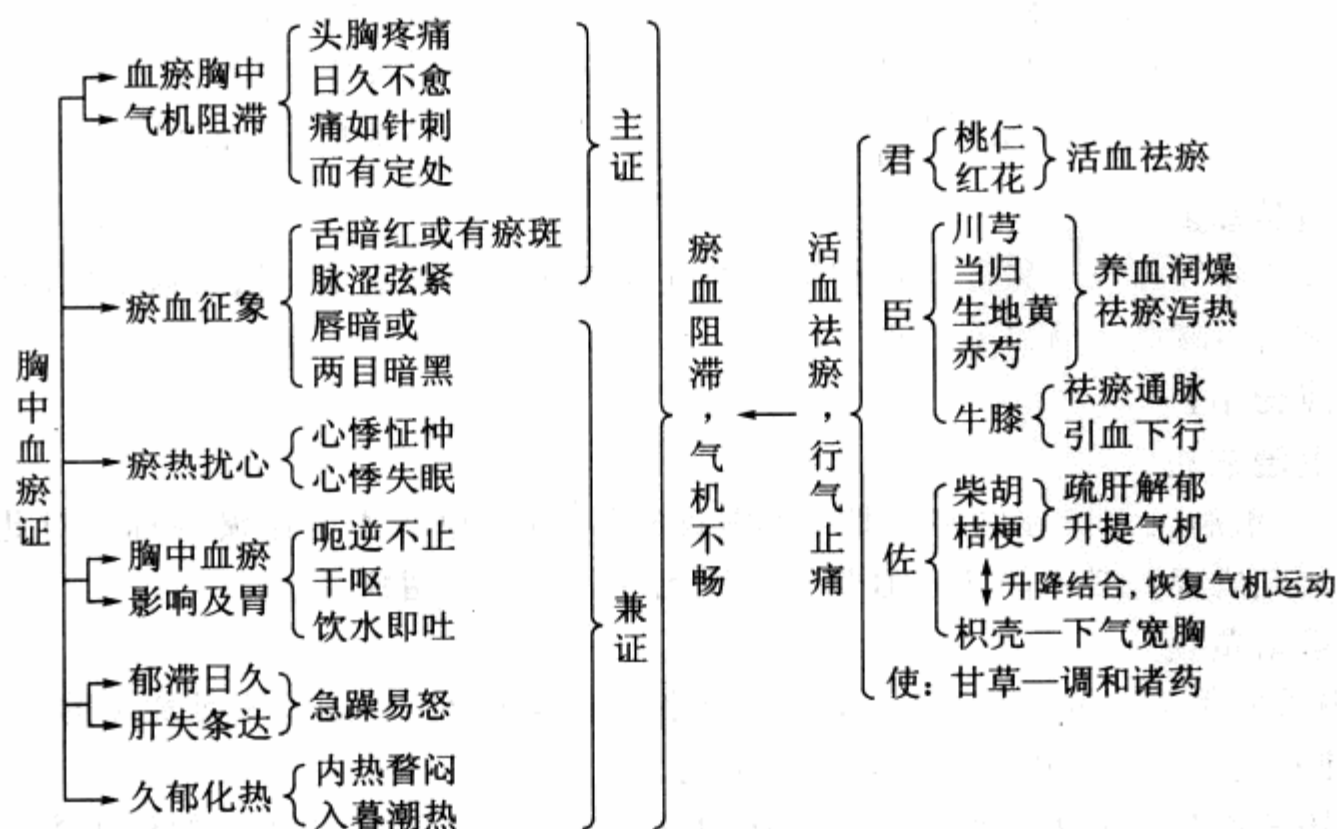
【组成】桃仁四钱 (12g) 红花三钱 (9g) 生地黄三钱 (9g) 川芎一钱半 (5g) 赤芍二钱 (6g) 牛膝三钱 (9g) 桔梗一钱半 (5g) 当归三钱 (9g) 柴胡一钱 (3g) 枳壳二钱 (6g) 甘草一钱 (3g)

【功用】活血祛瘀，行气止痛。

【主治】胸中血瘀证。胸痛，头痛日久，痛如针刺而有定处，或呃逆日久不止，干呕，饮水即吐，或内热瞋闷，或心悸怔忡，心悸失眠，急躁易怒，入暮潮热，唇暗或两目暗黑，舌暗红或有瘀斑，脉涩或弦紧。

【方歌】血府逐瘀牛柴草，桃红四物枳桔邀，
行瘀能止头胸痛，亦祛烦闷热如潮。

【表解】



【配伍特点】

- ① 气血同调（活血与行血并用，既行血分瘀滞，又解气分郁结）。
- ② 行中寓补（祛瘀与养血同施，活血不伤血，理气不伤阴）。
- ③ 升降兼顾（升清与降泄兼顾，恢复气血正常升降，使气血调和）。

【应用要点】本方为治疗血瘀胸中的常用方剂，也为治疗气滞血瘀证的代表方。以胸痛，痛有定处，舌暗红或有瘀斑为辨证要点。

现代临床本方常用于心脑血管病变（冠心病心绞痛、脑梗死、高血压），神经精神系病变（顽固性头痛、顽固性失眠、外伤头痛、血管神经性头痛、脑损伤后综合征、周期性精神病、神经根型颈椎病、爆震性耳聋、急性视神经炎），泌尿生殖系病变（阳痿、早泄、不育症）；妇科病变（痛经、乳腺增生、盆腔炎），消化系病变（慢性活动性肝炎、肝内胆管结石、萎缩性胃炎、顽固性便秘）等属血瘀气滞者。

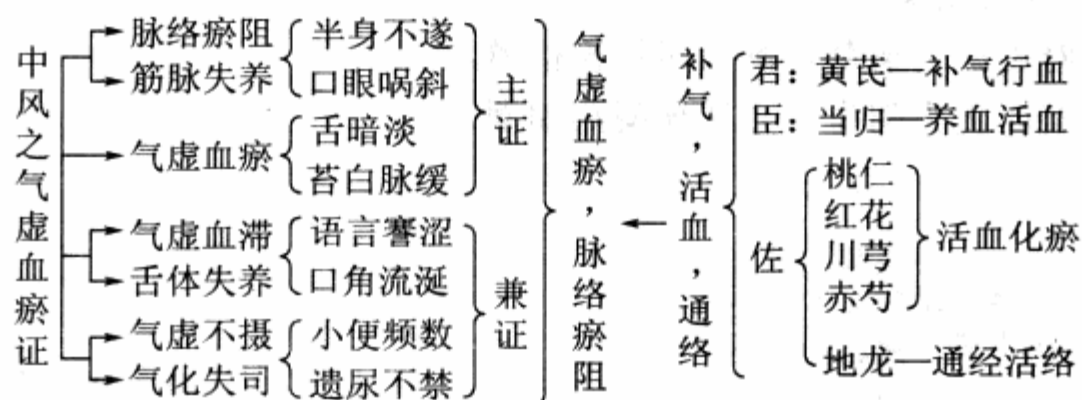
• 补阳还五汤（《医林改错》）•

【组成】黄芪生，四两（120g） 当归尾二钱（3g） 赤芍一钱半（5g） 地龙一钱（3g） 川芎一钱（3g） 红花一钱（3g） 桃仁一钱（3g）

【功用】补气，活血，通络。

【主治】中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼喎斜，语言謇涩，口角流涎，小便频数或遗尿不禁，舌暗淡，苔白，脉缓。

【方歌】补阳还五治中风，黄芪为主佐地龙，
芎归赤芍与桃红，补气活血络脉通。

【表解】**【配伍特点】**

- ① 大量补气药与少量活血药相配，补气令气旺血行以治本，祛瘀通络以治标。
- ② 补气不滞血，活血不伤正。

【难点提示】

1. 主治病机

本方主治病机为气虚血瘀，即“因虚致瘀”，以气血为本、血瘀为标。对此王清任认为：“元气既虚，必不能达于血管，血管无气，必停血留瘀。”

2. 重用黄芪

方中重用黄芪四两（120g），而活血通络药七钱半（22.5g），不足黄芪的五分之一，意在大补元气，令气旺以促血行，瘀去络通。

【应用要点】本方为治疗中风后遗症的常用方，又是益气活血法的代表方。以半身

不遂，口眼喎斜，苔白脉缓或脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于脑血管意外后遗症以及其他原因引起的偏瘫、上肢或下肢痿软、面神经麻痹、多发性神经炎等，并扩大运用于脑外伤后遗症、血瘀头痛、冠心病、慢性风心病，顽固性心力衰竭、高脂血症、肾病综合征、萎缩性胃炎、子宫内膜异位症、慢性盆腔瘀血综合征、不孕症、雷诺病、硬皮病、坐骨神经痛、慢性前列腺炎、眼型重症肌无力、肥大性鼻炎、妊娠高血压综合征性眼病等属气虚血瘀者。

【使用注意】

- ① 黄芪宜重用、生用，逐渐加量。
- ② 本方需久服缓治，疗效方显。愈后还应继续服用一段时间，以巩固疗效，防止复发。
- ③ 中风正气未虚或阴虚阳亢，风、火、痰、湿等余邪未尽者，应忌用。

张锡纯：“若遇脉之虚而无力者，用其方原可见效。若其脉象实而有力，其人脑中多患充血，而复用黄芪之温而升补者，以助其血愈上行，必至凶危立见，此固不可不慎也（《医学衷中参西录》）。”

• 复元活血汤（《医学发明》）•

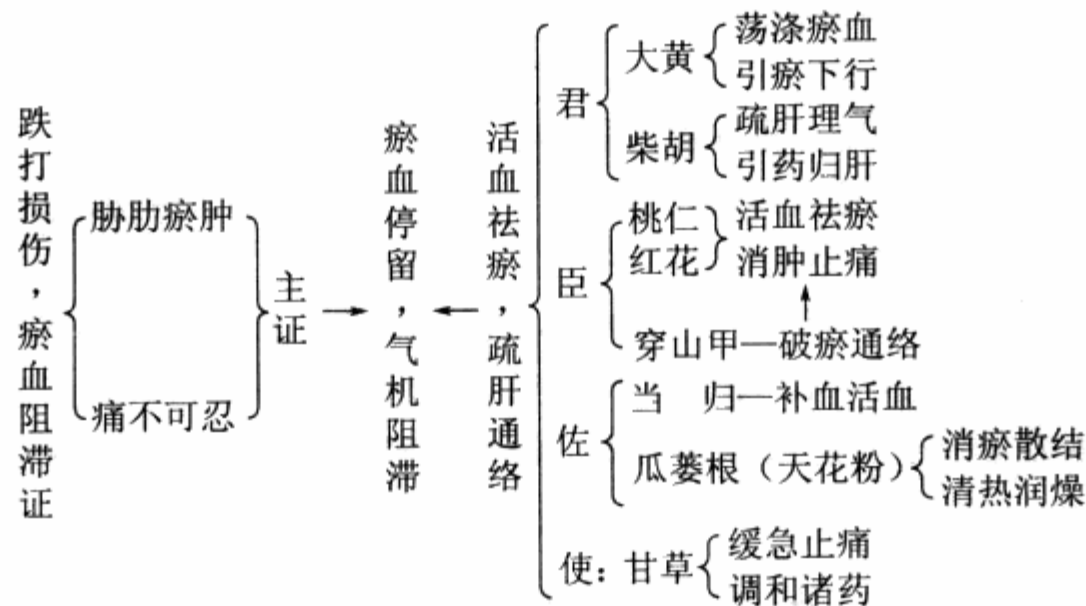
【组成】柴胡半两（9g） 瓜蒌根 当归各三钱（各 9g） 红花 甘草 穿山甲炮，各二钱（各 6g） 大黄酒浸，一两（12g） 桃仁酒浸，去皮尖，研如泥，五十个（9g）

【功用】活血祛瘀，疏肝通络。

【主治】跌打损伤，瘀血阻滞证。胁肋瘀肿，痛不可忍。

【方歌】复元活血黄柴胡，花粉当归山甲扶，
桃仁红花与甘草，加酒煎服伤瘀除。

【表解】



【配伍特点】

- ① 升降同施，以调畅气血。
- ② 活中寓养，活血破瘀而不伤阴血。

【应用要点】本方为治疗跌打损伤，瘀血阻滞证的常用方。以胁肋瘀肿，痛不可忍为辨证要点。

现代临床本方常用于肋间神经痛、肋软骨炎、胸胁部挫伤、乳腺增生等属血瘀气滞者。

• 温 经 汤 (《金匱要略》) •

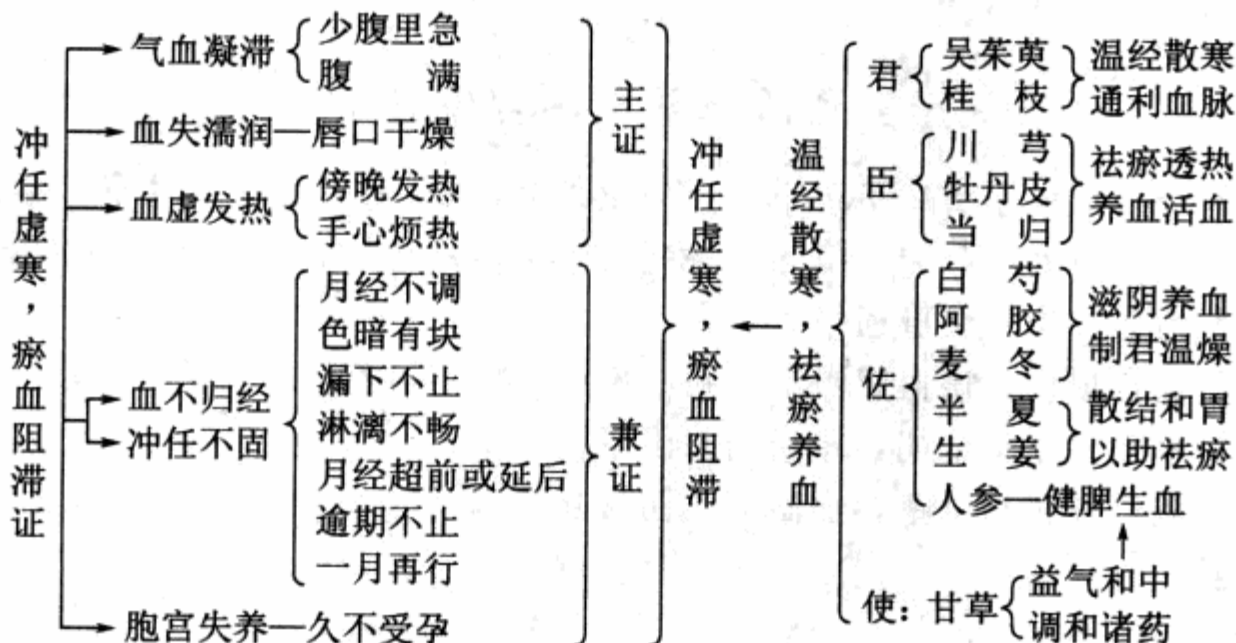
【组成】 吴茱萸三两 (9g) 当归二两 (6g) 芍药二两 (6g) 川芎二两 (6g) 人参二两 (6g) 桂枝二两 (6g) 阿胶二两 (6g) 牡丹皮二两, 去心 (6g) 生姜二两 (6g) 甘草二两 (6g) 半夏半升 (6g) 麦冬去心, 一升 (9g)

【功用】 温经散寒, 祛瘀养血。

【主治】 冲任虚寒, 瘀血阻滞证。漏下不止, 血色暗而有块, 淋漓不畅, 或月经超前或延后, 或逾期不止, 或一月再行, 或经停不至, 而见少腹里急, 腹满, 傍晚发热, 手心烦热, 唇口干燥, 舌质暗红, 脉细而涩。亦治妇人宫冷, 久不受孕。

【方歌】 温经汤用吴萸胶, 参麦桂枝夏姜草,
当归芍药芎丹皮, 冲任虚寒月经调。

【表解】



【配伍特点】

① 温、清、补、消并用, 重在温经补养。

② 寒热并用, 偏重于温, 温而不燥 (即大队温补药与少量寒凉药相配, 能使全方温而不燥, 刚柔相济, 以成温通、温养之剂)。

【应用要点】 本方为妇科调经常用方剂, 主要用于冲任虚寒而有瘀滞的月经不调、痛经、崩漏等证。以月经不调, 小腹冷痛, 经有瘀块, 时发烦热为辨证要点。

现代临床本方常用于功能性子宫出血、慢性盆腔炎、不孕症等属冲任虚寒, 瘀血阻滞证候者。

• 生 化 汤 (《傅青主女科》) •

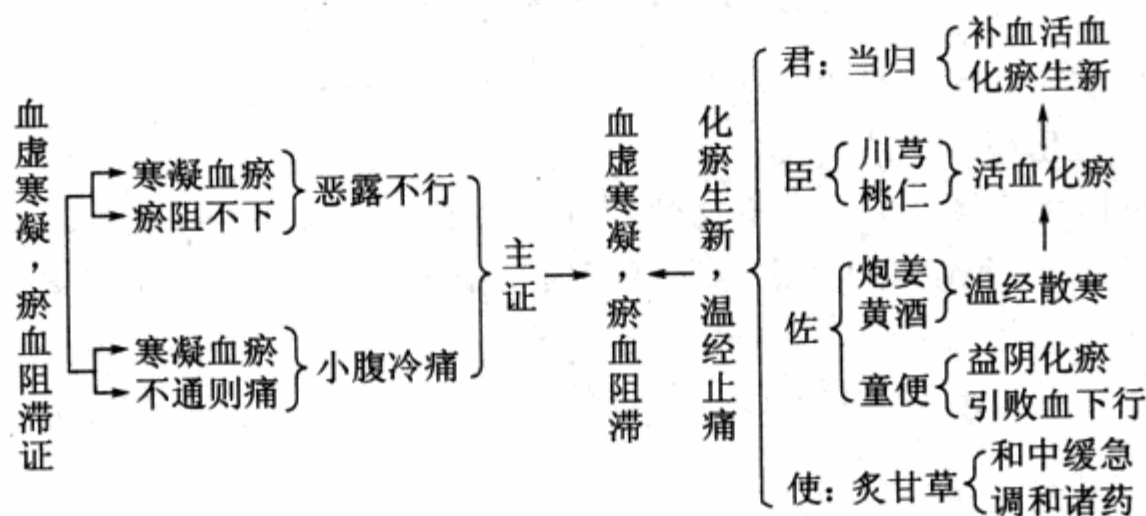
【组成】 全当归八钱 (24g) 川芎三钱 (9g) 桃仁去皮尖, 十四枚 (6g) 干姜炮黑, 五分 (2g) 甘草炙, 五分 (2g)

【功用】 化瘀生新, 温经止痛。

【主治】 血虚寒凝, 瘀血阻滞证。产后恶露不行, 小腹冷痛。

【方歌】 生化汤宜产后尝, 归芎桃草加炮姜,
恶露不行少腹痛, 温经活血最见长。

【表解】



【配伍特点】

- ① 消补兼施，寓补于消（补血配活血）。
- ② 温通并用，寓温于通（温里配活血）。

【应用要点】本方为妇女产后常用方剂。以产后恶露不行，小腹冷痛为辨证要点。

现代临床本方常用于药物流产后出血、引产后胎物残留、痛经、放置节育环及人流后不适症、产后痹证、产后出血、产后尿潴留、产后调理及输卵管梗阻性不孕症等属血虚受寒，瘀血阻滞者。

【使用注意】

- ① 若产后血热而有瘀滞者，不宜使用。
- ② 恶露过多、出血不止，甚则汗出气短神疲者，当禁用。

• 失笑散（《太平惠民和剂局方》）•

【组成】五灵脂酒研，淘去沙土 蒲黄炒香，各等分（各 6g）

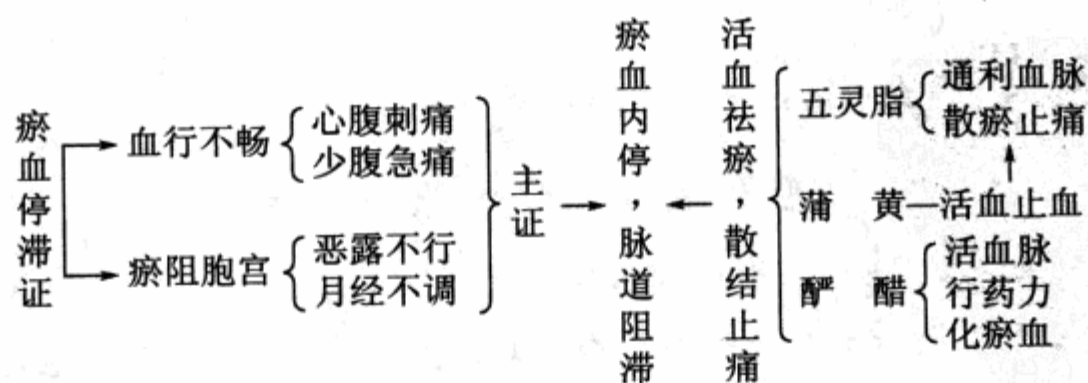
【功用】活血祛瘀，散结止痛。

【主治】瘀血停滞证。心腹刺痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛等。

【方歌】失笑灵脂蒲黄同，等量为散酳醋冲，

瘀滞心腹时作痛，祛瘀止痛有奇功。

【表解】



【应用要点】本方为治疗血瘀作痛的基础方剂，尤以肝经血瘀者为宜。以心腹刺痛，或妇人月经不调，少腹急痛为辨证要点。

现代临床本方常用于痛经、慢性胃炎、心绞痛或宫外孕等属瘀血停滞者。

【使用注意】本方具有活血祛瘀散结作用，故孕妇忌用；五灵脂易败胃，胃弱者慎用。

• 桂枝茯苓丸（《金匱要略》）•

【组成】桂枝 茯苓 丹皮 桃仁去皮尖 芍药各等分（各 6g）

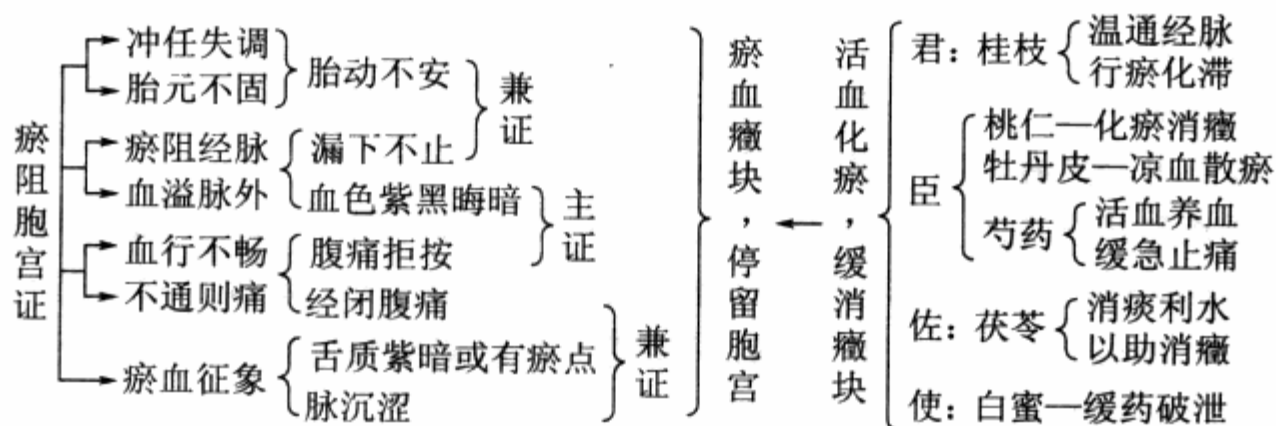
【功用】活血化癥，缓消癥块。

【主治】瘀阻胞宫证。妇人素有癥块，妊娠漏下不止，或胎动不安，血色紫黑晦暗，腹痛拒按，或经闭腹痛，或产后恶露不尽而腹痛拒按者，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩。

【方歌】桂枝茯苓桃芍丹，缓消癥积胎可安，

等分为末蜜丸服，若改汤剂可催产。

【表解】



【配伍特点】

① 寒温并用。既温通血脉，又凉血散瘀，无耗伤阴血之弊。

② 通因通用。瘀血癥块不去，血不归经，则漏下不止，用祛瘀消癥法，瘀去血自归经。

③ 渐消缓散。此方原治妇人妊娠素有癥块，漏下不止，或胎动不安。恐祛瘀损伤胎元，故炼蜜为丸，服量极小，意在渐消缓散。

【应用要点】本方为治疗瘀阻胞宫，妊娠胎动不安，漏下不止的常用方剂。以下血色黑晦暗，腹痛拒按为要点。

现代临床本方常用于子宫内膜炎、附件炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等属瘀血阻滞者。

【使用注意】

① 对于妇女妊娠而有瘀血癥块者，只能渐消缓散，不可峻攻猛破，若攻之过急，则易伤胎元。

② 原方用量小、用法严格，临证运用，切当注意。

• 鳖甲煎丸（《金匱要略》）•

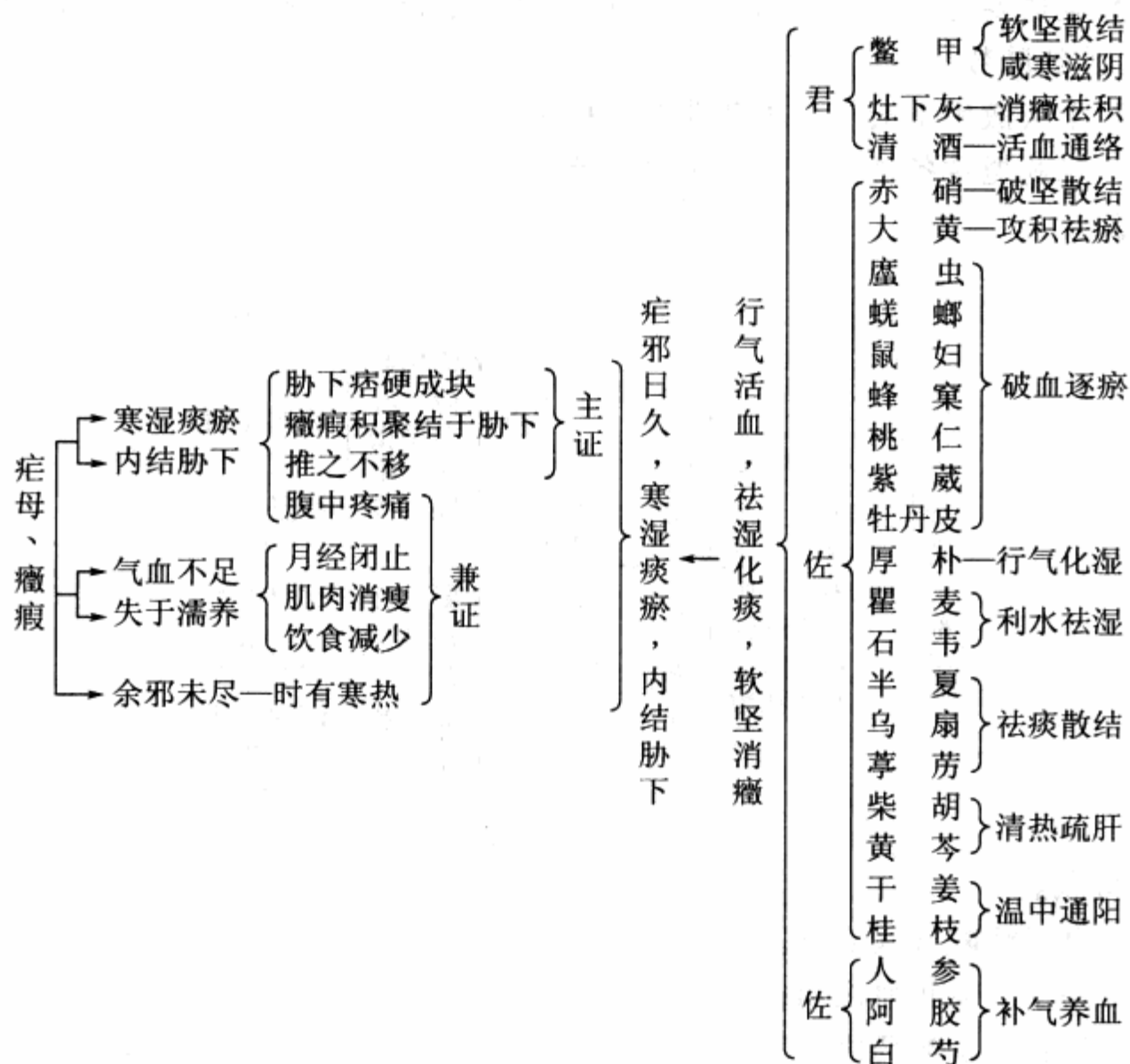
【组成】鳖甲十二分，炙 乌扇炮 黄芩 鼠妇熬 干姜 大黄 桂枝 石韦去毛 厚朴 瞿麦 紫葳 阿胶各三分 柴胡 蜣螂熬，各六分 芍药 牡丹去心 廔虫熬，各五分 蜂巢炙，四分 赤硝十二分 桃仁二分 人参 半夏 葶苈各一分

【功用】行气活血，祛湿化痰，软坚消癥。

【主治】疟母、癥瘕。疟疾日久不愈，胁下痞硬（或硬）成块，结成疟母；以及癥瘕积聚，结于胁下，推之不移，腹中疼痛，肌肉消瘦，饮食减少，时有寒热，或女子月经闭止等。

【方歌】鳖甲煎丸疟母方，虻虫鼠妇及蛭螂，
蜂巢石韦人参射，桂朴紫葳丹芍姜，
瞿麦柴芩胶半夏，桃仁葶苈和硝黄，
疟疾日久胁下硬，癥消积化保安康。

【表解】



【配伍特点】寒热并用，攻补兼施，气血津液同治。

【应用要点】本方为治疗疟母、癥瘕的常用方。以胁下癖块，触之硬痛，推之不移，舌暗无华，脉弦细为辨证要点。

现代临床本方常用于肝硬化、肝脾肿大、肝癌、子宫肌瘤、卵巢囊肿等属正气日衰，气滞血瘀者。

第二节 止血

止血剂适用于血溢脉外而出现的吐血、衄血、咳血、便血、尿血、崩漏等各种出血证。止血法应与温、清、消、补诸法结合使用，正确把握标本兼顾、急则治标、缓则治本的原则。如热证出血用侧柏叶、小蓟、白茅根、槐花、地榆等；寒证出血用炮姜、艾叶、灶心土等；瘀血所致之出血用三七、蒲黄等为主组成方剂。此外，上部出血忌用升提药，可酌配牛膝、大黄之类以引血下行；下部出血忌用沉降药物，可辅以焦芥穗、黑升麻、黄芪之类以助升举。代表方剂如十灰散、咳血方、小蓟饮子、槐花散、黄土汤。

• 十灰散 (《十药神书》) •

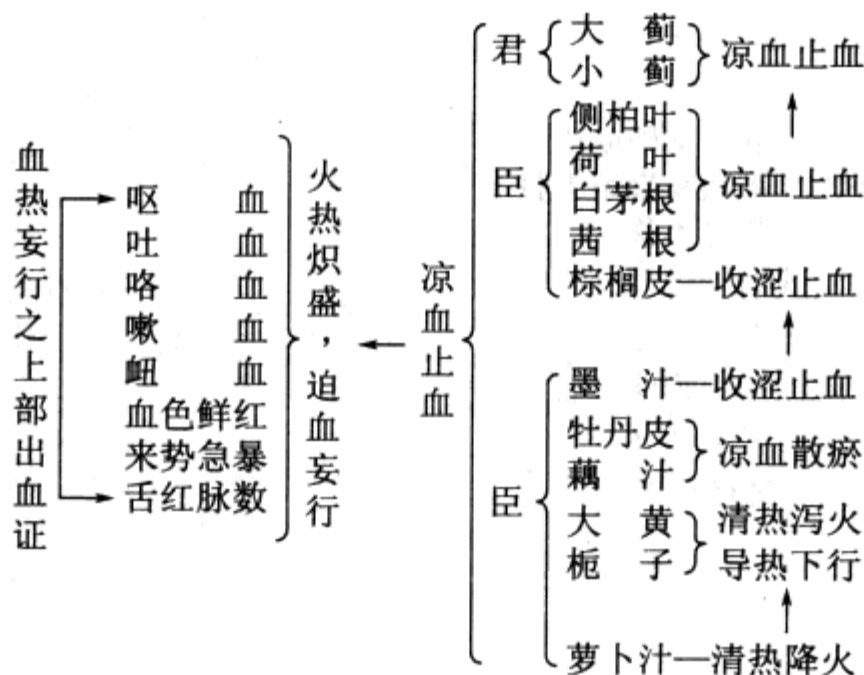
【组成】 大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 茅根 茜根 山梔 大黄 牡丹皮 棕榈皮 各等分 (各 9g)

【功用】 凉血止血。

【主治】 血热妄行之上部出血证。呕血、吐血、咯血、嗽血、衄血等，血色鲜红，来势急暴，舌红脉数。

【方歌】 十灰散用十般灰，柏茅茜荷丹桐煨，
二蓟梔黄各炒黑，上部出血势能摧。

【表解】



【配伍特点】

- ① 寓止血于清降气火之下。
- ② 寄祛瘀于凉血止血之内。
- ③ 蕴收涩止血于炭药之中。

【难点提示】 烧灰存性一般是指把药物放入密封容器内，再用火烧，直到药物外面碳化，里面焦黄。既保存了药物的固有药性，又能发挥炭药的止血作用。

【应用要点】 本方为治疗血热妄行之上部出血证的常用方。以上部出血，血色鲜红，舌红脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于消化道出血、支气管扩张咯血、更年期功能性子宫出血，以及肺结核咯血等属气火上逆者。

【使用注意】 本方运用大队凉血止血药，对于虚寒性出血者忌用。

• 咳血方 (《丹溪心法》) •

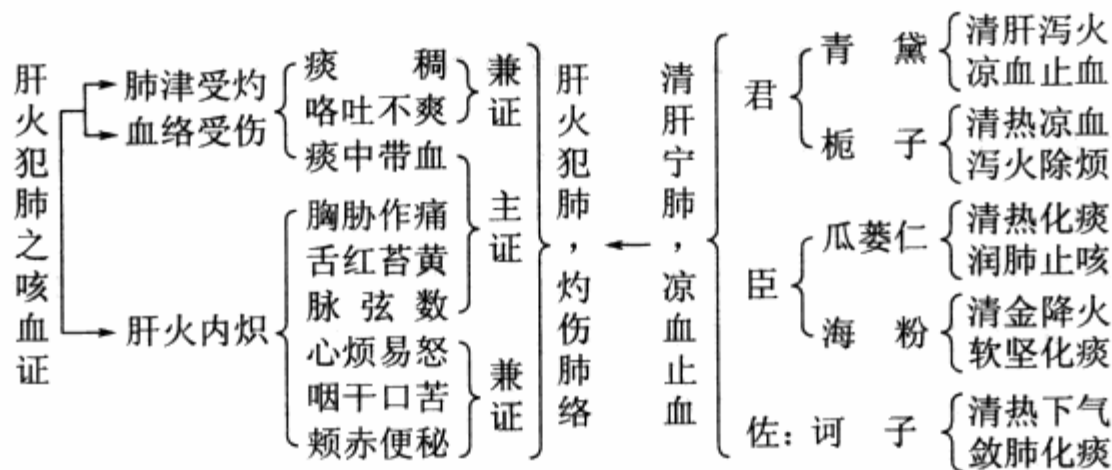
【组成】 青黛水飞 (6g) 瓜蒌仁去油 (9g) 海粉 (9g) 山梔子炒黑 (9g) 诃子 (6g)

【功用】 清肝宁肺，凉血止血。

【主治】 肝火犯肺之咳血证。咳嗽痰稠带血，咯吐不爽，心烦易怒，胸胁作痛，咽干口苦，颊赤便秘，舌红苔黄，脉弦数。

【方歌】咳血方中诃子收，瓜蒌海石山梔投，
青黛蜜丸口噙化，咳嗽痰血此方求。

【表解】



【配伍特点】

- ① 舍标图本。寓止血于清肝泻火之中，虽不专用止血药而咳血自止。
- ② 肝肺兼调。清肝凉血为主，结合清肺化痰、敛肺止咳，意在清肝宁肺。

【应用要点】本方为治疗肝火犯肺之咳血证的常用方。以咳痰带血，胸胁作痛，舌红苔黄，脉弦数为辨证要点。

现代临床本方常用于支气管扩张、肺结核等咳血属肝火犯肺者。

• 小蓟饮子（《济生方》，录自《玉机微义》）•

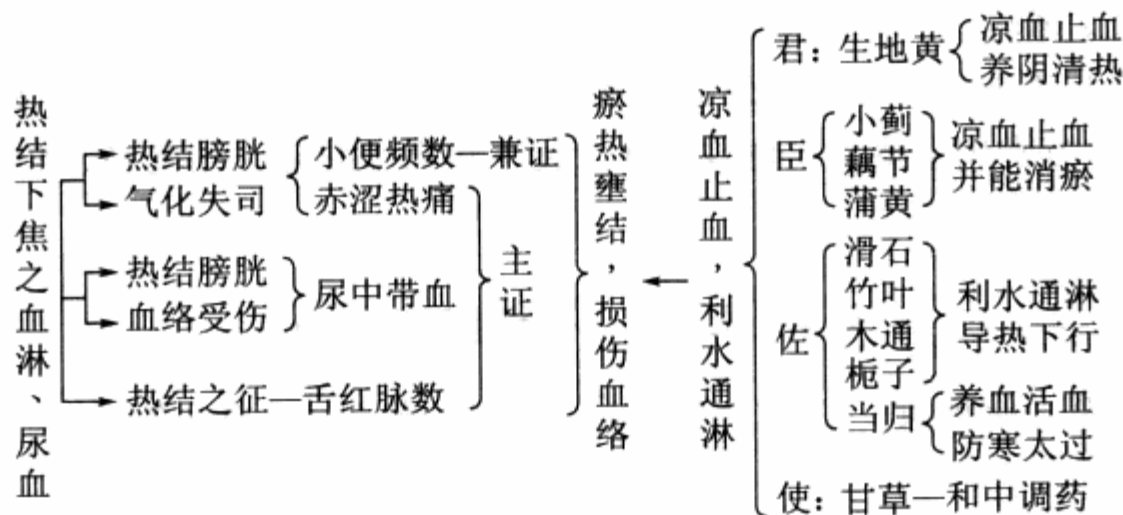
【组成】生地黄 小蓟 滑石 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 当归 山梔子 炙甘草各等分（各 9g）

【功用】凉血止血，利水通淋。

【主治】热结下焦之血淋、尿血。尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数等。

【方歌】小蓟饮子藕蒲黄，木通滑石生地藏，
归草黑梔淡竹叶，血淋热结服之康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 止血之中寓以化瘀，使止血而不留瘀。
- ② 清利之中寓以养阴，使利水而不伤阴。

【应用要点】本方为治疗血淋、尿血属实热证的常用方。以尿中带血，小便赤涩热

痛，舌红，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性泌尿系感染及泌尿系结石、急性肾小球肾炎、过敏性紫癜等属下焦瘀热蓄聚膀胱者。

• 槐花散（《普济本事方》）•

【组成】槐花炒（12g） 柏叶杵，焙（12g） 荆芥穗（6g） 枳壳麸炒（6g）各等分。

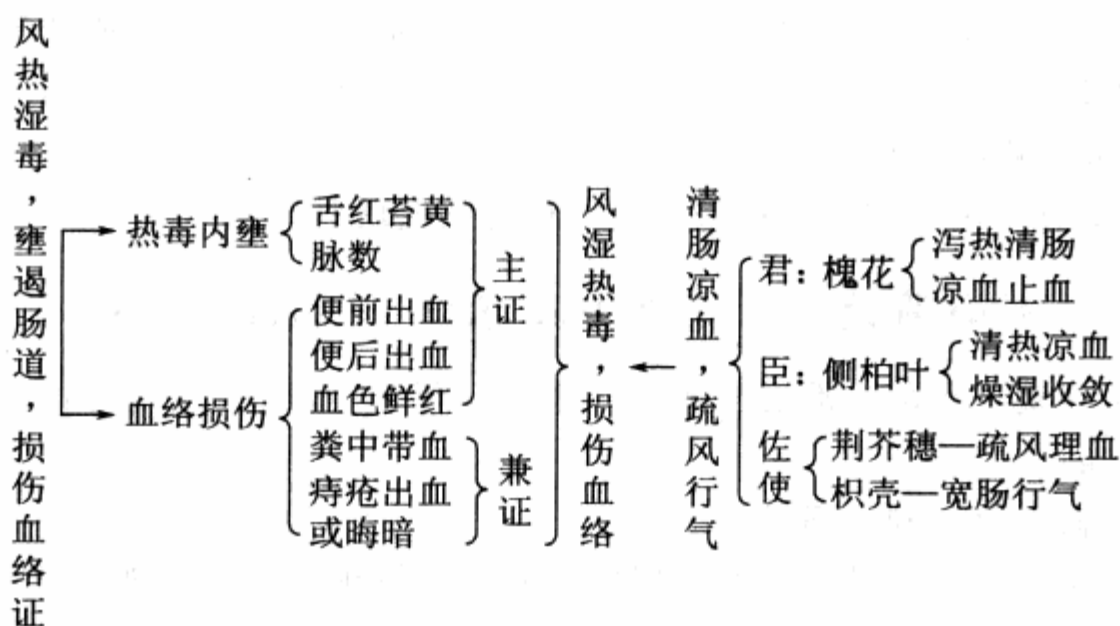
【功用】清肠凉血，疏风行气。

【主治】风热湿毒，壅遏肠道，损伤血络证。便前出血，或便后出血，或粪中带血，以及痔疮出血，血色鲜红或晦暗，舌红苔黄脉数。

【方歌】槐花侧柏荆枳壳，等分为末米饮调，

清肠止血又疏风，血热肠风脏毒疗。

【表解】



【配伍特点】

① 寓行气于止血之中，气血兼调。

② 寄收涩于清疏之内，相反相成。

【应用要点】本方为治疗热证便血的常用方。以血色鲜红，舌红，脉数为辨证要点。现代临床本方常用于痔疮出血或其他大便下血属血热者。结肠炎、肠癌之便血亦可应用。

• 黄土汤（《金匮要略》）•

【组成】甘草 干地黄 白术 附子炮 阿胶 黄芩各三两（各 9g） 灶心黄土半斤（30g）

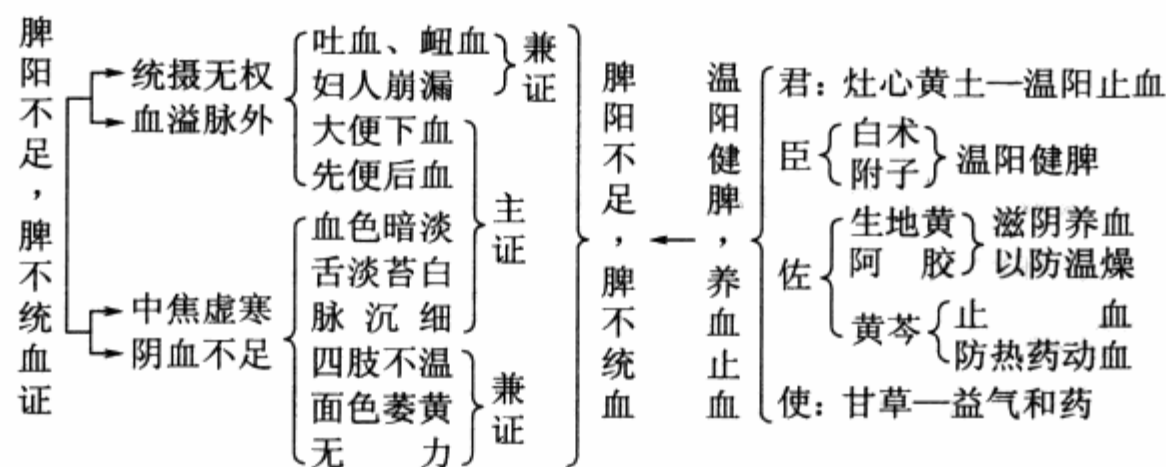
【功用】温阳健脾，养血止血。

【主治】脾阳不足，脾不统血证。大便下血，先便后血，或吐血、衄血，及妇人崩漏，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力者。

【方歌】黄土汤用芩地黄，术附阿胶甘草尝，

温阳健脾能摄血，便血崩漏服之康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 寒热并用，使温阳不动血。
- ② 标本兼顾，即止血以治标，温阳以治本。
- ③ 刚柔相济，使滋阴不碍阳。

【应用要点】 本方为治疗脾阳不足所致崩漏或便血的常用方。以血色暗淡，舌淡苔白，脉沉细无力为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃肠道出血及功能性子宫出血属脾阳不足者。

【使用注意】 本方药性偏温，治疗阳虚出血证，血热妄行导致的出血证忌用。

【类方比较】

黄土汤与归脾汤比较表

方 名		黄 土 汤	归 脾 汤
比 较	同	白术、甘草	
	异	干地黄、附子、 阿胶、黄芩、灶心黄土	茯神、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、 人参、木香、当归、远志
功 用	同	益气健脾，养血止血	
	异	长于温阳健脾止血，偏于温涩，标本兼顾	长于益气健脾，偏于补益治本，以补为固
主 治	同	脾不统血之便血、崩漏	
	异	脾阳不足，统摄无权之出血证。症见血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力	脾气不足，气不摄血之出血证。症见心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱

第十三章 治风剂

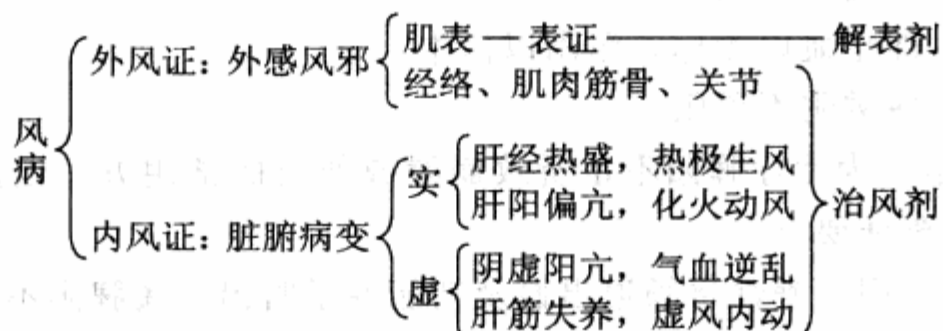
一、定义

凡以辛散祛风或息风止痉等药物为主组成，具有疏散外风或平息内风作用，用于治疗风病的方剂，统称治风剂。

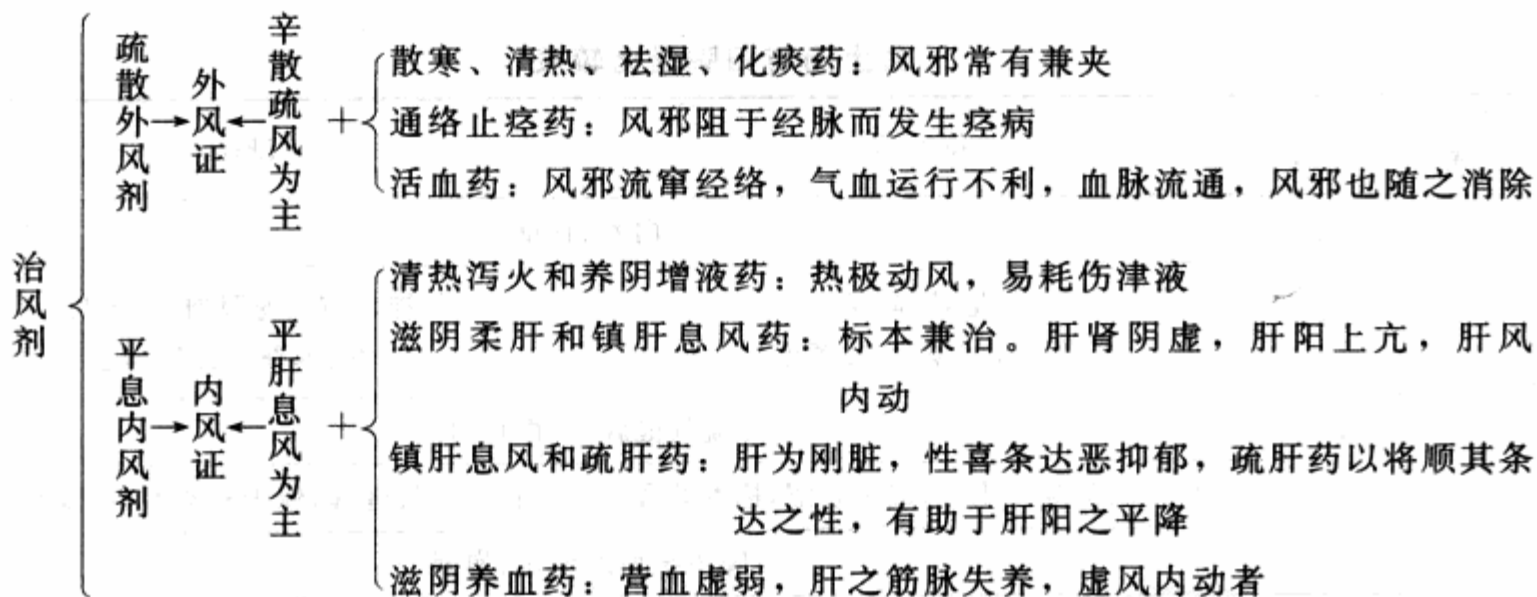
二、立法依据

治风剂分属于“八法”中“汗法”、“清法”、“补法”等范畴。其立法依据参考相应治法。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

① 准确辨证。分清外风、内风，而分别选用疏散外风法或平息内风法，并分辨寒、热、虚、实而分别配以温、清、补、泻等法。

② 辨明内外风兼夹。外风是否引动内风，内风是否兼夹外风，如有兼夹则当兼而治之。

③ 明辨兼证，数法合参。应针对不同的病情，灵活加减化裁，或数法合参，因风邪不能独伤人，多夹寒、热、湿、燥、痰等邪伤人。

④ 防温燥伤津助火。辛散疏风药多温燥，易伤津液，且易助火，对于津液不足或阴虚或阳亢有热者均应慎用，亦可少佐滋阴之品以制约之。

第一节 疏散外风

疏散外风剂适用于外风所致诸病。常用辛散祛风的药物如羌活、独活、防风、川芎、白芷、荆芥、白附子等为主组成方剂。在配伍用药方面，常因病人体质的强弱、感邪的轻重、病邪的兼夹等不同，而分别配合清热、祛寒、养血、活血之品。代表方剂如川芎茶调散、大秦芎汤、小活络丹、牵正散、消风散。

• 川芎茶调散（《太平惠民和剂局方》）•

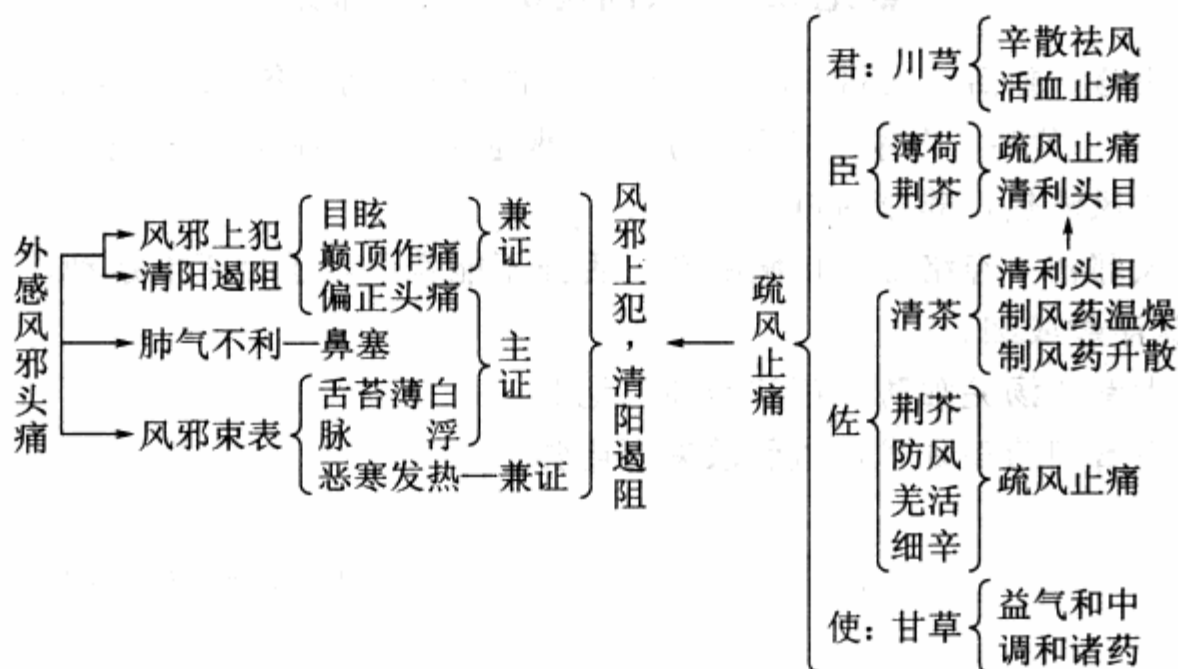
【组成】川芎 荆芥去梗，各四两（12g） 白芷 羌活 甘草炙，各二两（各 6g）
细辛一两（3g） 防风去芦，一两半（4.5g） 薄荷不见火，八两（12g）

【功用】疏风止痛。

【主治】外感风邪头痛。偏正头痛或巅顶作痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。

【方歌】川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌，
目昏鼻塞风攻上，正偏头痛悉能康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 辛升散疏风药众，疏风止痛力强。
- ② 头部引经用药，诸经头痛兼治。
- ③ 升散中寓有苦降，温燥中寓有寒凉。

【难点提示】

- ① 川芎在本方及四物汤、酸枣仁汤中的不同配伍意义。

川芎茶调散：辛散祛风，活血止痛。

四物汤：活血行气，调畅气血，与补血药配伍，补血不滞血，活血不伤血。

酸枣仁汤：与酸枣仁配伍一收一散，养血调肝。

- ② 薄荷在本方及地黄饮子、逍遥散、银翘散、桑菊饮中的不同配伍意义。

川芎茶调散：疏风散邪，清利头目。

地黄饮子：清轻上行，清利咽喉窍道。

逍遥散：与柴胡配伍疏肝解郁。

银翘散：疏散风热，清利咽喉。

桑菊饮：疏散上焦风热。

③ 清茶调服的意义。清茶调服，取其苦凉之性，既可上清头目，又能制约风药过于温燥与升散之弊端。

【应用要点】本方为治疗外感风邪头痛的常用方剂。以头痛，鼻塞，脉浮为辨证要点。

现代临床本方常用于偏头痛、血管神经性头痛，以及感冒、慢性鼻炎、鼻窦炎、急性慢性额窦炎、周围性神经麻痹、面神经炎、颈椎病、帕金森病、视疲劳等疾病所致头痛属外感风邪为患者。

【使用注意】

① 本方辛温药较多，凡久病气虚，血虚或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛，均非本方所宜。

② 本方应用时宜量轻微煎，以取其轻清之气上入头面而疏风。

• 大秦艽汤（《素问病机气宜保命集》）•

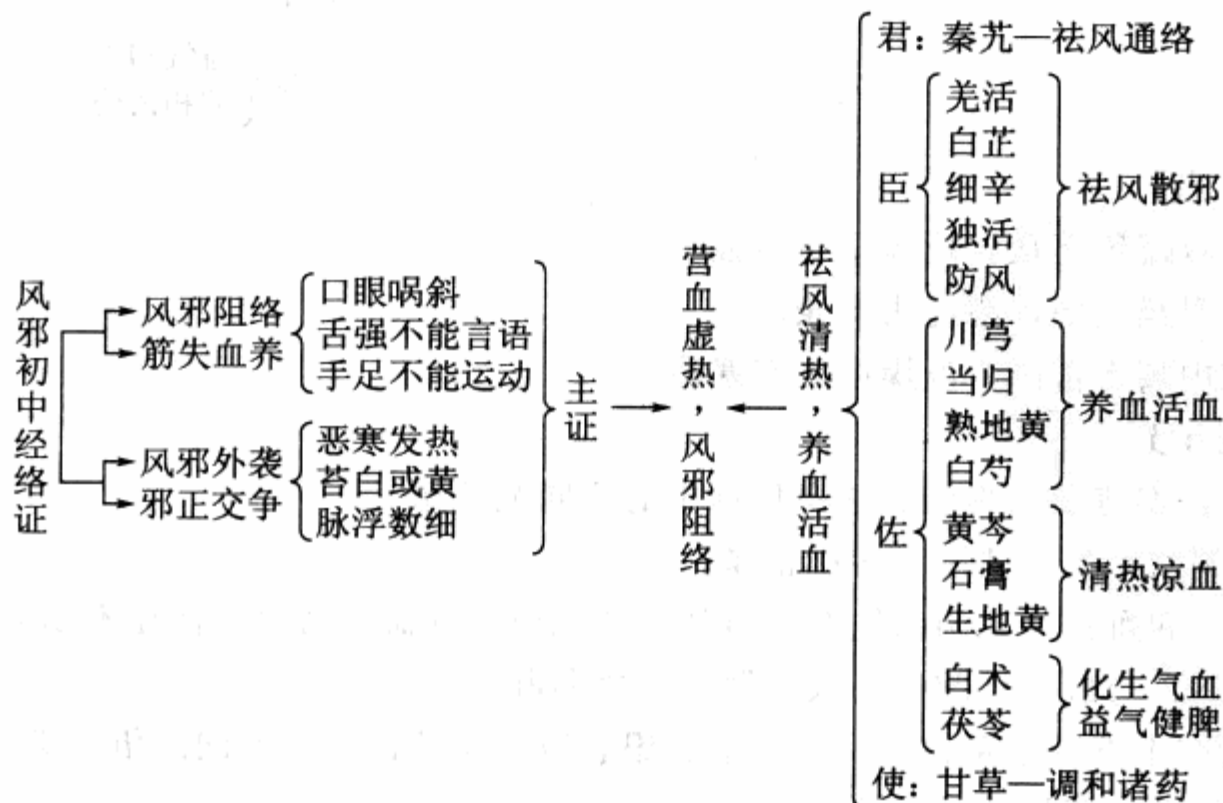
【组成】川芎 独活 当归 白芍 石膏 甘草各二两（各 6g） 秦艽三两（9g） 羌活 防风 白芷 黄芩 白术 茯苓 生地 熟地各一两（各 3g） 细辛半两（2g）

【功用】祛风清热，养血活血。

【主治】风邪初中经络证。口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动，或恶寒发热，苔白或黄，脉浮数或细。

【方歌】大秦艽汤羌独防，芎芷辛芩二地黄，
石膏归芍苓甘术，风邪散见可通尝。

【表解】



【配伍特点】

- ① 疏养结合，邪正兼顾。
- ② 治血以祛风（“先治风先治血，血行风自灭”）。
- ③ 清热以防风邪化热。

【应用要点】本方为治疗风邪初中经络证的常用方。以口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动，或恶寒发热，苔白或黄，脉浮数或细为辨证要点。

现代临床本方常用于颜面神经麻痹，以及脑血管痉挛、脑血栓形成而致的语言蹇涩、半身不遂等。风湿热痹亦可斟酌加减用之。

【使用注意】若属内风所致者，不宜应用本方。

• 小活络丹（《太平惠民和剂局方》）•

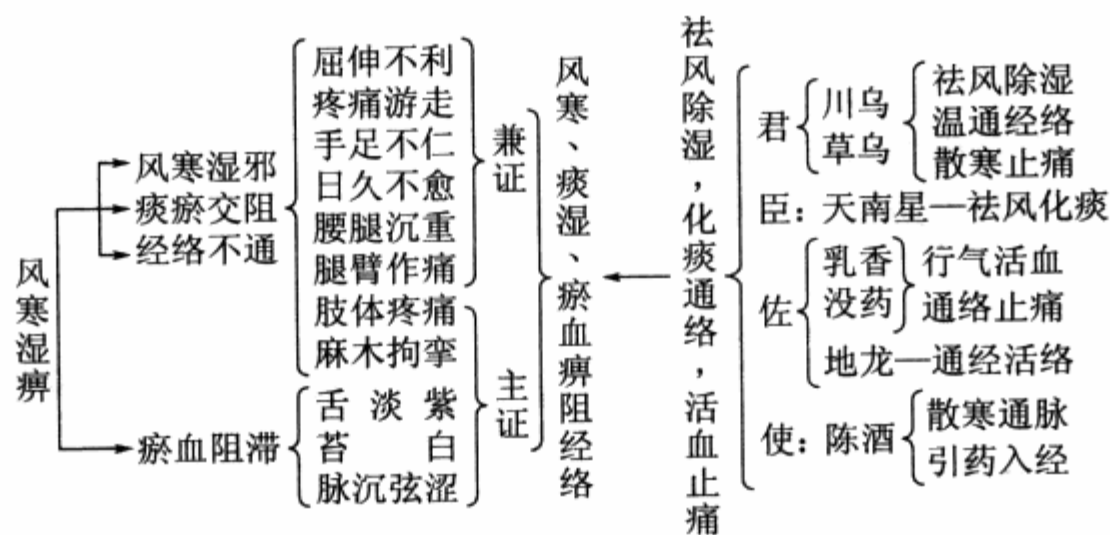
【组成】川乌炮，去皮、脐 草乌炮，去皮、脐 地龙去土 天南星炮，各六两（各6g）乳香研 没药研，各二两二钱（各5g）

【功用】祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

【主治】风寒湿痹。肢体筋脉疼痛，麻木拘挛，关节屈伸不利，疼痛游走不定，舌淡紫，苔白，脉沉弦或涩。亦治中风，手足不仁，日久不愈，经络中湿痰瘀血，而见腰腿沉重，或腿臂间作痛。

【方歌】小活络丹天南星，二乌乳没与地龙，
寒湿瘀血成痹痛，搜风活血经络通。

【表解】



【配伍特点】消散结合，峻药缓投。

【应用要点】本方为治疗风寒、痰湿、瘀血留滞经络的常用方。以筋脉挛痛，关节屈伸不利，疼痛游走不定，舌淡紫，苔白，脉沉弦或涩为辨证要点。

现代临床本方常用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎及骨质增生症等属风湿血瘀者。

【使用注意】方中药力较峻烈，以体实气壮者为宜，阴虚有热者及孕妇慎用。

• 牵正散（《杨氏家藏方》）•

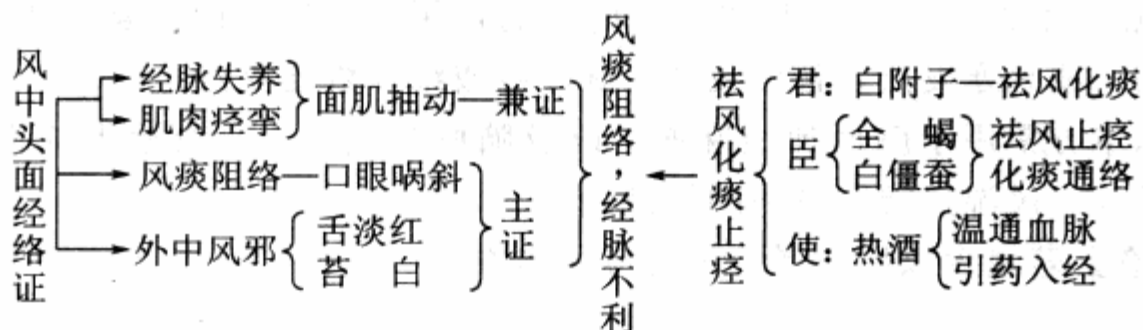
【组成】白附子 白僵蚕（各6g）全蝎去毒，并生用，各等分（3g）

【功用】祛风化痰止痉。

【主治】风中头面经络。口眼喎斜，或面肌抽动，舌淡红，苔白。

【方歌】牵正散治口眼偏，白附全蝎僵蚕研，
每服三克热酒下，风痰抽搐蜈蚣添。

【表解】



【应用要点】本方为治疗风痰阻于头面经络的常用方剂。以卒然口眼喎斜，舌淡苔白为辨证要点。

现代临床本方常用于颜面神经麻痹、三叉神经痛、偏头痛等属风痰痹阻经络者。

【使用注意】若属气虚血瘀或肝风内动引起的口眼喎斜或半身不遂者，不宜应用本方。方中附子和全蝎均为有毒之品，用量宜慎。

• 玉真散 (《外科正宗》) •

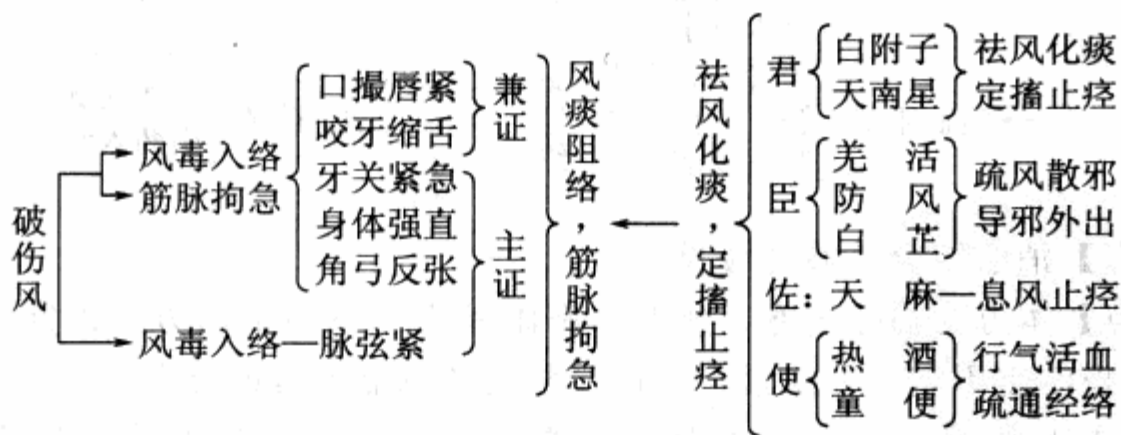
【组成】天南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子各等分 (各 6g)

【功用】祛风化痰，定搐止痉。

【主治】破伤风。牙关紧急，口撮唇紧，身体强直，角弓反张，甚则咬牙缩舌，脉弦紧。

【方歌】玉真散治破伤风，牙关紧闭反张弓，
星麻白附羌防芷，外敷内服一方通。

【表解】



【应用要点】本方为治疗破伤风的常用方。以牙关紧急，身体强直，角弓反张，脉弦紧为辨证要点。

现代临床本方常用于破伤风、面神经麻痹、三叉神经痛等属风邪袭于经络者。

【使用注意】

- ① 本方药性偏于温燥，易于耗气伤津，破伤风而见津气两虚者不宜使用。
- ② 白附子、天南星等均为有毒之品，用量宜慎，孕妇忌用。

• 消 风 散 (《外科正宗》) •

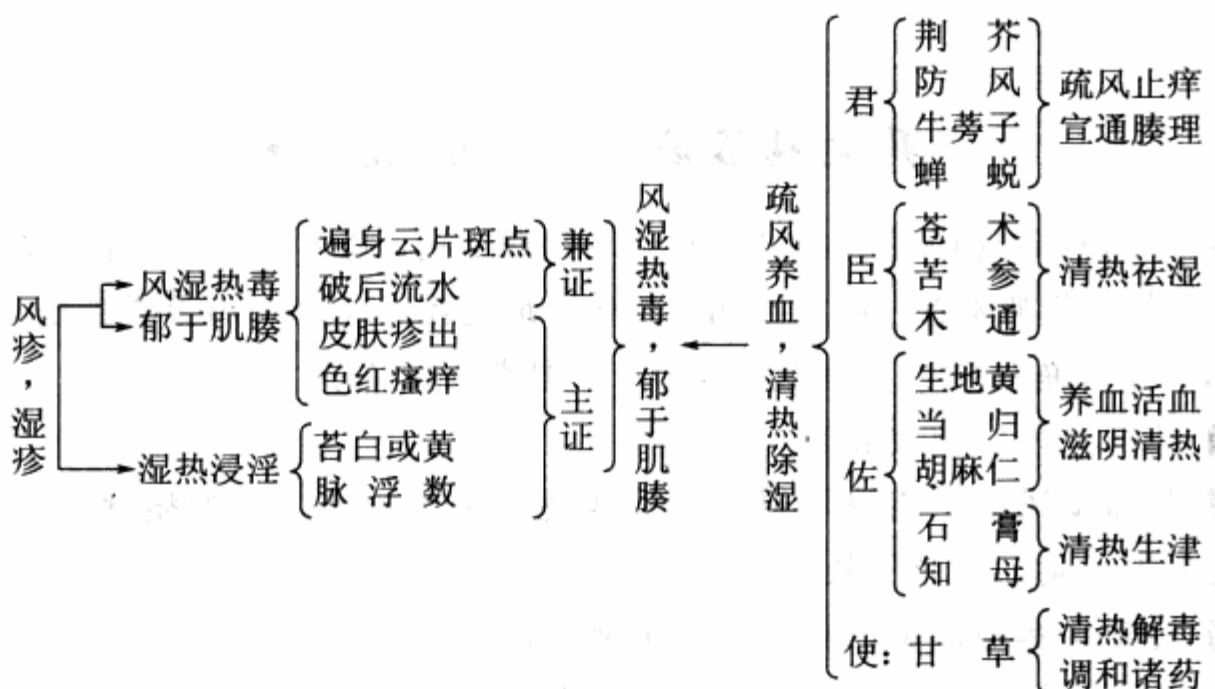
【组成】当归 生地 防风 蝉蜕 知母 苦参 胡麻仁 荆芥 苍术 牛蒡子 石膏各一钱 (各 6g) 甘草 木通各五分 (各 3g)

【功用】疏风养血，清热除湿。

【主治】风疹，湿疹。皮肤疹出色红，或遍身云片斑点，瘙痒，抓破后渗出津水，苔白或黄，脉浮数。

【方歌】消风散内有荆防，蝉蜕胡麻苦参苍，
知膏蒡通归地草，风疹湿疹服之康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 上疏下渗，使风湿上下分消。
- ② 内清外透，使热毒内外分消。
- ③ 标本兼顾，使邪去正气安和。

【难点提示】方中生地黄、当归、胡麻仁的配伍意义有四：①风热久羁，必耗伤阴血；②苦燥渗利之药亦易伤阴；③血虚易感风邪；④血虚则瘙痒更甚。基于以上原因，故配伍当归、生地黄、胡麻仁以养血活血、滋阴清热，寓“治风先治血，血行风自灭”之意。

【应用要点】本方为治疗风疹、湿疹的常用方剂。以疹出色红、瘙痒，脉浮数为辨证要点。

现代临床本方常用于湿疹、荨麻疹、药疹、急性肾炎、春季卡他性结膜炎、毒蛇咬伤、过敏性紫癜、银屑病、玫瑰糠疹、肠道易激综合征、疥疮、痤疮等疾病属外感风湿热邪之表实证。

【使用注意】

- ① 方中疏风药、祛湿药易伤阴血，故气血虚弱者不宜用本方。
- ② 使用本方，配合外用药，收效更大，但切忌用热水烫洗患处。
- ③ 服药期间不宜食辛辣厚味、海鲜鱼腥、烟酒浓茶，以免影响疗效或复发。

第二节 平息内风

平息内风剂适用于内风病证，有外感温热病热极动风及内伤病肝阳化风、阴虚动风和血虚生风等证候。症见眩晕、震颤、足废不用、语言不利或卒然昏倒、手足抽搐，口眼喎斜、半身不遂等。常以平肝息风药如钩藤、羚羊角、天麻、代赭石、龙骨、牡蛎等为主。若温邪久留，耗伤真阴，虚风内动，则见筋脉拘挛、手足蠕动、神倦、脉虚等症，治宜滋液息风，代表方如大定风珠；若肝阳偏亢，肝风内动，血气并走于上，常见头痛、眩晕、脑中热疼、面色如醉，甚则突然昏倒、口眼喎斜、半身不遂等症，治宜镇肝息风，代表方如镇肝熄风汤；若阳邪亢盛，热极动风，常见高热昏迷、四肢抽搐等症，治宜凉肝息风，代表方如羚角钩藤汤等。

• 羚角钩藤汤（《通俗伤寒论》）•

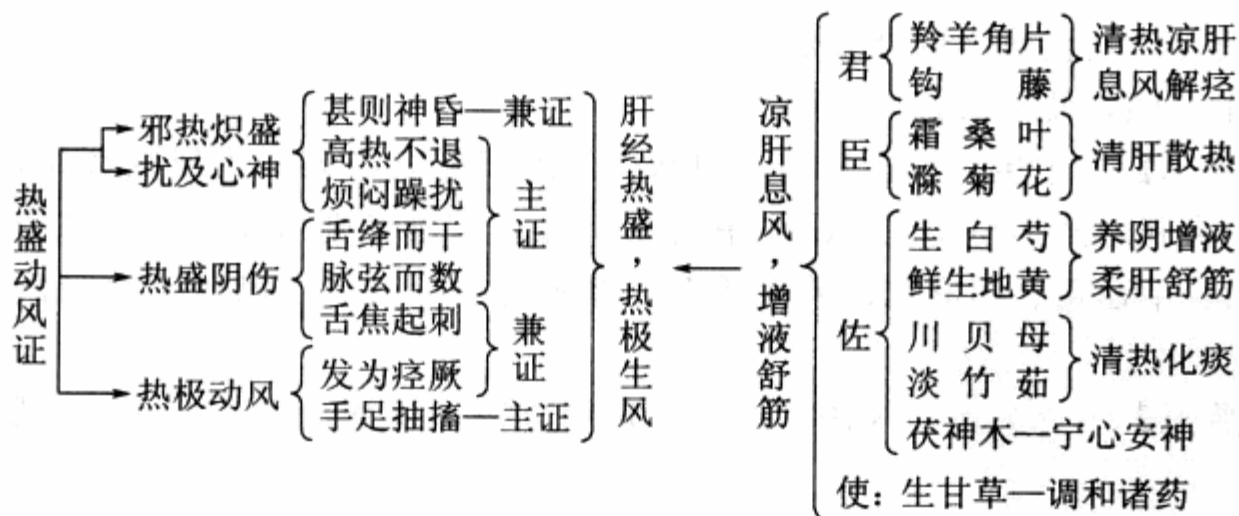
【组成】羚羊片一钱半，先煎（4.5g） 双钩藤三钱，后入（9g） 霜桑叶二钱（6g） 滁菊花 生白芍 茯神木各三钱（各 9g） 鲜生地五钱（15g） 川贝母四钱，去心（12g） 淡竹茹鲜刮，与羚羊角先煎代水，五钱（15g） 生甘草八分（3g）

【功用】凉肝息风，增液舒筋。

【主治】热盛动风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。

【方歌】羚角钩藤芍地黄，竹菊贝草茯神桑，
清肝息风止痉厥，热极生风急煎尝。

【表解】



【配伍特点】

- ① 内清外透。既清肝热，又透泄肝热。
- ② 标本兼顾。既凉肝平肝，又养阴柔肝。

【应用要点】本方为治疗热盛动风证的常用方。以高热，手足抽搐，脉弦数为辨证要点。

现代临床本方常用于出血性脑卒中、面肌痉挛、头面部带状疱疹、病毒性脑炎、偏

头痛等证属热盛动风者。

【使用注意】

- ① 热病后期阴虚风动者，不宜使用本方。
- ② 临床运用时，羚羊角可用山羊角或珍珠母代，但用量宜大。

• 镇肝熄风汤（《医学衷中参西录》）•

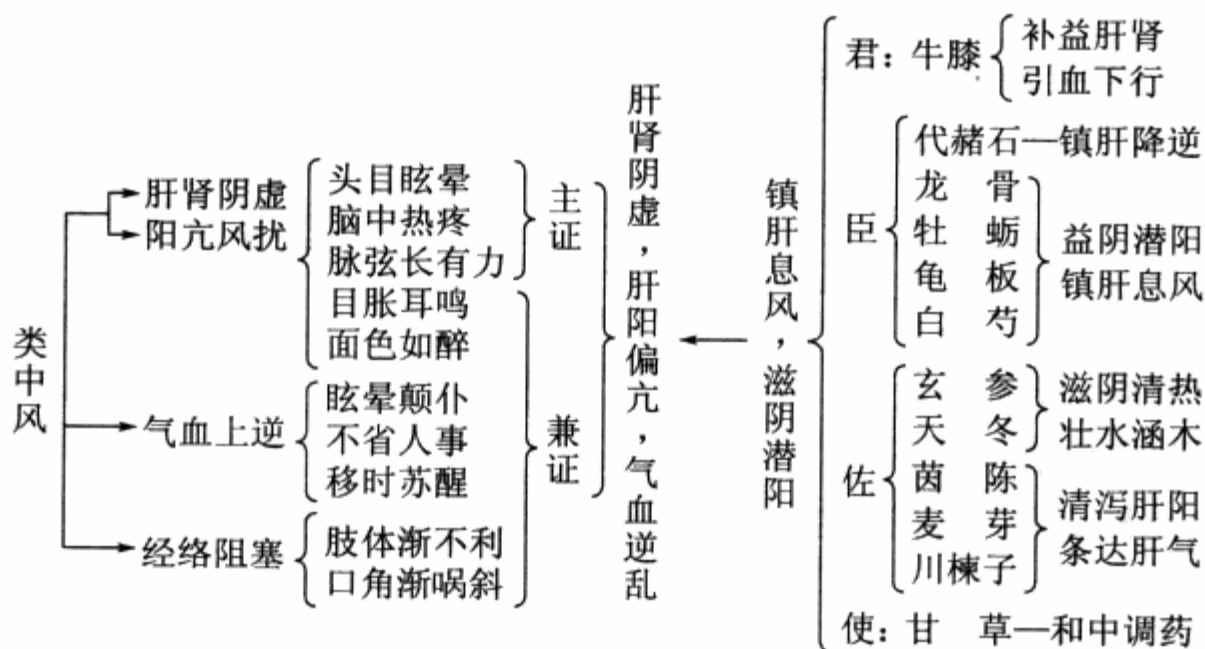
【组成】 怀牛膝一两（30g） 生赭石轧细，一两（30g） 川楝子捣碎，两钱（6g） 生龙骨五钱，捣碎（15g） 生牡蛎五钱，捣碎（15g） 生龟板五钱，捣碎（15g） 生杭芍 玄参 天冬各五钱（15g） 生麦芽 茵陈各二钱（各6g） 甘草一钱半（4.5g）

【功用】 镇肝息风，滋阴潜阳。

【主治】 类中风。头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，或时常噫气，或肢体渐觉不利，口角渐形喎斜；甚或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒；或醒后不能复原，脉弦长有力者。

【方歌】 镇肝熄风赭牡龙，玄芍龟板膝天冬，
茵陈川楝麦芽草，擅治阳亢息内风。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，重在治标。
- ② 镇肝疏肝，顺应肝木。

【难点提示】 茵陈、麦芽、川楝子的配伍意义为：肝为刚脏，性喜条达而恶抑郁，方中用重镇降逆之品，势必影响其条达疏泄之性，不利于肝阳平降及气血恢复，则“转激发其反动之力”、“转觉气血上攻而病加剧”。根据《黄帝内经》“甚者从之”的原则，运用“从治”方法，故用茵陈、麦芽（张锡纯认为二者可条达肝气）、川楝子，既能疏肝理气，条达肝气，以遂其性，又能清泻肝热。

【应用要点】 本方为治疗类中风的常用方。以头目眩晕，脑部热痛，面色如醉，脉弦长有力为辨证要点。

现代临床本方常用于高血压、脑血栓形成、脑出血、血管神经性头痛等属于肝肾阴

虚，肝风内动者。

【使用注意】若属气虚血瘀之风，则不宜使用本方。

• 天麻钩藤饮（《中医内科杂病证治新义》）•

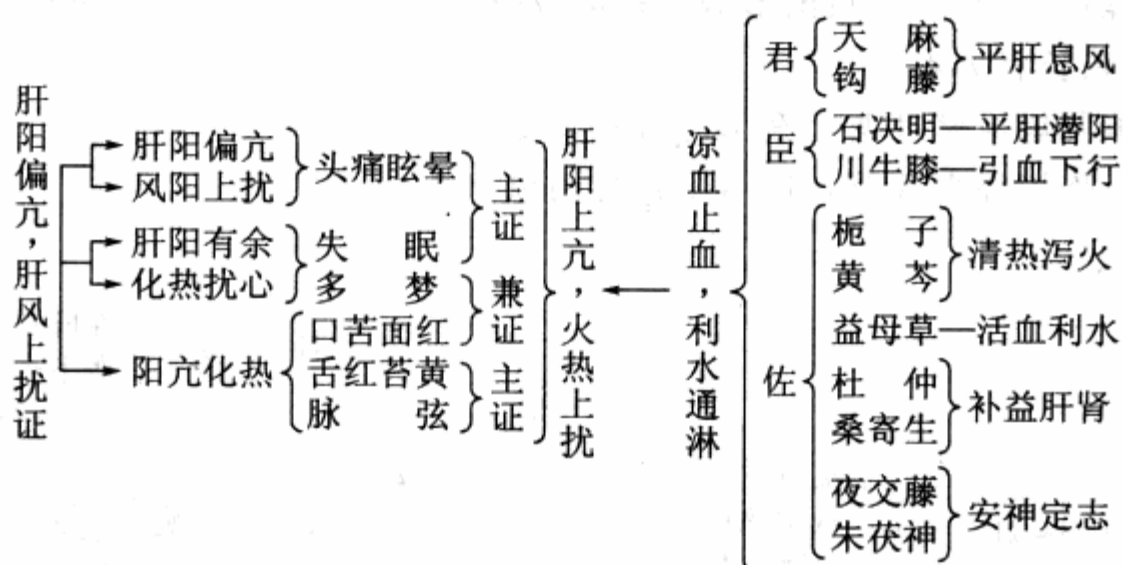
【组成】天麻 栀子 黄芩 杜仲 益母草 桑寄生 夜交藤 朱茯神（各 9g）
川牛膝（12g） 钩藤后下（12g） 石决明先煎（18g）

【功用】平肝息风，清热活血，补益肝肾。

【主治】肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦。

【方歌】天麻钩藤石决明，寄生益母夜交藤，
牛膝杜仲芩芩栀，阳亢头痛与眩晕。

【表解】



【配伍特点】

① 标本兼治，治标为主。

② 辨证与辨病结合用药。

【应用要点】本方为肝阳偏亢，肝风上扰的常用方。以头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于高血压病属肝阳上亢者。

• 大定风珠（《温病条辨》）•

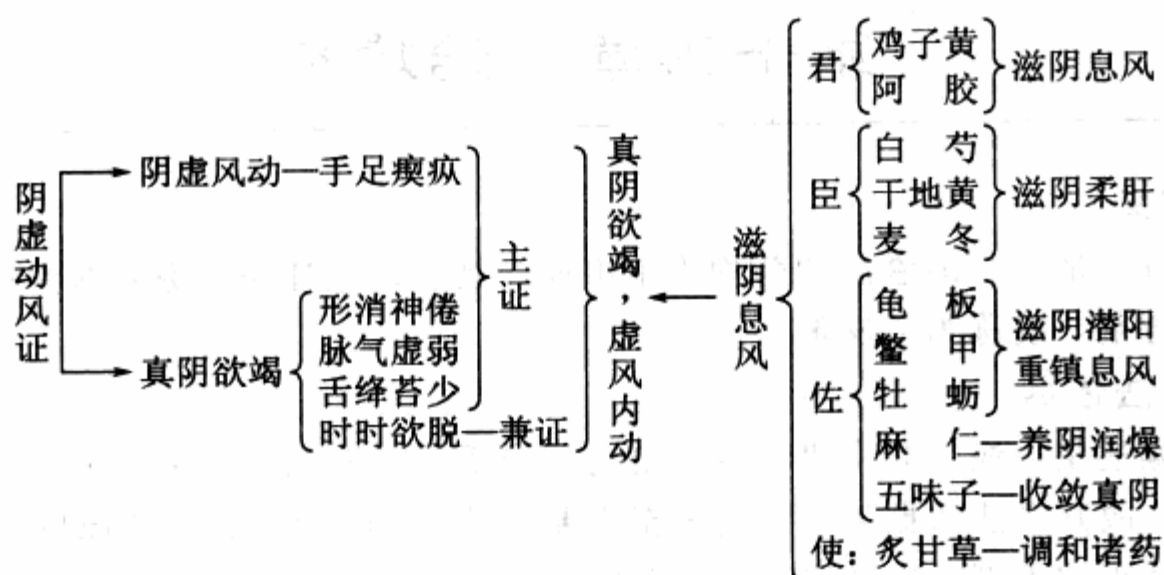
【组成】生白芍 干地黄各六钱（各 18g） 麦冬连心，六钱（各 18g） 麻仁 五味子各二钱（各 6g） 生龟板 生牡蛎 甘草炙 鳖甲生，各四钱（各 12g） 阿胶 三钱（9g） 鸡子黄生，二枚（2 个）

【功用】滋阴息风。

【主治】阴虚动风证。温病后期，手足瘛疔，形消神倦，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者。

【方歌】大定风珠鸡子黄，牡蛎鳖甲龟地黄，
胶芍麦味麻仁草，滋阴息风是良方。

【表解】



【配伍特点】

① 滋阴与（酸甘）化阴并用以填补真阴，重在治本。

② 酸收与潜降兼施，既防真阴脱散，又能潜降风阳。

【应用要点】本方为治疗温病后期，真阴大亏，虚风内动的常用方。以神倦痿痹，脉虚弱，舌绛苔少为辨证要点。

现代临床本方常用于乙脑后遗症、眩晕、放疗后舌萎缩、甲状腺功能亢进及其术后手足抽搐、神经性震颤等属阴虚动风者。

第十四章 治燥剂

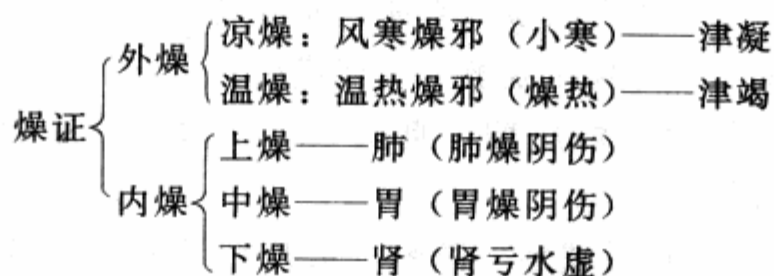
一、定义

凡以轻宣辛散或甘凉滋润的药物为主组成，具有轻宣外燥或滋阴润燥等作用，用于治疗燥证的方剂，统称为治燥剂。

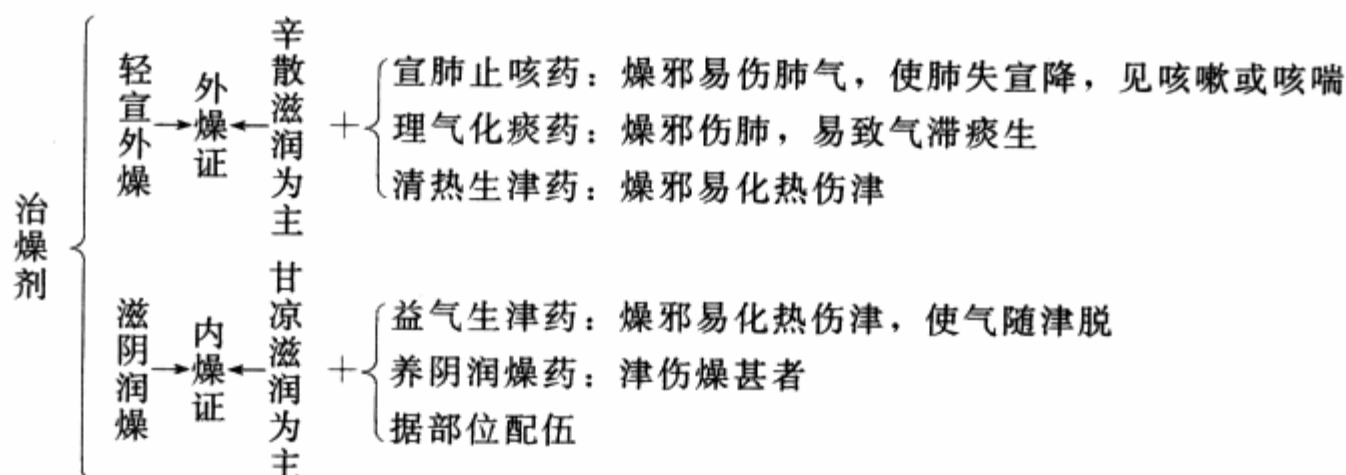
二、立法依据

不管外燥还是内燥，其病机特点主要为津液受损，即《素问·阴阳应象大论》所谓“燥甚则干”，故其立法依据为《素问·至真要大论》“燥者润之”的原则，主要采用濡润的方法，体现“十剂”中“湿可去枯”的方法。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

① 分清外燥与内燥。外燥当分温燥抑或凉燥，内燥则应分上燥、中燥或（和）下燥，之后确定治法，选方用药。因人体内外、脏腑相互联系，故在临床上亦多相互影响，如外感温燥兼有上燥之证，上燥和下燥合病等。故需根据病情，灵活掌握。

② 滋阴润燥剂用药多为滋腻之品，易于助湿碍气，故素体多湿、脾虚便溏以及气滞痰盛者应慎用或忌用。

③ 由于温燥之邪易伤津耗气，故治疗上宜配伍甘寒清热或益气生津之品。此外，辛香药物易耗津、苦寒药物易化燥，故治燥病时应慎用。

第一节 轻宣外燥

轻宣外燥剂适用于外感凉燥或温燥之证。凉燥属次寒、小寒，凉燥犯肺，则肺气不宜，津液不布，症见头痛恶寒、咳嗽痰稀、鼻塞咽干、舌苔薄白。常以苦辛温润药为主，配伍宣肺止咳、理气化痰之品组方，药用苏叶、杏仁、前胡、陈皮等，代表方如杏

苏散。温燥属热，易耗津灼液，常使肺失清肃之令，症见头痛身热、干咳少痰或气逆而喘、口渴鼻燥、舌边尖红、苔薄白而燥。常以辛凉甘润药物为主，配伍止咳化痰、生津止渴、清热泻火药组方，药用桑叶、薄荷、天花粉、石膏、知母、黄芩等，代表方如桑杏汤、清燥救肺汤。

• 杏 苏 散（《温病条辨》）•

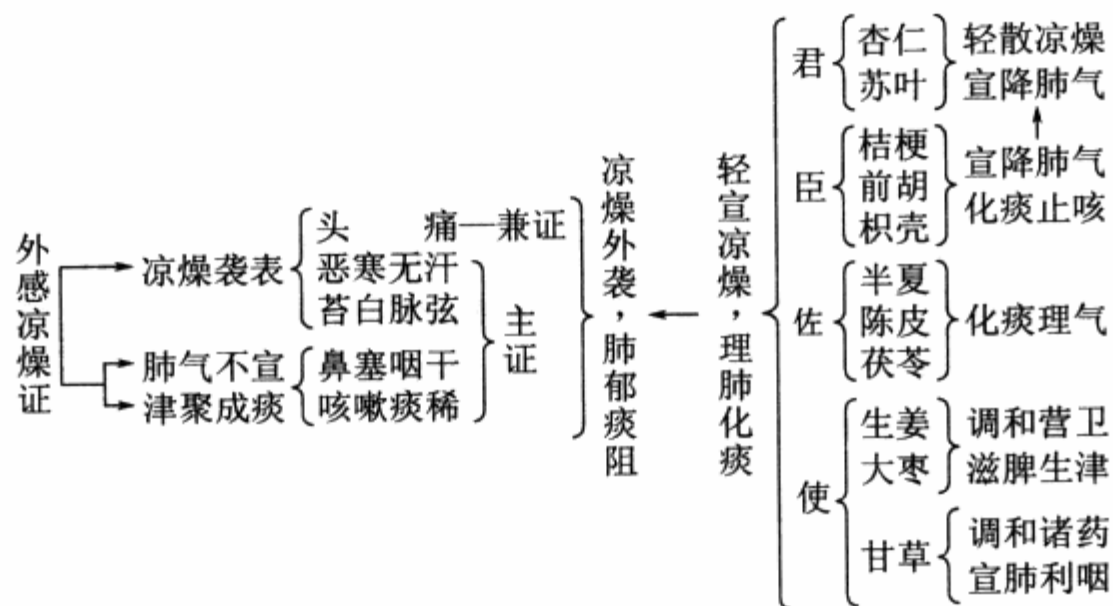
【组成】 苏叶 杏仁 半夏 茯苓 前胡（各 9g） 橘皮 苦桔梗 枳壳（各 6g）
甘草 生姜（各 3g） 大枣（3 枚）

【功用】 轻宣凉燥，理肺化痰。

【主治】 外感凉燥证。头痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。

【方歌】 杏苏散内夏陈前，枳桔苓草姜枣研，
轻宣温润治凉燥，咳止痰化病自痊。

【表解】



【配伍特点】

- ① 辛甘苦温并用。
- ② 表里同治，外可轻宣发表而解凉燥，内可理肺化痰而止咳嗽。

【难点提示】 本方主治凉燥证，本应“濡润”，而方中为何用辛香温燥之品？

凉燥属“次寒”、“小寒”，较“严冬风寒为轻”，凉燥犯肺，则肺气不宣，津液不布，凝聚成痰，其本质在于“津液凝聚”，与一般燥邪之“津液枯竭”有本质区别。故用药重在用辛香温燥药物，轻宣达邪，燥湿化痰，以利于津液布散，不宜养阴润燥。证似小青龙汤“外寒内饮”，但较轻，故吴鞠通谓本方“减小青龙汤一等”即为此意。

【应用要点】 本方为治疗外感凉燥证的代表方剂。以恶寒无汗，咳嗽痰稀，咽干，苔白，脉弦为辨证要点。

现代临床本方常用于流行性感、慢性支气管炎、支气管扩张、肺气肿等属外感凉燥（或外感风寒轻证），肺气不宣，痰湿内阻者。

【使用注意】 本方辛温，只宜于凉燥和风寒表证，不宜于风温，也不能作为四时伤风咳嗽通用之方。

• 桑 杏 汤 (《温病条辨》) •

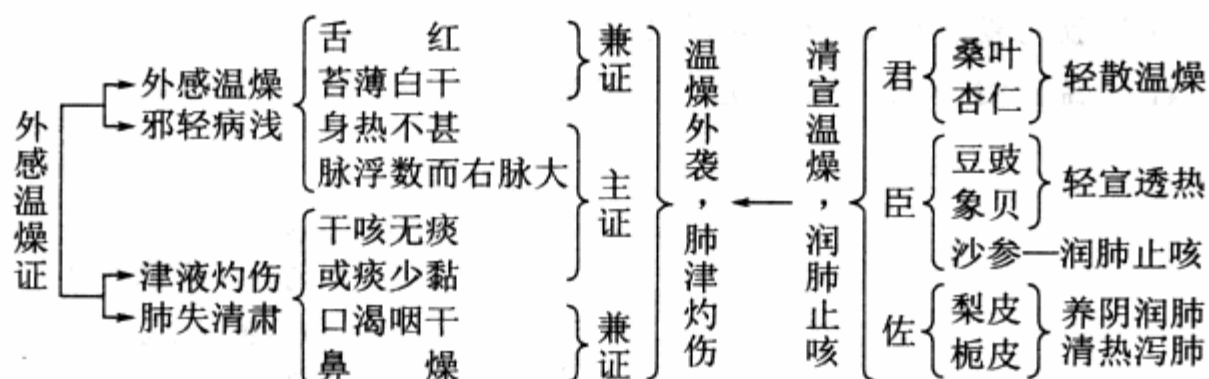
【组成】桑叶 象贝 香豉 栀皮 梨皮各一钱 (各 3g) 杏仁一钱五分 (5g) 沙参二钱 (6g)

【功用】清宣温燥，润肺止咳。

【主治】外感温燥证。身热不甚，口渴，咽干鼻燥，干咳无痰或痰少而黏，舌红，苔薄白而干，脉浮数而右脉大者。

【方歌】桑杏汤中象贝宜，沙参栀豉与梨皮，
干咳鼻燥右脉大，辛凉甘润燥能医。

【表解】



【配伍特点】外可轻宣燥热，内可凉润肺金，体现辛凉甘润之法。

【应用要点】本方为治疗温燥外袭，肺燥咳嗽之轻证的常用方。以病发初秋炎热干燥季节，身微热，干咳无痰，或痰少而黏，脉浮数为辨证要点。

现代临床本方常用于上呼吸道感染、急性支气管炎、肺炎、百日咳、支气管扩张咯血和硅沉着病等属外感温燥，灼伤肺津者。

【使用注意】

① 用量宜轻。“轻药不得重用”，“重用必过病所”。适宜于邪气轻浅病证，而肺药亦宜轻清。

② 脾虚有湿者慎用。

③ 不宜配黄芩、黄连等苦燥之品。

【类方比较】

桑杏汤与桑菊饮比较表

比较 \ 方名		桑 杏 汤	桑 菊 饮
组成	同	桑叶、杏仁	
	异	象贝、香豉、栀皮、梨皮、沙参	菊花、连翘、桔梗、苇根、薄荷、甘草
功用	同	宣散热邪	
	异	轻宣温燥，凉润肺金。体现辛凉甘润法	疏散风热，宣肺止咳。体现辛凉解表法
主治	同	外感温邪咳嗽，受邪轻浅，身热不甚、口渴、脉数	
	异	外感温燥，津伤较甚。口渴明显，咽干鼻燥	风温初起，津伤不甚。但咳嗽明显，口微渴

桑杏汤与杏苏散比较表

比较 \ 方名		桑 杏 汤	杏 苏 散
组成	同	杏仁	
	异	桑叶、象贝、香豉、梔皮、梨皮、沙参	苏叶、半夏、茯苓、前胡、橘皮、桔梗、枳壳、甘草、生姜、大枣
功用	同	轻宣外燥	
	异	轻宣温燥，凉润肺金。体现辛凉甘润法	轻宣凉燥，理肺化痰。体现辛温甘苦法
主治	同	外燥咳嗽	
	异	外感温燥证。为温燥外袭，肺津灼伤。症见身微热干咳无痰，或痰少而黏，脉浮数	外感凉燥证。为凉燥外袭，肺郁痰阻。症见恶寒无汗，咳嗽痰稀，咽干，苔白，脉弦

• 清燥救肺汤（《医门法律》） •

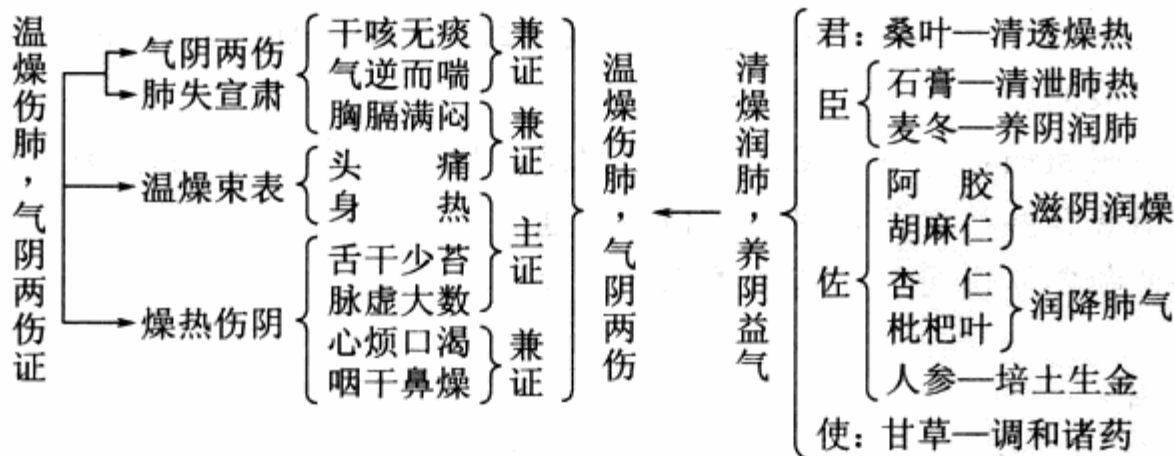
【组成】桑叶经霜者，去枝、梗，三钱（9g） 石膏煨，两钱五分（8g） 甘草一钱（3g） 胡麻仁炒，研，一钱（3g） 人参七分（2g） 真阿胶八分（3g） 麦门冬去心，一钱二分（4g） 杏仁泡，去皮尖，炒黄，七分（2g） 枇杷叶一片，刷去毛，蜜涂，炙黄（3g）

【功用】清燥润肺，养阴益气。

【主治】温燥伤肺，气阴两伤证。头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，胸膈满闷，舌干少苔，脉虚大而数。

【方歌】清燥救肺桑石膏，参麦麻仁杷叶草，
阿胶烊化频热服，甘寒滋润退温燥。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清宣肺燥，以解外邪。
- ② 甘寒濡润，以治肺燥。
- ③ 苦而润降，以治痰郁。
- ④ 培土生金，以复气津。

【应用要点】本方为治疗燥热伤肺重证的常用方剂。以身热，干咳少痰，气逆而喘，舌红少苔，脉虚大而数为辨证要点。

现代临床本方常用于治疗急性呼吸道感染、放射性肺炎、咯血、蘑菇肺、反复发作型肺炎喘嗽、燥咳、喉痹、失音等属燥热伤肺，气阴两伤者。

【类方比较】

桑杏汤与清燥救肺汤比较表

比较 \ 方名		桑 杏 汤	清燥救肺汤
组成	同	桑叶、杏仁	
	异	象贝、香豉、梔皮、梨皮、沙参	石膏、甘草、胡麻仁、人参、阿胶、麦冬、枇杷叶
功用	同	清燥润肺	
	异	轻宣清透，凉润肺金	清宣润肺，益气养阴
主治	同	温燥伤肺，津液损伤	
	异	外感温燥，伤及肺卫，肺津灼伤轻证。症见身热，咳嗽不甚，右脉数大	燥热伤肺，卫气同病，气阴两伤重证。症见气逆而喘，胸膈满闷，脉虚大而数

第二节 滋 阴 润 燥

滋阴润燥剂适应于脏腑津伤液耗的内燥证。内燥证或由汗、吐、下重伤津液，或由久病精血大虚，或由感受温邪化燥伤阴所致。治宜甘寒滋润以补损耗之阴液，常以玄参、生地黄、麦冬等养阴增液药为主组方，代表方如增液汤、麦门冬汤、益胃汤、养阴清肺汤、百合固金汤。

• 增 液 汤（《温病条辨》） •

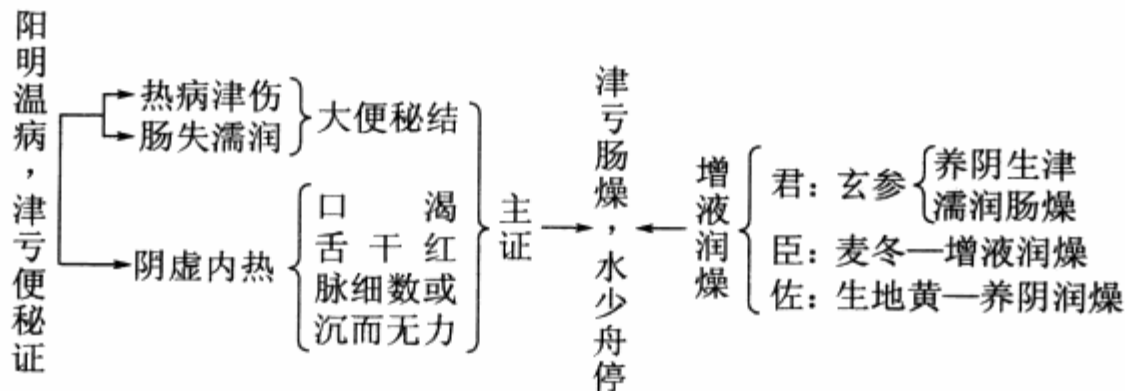
【组成】玄参一两（30g） 麦冬连心，八钱（24g） 细生地八钱（24g）

【功用】增液润燥。

【主治】阳明温病，津亏便秘证。大便秘结，口渴，舌干红，脉细数或沉而无力者。

【方歌】增液玄参与地冬，热病津枯便不通，
补药之体作泻剂，若非重用不为功。

【表解】



【配伍特点】

① 咸寒甘苦同用，共奏滋养肺肾与生津润肠之功。

② 寓泻于补，以补药之体为泻药之用，旨在增水行舟，而非攻下。

【难点提示】增水行舟是指用滋阴增液的药物组成方剂，以润滑肠道、导下便结，用于阴亏液枯之便秘证的一种治疗方法。增液汤中以大剂量的玄参、生地黄、麦冬滋阴增液，使热结液枯的粪便得以自下，犹如水涨则舟行通畅，故名。

【应用要点】本方为治疗津亏肠燥便秘的常用方，也为阴虚津亏的基础方。以便秘，口渴，舌干红，脉细数或沉而无力为辨证要点。

现代临床本方常用于肛裂、慢性牙周炎、慢性咽喉炎、复发性口腔溃疡、糖尿病等属阴津不足者。

• 麦门冬汤（《金匱要略》）•

【组成】麦门冬七升（70g） 半夏一升（10g） 粳米三合（5g） 人参三两（6g） 甘草二两（6g） 大枣十二枚（4枚）

【功用】润肺益胃，降逆下气。

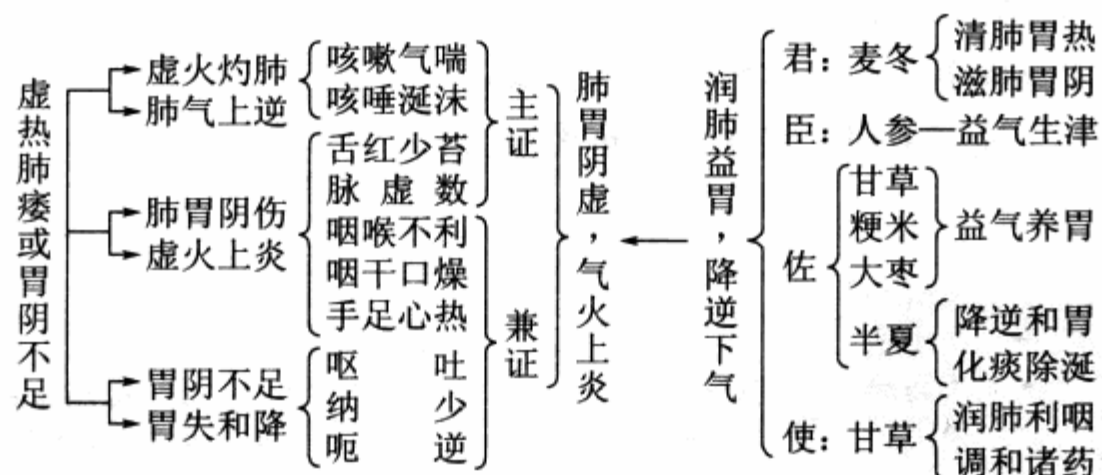
【主治】

① 虚热肺痿。咳嗽气喘，咽喉不利，咳痰不爽，或咳唾涎沫，咽干口燥，手足心热，舌干红少苔，脉虚数。

② 胃阴不足。呕吐，纳少，呃逆，口渴咽干，舌红少苔，脉虚数。

【方歌】麦门冬汤肺痿疗，半参草米与大枣，

培土生金益气津，降火除烦逆自消。

【表解】**【配伍特点】**

① 培土生金。

② 润燥结合，滋而不膩，燥不伤津。

【难点提示】

(1) 培土生金法 概念见补益剂参苓白术散。本方用人参、甘草、粳米、大枣益胃生津，胃津充足，自能上归于肺，以生肺气，故有“培土生金”之意。

体现“培土生金”法方剂小结：参苓白术散、清燥救肺汤、麦门冬汤。

(2) 麦冬与半夏的配伍意义 方中麦冬与半夏的比例为 7:1。即少用半夏以降逆和胃、化痰除涎。肺气上逆者得之，可化其痰；胃气上逆者得之，可和其胃。但其为温燥之品，与大量麦冬配伍，可制其温燥，而存其降逆和胃、化痰除涎之用，则无伤津之弊，故半夏得麦冬则温而不燥，麦冬得半夏则滋而不腻。如此配伍，温而不燥，滋而不腻，润降相宜。

(3) 半夏在本方及小青龙汤、小柴胡汤、半夏泻心汤、温经汤中的配伍意义。

麦门冬汤：降逆下气，化痰除涎。

小青龙汤：燥湿化痰，和胃降逆。

小柴胡汤：和胃降逆止呕。

半夏泻心汤：辛开苦降，散结除痞。

温经汤：通降胃气而散结，有助于祛瘀调经。

【应用要点】 本方为治疗肺胃阴虚，气机上逆所致咳嗽或呕吐的常用方。以咳唾涎沫，短气喘促，舌干红少苔，脉虚数为辨证要点。

现代临床本方常用于治疗慢性支气管炎、支气管扩张、慢性咽喉炎、硅沉着病、肺结核等属肺胃阴虚，气火上逆者。亦治胃及十二指肠溃疡、慢性萎缩性胃炎属胃阴不足，气逆呕吐者。

• 益胃汤（《温病条辨》）•

【组成】 沙参三钱（9g） 麦冬五钱（15g） 冰糖一钱（3g） 细生地五钱（15g） 玉竹炒香，钱五分（4.5g）

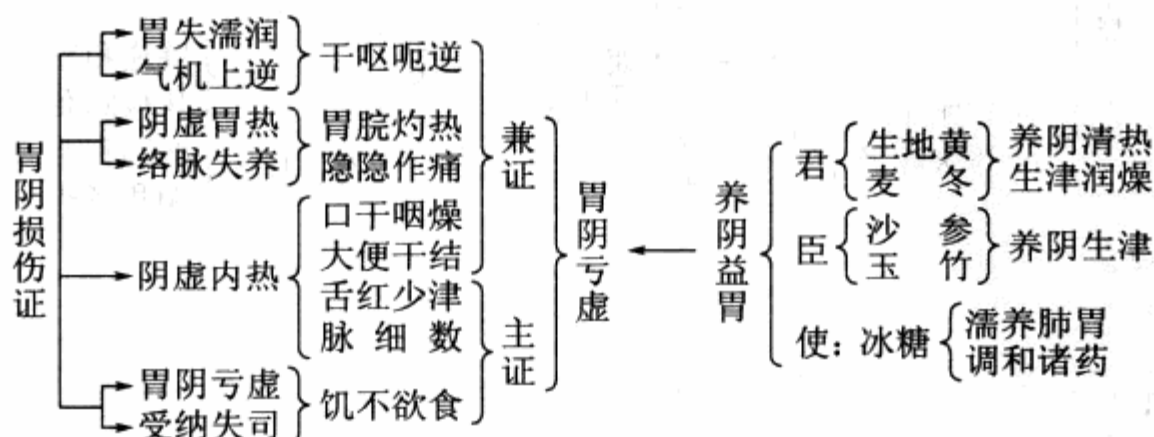
【功用】 养阴益胃。

【主治】 胃阴损伤证。胃脘灼热隐痛，饥不欲食，口干咽燥，大便干结，或干呕、呃逆，舌红少津，脉细数者。

【方歌】 益胃汤能养胃阴，冰糖玉竹与沙参，

麦冬生地同煎服，温病须虑热伤津。

【表解】



【配伍特点】 甘凉清润，清而不寒，润而不腻。

【应用要点】 本方为滋养胃阴的常用方。以饥不欲食，口干咽燥，舌红少津，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃炎、糖尿病、小儿厌食症等属胃阴亏损者，均可加减应用。

• 养阴清肺汤（《重楼玉钥》）•

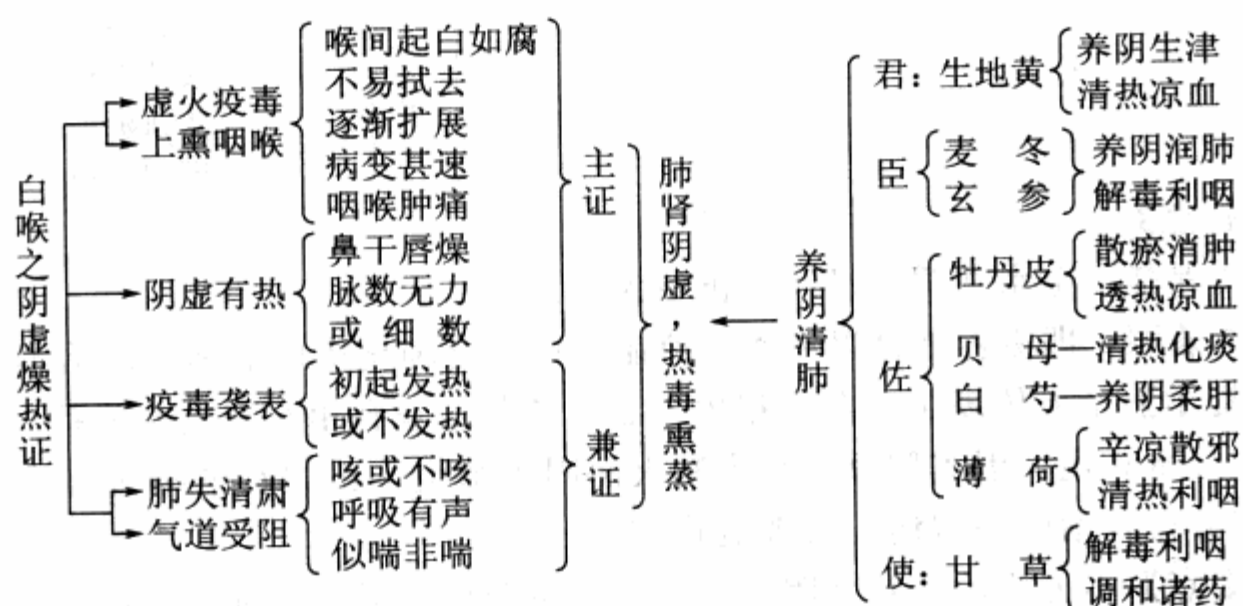
【组成】大生地二钱（12g） 生甘草 薄荷各五分（各3g） 贝母去心 丹皮 白芍各八分（5g） 麦冬一钱二分（9g） 玄参钱半（9g）

【功用】养阴清肺。

【主治】白喉之阴虚燥热证。喉间起白如腐，不易拭去，并逐渐扩展，病变甚速，咽喉肿痛，初起发热，或不发热；鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，似喘非喘，脉数无力或细数。

【方歌】养阴清肺玄地冬，丹贝薄芍甘草同，
白喉初起体阴虚，慢性咽炎亦常用。

【表解】



【配伍特点】邪正兼顾。即养肺肾之阴以扶其本；凉血解毒、散邪利咽以祛其邪。

【应用要点】本方为治疗阴虚白喉的常用方剂。以喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，鼻干唇燥，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性扁桃体炎、急性咽喉炎、鼻咽癌等属阴虚燥热者。

• 百合固金汤（《慎斋遗书》）•

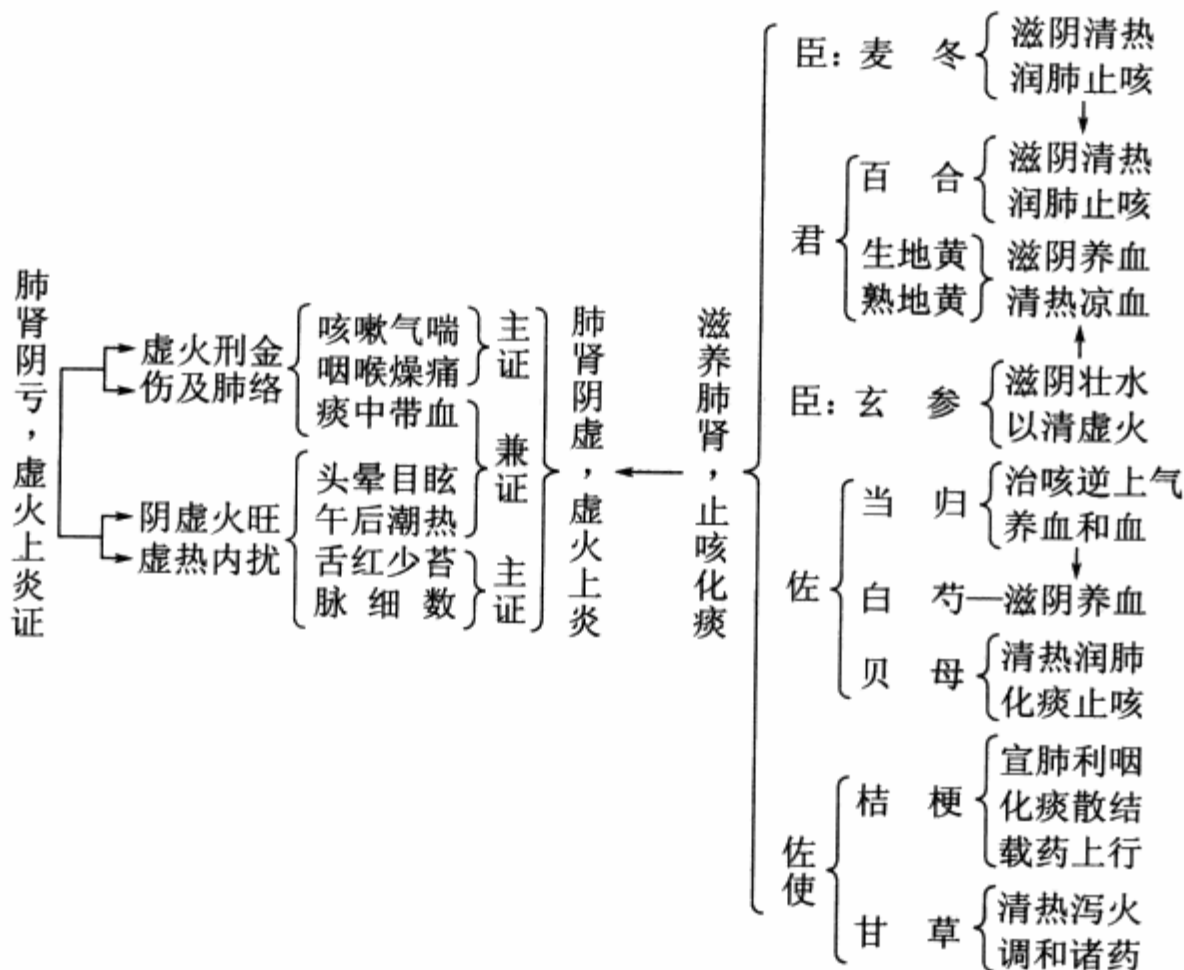
【组成】百合一钱半（12g） 麦冬一钱半（9g） 贝母（6g） 熟地 生地 当归身各三钱（各9g） 白芍 甘草各一钱 桔梗（6g） 玄参各八分（3g）

【功用】滋养肺肾，止咳化痰。

【主治】肺肾阴亏，虚火上炎证。咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛，头晕目眩，午后潮热，舌红少苔，脉细数。

【方歌】百合固金玄归冬，两地贝芍桔草同，
滋阴润肺祛痰热，喘咳咯血咽燥痛。

【表解】



【配伍特点】

- ① 滋肾保肺，金水并调，以润肺止咳为主。
- ② 标本兼顾，即滋养肺肾以治本，凉血止血，宣肺化痰以治标，以治本为主。

【难点提示】本方体现了“金水相生”法。肺肾二脏有相互滋生的关系，金可生水，水可润金，金水相生，但其侧重于壮水制火而固护肺金，正如费伯雄所言：“此方金水相生，又兼养血，治肺伤咽痛失血者最宜。”

【应用要点】本方为治疗肺肾阴亏，虚火上炎而致咳嗽痰血证的常用方剂。以咳嗽，咽喉燥痛，舌红少苔，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于肺结核、慢性支气管炎、支气管扩张咯血、慢性咽喉炎、自发性气胸等属肺肾阴虚者。

【类方比较】

百合固金汤与养阴清肺汤比较表

比较		方名	百合固金汤	养阴清肺汤
组成	同		生地黄、麦冬、玄参、白芍、贝母、甘草	
	异		百合、桔梗、熟地黄、当归	薄荷、贝母、牡丹皮
功用	同		滋肾润肺，清降虚火	
	异		重在滋肾阴、降虚火，兼以化痰止咳，体现金水相生	重在滋阴清热、解毒利咽，兼以清热祛邪
主治	同		肺肾阴虚，虚火上炎证	
	异		肺肾阴虚，虚火上炎，灼伤肺络之咳痰带血证。症见咳嗽，咽喉燥痛，舌红少苔，脉细数	肺肾阴虚，复感疫毒之白喉或阴虚燥热之咽喉肿痛证。症见喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，鼻干唇燥，脉数

第十五章 祛湿剂

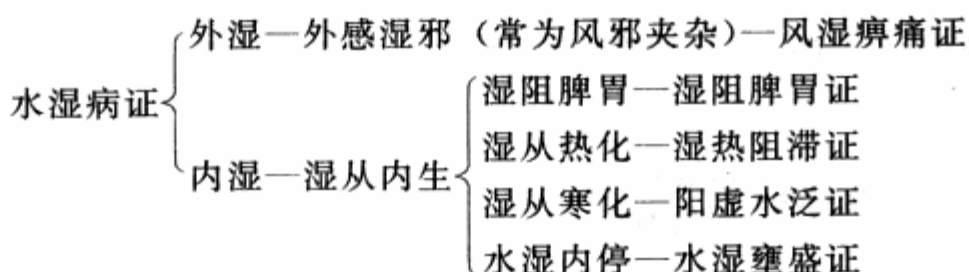
一、定义

凡以祛湿药物为主组成，具有化湿行水、通淋泄浊作用，治疗水湿病证的方剂统称为祛湿剂。属于“八法”中“消法”范畴。

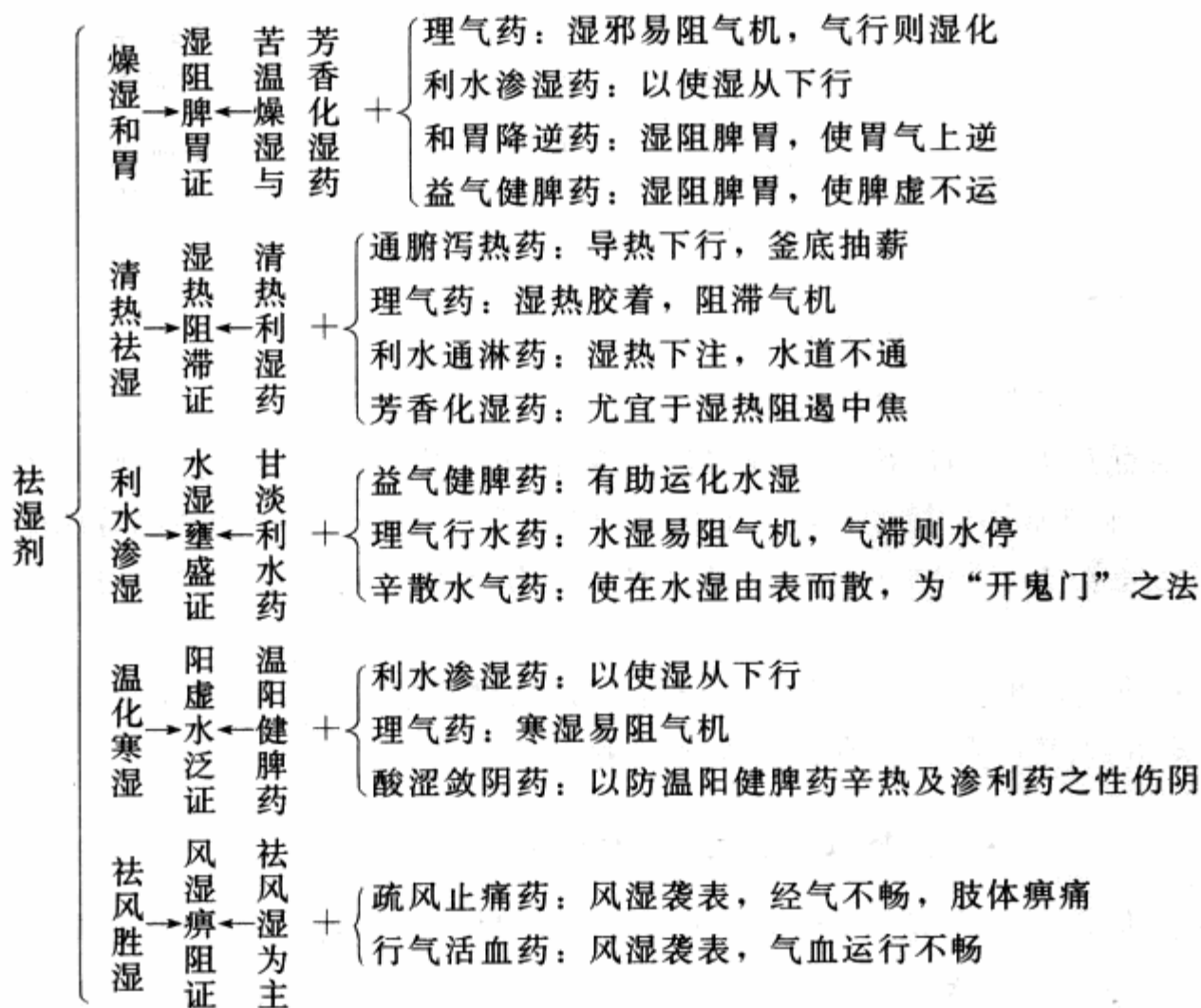
二、立法依据

湿邪伤人，常与风、寒、暑、热相兼，人体又有虚实强弱之分，所犯部位又有表里上下之别，病情亦有寒化、热化之异。因此，湿邪为病较为复杂，祛湿之法亦种类繁多。大抵湿邪在外在上者，可表散微汗以解之；在内在下者，可芳香苦燥以化之，或甘淡渗利以除之；水湿壅盛，形气俱实者，又可攻下以逐之；从寒化者，宜温阳化湿；从热化者，宜清热祛湿；体虚湿盛者，又当祛湿与扶正兼顾。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

本章方剂多属辛香温燥或甘淡渗利之品，易耗伤阴津。素体阴虚、病后体弱，以及孕妇等均应慎用。

第一节 燥湿和胃

燥湿和胃适用于湿浊阻滞，脾胃失和证。症见脘腹胀满，暖气吞酸，呕吐泄泻，食少体倦。常用苦温燥湿与芳香化湿药物，如苍术、陈皮、藿香、白豆蔻等组成方剂，其代表方如平胃散、藿香正气散等。

• 平胃散（《太平惠民和剂局方》）•

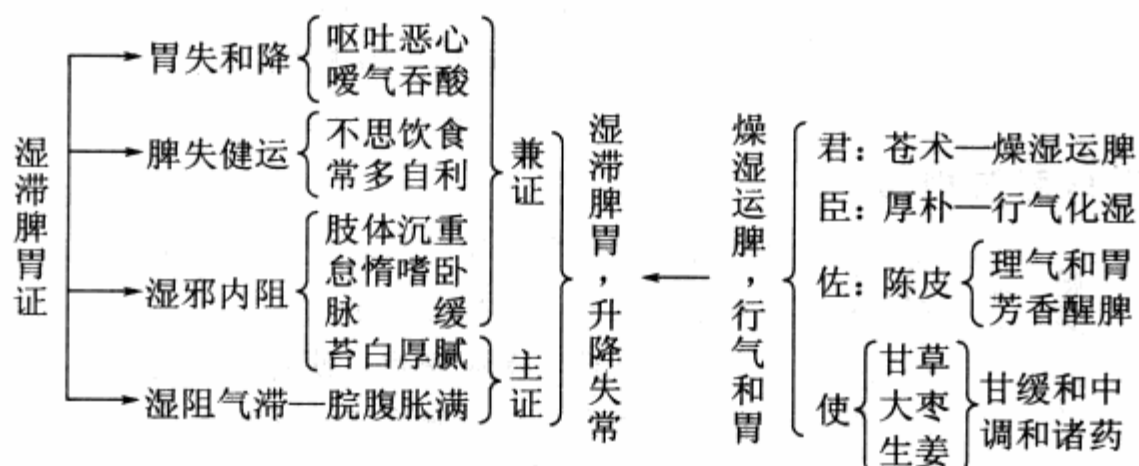
【组成】苍术去粗皮，米泔浸二日，五斤（15g） 厚朴去粗皮，姜汁制，炒香 陈皮去白，各三斤二两（各 9g） 甘草锉，炒，三十两（6g）

【功用】燥湿运脾，行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。脘腹胀满，怠惰嗜卧，不思饮食，呕吐恶心，暖气吞酸，肢体沉重，常多自利，舌苔白腻而厚，脉缓。

【方歌】平胃散用朴陈皮，苍术甘草姜枣齐，
燥湿运脾除胀满，调胃和中此方宜。

【表解】



【配伍特点】

- ① 燥湿与行气并用，以燥湿为主。
- ② 运脾与和胃兼顾，以运脾为主。

【应用要点】本方为治疗湿滞脾胃证的基础方。以脘腹胀满，舌苔厚腻为辨证要点。现代临床本方常用于慢性胃炎、消化道功能紊乱、胃及十二指肠溃疡等属湿滞脾胃者。

【使用注意】本方药物多苦温辛燥之品，易伤人体之阴精、阴血，故使用时应注意以下两点。

- ① 中病即止，不宜多服、久服，素体肝肾阴虚者更应慎用，孕妇不宜用。
- ② 虽病在脾胃，阴虚气滞、脾虚胃弱者不宜应用。

• 藿香正气散（《太平惠民和剂局方》）•

【组成】大腹皮 白芷 紫苏 茯苓去皮，各一两（各 5g） 半夏曲 白术 陈皮去白 厚朴去粗皮，姜汁炙 苦桔梗各二两（各 10g） 藿香去土，三两（15g） 甘

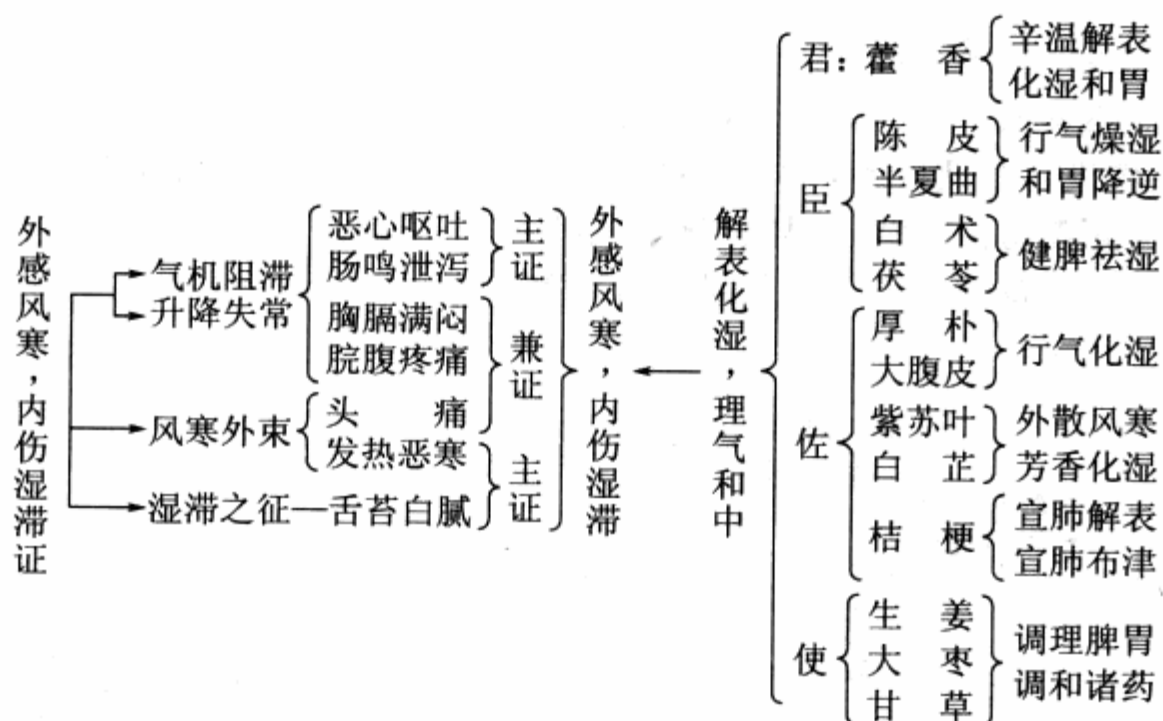
草炙，二两半（12g）

【功用】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞证。发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，肠鸣泄泻，舌苔白腻，以及山岚瘴疟等。

【方歌】藿香正气腹皮苏，甘桔陈苓芷术朴，
夏曲加入姜枣煎，外寒内湿均能除。

【表解】



【配伍特点】

- ① 表里双解，以化湿和中治里为主。
- ② 升清降浊，以降湿浊为主。
- ③ 邪正兼顾，以祛邪为主。

【难点提示】

(1) 关于“半夏曲”的应用 方中用半夏曲，而非半夏。半夏曲为清半夏、生姜汁、白矾、六神曲、面粉等制成的曲剂；或用法半夏、赤小豆、苦杏仁、面粉等与鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳煎出液体制成的曲剂。其味苦辛，性平，功能化痰湿、消食滞，主治咳嗽、痰多、呕恶、食积、泄泻。较之于半夏，其化湿和胃之力优，而燥湿之力弱。本方原方用半夏曲即取其化湿和胃之作用。

(2) 关于桔梗的配伍意义 桔梗可开宣肺气，肺主表，合皮毛，肺气宣通有助腠理开泄，以助解表散寒；二则肺为水之上源，可通调水道，肺气宣通有助水道通畅，以祛湿浊。

【应用要点】本方为治疗外感风寒，内伤湿滞证的常用方。以上吐下泻，恶寒发热，舌苔白腻为辨证要点。

现代临床本方常用于胃肠型感冒、急性胃肠炎、急性酒精中毒、皮肤病（痱子、手足癣、体癣等）、妊娠恶阻等属外感风寒，内伤湿滞者。

【使用注意】

- ① 本方重在化湿和胃，解表散寒之力较弱，故服后宜温覆以助解表。
- ② 湿热霍乱非本方所宜。

第二节 清热祛湿

清热祛湿剂适用于外感湿热，或湿从热化，或湿热下注所致的湿温、黄疸、热淋、痿痹等病证。常用清热利湿药如茵陈、滑石、薏苡仁等，或清热燥湿药如黄连、黄柏、黄芩等为主组成方剂，代表方如茵陈蒿汤、八正散、三仁汤、甘露消毒丹等。

• 茵陈蒿汤（《伤寒论》）•

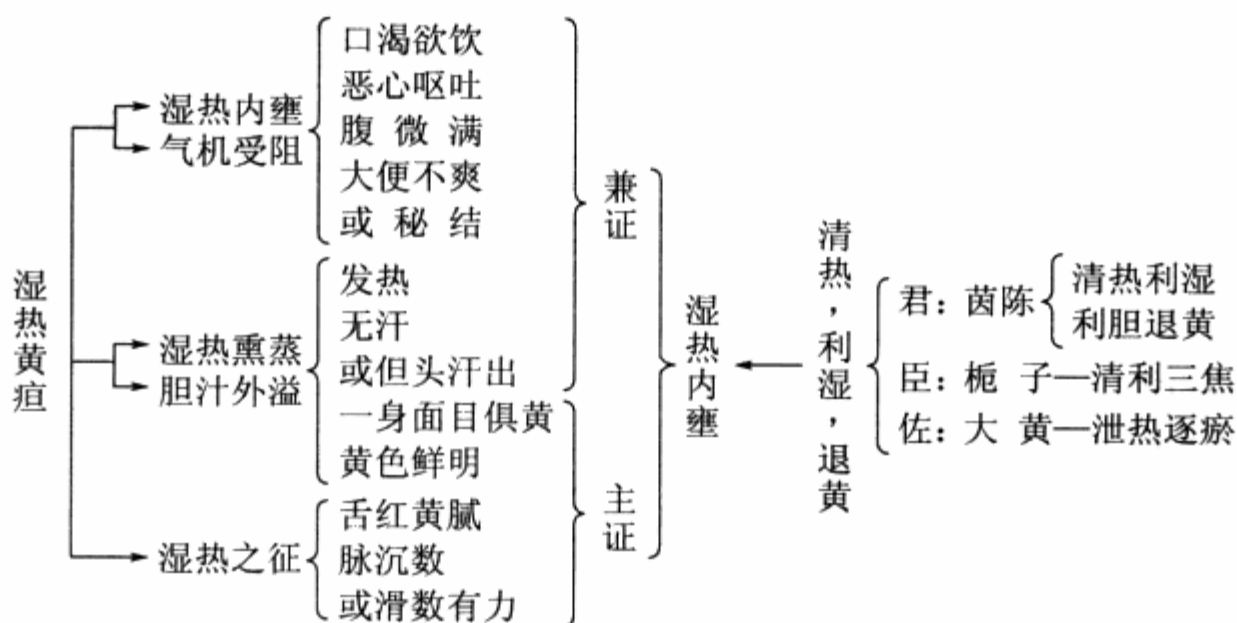
【组成】茵陈六两（18g） 栀子十四枚（9g） 大黄二两（6g）

【功用】清热，利湿，退黄。

【主治】湿热黄疸。一身面目俱黄，黄色鲜明，发热，无汗或但头汗出，口渴欲饮，恶心呕吐，腹微满，小便短赤，大便不爽或秘结，舌红苔黄腻，脉沉数或滑数有力。

【方歌】茵陈蒿汤治疸黄，阴阳寒热细推详，
阳黄大黄栀子入，阴黄附子与干姜。

【表解】



【配伍特点】

- ① 利湿与泻热并进。
- ② 通利二便，前后分消。

【应用要点】本方为治疗湿热黄疸的常用方，也为基础方。以一身面目俱黄，黄色鲜明，舌苔黄腻，脉沉数为辨证要点。

现代临床本方常用于各种类型的黄疸、各类肝炎、胆囊炎、肝内胆汁淤积症、肝癌化疗后发热、肝癌介入治疗后急性综合征、接触性皮炎、湿疹、痤疮、多形红斑、荨麻疹等属湿热内蕴者。

• 八 正 散（《太平惠民和剂局方》）•

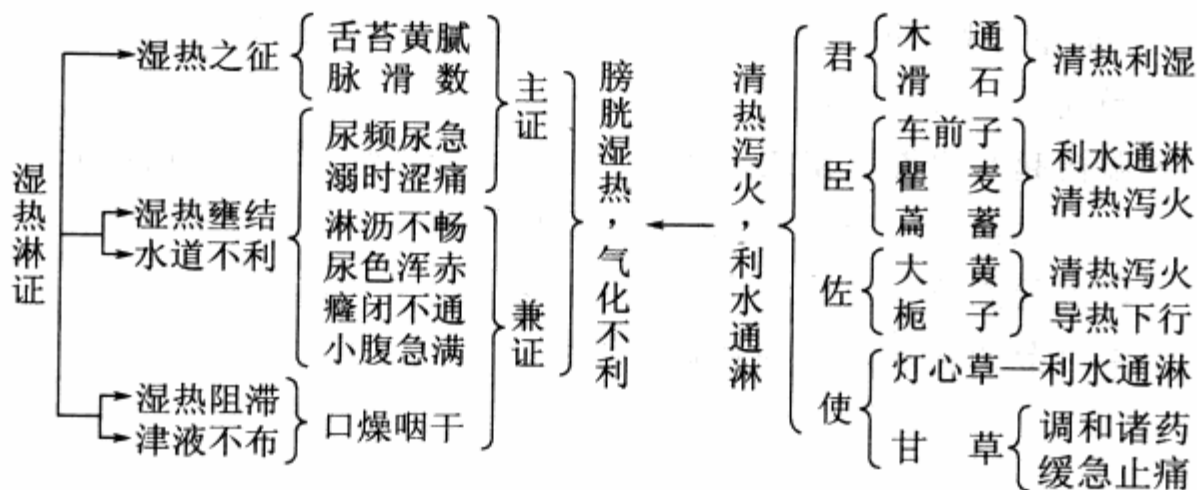
【组成】车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 山栀子仁 甘草炙 木通 大黄面裹煨，去面，切，焙，各一斤（各 9g）

【功用】清热泻火，利水通淋。

【主治】湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

【方歌】八正散用瞿麦通，滑石车前篇蓄同，
 大黄栀子灯心草，湿热下注淋常用。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清利结合，以利为主。
- ② 三焦通调，前后分消。

【难点提示】大黄在本方及大承气汤、凉膈散、芍药汤、复元活血汤、茵陈蒿汤中的配伍意义。

大承气汤：荡涤肠胃，泻热通便。

凉膈散：以泻代清，有助于胸膈郁热的清除，又可防无形邪热积于肠腑与肠中糟粕相结而成阳明腑实之证。

芍药汤：泻热导滞，使湿热积滞从大便而去；活血，使血行则便脓自愈。

复元活血汤：荡涤瘀血，引瘀下行。

茵陈蒿汤：泻热逐瘀。

八正散：清热泻火，导热下行。

【应用要点】本方为治疗湿热淋证的常用方。以尿频尿急，溺时涩痛，舌苔黄腻，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于治疗各种尿道炎、急慢性前列腺炎、前列腺肥大、尿路感染、尿路结石等属湿热证者；还可治疗急慢性盆腔炎及产后、肛肠手术后产生的急性尿潴留和下肢骨科手术后尿道激惹征、多种皮肤病等。

【使用注意】本方为苦寒通利之剂，淋证日久，肾气虚弱者忌用。

【类方比较】

八正散与小蓟饮子比较表

比较	方名	八 正 散	小蓟饮子
组成	同	滑石、木通、栀子、炙甘草	
	异	车前子、瞿麦、篇蓄、大黄	生地黄、小蓟、蒲黄、藕节、竹叶、当归
功用	同	清热泻火，利水通淋	
	异	专于清热泻火，利水通淋	重在凉血止血、清热泻火，利水通淋较弱
主治	同	膀胱湿热，气化不利证。症见小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数等	
	异	病偏气分。伴见湿热内壅之口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数	病偏血分。伴见血络损伤之尿中带血，血色鲜红

• 三仁汤 (《温病条辨》) •

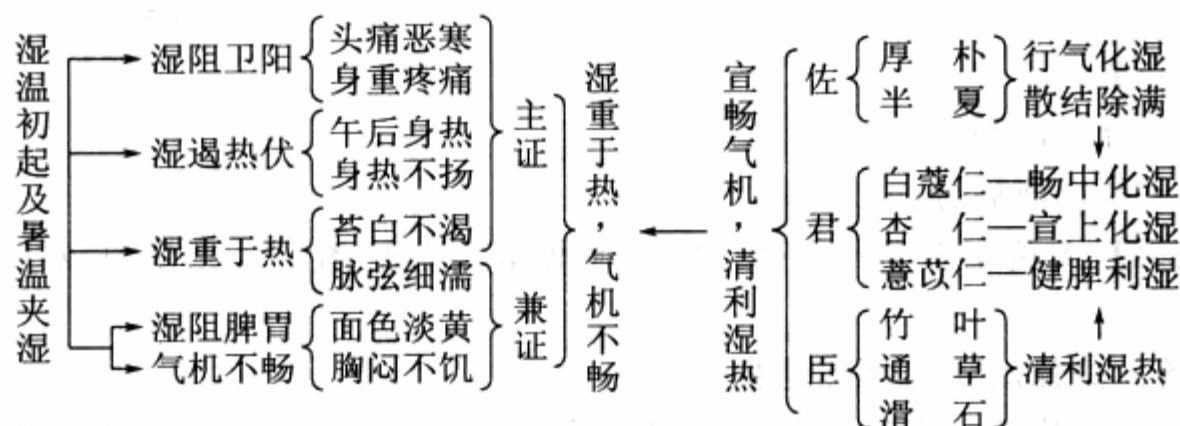
【组成】杏仁五钱 (12g) 飞滑石六钱 (18g) 白通草二钱 (6g) 白蔻仁二钱 (6g) 竹叶二钱 (6g) 厚朴二钱 (6g) 生薏苡仁六钱 (18g) 半夏五钱 (10g)

【功用】宣畅气机，清利湿热。

【主治】湿温初起及暑温夹湿之湿重于热。头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。

【方歌】三仁杏蔻薏苡仁，朴通滑夏竹叶群，
湿温暑湿初化热，自须轻宣与淡渗。

【表解】



【配伍特点】

- ① 祛湿为主，清热为辅。
- ② 宣通三焦，分消湿热。

【难点提示】

(1) 立法“三禁” 对于该方方证，《温病条辨》曾示三点告诫：其一，禁汗，即不可见其头痛恶寒，身重疼痛也，以为伤寒而汗之，汗伤心阳，湿随辛温发表之剂蒸腾上逆，内蒙心窍则神昏，上蒙清窍则耳聋目瞑不言；其二，禁下，即不可见其中满不饥，以为停滞而大下之，误下伤阴，而重抑脾阳之升，脾气转陷，湿邪乘势内溃，故洞泄；其三，禁润，更不要见其午后身热，以为阴虚而用柔药润之，湿为胶滞阴邪，再加柔润阴药，二阴相合，同气相求，遂有锢结而不可解之势。“唯以三仁汤轻开上焦肺气，盖肺主一身之气，气化则湿亦化也”。

(2) 杏仁在本方及麻子仁丸、杏苏散中的作用。

三仁汤：宣肺化湿。

麻子仁丸：上肃肺气，下润大肠，以通大便。

杏苏散：降利肺气，润肺止咳。

【应用要点】本方为治疗肺胃阴虚，气机上逆所致咳嗽或呕吐的常用方。以头痛恶寒，身重疼痛，午后身热，苔白不渴为辨证要点。

现代临床本方常用于治疗伤寒、夏季感冒、腹泻、消化不良等病，亦有报道用于急性慢性肾炎、慢性肺心病、糖尿病不宁肢综合征、急性高山反应、眩晕、接触性皮炎、湿疹、扁平疣、痤疮、带状疱疹、过敏性紫癜、睑缘炎、鼻窦炎、病毒性角膜炎、中心性

浆液性视网膜炎、卡他性结膜炎、阳痿、射精痛、精液不化、淋证、汗证、慢性盆腔炎等属湿重于热者。

【使用注意】

- ① 热重于湿，舌苔黄腻者慎用。
- ② 湿热入营，谵语舌绛者非本方所宜。

• 甘露消毒丹（《医效秘传》）•

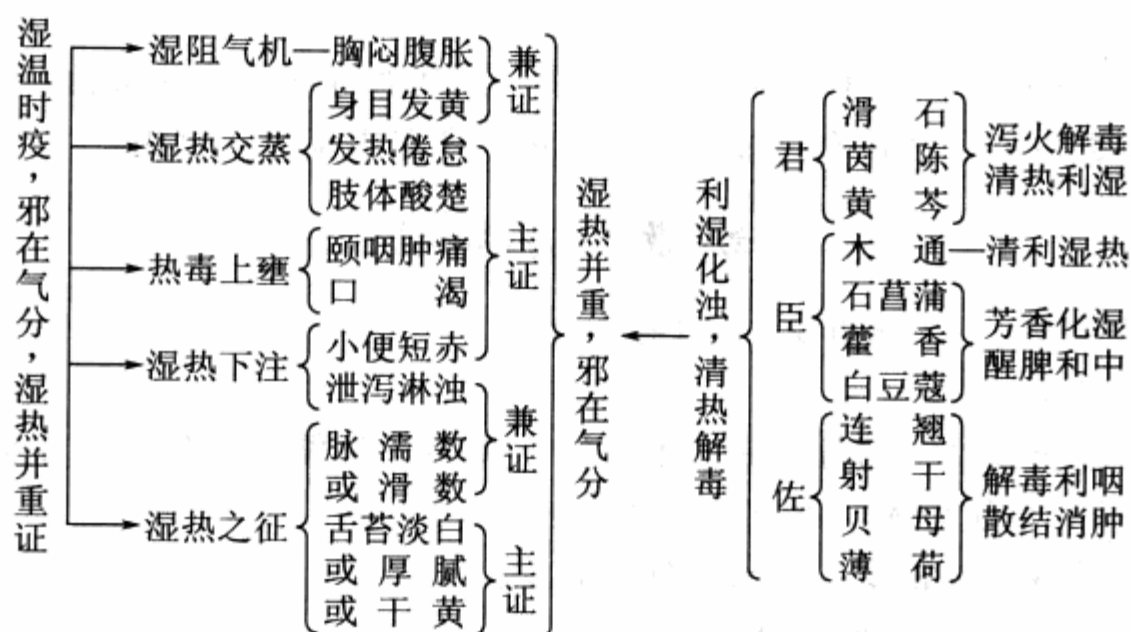
【组成】 飞滑石十五两（15g） 淡黄芩十两（10g） 绵茵陈十一两（11g） 石菖蒲六两（6g） 川贝母五两（5g） 木通五两（5g） 藿香四两（4g） 连翘四两（4g） 白蔻仁四两（4g） 薄荷四两（4g） 射干四两（4g）

【功用】 利湿化浊，清热解毒。

【主治】 湿温时疫，邪在气分，湿热并重证。发热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽肿，身目发黄，颐肿口渴，小便短赤，泄泻淋浊等，舌苔淡白或厚腻或干黄，脉濡数或滑数。

【方歌】 甘露消毒藿茵陈，菖蒲连翘射黄芩，
贝蔻滑石通薄荷，湿热并重留气分。

【表解】



【配伍特点】

- ① 利湿与清热并重，突出解毒。
- ② 清上、悦中、利下，分消三焦湿热疫毒。
- ③ 寓轻宣与清解之中。

【应用要点】 本方为夏令暑湿季节常用方剂，王士雄誉之为“治湿温时疫之主方”。以身热肢酸，口渴尿赤，或咽痛身黄，舌苔白腻或微黄为辨证要点。

现代临床本方常用于夏季感冒、伤寒及多种沙门菌属感染性病证、胆囊炎、胃炎、黄疸以及多种皮肤病证等属湿热并重者。

• 连朴饮（《霍乱论》）•

【组成】 制厚朴二钱（6g） 川连姜汁炒 石菖蒲 制半夏各一钱（各 3g） 香豉炒

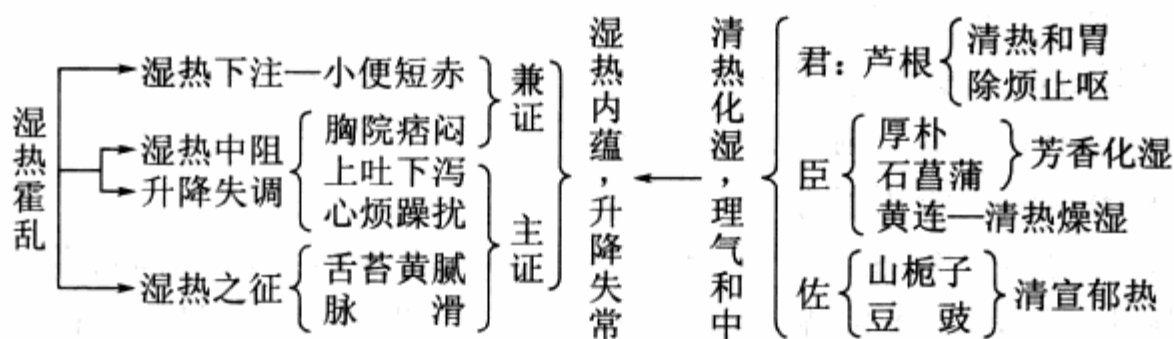
焦栀各三钱（各 9g） 芦根二两（60g）

【功用】清热化湿，理气和中。

【主治】湿热霍乱。上吐下泻，胸脘痞闷，心烦躁扰，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑等。

【方歌】连朴饮出霍乱论，菖蒲栀豉夏芦根，
清热化湿和脾胃，霍乱吐泻效如神。

【表解】



【配伍特点】

- ① 辛开与苦泄并行，升清降浊。
- ② 清化与宣透兼施，重在清化。

【应用要点】本方为治疗湿热霍乱的常用方。以吐泻烦闷，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性胃肠炎、肠伤寒、副伤寒等属湿热并重者。

【使用注意】本方药性苦寒，虚寒吐泻忌用，寒湿霍乱也不宜用。

• 二 妙 散 (《丹溪心法》) •

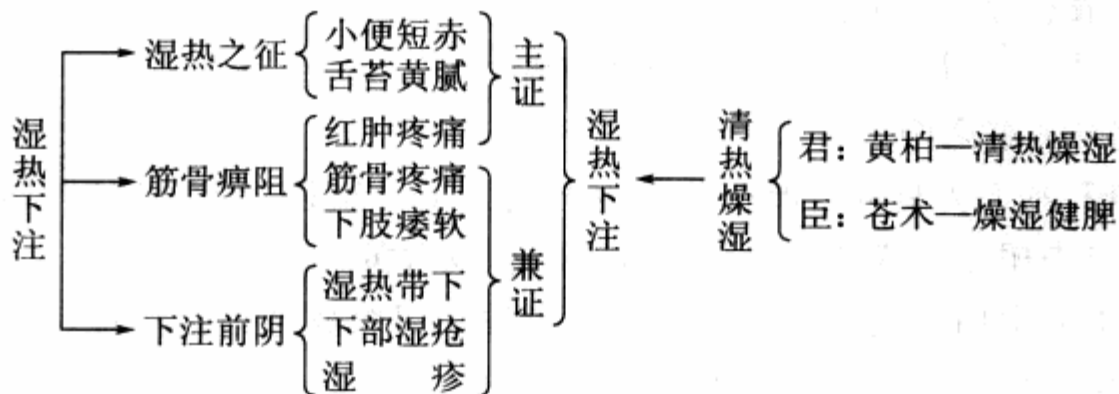
【组成】黄柏炒 苍术米泔浸，炒（各 15g）

【功用】清热燥湿。

【主治】湿热下注证。筋骨疼痛，下肢痿软无力，足膝红肿疼痛，或湿热带下，或下部湿疮、湿疹，小便短赤，舌苔黄腻者。

【方歌】二妙散本苍柏研，若云三妙牛膝添，
再加苡仁名四妙，湿热下注廉便验。

【表解】



【配伍特点】

- ① 清热与燥湿并举。
- ② 标本兼顾，洁源清流。

【应用要点】本方为治疗痿、痹、脚气、带下、湿疮等病证的基础方。以小便短赤，舌苔黄腻为辨证要点。

现代临床本方常用于关节炎、阴囊湿疹、阴道炎等属湿热下注者。

• 当归拈痛汤（拈痛汤）（《医学启源》）•

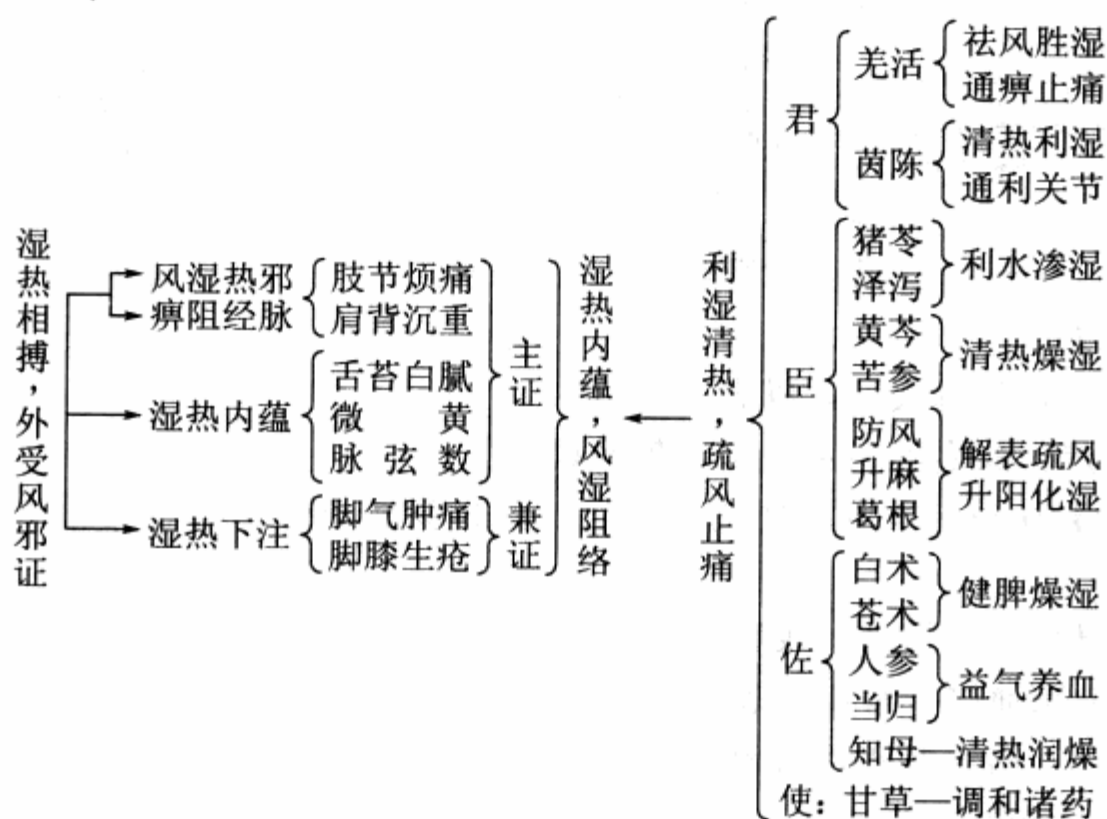
【组成】羌活半两（15g） 防风三钱（9g） 升麻一钱（3g） 葛根二钱（6g） 白术一钱（3g） 苍术三钱（9g） 当归身三钱（9g） 人参二钱（6g） 甘草五钱（15g） 苦参酒浸，二钱（6g） 黄芩炒，一钱（3g） 知母酒洗，三钱（9g） 茵陈酒炒，五钱（15g） 猪苓三钱（9g） 泽泻三钱（9g）

【功用】利湿清热，疏风止痛。

【主治】湿热相搏，外受风邪证。遍身肢节烦痛，或肩背沉重，或脚气肿痛，脚膝生疮，舌苔白腻微黄，脉弦数等。

【方歌】当归拈痛泽猪根，升麻防风知草参，
二术茵芩苦苓羌，湿重热轻兼风证。

【表解】



【配伍特点】

- ① 发散风湿与清热利湿相配，表里同治。
- ② 邪正兼顾，苦燥渗利，佐以补气养血。

【应用要点】本方为治疗风湿热痹及湿热脚气初起属湿邪偏重的常用方剂。以肢节沉重肿痛，舌苔白腻微黄，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎属湿热内蕴而兼风湿表证者。

第三节 利水渗湿

利水渗湿剂适用于水湿壅盛所致的癃闭、淋浊、水肿、泄泻等症。常以甘淡利水药

如茯苓、泽泻、猪苓等为主组成方，代表方如五苓散、猪苓汤等。

• 五苓散（《伤寒论》）•

【组成】猪苓十八铢，去皮（9g） 泽泻一两六铢（15g） 白术十八铢（9g） 茯苓十八铢（9g） 桂枝半两，去皮（6g）

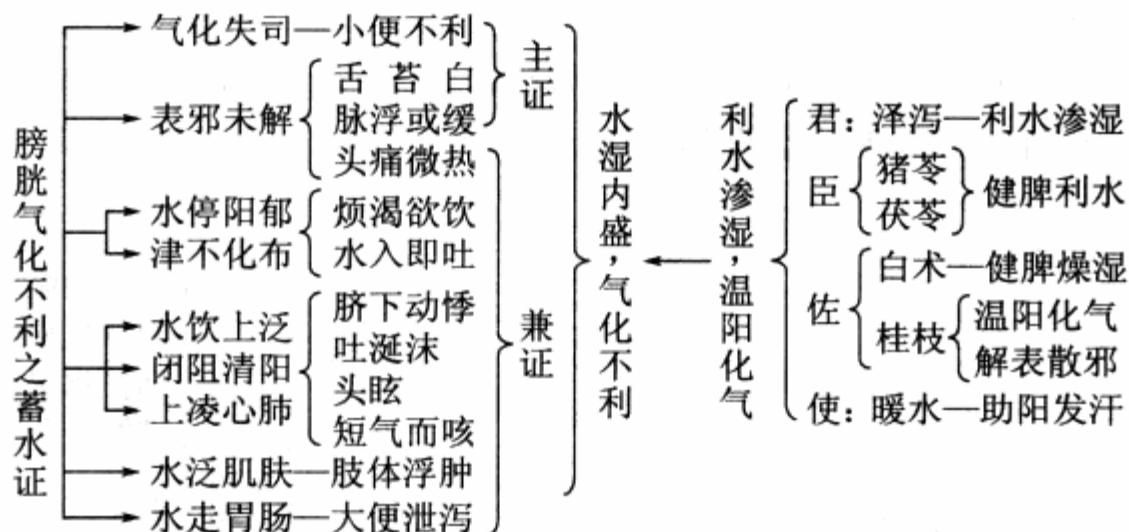
【功用】利水渗湿，温阳化气。

【主治】膀胱气化不利之蓄水证。小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐；或脐下动悸，吐涎沫而头眩；或短气而咳；或水肿，泄泻。舌苔白，脉浮或浮数。

【方歌】五苓苓桂泽猪术，水停膀胱津不输，

口渴心烦尿不利，饮入则吐脉来浮。

【表解】



【配伍特点】

① 内利水湿，外解表邪，以表里同治。

② 通利下焦，兼实脾制水，以二焦并调。

【难点提示】桂枝在本方及桂枝汤、当归四逆汤、小建中汤、苓桂术甘汤中不同的配伍意义如下。

五苓散：温阳化气行水，兼解表散邪。

桂枝汤：助阳通络，解肌发表。

当归四逆汤：温经散寒，通利血脉。

小建中汤：温阳祛寒。

苓桂术甘汤：温阳化饮。

【应用要点】本方为利水的基础方，适用于各种水饮内停所致的水肿、痰饮、泄泻病证。小便不利，舌苔白，脉浮或缓为辨证要点。

现代临床本方常用于治疗急性肾炎、尿潴留、水肿和组织器官积液、泌尿系结石和泌尿生殖系感染、梅尼埃病、胃肠炎、泄泻和呕吐、眼病、妊娠高血压综合征及自汗、盗汗等属水饮内停者。

• 猪苓汤（《伤寒论》）•

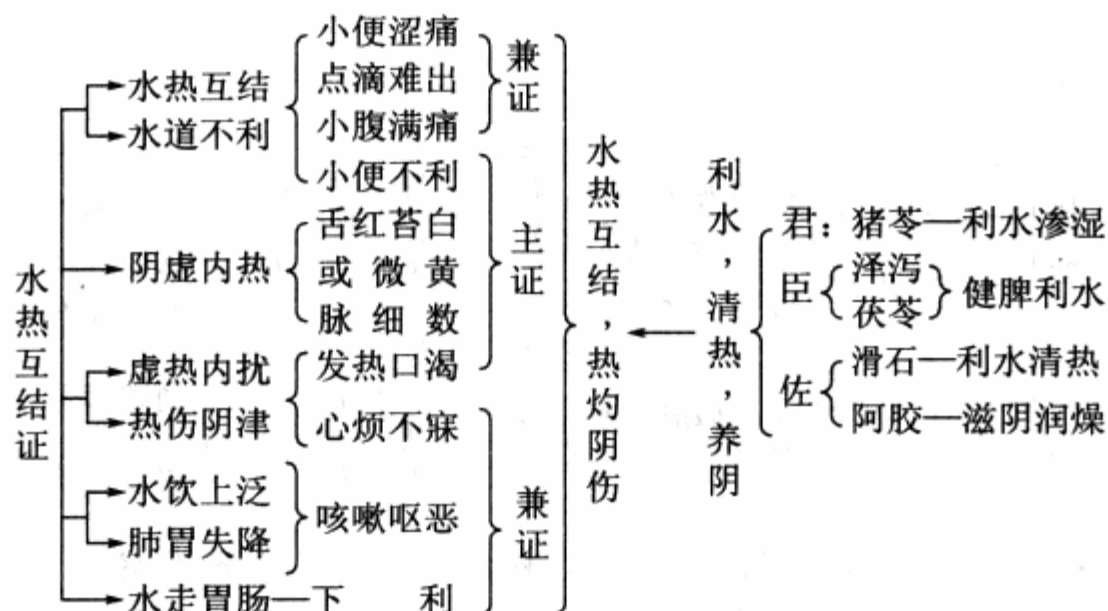
【组成】猪苓去皮 茯苓 泽泻 阿胶 滑石碎，各一两（各 10g）

【功用】利水，清热，养阴。

【主治】水热互结证。小便不利，发热，口渴欲饮，或见心烦不寐，或兼有咳嗽，呕恶，下利，舌红苔白或微黄，脉细数。又治血淋，小便涩痛，点滴难出，小腹满痛者。

【方歌】猪苓汤用猪茯苓，泽泻滑石阿胶并，
小便不利兼烦渴，利水养阴热亦平。

【表解】



【配伍特点】利水渗湿为主，清热养阴为辅。利水而不伤阴，滋阴而不敛邪。

【应用要点】本方为治疗水热互结而兼阴虚证的常用方。以小便不利，口渴，身热，舌红，脉细数为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肾炎、糖尿病性肾病、慢性肾盂肾炎、小儿肾炎、肾积水、肝硬化腹水、急性膀胱炎、前列腺增生性尿潴留、产后尿潴留、尿道综合征、流行性出血热等证属水热互结而兼阴虚者。

【使用注意】内热盛，阴津大亏者忌用。《伤寒论》指出：“阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。”

【类方比较】

五苓散与猪苓汤比较表

比较	方名	五苓散	猪苓汤
组成		泽泻、猪苓、茯苓	
		白术、桂枝	滑石、阿胶
功用		利水渗湿	
		解表化气(偏温)	清热养阴(偏寒)
主治		水湿内停，小便不利	
		蓄水证(水湿内停)	水热互结伤阴证

• 防己黄芪汤 (《金匮要略》) •

【组成】防己一两(12g) 黄芪一两一分，去芦(15g) 甘草半两，炒(6g) 白术七

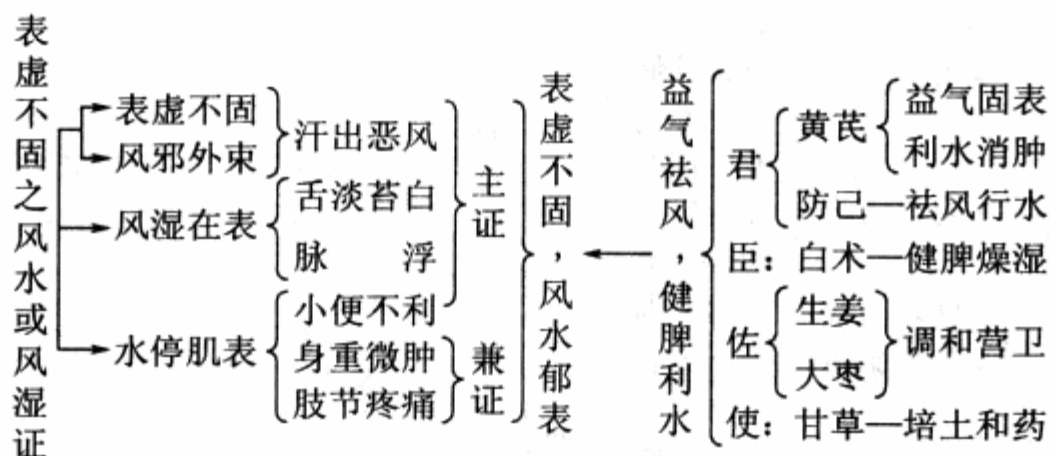
钱半 (9g)

【功用】 益气祛风，健脾利水。

【主治】 表虚不固之风水或风湿证。汗出恶风，身重微肿，或肢节疼痛，小便不利，舌淡苔白，脉浮。

【方歌】 防己黄芪汤常用，白术甘草姜枣同，
益气固表利水湿，风水能消痹可通。

【表解】



【配伍特点】 祛风利水与益气健脾并用，祛邪不伤正，固表不留邪。

【难点提示】 黄芪在本方及当归补血汤、补阳还五汤、补中益气汤、玉屏风散中的配伍意义如下。

防己黄芪汤：益气固表，利水消肿。

当归补血汤：补气生血。

补阳还五汤：补气活血。

补中益气汤：益气升阳。

玉屏风散：益气固表。

【应用要点】 本方为治疗风水、风湿属于表虚证的常用方剂，亦为补气利水之代表方。以汗出恶风，小便不利，苔白脉浮为辨证要点。

现代临床本方常用于心源性水肿、慢性肾小球肾炎、狐臭、肥胖病、风湿性关节炎属表虚水湿偏盛者。

【使用注意】

① 若水湿壅盛，汗不出者，虽有脉浮恶风，亦非本方所宜。

② 风邪在表，自当解外，外不解则邪不去，而湿不消；欲解其外，卫又不固时，不可过发其汗，且需益气固表。

• 五 皮 散 (《华氏中藏经》) •

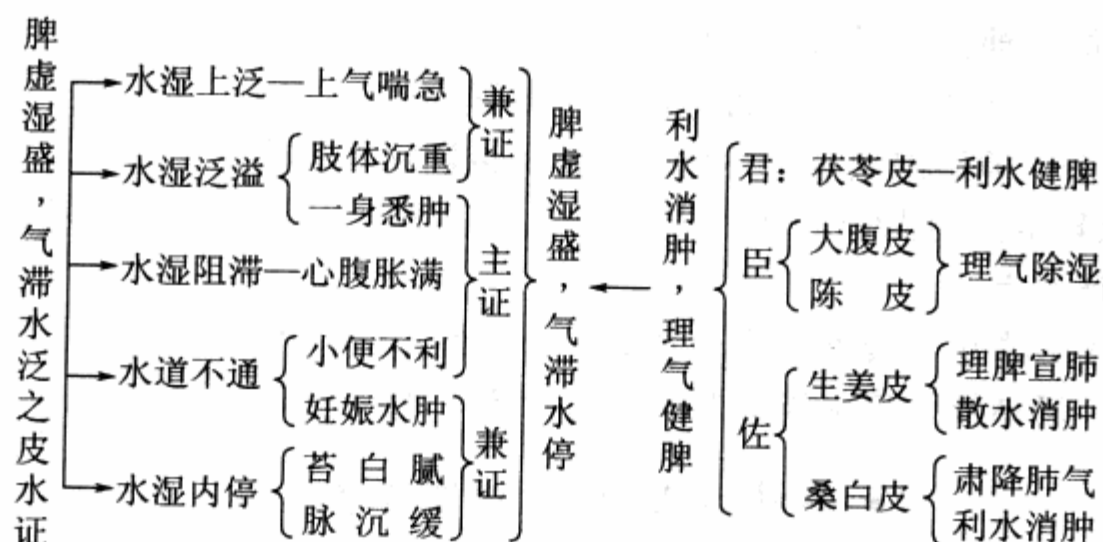
【组成】 生姜皮、桑白皮、陈橘皮、大腹皮、茯苓皮各等分 (各 9g)

【功用】 利水消肿，理气健脾。

【主治】 脾虚湿盛，气滞水泛之皮水证。一身悉肿，肢体沉重，心腹胀满，上气喘急，小便不利，以及妊娠水肿，苔白腻，脉沉缓。

【方歌】 五皮散用五般皮，陈茯姜桑大腹奇，
或以五加易桑白，脾虚肤胀此方医。

【表解】



【配伍特点】

① 五药用皮，以行皮间水气。② 利水消肿与健脾利肺同用，使气行则水行。

【应用要点】本方为治疗皮水的常用方。以一身悉肿，心腹胀满，小便不利为辨证要点。现代临床本方常用于肾炎水肿、心源性水肿、妊娠水肿等属脾虚湿盛者。

第四节 温化水湿

温化水湿剂适用于阳虚气不化水，水湿内停或湿从寒化所致的痰饮、水肿等病证。常用温阳药与利湿药，如桂枝、附子、茯苓、白术等组成方剂。代表方如苓桂术甘汤、真武汤、甘草干姜茯苓白术汤、实脾散。

• 真武汤（《伤寒论》）•

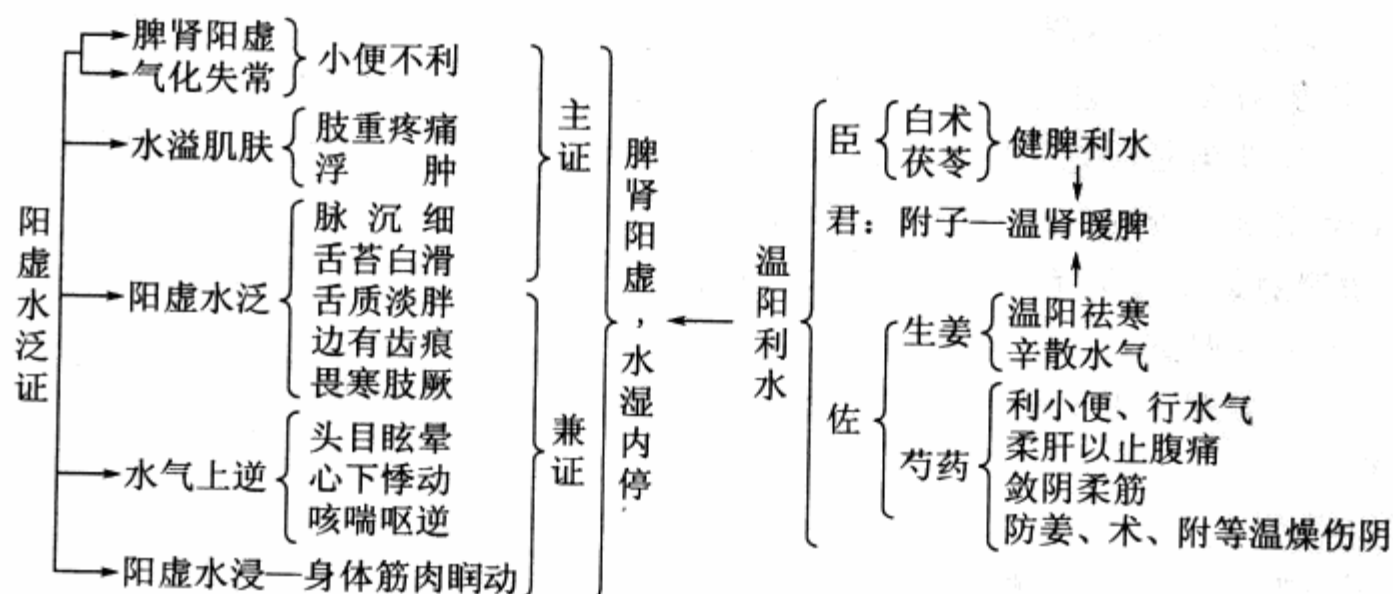
【组成】茯苓三两（9g）芍药三两（9g）白术二两（6g）生姜三两（9g）附子炮，去皮，一枚，破八片（9g）

【功用】温阳利水。

【主治】阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不安，头目眩晕，身体筋肉瞤动，站立不稳，四肢沉重疼痛，肢体浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻，或咳喘呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。

【方歌】真武汤壮肾中阳，附子茯苓术芍姜，
实脾饮乃真武化，大腹草果朴香瓜。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，即温阳以治本，利水、散水以治标。
- ② 脾肾同治，即以温肾助阳为主，温中健脾为辅。
- ③ 刚柔相济，即温阳利水而不伤阴，益阴敛阴而不留邪。

【应用要点】本方为温阳利水的基础方和常用方。以小便不利，肢体沉重或浮肿，苔白脉沉为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肾小球肾炎、心源性水肿、甲状腺功能低下、慢性支气管炎、慢性肠炎、肠结核、梅尼埃病等属脾肾阳虚，水湿内盛者。

• 苓桂术甘汤（《金匱要略》）•

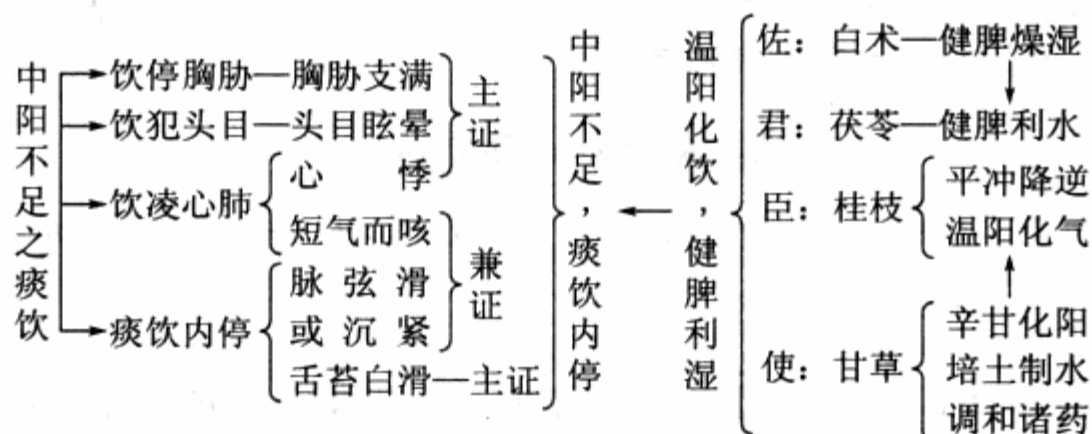
【组成】茯苓四两（12g） 桂枝三两（9g） 白术三两（9g） 甘草二两（6g）

【功用】温阳化饮，健脾利湿。

【主治】中阳不足之痰饮。胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑或沉紧。

【方歌】苓桂术甘化饮剂，温阳化饮又健脾，
饮邪上逆胸胁满，水饮下行悸眩去。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温阳健脾以治本，祛湿化饮以治标。
- ② 温而不燥，利而不峻，为温化痰饮和剂。

【难点提示】如何理解“病痰饮者，当以温药和之”。

“病痰饮者，当以温药和之”是张仲景对痰饮病证提出的治疗方法，也是苓桂术甘汤的立法依据所在。该法主要针对中阳不足，脾失健运，津液停滞而为痰为饮之证。盖饮为阴邪，其性黏滞，易伤阳气，得寒则聚，得温则化，故治疗当以温药温阳化饮，但又不可温燥太过，否则会伤及阴津。苓桂术甘汤是其代表方剂。

【应用要点】本方为治疗中阳不足之痰饮病证的代表方剂。以胸胁支满，目眩心悸，舌苔白滑为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎、支气管哮喘、心源性或慢性肾小球肾炎所致水肿属阳虚者。

【使用注意】

- ① 本方服后，当小便增多时，为饮从小便而去之征。

② 本方药性偏温，且利小便，故痰饮化热及阴虚之人忌用。

【类方比较】

五苓散与苓桂术甘汤比较表

比较	方名	五苓散	苓桂术甘汤
组成		茯苓、桂枝、白术	
		泽泻、猪苓	甘草
功用		温阳化饮，健脾渗湿	
		重在利水渗湿以治本	重在温化痰饮以治标
主治		痰饮病	
		痰饮停于下焦之头眩、脐下动悸或吐涎沫等	痰饮停于中焦之痰饮。症见胸胁支满、目眩、心悸等

• 实脾散（《济生方》）•

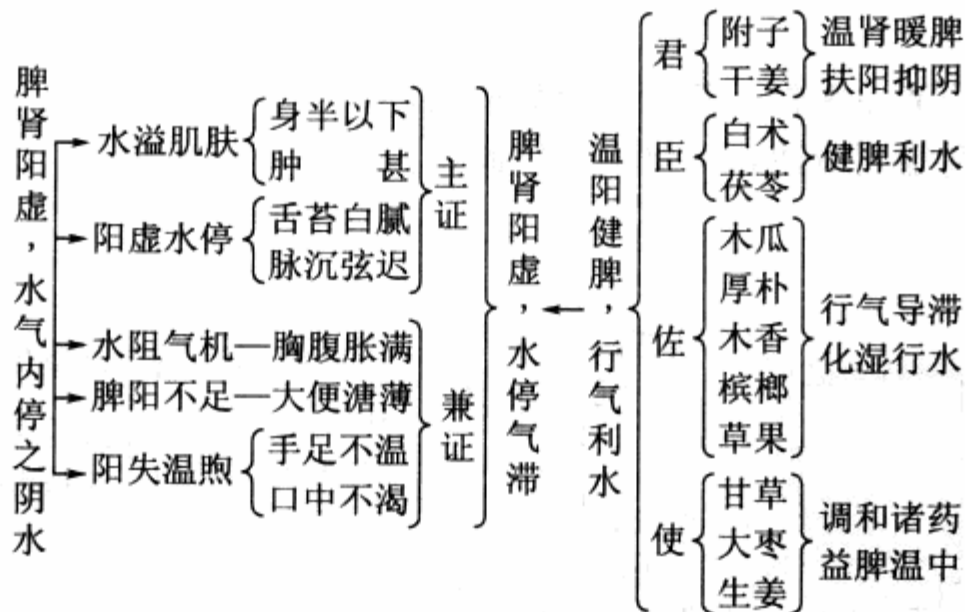
【组成】厚朴去皮，姜制，炒 白术 木瓜去瓤 木香不见火 草果仁 大腹子 附子炮，去皮，脐 白茯苓去皮 干姜炮，各一两（各 30g） 甘草炙，半两（15g）

【功用】温阳健脾，行气利水。

【主治】脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉弦而迟者。

【方歌】实脾苓术与木瓜，甘草木香大腹加，
草果附姜兼厚朴，虚寒阴水效堪夸。

【表解】



【配伍特点】

① 脾肾同治，而以温脾阳为主。

② 寓行气于温利之中，气化则湿化。

【应用要点】本方为治疗脾肾阳虚水肿的常用方剂。以身半以上肿甚，胸腹胀满，舌淡苔腻，脉沉迟为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性肾小球肾炎、心源性水肿、肝硬化腹水等属脾肾阳虚气

滞者。

【类方比较】

真武汤与实脾散比较表

比较 \ 方名	真武汤	实脾散
组成	附子、白术、茯苓	
	芍药、生姜	干姜、木香、厚朴、槟榔、草果、木瓜、大枣、生姜、甘草
功用	温补脾肾，利水渗湿	
	偏于温肾利水，兼敛阴缓急	偏于温补脾阳，兼行气导滞
主治	脾肾阳虚，水气内停之水肿	
	偏于肾阳虚弱、水气内停之水肿，伴见身体筋肉瞤动、站立不稳、四肢沉重疼痛等症	偏于脾阳虚弱，水停气滞之水肿，伴有胸腹胀满、大便溏薄等症

• 萆薢分清散（萆薢分清饮）（《杨氏家藏方》）•

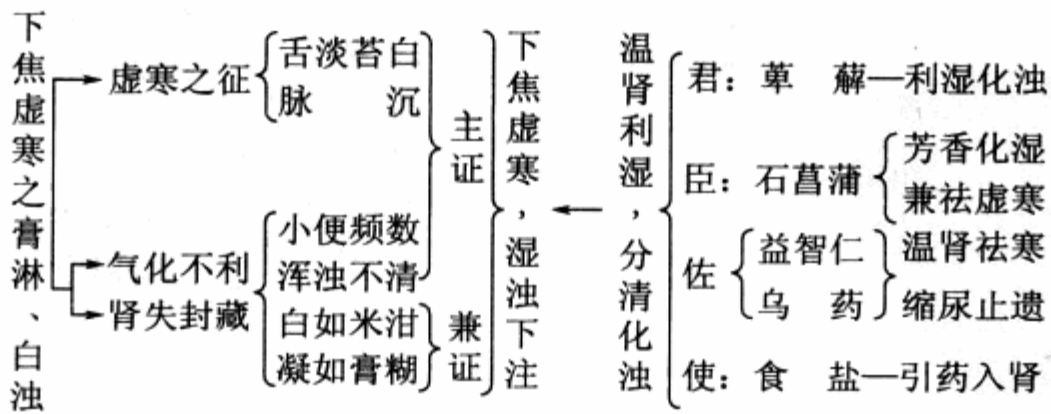
【组成】益智 川萆薢 石菖蒲 乌药各等分（各 9g）

【功用】温肾利湿，分清化浊。

【主治】下焦虚寒之膏淋、白浊。小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。

【方歌】萆薢分清益智仁，菖蒲乌药盐煎成，
温肾利湿别清浊，下焦虚寒用此灵。

【表解】



【配伍特点】标本兼顾，以治标为主，即利湿化浊以治标，温暖下元以治本。

【应用要点】本方为治疗下焦虚寒湿白浊的常用方。以小便浑浊而频数，舌淡苔白，脉沉为辨证要点。

现代临床本方常用于乳糜尿、慢性前列腺炎属下焦虚寒证。

第五节 祛风胜湿

祛风胜湿剂适用于风湿在表所致的头痛身重，或风湿侵袭痹阻经络所致的腰膝顽麻痹痛等症。常用祛风胜湿药如羌活、秦艽、桑寄生等组成方剂。代表方如羌活胜湿汤、独活寄生汤。

• 羌活胜湿汤（《脾胃论》）•

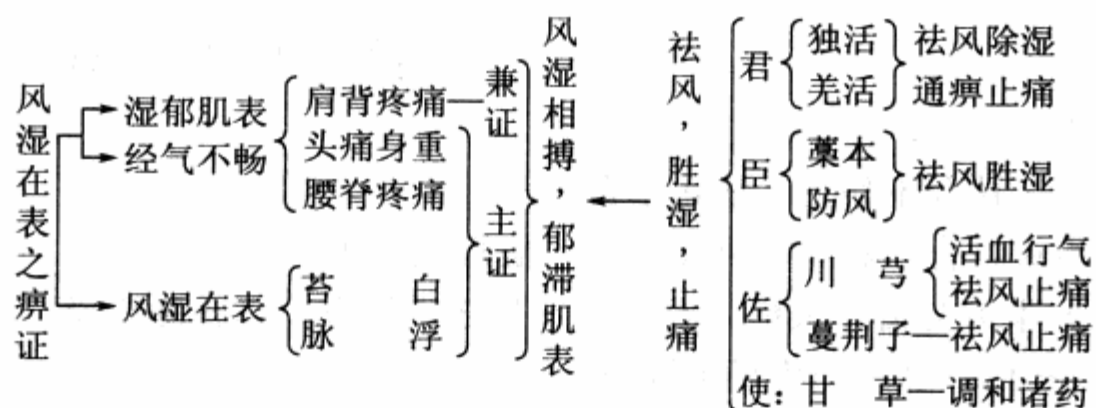
【组成】羌活 独活各一钱（各 6g） 藁本 防风 甘草炙，各五分（各 3g） 蔓荆子三分（2g） 川芎二分（1.5g）

【功用】祛风，胜湿，止痛。

【主治】风湿在表之痹证。肩背痛不可回顾，头痛身重，腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。

【方歌】羌活胜湿羌独芎，甘蔓藁本与防风，
湿气在表头腰重，发汗升阳有异功。

【表解】



【配伍特点】

① 体现轻扬微汗法。

② 治风与治血结合，寓“治风先治血，血行风自灭”。

【应用要点】本方为治疗风湿在表之头身重痛而表证不明显的常用方。临床应用以头身重痛或腰脊疼痛，苔白脉浮为辨证要点。

现代临床本方常用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨质增生症、强直性脊柱炎等属风湿在表者。

• 独活寄生汤（《备急千金要方》）•

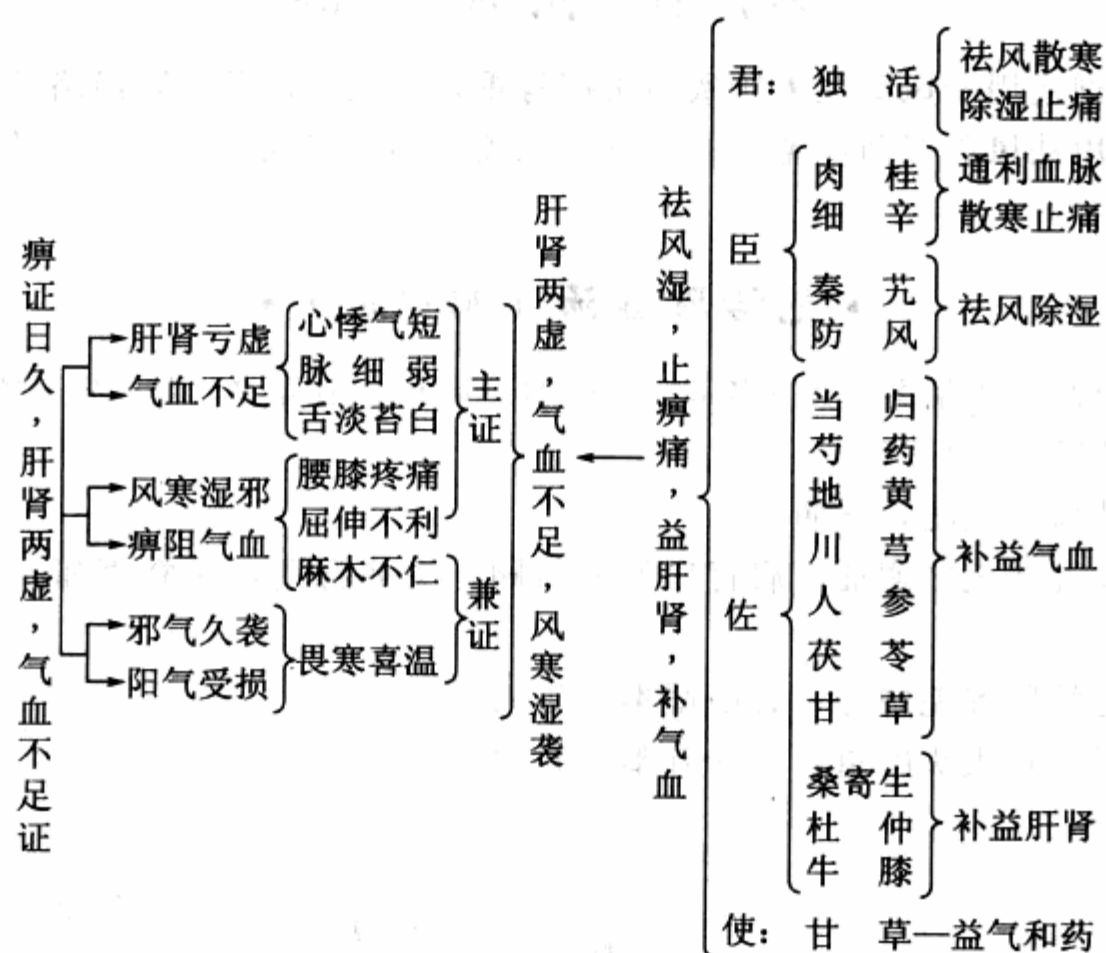
【组成】独活三两（9g） 桑寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 肉桂心 防风 川芎 人参 甘草 当归 芍药 干地黄各二两（各 6g）

【功用】祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

【主治】痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。腰膝疼痛，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱。

【方歌】独活寄生辛风秦，八珍去术杜膝心，
肝肾两亏气血虚，风寒湿痹效特灵。

【表解】



【配伍特点】

- ① 邪正兼顾，祛邪不伤正，扶正不留邪。
- ② 治风与治血结合，寓“治风先治血，血行风自灭”。

【应用要点】本方为治疗久痹而致正气不足之常用方。以腰膝冷痛，关节屈伸不利，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性关节炎、腰肌劳损、骨质增生症、风湿性坐骨神经痛等属肝肾两虚，气血不足者。

第十六章 祛痰剂

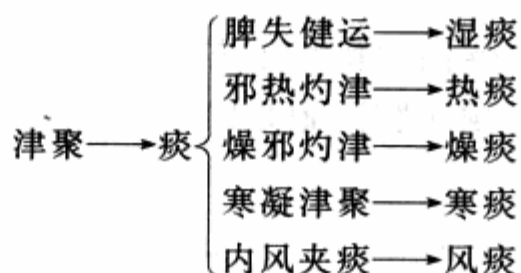
一、定义

凡以祛痰药为主组成，具有消除痰饮作用，治疗各种痰病的方剂，统称为祛痰剂。

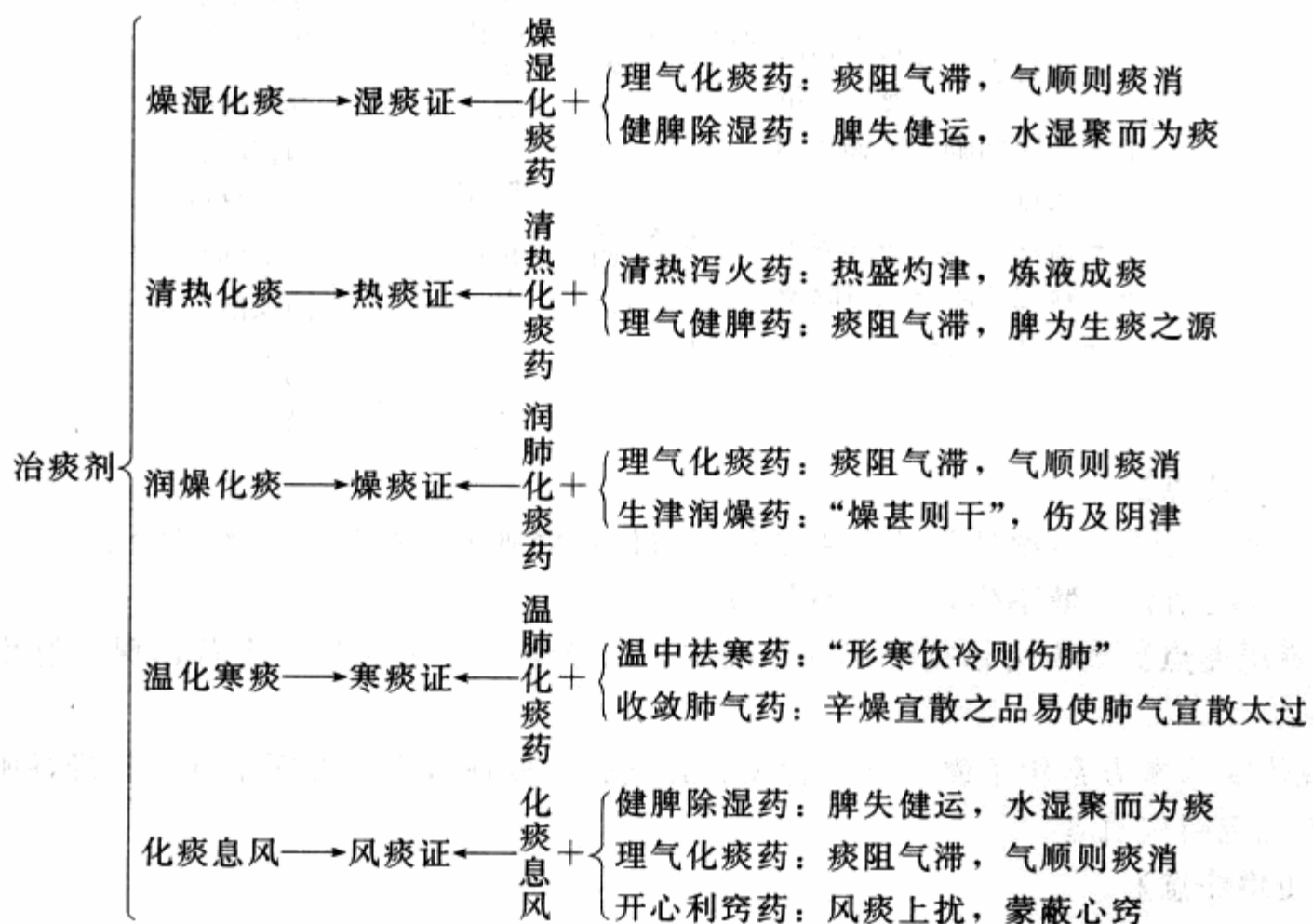
二、立法依据

祛除痰饮属“八法”中“消法”范畴。《医学心悟》：“消者，祛其壅也，脏腑、筋络、肌肉之间，本无此物而忽有之，必为消散，乃得其平。”痰饮为水液代谢病理产物，留驻全身而变生诸证，故应及时祛除。

三、适应范围



四、分类与配伍规律



五、使用注意

- ① 辨别痰病的性质，即寒痰、热痰、燥痰、湿痰、风痰的不同。
- ② 同时还应注意病情，分清标本缓急。有咳血倾向者，不宜用燥烈之剂，以免引起大量咯血；表邪未解或痰多者，慎用滋润之品，以防壅滞留邪，病久不愈。

第一节 燥湿化痰

燥湿化痰剂适用于湿痰证。症见痰多易咯，胸脘痞闷，呕恶眩晕，肢体困倦，舌苔白腻或白滑，脉缓或滑等。常以燥湿化痰药如半夏、南星为主，配伍健脾渗湿及理气之品如白术、茯苓及陈皮、枳实等组成方剂，代表方如二陈汤、茯苓丸、温胆汤。

• 二陈汤（《太平惠民和剂局方》）•

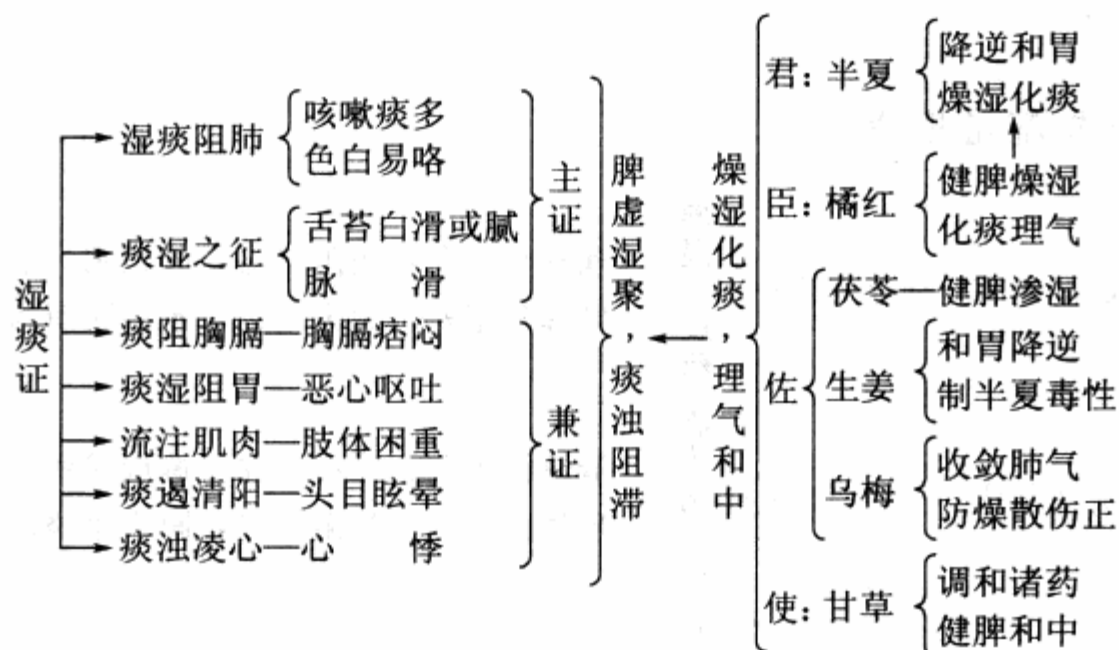
【组成】半夏汤洗七次 橘红各五两（15g） 白茯苓三两（9g） 甘草炙，一两半（4.5g）

【功用】燥湿化痰，理气和中

【主治】湿痰证。咳嗽痰多，色白易咯，恶心呕吐，胸膈痞闷，肢体困重，或头眩心悸，舌苔白滑或腻，脉滑。

【方歌】陈夏苓草二陈汤，燥湿化痰是主方，
若加星枳名导痰，顽痰胶固癫眩康。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，燥湿理气祛已生之痰以治标，健脾渗湿杜生痰之源以治本。
- ② 散收结合，散不伤正，收不敛邪。

【应用要点】本方为治疗湿痰的基础方。以咳嗽，痰多易咯，舌苔白腻，脉滑为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎、肺气肿、慢性胃炎、妊娠呕吐、神经性呕吐等属湿痰或湿阻气机者。

【使用注意】

- ① 本方因其性燥，故燥痰者慎用。
- ② 吐血、咳血、消渴、阴虚血虚者忌用。

• 温胆汤（《三因极一病证方论》）•

【组成】半夏汤洗七次 竹茹 枳实麸炒，去瓢，各二两（各6g） 橘皮三两（9g）

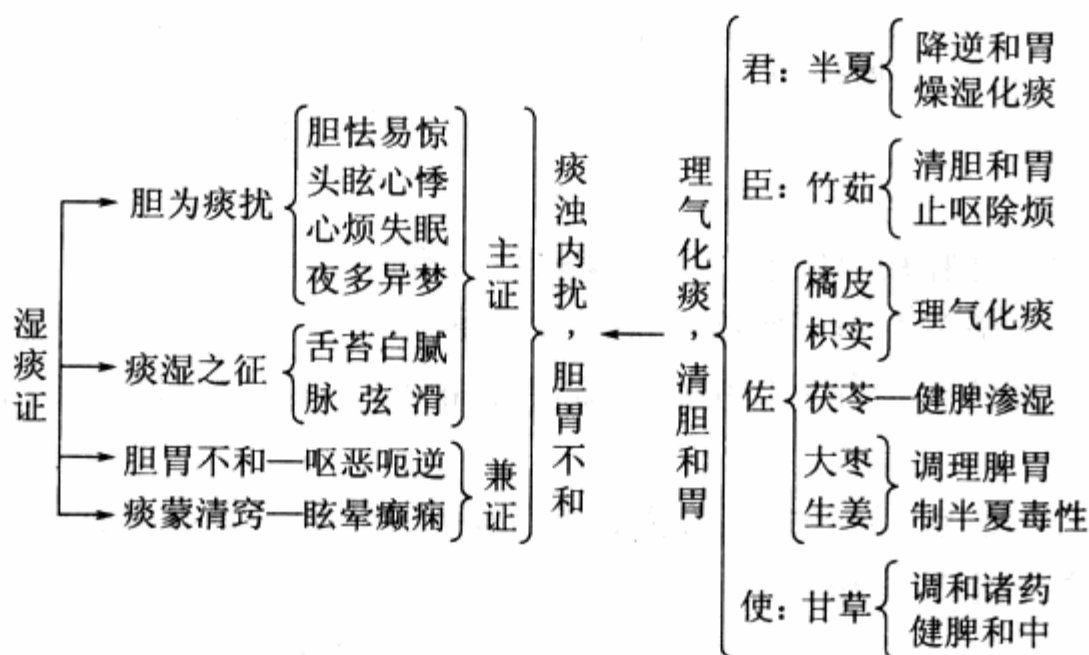
白茯苓一两半（4.5g） 甘草炙，一两（3g）

【功用】理气化痰，清胆和胃。

【主治】胆郁痰扰证。胆怯易惊，头眩心悸，心烦失眠，夜多异梦，或呕恶呃逆，眩晕，癫痫。苔白腻，脉弦滑。

【方歌】陈夏苓草二陈汤，燥湿化痰是主方，
若加枳茹即温胆，清胆宁神勿迷茫。

【表解】



【配伍特点】

- ① 温凉并进，温而不燥。
- ② 寓利胆于理气化痰和胃之中。

【难点提示】本方是从《备急千金要方》温胆汤衍化而成，原方较本方少茯苓、大枣，而生姜用至四两，治“大病后虚烦不得眠，此胆寒故也”，故曰“温胆”。

后世诸家减生姜用量而治痰热，故方名虽仍称“温胆”，而其功用则为清胆。

【应用要点】本方为治疗胆郁痰扰所致惊悸、失眠、呕恶及眩晕、癫痫的常用方。以心烦不寐，怔忡呕恶，舌苔白腻，脉弦滑为辨证要点。

现代临床本方常用于神经官能症、急慢性胃炎、慢性支气管炎、梅尼埃病、妊娠呕吐等属痰热内扰与胆胃不和者。

• 茯苓丸（《全生指迷方》）•

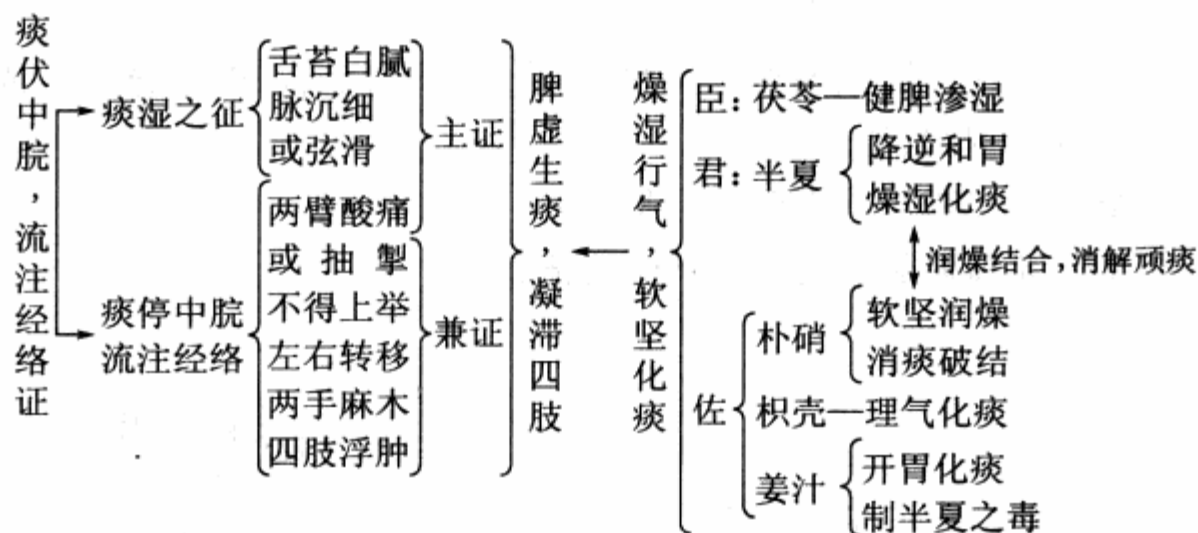
【组成】半夏二两（9g） 茯苓一两（6g） 枳壳麸炒，去瓢，半两（3g） 风化朴硝一分（3g）

【功用】燥湿行气，软坚化痰。

【主治】痰伏中脘，流注经络证。两臂酸痛或抽掣，不得上举，或左右时复转移，或两手麻木，或四肢浮肿，舌苔白腻，脉沉细或弦滑等。

【方歌】茯苓丸用风化硝，半夏枳壳姜汤调，
痰停中脘流四肢，臂痛肢肿有良效。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，健脾祛湿以治本，化痰软坚以治标。
- ② 润燥结合，消下并用，使结滞伏痰从二便分消。

【应用要点】本方为治疗痰伏中脘，流注经络证的常用方。以舌苔白腻，脉沉细或弦滑为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎、上肢血管性水肿等属湿痰者。

【使用注意】风湿臂痛忌用。

第二节 清热化痰

清热化痰剂适用于热痰证。症见咳嗽痰黄，黏稠难咯，舌红苔黄腻，脉滑数，或为癫狂癰癧。常以清热化痰药以胆南星、瓜蒌为主，配伍理气药如枳实、陈皮组成方剂。代表方剂如清气化痰丸、小陷胸汤、滚痰丸。

• 小陷胸汤（《伤寒论》）•

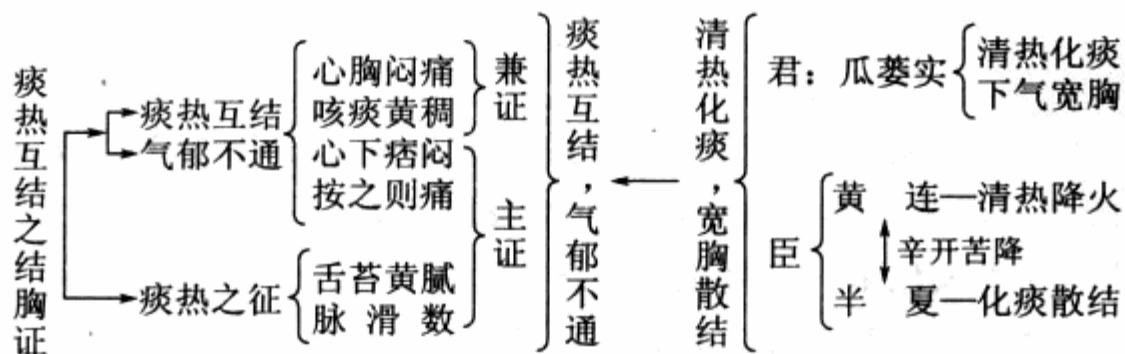
【组成】黄连一两（6g） 半夏洗，半升（12g） 瓜蒌实大者一枚（20g）

【功用】清热化痰，宽胸散结。

【主治】痰热互结之结胸证。心下痞闷，按之则痛，或心胸闷痛，或咳痰黄稠，舌红苔黄腻，脉滑数。

【方歌】小陷胸汤连夏蒌，宽胸开结涤痰优，
膈上热痰痞满痛，舌苔黄腻服之休。

【表解】



【配伍特点】

- ① 辛开苦降。
- ② 润燥相得，以求清热化痰、散结开痞。

【应用要点】本方为治疗痰热互结的常用方剂。以胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

现代临床本方常用于急性胃炎、胸膜炎、胸膜粘连、急性支气管炎、肋间神经痛等属痰热者。

• 清气化痰丸（《医方考》）•

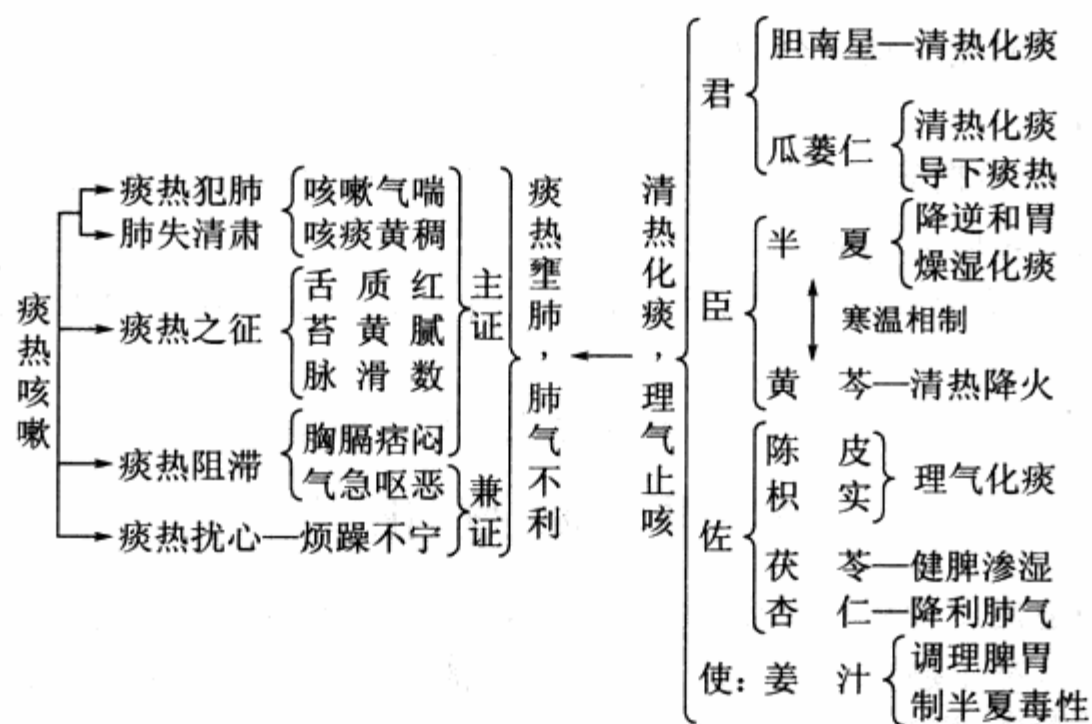
【组成】瓜蒌仁去油 陈皮去白 黄芩酒炒 杏仁去皮尖 枳实麸炒 茯苓各一两（各6g） 胆南星 制半夏各一两半（各9g）

【功用】清热化痰，理气止咳。

【主治】痰热咳嗽。咳嗽气喘，咳痰黄稠，胸膈痞闷，甚则气急呕恶，烦躁不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方歌】清气化痰萎杏仁，芩苓实夏胆星陈，
姜汁为丸温水下，咳嗽痰黄呕恶停。

【表解】



【配伍特点】化痰与清热、理气并进。

【应用要点】本方为治疗痰热咳嗽的常用方。以咳嗽痰稠色黄，胸膈痞闷，苔黄，脉数为辨证要点。

现代临床本方常用于肺炎、急慢性支气管炎发作见有痰稠色黄，证属痰热内结者。

• 滚痰丸（《金匱要略》）•

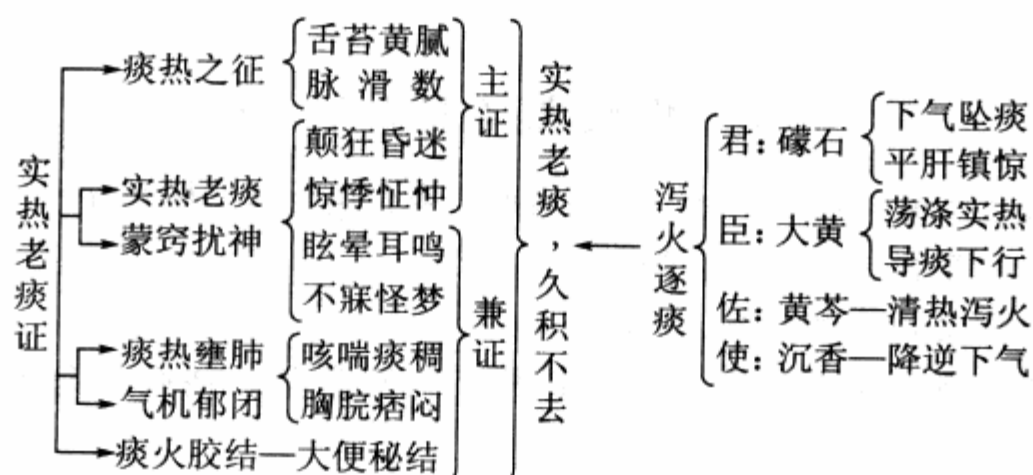
【组成】大黄酒蒸 片黄芩酒洗净，各八两（各240g） 沉香半两（30g） 礞石一两（30g），捶碎，同焰硝一两，放入小砂罐内盖之，铁线缚定，盐泥固济，晒干，火煅红，候冷取出

【功用】泻火逐痰。

【主治】实热老痰证。癫狂昏迷，或惊悸怔忡，或不寐怪梦，或咳喘痰稠，或胸脘痞闷，或眩晕耳鸣，大便秘结，舌苔黄腻，脉滑数有力。

【方歌】滚痰丸是逐痰方，礞石黄芩及大黄，
少佐沉香为引导，实热顽痰一扫光。

【表解】



【配伍特点】清上开下，正本清源，为降火逐痰峻剂。

【应用要点】本方为治疗实热老痰证的常用方。以癫狂惊悸，大便秘结，舌苔黄腻，脉滑数有力为辨证要点。

现代临床本方常用于精神分裂症、癫痫、神经官能症等属痰火内闭者。

【使用注意】

① 增减药量。根据病情之轻重、病势之缓急及药后反应增减药量。急重病，每服9~12g；慢性病，每服6~9g。

② 服药方法。要求临睡前用温开水送咽，令药在咽喉间徐徐而下，使药力缓缓而发，以求峻药缓用。

③ 使用禁忌。因本方药力较峻，体虚之人及孕妇等皆应慎用。

第三节 润燥化痰

润燥化痰剂适用于燥痰证。症见咳嗽甚或呛咳，咯痰不爽，或痰黏成块，或痰中带血，胸闷胸痛，口鼻干燥，舌干少津，苔干，脉涩等。常以润燥化痰药如贝母、瓜蒌等为主，配伍生津润燥药如天花粉及宣利肺气之品如桔梗组成方剂。代表方剂如贝母瓜蒌散。

• 贝母瓜蒌散（《医学心悟》）•

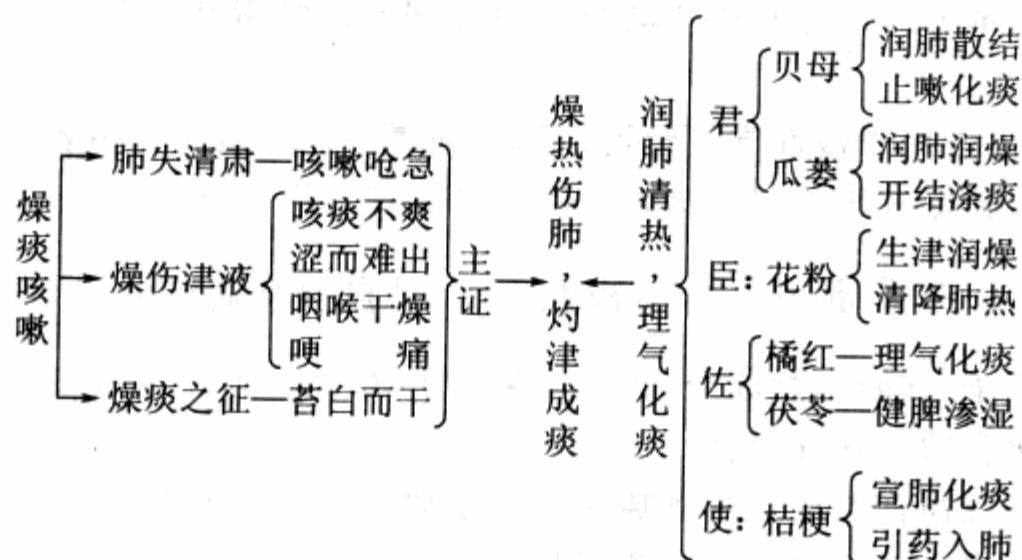
【组成】贝母一钱五分（5g） 瓜蒌一钱（3g） 花粉 茯苓 橘红 桔梗各八分（各2.5g）

【功用】润肺清热，理气化痰。

【主治】燥痰咳嗽。咳嗽呛急，咳痰不爽，涩而难出，咽喉干燥哽痛，苔白而干。

【方歌】贝母瓜蒌花粉研，橘红桔梗茯苓添，
咳嗽咽干痰难出，润燥化痰病自安。

【表解】



【配伍特点】

- ① 肺脾通调，即健脾祛湿以杜生痰之源，润肺化痰以防燥痰伤肺。
- ② 清润宣化，而以润肺化痰为主，润肺不留痰，化痰不伤津。

【应用要点】本方为治疗燥痰证的常用方。以咯痰难出，咽喉干燥，苔白而干为辨证要点。

现代临床本方常用于肺结核、肺炎等见有燥痰证者。

【使用注意】不宜用于肺肾阴虚，虚火上炎之咳嗽。

第四节 温化寒痰

温化寒痰剂适用于寒痰证。症见咳嗽，吐痰清稀，胸闷脘痞，气喘哮鸣，畏寒肢冷，舌苔白腻，脉弦滑或弦紧。常以温化寒痰药如干姜、细辛、白芥子、半夏为主组方。代表方剂如苓甘五味姜辛汤、三子养亲汤。

• 苓甘五味姜辛汤（《金匱要略》）•

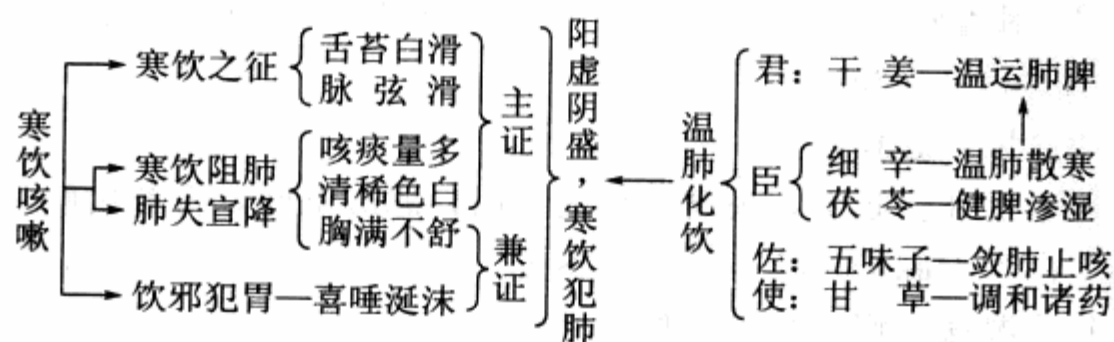
【组成】茯苓四两（12g） 甘草三两（9g） 干姜三两（9g） 细辛三两（5g） 五味子半升（5g）

【功用】温肺化饮。

【主治】寒饮咳嗽。咳痰量多，清稀色白，或喜唾涎沫，胸满不舒，舌苔白滑，脉弦滑等。

【方歌】苓甘五味姜辛汤，温阳化饮常用方，
半夏杏仁均可入，寒痰冷饮保安康。

【表解】



【配伍特点】温散并行；开合相济；肺脾同调；标本兼顾。

【应用要点】本方为治疗寒饮咳嗽的常用方剂。以咳嗽痰稀色白，舌苔白滑为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性支气管炎、肺气肿属寒饮而咳痰清稀者。

【使用注意】肺燥有热、阴虚咳嗽、痰中带血者忌用本方。

• 三子养亲汤（《皆效方》，录自《杂病广要》）•

【组成】白芥子（6g） 紫苏子（9g） 莱菔子（9g）（原书未著剂量）

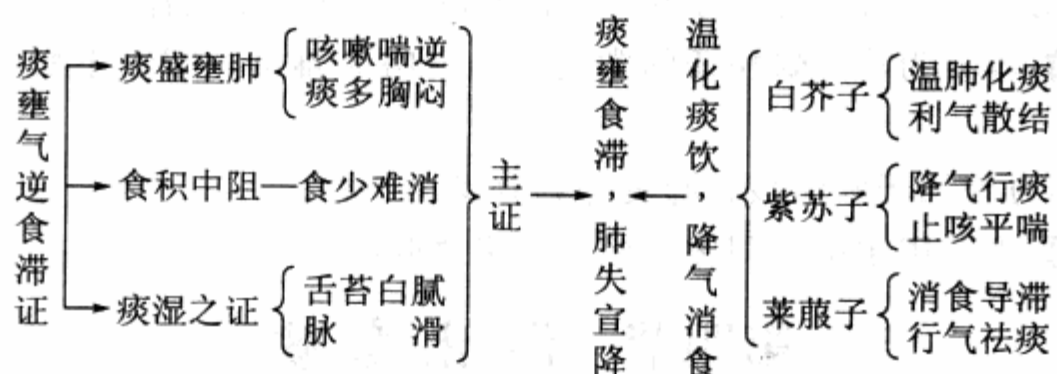
【功用】温化痰饮，降气消食。

【主治】痰壅气逆食滞证。咳嗽喘逆，痰多胸闷，食少难消，舌苔白腻，脉滑。

【方歌】三子养亲祛痰方，芥苏莱菔共煎汤，

大便实硬加熟蜜，冬寒更可加生姜。

【表解】



【应用要点】本方为治疗痰壅气逆食滞证的常用方。以咳嗽痰多，食少胸痞，舌苔白腻，脉滑为辨证要点。

现代临床本方常用于顽固性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、肺源性心脏病等属痰壅气逆食滞者。

【使用注意】本方属治标之剂，绝非图本，服后一俟病情缓解，即当标本兼治。

第五节 化痰息风

化痰息风剂适用于内风夹痰证。症见眩晕头痛，或发癫痫，甚则昏厥，不省人事，舌苔白腻，脉弦滑等。常以平肝息风药与化痰药如天麻、半夏、胆南星、僵蚕为主，配伍健脾祛湿药如茯苓、白术等组方。代表方剂如半夏白术天麻汤。

• 半夏白术天麻汤（《医学心悟》）•

【组成】半夏一钱五分（9g） 天麻一钱（6g） 茯苓一钱（6g） 橘红一钱（6g） 白术三钱（15g） 甘草五分（3g）

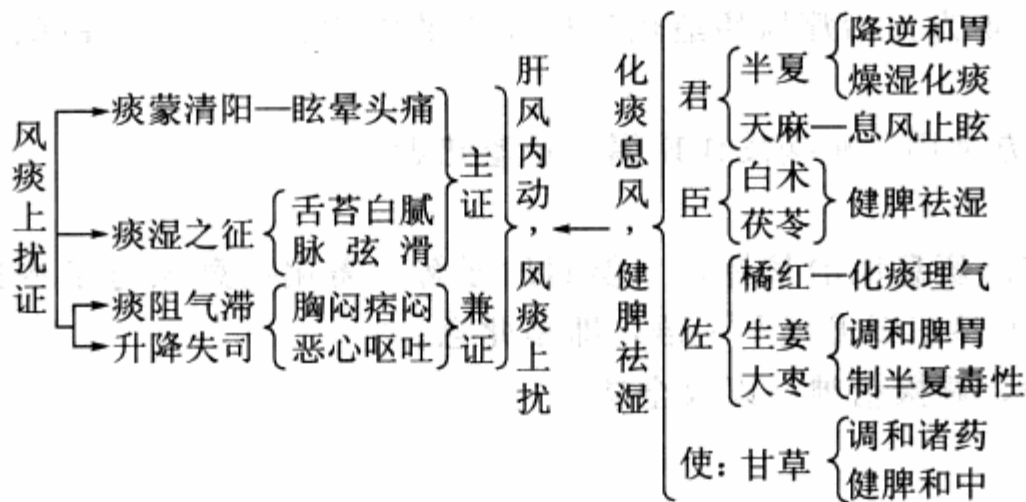
【功用】化痰息风，健脾祛湿。

【主治】风痰上扰证。眩晕，头痛，胸闷痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。

【方歌】半夏白术天麻汤，茯苓橘红草枣姜，

健脾化湿祛风痰，眩晕头痛辨参详。

【表解】



【配伍特点】① 风痰并治。② 标本兼顾，化痰息风以治标为主，健脾祛湿以治本为辅。

【应用要点】本方为治疗风痰上扰眩晕头痛的常用方。以眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑为辨证要点。现代临床本方常用于耳源性眩晕、高血压病、神经性眩晕、癫痫、面神经瘫痪等属风痰上扰者。

【使用注意】对于肝肾阴虚，气血不足所致之眩晕，不宜应用。

• 定 痛 丸 (《医学心悟》) •

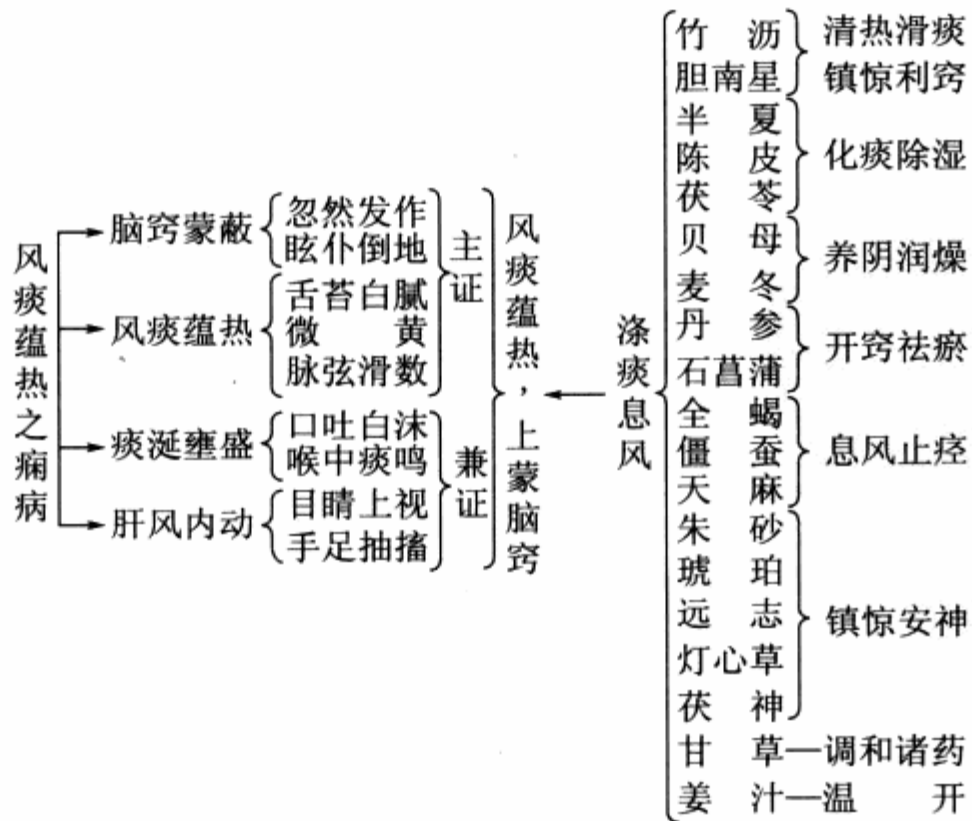
【组成】明天麻 川贝母 半夏姜汁炒 茯苓蒸 茯神去木，蒸，各一两（各 6g） 胆南星九制者 石菖蒲杵碎，取粉 全蝎去尾，甘草水洗 僵蚕甘草水洗，去咀，炒 真琥珀腐煮，灯草研，各五钱（各 3g） 辰砂细研，水飞，三钱（2g） 陈皮洗，去白 远志去心，甘草水泡，各七钱（各 4.5g） 丹参酒蒸 麦冬去心，各二两（各 12g）

【功用】涤痰息风。

【主治】风痰蕴热之痫病。忽然发作，眩仆倒地，目睛上视，口吐白沫，喉中痰鸣，叫喊作声，甚则手足抽搐，舌苔白腻微黄脉弦滑数。亦可用于癫狂。

【方歌】定痛二茯贝天麻，丹麦陈远菖蒲夏，
胆星蝎蚕草竹沥，姜汁琥珀与朱砂。

【表解】



【配伍特点】寒热并用，润燥结合。

【应用要点】本方为治疗风痰蕴热痫病发作的常用方。以舌苔白腻微黄，脉弦滑略数为辨证要点。

现代临床本方常用于癫痫发作期属风痰蕴热者。

【使用注意】

① 本方重在涤痰息风治其标，一俟痫病缓解，需化痰息风与培本扶正兼顾。故原方后有“方内加人参三钱尤佳”一语，即是此意。

② 注意饮食，调摄精神，以收全功。

第十七章 消食剂

一、定义

凡以消食药为主组成，具有消食健脾、化积导滞作用，治疗食积停滞的方剂，统称消导化积剂。

二、立法依据

消食，属于“八法”中的“消法”。《素问·至真要大论》曰“坚者消之”、“结者散之”；《医学心悟》曰“消者，祛其壅也，脏腑、筋络、肌肉之间，本无此物，而忽有之，必为消散，乃得其平”。食积为病理产物，停滞则变生诸证，故应及时祛除。

三、适应范围

食积停滞 { 食积内停，实而不虚
脾胃虚弱，食积内停

四、分类与配伍规律

消食剂 { 消食化滞 → 食积证 ← 消食药 + { 理气药：食积易阻气机
清热祛湿药：食积日久，生湿化热
健脾消食 → 脾虚食积证 ← 消食药 + { 益气健脾药：素有脾胃虚弱
理气醒脾药：食积易阻气机，困阻脾胃

五、使用注意

① 消食剂与泻下剂均能消除体内有形之实邪，但在运用时两者应有所区别。消食剂多属渐消缓散之剂，适用于病势较缓的食积证；而泻下剂多属攻逐之剂，适用于病势较急、积滞较重之食积证。若当用泻法而误用消法，则病重而药轻，其疾难愈；若当用消法而误用泻法，则病轻药重，易伤正气，病反深锢。故朱震亨在《丹溪心法》中指出：“凡积病不可用下药，徒损真气，病亦不去，当用消积药使之融化，则根除矣。”

② 消食剂虽功力较缓和，但终属攻伐之方，故不宜长期服用，而纯虚无实者更当禁用或慎用。

第一节 消食化滞

消食化滞剂适用于食积内停之证。症见胸脘痞闷，噯腐吞酸，恶食呕逆，腹痛泄泻等。常以消食药物如山楂、神曲、麦芽、莱菔子等为主组成方剂。由于饮食积滞易阻碍气机，并容易生湿化热，故常配伍理气、祛湿、清热之品。代表方剂如保和丸、枳实导滞丸。

• 保和丸（《丹溪心法》）•

【组成】山楂六两（18g） 神曲二两（6g） 半夏 茯苓各三两（各9g） 陈皮 连

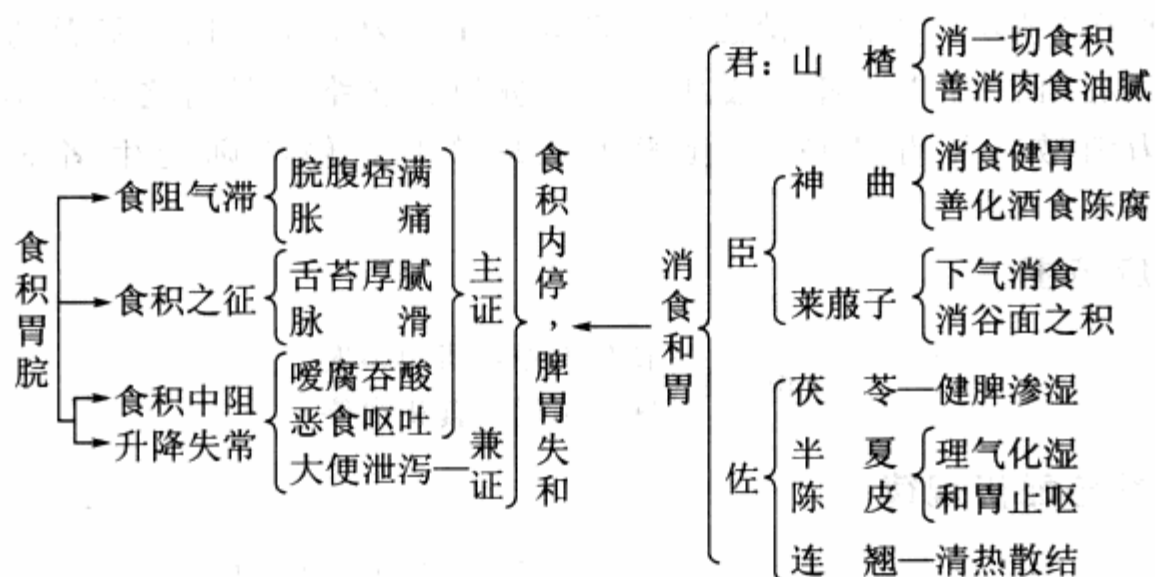
翘 莱菔子各一两（各 6g）

【功用】消食和胃。

【主治】食积胃脘。脘腹痞满胀痛，噯腐吞酸，恶食呕吐，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

【方歌】保和神曲和山楂，莱菔连翘苓陈夏，
饮食自倍肠胃伤，消积导滞助传化。

【表解】



【配伍特点】

- ① 标本兼顾，消食化积治本为主，行气、化湿、清热兼治气标。
- ② 药力和缓，炊饼为丸。

【难点提示】连翘在本方及银翘散、清营汤、凉膈散中的配伍意义如下。

保和丸：清热散结，以助消积，又可清食积所生之蕴热。

银翘散：与金银花配伍清热解毒，兼解表透邪。

清营汤：清心解毒，透热转气。

凉膈散：清热解毒，透散上焦热邪。

【应用要点】本方为治疗一切食积的通用方剂。以脘腹胀满，噯腐厌食，苔厚腻，脉滑为辨证要点。

现代临床本方常用于急慢性胃炎、急慢性肠炎、消化不良、婴儿腹泻等属食积内停者。

【使用注意】本方属攻伐之剂，不宜久服。

• 枳实导滞丸（《内外伤辨惑论》）•

【组成】大黄一两（9g） 枳实麸炒 神曲炒，各五钱（各 9g） 茯苓 黄芩 黄连 白术各三钱（各 6g） 泽泻二钱（6g）

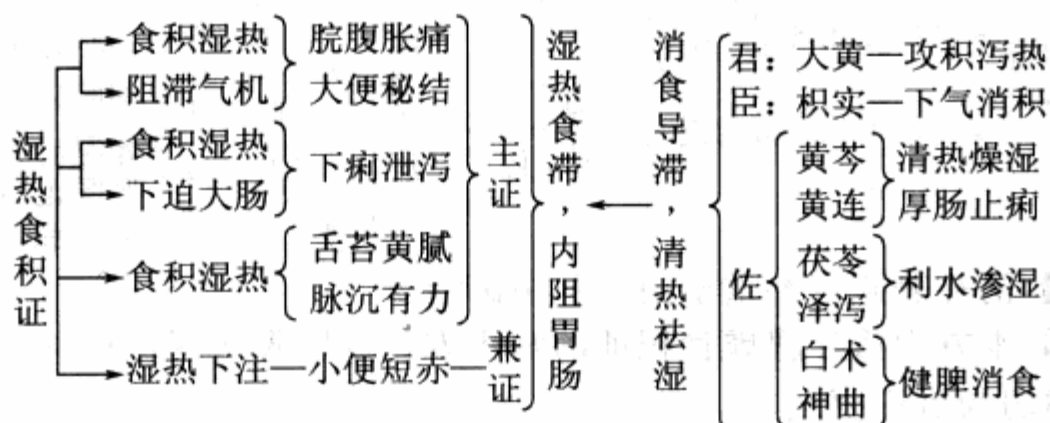
【功用】消食导滞，清热利湿。

【主治】湿食积证。脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔黄腻，

脉沉有力。

【方歌】 枳实导滞用泻心，神曲泽泻术茯苓，
消导积滞便秘下，通因通用痢亦停。

【表解】



【配伍特点】

- ① 消、下、清、利并用，以下为主，通因通用。
- ② 攻补兼施，使攻积而不伤正。

【难点提示】 本方是以攻积泻热之大黄配伍下气消积之枳实，开下行之路，可导湿热积滞从大便而出，属通因通用之法。

体现“通因通用”的方剂有：大承气汤、芍药汤、枳实导滞丸。

【应用要点】 本方为治疗湿热食积，内阻肠胃的常用方。以腕腹胀痛，大便失常，苔黄腻，脉沉有力为辨证要点。

现代临床本方常用于胃肠功能紊乱、慢性痢疾等属湿热积滞者。

【使用注意】 泄泻无积滞者及孕妇不宜使用。

第二节 健脾消食

健脾消食剂适用于脾胃虚弱，食积内停之证。症见脘腹痞满，不思饮食，面黄体瘦，倦怠乏力，大便溏薄等。常选用消食药如山楂、神曲、麦芽等配伍益气健脾药如人参、白术、山药等组成方剂。代表方剂如枳术丸、健脾丸等。

• 健脾丸（《证治准绳》）•

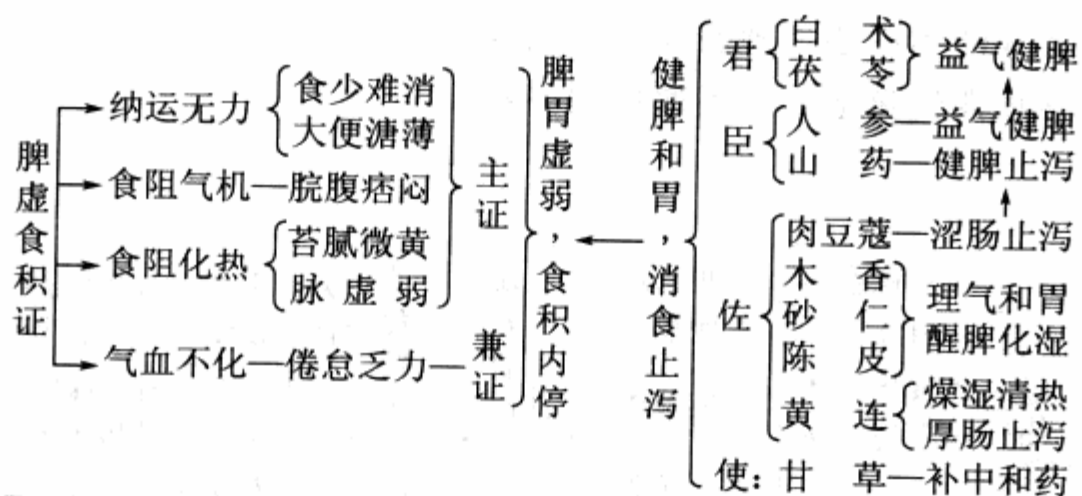
【组成】 白术炒，二两半（15g） 木香另研 黄连酒炒 甘草各七钱半（各 6g） 白茯苓去皮，二两（10g） 人参一两五钱（9g） 神曲炒 陈皮 砂仁 麦芽炒 山楂取肉 山药 肉豆蔻面裹煨热，纸包槌去油，各一两（各 6g）

【功用】 健脾和胃，消食止泻。

【主治】 脾虚食积证。食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱。

【方歌】 健脾丸内四君砂，麦曲陈皮山药楂，
木香川连肉豆蔻，消补兼施效尤佳。

【表解】



【配伍特点】消补兼施，补重于消，补中寓涩。

【应用要点】本方为治疗脾虚食积证的常用方。以脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻微黄，脉虚弱为辨证要点。

现代临床本方常用于慢性胃炎、慢性肠炎、消化不良等属脾虚食滞者。

【类方比较】

保和丸与健脾丸比较表

比较	方名	保和丸	健脾丸
组成	同	山楂、神曲、陈皮、茯苓	
	异	莱菔子、半夏、连翘	麦芽、砂仁、木香、人参、白术、甘草、山药、肉豆蔻、黄连
功用	同	消食和胃，健脾化湿	
	异	专于消食和胃	健脾止泻(寓消于补)
主治	同	食积内停	
	异	食积实证(胀暖较著)	脾虚食积(泄泻较显)

• 枳实消痞丸（失笑丸）（《兰室秘藏》）•

【组成】干生姜一钱（3g）炙甘草 麦芽曲 白茯苓 白术各二钱（各 6g）半夏曲 人参各三钱（各 9g）厚朴炙，四钱（12g）枳实 黄连各五钱（各 15g）

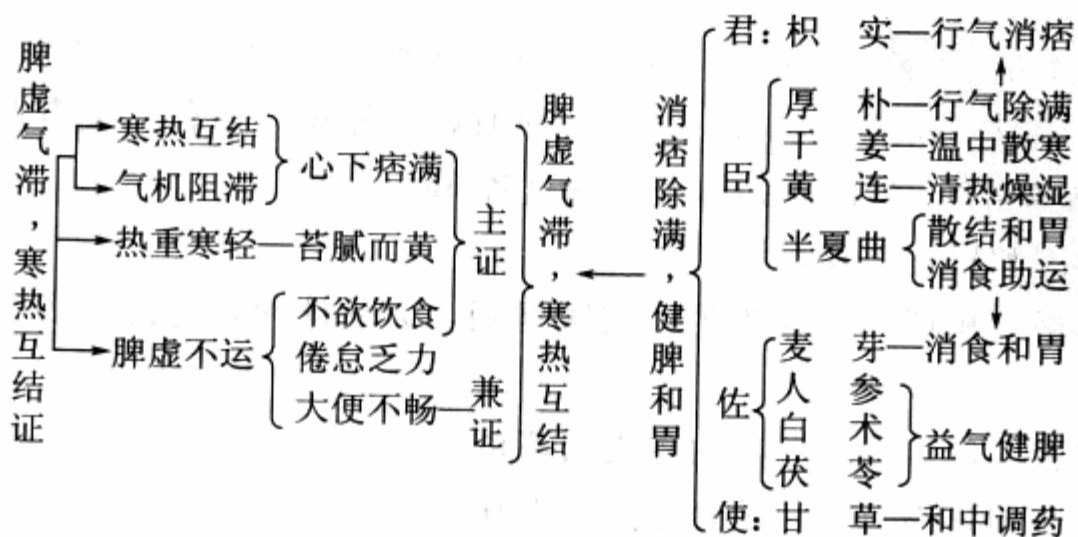
【功用】消痞除满，健脾和胃。

【主治】脾虚气滞，寒热互结证。心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便不畅，苔腻而黄。

【方歌】枳实消痞干姜连，朴夏麦芽四君全，

寒热交结虚痞止，消散为主补益兼。

【表解】



【配伍特点】消补兼施，以消为主；温清并用，以清为主；辛开苦降，以苦降为主。

【应用要点】本方为治疗脾虚气滞，寒热互结证的常用方。以心下痞满，食少倦怠，苔腻而黄为辨证要点。现代临床本方常用于慢性胃炎、慢性支气管炎、胃肠神经官能症等属脾虚气滞，寒热互结者。

• 葛花解酲汤（《内外伤辨惑论》）•

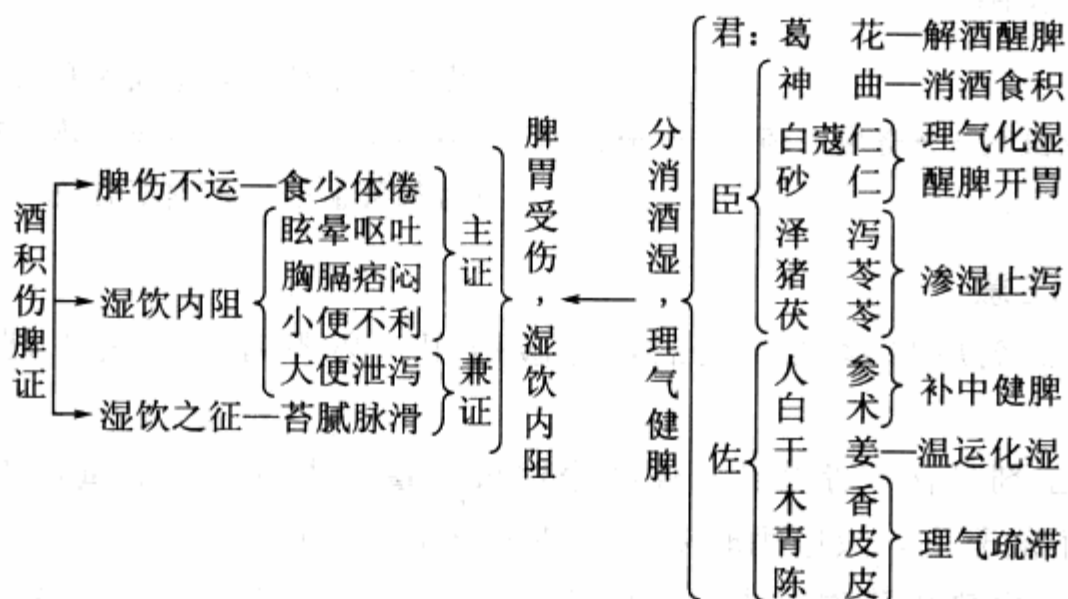
【组成】木香五分（1.5g） 人参去芦 猪苓去皮 白茯苓 橘皮去白 白术 干生姜、神曲炒黄 泽泻各二钱（各 6g） 青皮三分（1g） 缩砂仁 白豆蔻仁 葛花各五钱（各 15g）

【功用】分消酒湿，理气健脾。

【主治】酒积伤脾证。眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利，大便泄泻，苔腻，脉滑。

【方歌】葛花解酲泽二苓，砂蔻青陈木香并，
姜曲参术温健脾，分消寒化酒湿灵。

【表解】



【配伍特点】发汗与利水并行，以分消就湿；消食理气与补气健脾同用，以邪正兼顾。

【应用要点】本方为治疗酒积伤脾证的常用方剂。以眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利为辨证要点。现代临床本方常用于饮酒过量致醉，或嗜酒成性者。

第十八章 驱虫剂

一、定义

凡以驱虫药物为主组成，具有驱杀人体内寄生虫的作用，用治人体寄生虫病的方剂，统称驱虫剂。

二、立法依据

驱虫剂，属于“八法”中“消法”范畴。《医学心悟》“消者，祛其壅也，脏腑、筋络、肌肉之间，本无此物，而忽有之，必为消散，乃得其平”。寄生虫寄生于体内，易变生诸证，故应及时驱除。

三、适应范围

寄生虫病证：主要适用于寄生人体消化道的蛔虫、蛲虫、钩虫、绦虫、姜片虫等寄生虫病。

四、配伍规律

驱虫剂 → 寄生虫病证 ← 驱虫药 + {
温中祛寒药：兼寒或因寒而动
清热燥湿药：兼热或因热而动
益气补血药：正虚不宜攻伐

五、使用注意

① 服用驱虫剂应忌食油腻之品，空腹服用。必要时可与泻下剂同用，以破结去虫。

② 某些驱虫剂多含有毒之品，连续服用极易蓄积中毒，若剂量过大易损伤人体正气，不及则又不能驱虫，故应用时要注意剂量及服药间隔时间。

③ 驱虫剂多由攻伐药物组成，所以脾胃素亏者、年老体弱者、孕妇等均应慎用或禁用。

④ 辨证选用驱虫剂时，宜结合粪便检验报告。

⑤ 服用驱虫剂驱虫后，应适当调护脾胃。

• 乌梅丸（《伤寒论》）•

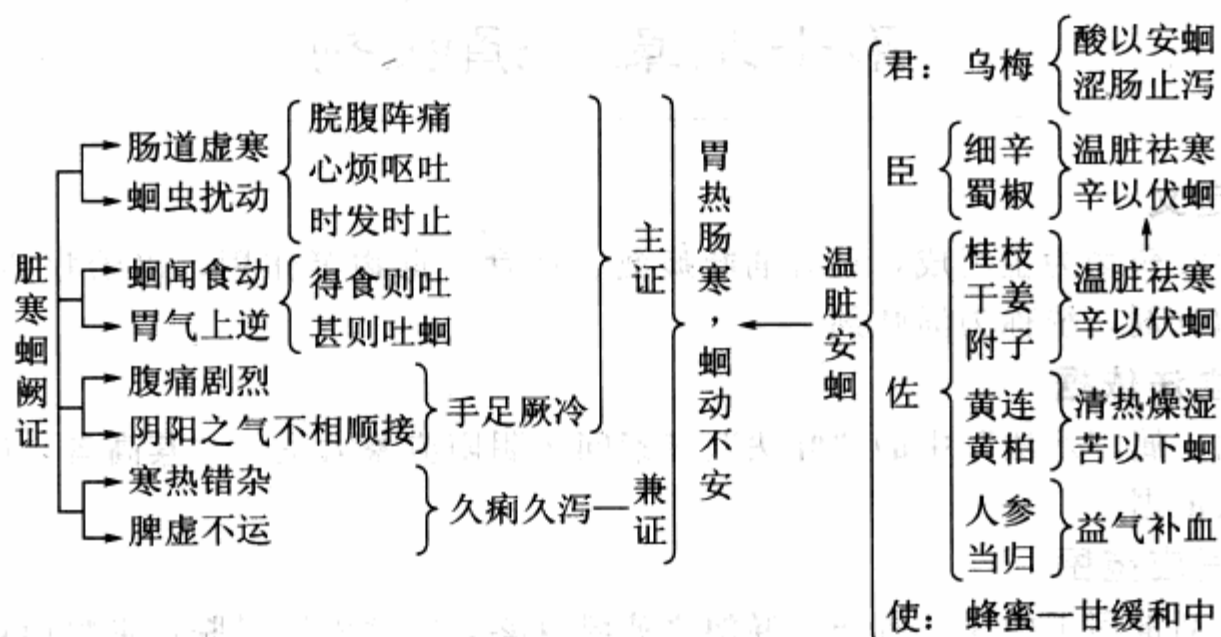
【组成】乌梅三百枚（30g） 细辛六两（3g） 干姜十两（9g） 黄连十六两（6g） 当归四两（6g） 附子炮，去皮，六两（6g） 蜀椒炒香，四两（5g） 桂枝六两（6g） 人参六两（6g） 黄柏六两（6g）

【功用】温脏安蛔。

【主治】脏寒蛔厥证。脘腹阵痛，心烦呕吐，时发时止，得食则吐，甚则吐蛔，手足厥冷。或治久痢久泻。

【方歌】乌梅丸用细辛桂，人参附子椒姜配，
黄连黄柏及当归，温脏安蛔寒厥退。

【表解】



【配伍特点】

- ① 酸苦辛并进，以酸安蛔为主。
- ② 寒热并用，以温下寒为主。
- ③ 邪正兼顾，以驱邪为主。

【难点提示】由于乌梅兼有涩肠止泻之功，因此本方对于寒热错杂、正气虚弱之久泻久痢亦可奏效。此外，治疗久泻久痢的常用方剂还有补中益气汤、真人养脏汤。

【应用要点】本方为治疗脏寒蛔厥证的常用方剂，也为治疗寒热错杂、正气虚弱之久泻久痢的常用方剂。以腹痛时作，烦闷呕吐，常自吐蛔，手足厥冷为辨证要点。

现代临床本方常用于胆道蛔虫症、肠道蛔虫症、慢性肠炎、慢性菌痢等属寒热错杂而正气虚者。

一、定义

凡以涌吐药物为主组成，具有涌吐痰涎、宿食、毒物等作用，以治疗痰厥、食积、误食毒物的方剂，统称为涌吐剂。

二、立法依据

涌吐剂，属“八法”中的“吐法”。《素问·阴阳应象大论》：“其高者，因而越之。”这是其立法依据。

三、适应范围

本类方剂常用于中风、癫狂、喉痹之痰涎壅盛，宿食停留胃脘，毒物尚留胃中，以及干霍乱吐泻不得等，病在上、中焦，病情急迫而又急需吐出之证。

四、使用注意

① 本类方剂作用迅猛，易伤胃气，应中病即止，年老体弱、幼儿、孕妇产后均宜慎用。

② 服涌吐剂后呕吐不止者，可服姜汁少许，或服冷粥、冷开水等以止之。仍不止，则据所服吐药的不同而进行解救。

③ 服涌吐剂后不吐者，以翎毛或手指探喉，亦可多饮开水，以助其吐。

④ 服药得吐后，需令病人避风，同时要注意调理脾胃。

• 瓜蒂散（《伤寒论》）•

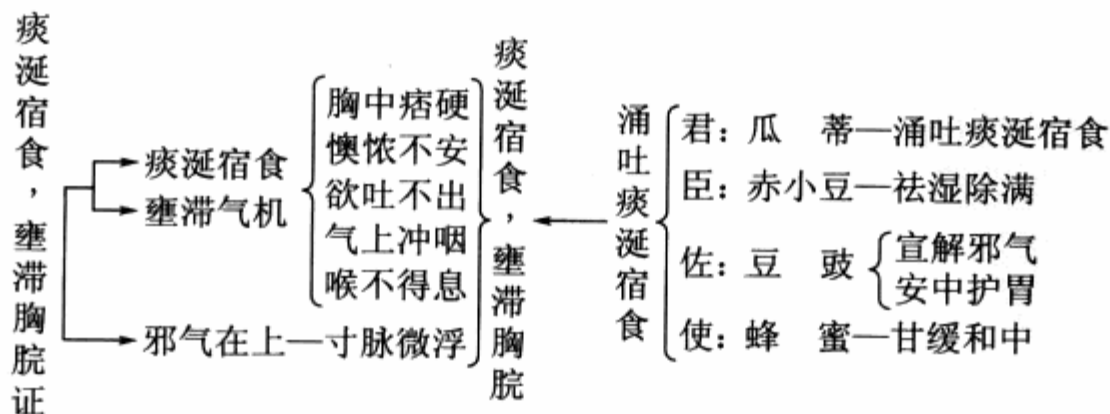
【组成】瓜蒂熬黄，一分 赤小豆一分

【功用】涌吐痰涎宿食。

【主治】痰涎宿食，壅滞胸脘证。胸中痞硬，懊恼不安，欲吐不出，气上冲咽喉不得息，寸脉微浮者。

【方歌】瓜蒂散是涌吐方，胸中痞硬痰邪猖，
气冲咽喉不得息，蒂豆研散调豉汤。

【表解】



【应用要点】

本方为涌吐法的要方。以胸中痞硬，懊恼不安，气上冲咽喉不得息，或误食食物尚在胃中为辨证要点。

现代临床本方常用于暴饮暴食之胃扩张、误食毒物、精神分裂症、精神抑郁症等属痰涎宿食，壅滞胸脘者。

【使用注意】

- ① 诸亡血虚家不可用瓜蒂散。
- ② 服瓜蒂散吐不止者，可服麝香 0.03~0.06g 解之。
- ③ 因方中瓜蒂苦寒有毒，易于伤气败胃，非形气俱实者慎用。
- ④ 若食已离胃入肠，痰涎不在胸膈者，均须禁用。



参考文献

- [1] 李嵩山等编.《中医方剂论解》[M]. 石家庄:河北科学技术出版社, 1990.
- [2] 邓中甲.《方剂学》[M]. 北京:中国中医药出版社, 2003.
- [3] 倪诚等.《方剂学》[M]. 北京:中国中医药出版社, 2004.
- [4] 王洪图.《内经》[M]. 北京:中国中医药出版社, 1999.
- [5] 李庆业等.《方剂学图表解》[M]. 北京:人民卫生出版社, 2004.
- [6] 刘喜平.《敦煌古医方研究》[M]. 北京:科学普及出版社, 2006.
- [7] 吴红彦.《方剂学概要》[M]. 兰州:甘肃文化出版社, 2001.



索引

A

安宫牛黄丸 95

B

八珍汤 75
八正散 144
白虎汤 38
白头翁汤 50
百合固金汤 139
败毒散 19
半夏白术天麻汤 166
半夏厚朴汤 102
半夏泻心汤 35
保和丸 169
贝母瓜蒌散 164
藜蘼分清散(藜蘼分清饮) 156
鳖甲煎丸 116
补阳还五汤 112
补中益气汤 67

C

柴葛解肌汤 17
川芎茶调散 123

D

大补阴丸 78
大柴胡汤 31
大承气汤 23
大定风珠 130
大黄附子汤 26
大黄牡丹汤 25
大秦艽汤 124
当归补血汤 72
当归六黄汤 53
当归拈痛汤(拈痛汤) 149
当归四逆汤 63
导赤散 44

地黄饮子 81
定喘汤 106
定痛丸 167
独活寄生汤 157

E

二陈汤 160
二妙散 148

F

防己黄芪汤 151
茯苓丸 161
复元活血汤 113

G

甘露消毒丹 147
葛根黄芩黄连汤 49
葛花解醒汤 173
固冲汤 89
固经丸 89
瓜蒂散 176
归脾汤 73
龟鹿二仙胶 82
桂苓甘露饮 56
桂枝茯苓丸 116
桂枝汤 11
滚痰丸 163

H

蒿芩清胆汤 32
厚朴温中汤 103
槐花散 120
黄连解毒汤 42
黄土汤 120
回阳救急汤 62
藿香正气散 142

J

济川煎 28

加减葳蕤汤 21
健脾丸 171
金铃子散 103
金锁固精丸 87
九味羌活汤 12
九仙散 85
橘皮竹茹汤 108

K

咳血方 118

L

理中丸 58
连朴饮 147
凉膈散 43
苓甘五味姜辛汤 165
苓桂术甘汤 154
羚角钩藤汤 128
六味地黄丸 76
六一散 55
龙胆泻肝汤 45

M

麻黄汤 10
麻黄细辛附子汤 21
麻黄杏仁甘草石膏汤 16
麻子仁丸 27
麦门冬汤 137
牡蛎散 85

N

暖肝煎 104

P

平胃散 142
普济消毒饮 41

Q

牵正散 125
羌活胜湿汤 157
青蒿鳖甲汤 51
清骨散 52

清络饮 54
清气化痰丸 162
清暑益气汤 56
清胃散 48
清营汤 39
清燥救肺汤 135

S

参苓白术散 68
参苏饮 20
三仁汤 146
三子养亲汤 166
桑菊饮 15
桑螺蛸散 88
桑杏汤 134
芍药汤 49
肾气丸 80
升麻葛根汤 18
生化汤 114
生脉散 69
失笑散 115
十灰散 118
十枣汤 29
实脾散 155
四君子汤 67
四逆散 33
四逆汤 61
四神丸 87
四物汤 72
苏合香丸(吃力伽丸) 98
苏子降气汤 105
酸枣仁汤 92

T

桃核承气汤 110
天麻钩藤饮 130
天台乌药散 104
天王补心丹 93
痛泻要方 34

W

完带汤 71

苇茎汤 46
温胆汤 160
温经汤 114
温脾汤 26
乌梅丸 174
吴茱萸汤 60
五苓散 150
五皮散 152

X

犀角地黄汤 40
仙方活命饮 43
香薷散 55
逍遥散 34
消风散 127
小柴胡汤 30
小活络丹 125
小蓟饮子 119
小建中汤 59
小青龙汤 13
小陷胸汤 163
泻白散 47
杏苏散 133
旋覆代赭汤 107
血府逐瘀汤 111

Y

阳和汤 64
养阴清肺汤 139

一贯煎 78
易黄汤 90
益胃汤 138
茵陈蒿汤 144
银翘散 14
右归丸 80
玉女煎 47
玉屏风散 70
玉真散 126
越鞠丸 101

Z

增液汤 136
真人养脏汤 86
真武汤 153
镇肝熄风汤 129
止嗽散 13
枳实导滞丸 170
枳实消痞丸(失笑丸) 172
枳实薤白桂枝汤 101
至宝丹 97
炙甘草汤 74
朱砂安神丸 91
猪苓汤 150
竹叶石膏汤 39
紫雪 96
左归丸 77
左金丸 46